

ΟΙ

100

ΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πλήρης έκδοση 100 ερωτήσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι 100 ερωτήσεις

Q1	Πώς προσεγγίζετε έναν νέο ψυχιατρικό ασθενή και πώς οργανώνετε την αρχική εκτίμηση;	1
Q2	Πώς διακρίνετε μια παραληρητική ιδέα, μια υπερτιμημένη ιδέα και μια ιδεοληψία;	3
Q3	Όταν εμφανίζονται ψυχιατρικά συμπτώματα για πρώτη φορά, πότε πρέπει να υποψιαστείτε ιατρικό, νευρολογικό, φαρμακευτικό ή σχετιζόμενο με ουσίες αίτιο;	4
Q4	Πώς εκτιμάτε την αυτοκτονική πρόθεση και τον άμεσο κίνδυνο αυτοκτονίας;	5
Q5	Ένας ασθενής επέζησε από απόπειρα αυτοκτονίας. Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο επανάληψης;	7
Q6	Πώς εκτιμάτε τον κίνδυνο βίας ή επιθετικότητας;	9
Q7	Πώς αντιμετωπίζετε τη σοβαρή διέγερση στα επείγοντα;	10
Q8	Πώς εκτιμάτε αν ένας ασθενής μπορεί να δώσει έγκυρη ενημερωμένη συναίνεση;	11
Q9	Πότε μπορεί ένας ασθενής να νοσηλευτεί ακούσια στην Ελλάδα και ποια είναι η διαδικασία;	13
Q10	Πώς αναγνωρίζετε την κατατονία και πώς την αντιμετωπίζετε;	15
Q11	Ένας 23χρονος παρουσιάζει παρανοειδείς ιδέες, ακουστικές ψευδαισθήσεις και κοινωνική απόσυρση. Πώς θα προσεγγίζατε την περίπτωση;	17
Q12	Περιγράψτε την κλινική εικόνα και τη διάγνωση της σχιζοφρένειας.	19
Q13	Πώς διακρίνετε τη σχιζοφρένεια από τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και από μια διαταραχή διάθεσης με ψυχωτικά συμπτώματα;	21
Q14	Τι γνωρίζουμε για τη νευροβιολογία της σχιζοφρένειας;	22
Q15	Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την πρόγνωση στη σχιζοφρένεια;	24
Q16	Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε τα αρνητικά συμπτώματα και τη γνωστική δυσλειτουργία στη σχιζοφρένεια;	25
Q17	Πώς αντιμετωπίζετε τη σχιζοφρένεια μακροχρόνια;	26
Q18	Πότε χαρακτηρίζετε τη σχιζοφρένεια ως θεραπευτικά ανθεκτική και τι πρέπει να αποκλείσετε πρώτα;	28
Q19	Μιλήστε μου για την κλοζαπίνη: ενδείξεις, κύριοι κίνδυνοι και παρακολούθηση.	30
Q20	Ποια είναι η κλινική εικόνα, η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής;	32
Q21	Πώς αντιμετωπίζετε ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο;	34
Q22	Τι κάνετε όταν η κατάθλιψη είναι ανθεκτική στη θεραπεία;	36
Q23	Πώς διαγιγνώσκετε τη διπολική διαταραχή και πώς τη διακρίνετε από σημαντικές εναλλακτικές διαγνώσεις;	38
Q24	Πώς αντιμετωπίζετε την οξεία μανία;	40
Q25	Πώς αντιμετωπίζετε τη διπολική κατάθλιψη;	42
Q26	Πώς αντιμετωπίζετε τη διπολική διαταραχή μακροχρόνια;	43
Q27	Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε την επιλόχεια ψύχωση;	45
Q28	Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή πανικού και την αγοραφοβία;	47
Q29	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή;	48
Q30	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή κοινωνικού άγχους;	49
Q31	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή;	50
Q32	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή μετατραυματικού στρες;	52
Q33	Πώς διακρίνετε την οξεία διαταραχή στρες από τη διαταραχή προσαρμογής;	53
Q34	Ποιες είναι οι κύριες διασχιστικές διαταραχές και πώς τις αξιολογείτε;	54

Q35	Πώς διακρίνετε τη διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων από τη διαταραχή άγχους ασθένειας;	56
Q36	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη λειτουργική νευρολογική διαταραχή;	58
Q37	Πώς αξιολογείτε και διατυπώνετε μια διαταραχή χρήσης ουσιών;	60
Q38	Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε το στερητικό σύνδρομο από αλκοόλ;	62
Q39	Πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης αλκοόλ μετά την αποτοξίνωση;	64
Q40	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης οπιοειδών;	66
Q41	Ποια ψυχιατρικά σύνδρομα που σχετίζονται με την κάνναβη πρέπει να αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης κάνναβης;	68
Q42	Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε διαταραχές που σχετίζονται με διεγερτικές ουσίες;	70
Q43	Πώς αντιμετωπίζετε την εξάρτηση και τη στέρηση από βενζοδιαζεπίνες;	72
Q44	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή τζόγου;	73
Q45	Πώς αναγνωρίζετε, αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε το ντελίριο;	75
Q46	Πώς αξιολογείτε έναν ασθενή με πιθανή άνοια;	77
Q47	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη νόσο Alzheimer;	79
Q48	Πώς διακρίνετε την άνοια με σωματίδια Lewy από την άνοια στη νόσο Parkinson;	81
Q49	Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε τη μετωποκροταφική άνοια;	83
Q50	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε την αγγειακή γνωστική διαταραχή / αγγειακή άνοια;	85
Q51	Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα της άνοιας;	87
Q52	Πώς προσεγγίζετε σοβαρή αυτοπαράμεληση ή διαβίωση σε ακραία ακαταστασία όταν ο ασθενής αρνείται βοήθεια;	89
Q53	Ποια σημεία σας κάνουν να υποψιαστείτε αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα σε ψυχιατρική παρουσίαση;	91
Q54	Ποιες είναι οι βασικές ψυχιατρικές εκδηλώσεις της επιληψίας και πώς τις προσεγγίζετε;	93
Q55	Ποιες είναι οι ψυχιατρικές συνέπειες της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης και πώς τις αντιμετωπίζετε;	95
Q56	Πώς προσεγγίζετε ψυχιατρική διασύνδεση σε νοσηλευόμενο ασθενή με σωματική νόσο;	97
Q57	Πώς διακρίνετε την απάθεια από την κατάθλιψη;	99
Q58	Πώς διακρίνετε το σύνδρομο Charles Bonnet από ψύχωση, ντελίριο και νευροεκφυλιστική νόσο;	100
Q59	Πώς διαγιγνώσκετε ΔΕΠΥ σε ενήλικα και ποιες είναι οι συχνές μιμητικές καταστάσεις;	102
Q60	Πώς αξιολογείτε πιθανό αυτισμό σε ενήλικα;	104
Q61	Πώς προσεγγίζετε νέα ψυχιατρικά ή συμπεριφορικά συμπτώματα σε ενήλικα με νοητική αναπηρία;	106
Q62	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη νευρική ανορεξία;	108
Q63	Πώς αντιμετωπίζετε ιατρικά επιβαρυνμένη νευρική ανορεξία;	110
Q64	Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη νευρογενή βουλιμία;	112
Q65	Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε τη χρόνια άπνεια;	114
Q66	Πώς αξιολογείτε υπερβολική ημερήσια υπνηλία και πιθανή ναρκοληψία;	116
Q67	Ποια είναι τα στάδια του ύπνου και τα βασικά ηλεκτροεγκεφαλογραφικά χαρακτηριστικά τους;	118
Q68	Πώς ταξινομείτε και διατυπώνετε τις διαταραχές προσωπικότητας;	119
Q69	Πώς αντιμετωπίζετε τη μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας;	121
Q70	Πώς διακρίνετε αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας από ψυχοπάθεια;	123

Q71	Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε σεξουαλική δυσλειτουργία;	125
Q72	Πότε ένα παραφιλικό ενδιαφέρον αποτελεί διαταραχή και πώς αξιολογείτε τον κίνδυνο;	127
Q73	Πώς προσεγγίζετε ενήλικα με δυσφορία φύλου ή ασυμφωνία φύλου;	129
Q74	Ποιες βασικές αρχές φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής πρέπει να γνωρίζει ο ψυχίατρος;	131
Q75	Ποιες σημαντικές αλληλεπιδράσεις ψυχοτρόπων πρέπει να γνωρίζετε;	133
Q76	Πώς επιλέγετε αντιψυχωσικό;	135
Q77	Ποιες είναι οι εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιψυχωσικών και πώς αντιμετωπίζονται;	136
Q78	Ποιες μεταβολικές, ενδοκρινικές και καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιψυχωσικών παρακολουθείτε;	138
Q79	Πώς επιλέγετε αντικαταθλιπτικό;	140
Q80	Ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, αλληλεπιδράσεις και αρχές switching/διακοπής αντικαταθλιπτικών πρέπει να γνωρίζετε;	141
Q81	Τι πρέπει να γνωρίζετε για το λίθιο;	143
Q82	Τι πρέπει να γνωρίζετε για το βαλπροϊκό;	145
Q83	Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη λαμοτριγίνη;	146
Q84	Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις βενζοδιαζεπίνες και τα υπνωτικά;	147
Q85	Πώς χρησιμοποιείτε φαρμακοθεραπεία στη ΔΕΠΥ ενηλίκων;	148
Q86	Ποιες είναι οι βασικές αρχές ψυχοφαρμακολογίας στην εγκυμοσύνη και την αναπαραγωγική περίοδο;	150
Q87	Πώς διακρίνετε το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο από το σύνδρομο σεροτονίνης;	152
Q88	Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε υπερδοσολογία τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών;	153
Q89	Ποιες είναι οι ενδείξεις, η διαδικασία και οι βασικές ανεπιθύμητες ενέργειες της ηλεκτροσπασμοθεραπείας;	155
Q90	Τι είναι η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία και πώς χρησιμοποιείται στην ψυχιατρική;	157
Q91	Τι είναι η μεταβίβαση και η αντιμεταβίβαση και γιατί έχουν κλινική σημασία;	158
Q92	Τι είναι η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία και πότε είναι χρήσιμη;	160
Q93	Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση και πώς βελτιώνει την ψυχιατρική θεραπεία;	161
Q94	Ποια μετωποϋποφλοιώδη και μεταιχμιακά κυκλώματα είναι πιο σημαντικά στην ψυχιατρική;	162
Q95	Ποιες είναι οι κύριες ντοπαμινεργικές οδοί και η κλινική τους σημασία;	163
Q96	Τι σημαίνουν η κληρονομικότητα, ο οικογενειακός κίνδυνος και ο πολυγονιδιακός κίνδυνος στην ψυχιατρική;	164
Q97	Τι σημαίνουν μικτά χαρακτηριστικά και ταχεία εναλλαγή στη διπολική διαταραχή και πώς επηρεάζουν την αντιμετώπιση;	165
Q98	Πότε η κατάθλιψη είναι ψυχωτική ή τόσο βαριά ώστε να αλλάζει άμεσα η αντιμετώπιση;	166
Q99	Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε υπερπρολακτιναιμία και σεξουαλικές ή ενδοκρινικές ανεπιθύμητες ενέργειες από αντιψυχωσικά;	168
Q100	Πότε θεωρείτε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ανθεκτική και πώς προχωράτε θεραπευτικά;	170

Πώς προσεγγίζετε έναν νέο ψυχιατρικό ασθενή και πώς οργανώνετε την αρχική εκτίμηση;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην πρώτη ψυχιατρική εκτίμηση ξεκινώ από το αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος ή ιατρικό επείγον και, αν όχι, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το κύριο ψυχιατρικό πρόβλημα, πώς εξελίχθηκε και τι χρειάζεται να γίνει άμεσα.

Πριν από το πλήρες ιστορικό ελέγχω αν υπάρχει κάτι που απαιτεί άμεση παρέμβαση: αυτοκαταστροφικός ή ετεροκαταστροφικός ιδεασμός ή συμπεριφορά, ψυχοκινητική διέγερση, αδυναμία αυτοφροντίδας, τοξίκωση ή στερητικό σύνδρομο, ντελίριο, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης ή άλλη ιατρική αστάθεια. Αν υπάρχει επείγον πρόβλημα, η ασφάλεια και η σωματική σταθεροποίηση προηγούνται ή γίνονται παράλληλα με την υπόλοιπη εκτίμηση.

Στη συνέχεια αποσαφηνίζω την αιτία προσέλευσης και το ιστορικό της παρούσας κατάστασης: έναρξη, διάρκεια, πορεία, διακυμάνσεις, βαρύτητα, πιθανούς εκλυτικούς παράγοντες και επίδραση στη λειτουργικότητα. Συμπληρώνω προηγούμενο ψυχιατρικό, ιατρικό και νευρολογικό ιστορικό, προηγούμενες νοσηλείες και θεραπείες, φαρμακευτική αγωγή, χρήση ουσιών, οικογενειακό ιστορικό και το αναπτυξιακό, κοινωνικό, επαγγελματικό και διαπροσωπικό ιστορικό. Δικαστικό ή ποινικό ιστορικό λαμβάνω όταν είναι σχετικό.

Παράλληλα, όπου χρειάζεται, παίρνω πληροφορίες από το περιβάλλον — συνήθως από την οικογένεια ή άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν τον ασθενή — ιδιαίτερα όταν υπάρχει μειωμένη εναισθησία, γνωστική διαταραχή, αμφιβολία για την αξιοπιστία του ιστορικού, μεταβολή της λειτουργικότητας ή ζήτημα κινδύνου.

Η εξέταση της ψυχικής κατάστασης περιλαμβάνει συστηματικά:

- εμφάνιση, επαφή, στάση και συμπεριφορά,
- ψυχοκινητική δραστηριότητα,
- ομιλία,
- διάθεση και συναίσθημα,
- μορφή και ροή της σκέψης και περιεχόμενο της σκέψης,
- αντίληψη,
- επίπεδο συνείδησης, προσοχή και συγκέντρωση, προσανατολισμό, μνήμη και λοιπές γνωστικές λειτουργίες,
- εναισθησία και κρίση.

Ακολουθεί η **σωματική και νευρολογική εξέταση**, ιδιαίτερα σε πρώτη εμφάνιση, άτυπη εικόνα, οξεία μεταβολή ή υποψία οργανικού αιτίου. Εργαστηριακός, τοξικολογικός ή απεικονιστικός έλεγχος γίνεται στοχευμένα, ανάλογα με το ιστορικό και τα ευρήματα.

Η **εκτίμηση κινδύνου** περιλαμβάνει αυτοκαταστροφικό ιδεασμό ή συμπεριφορά και αυτοκτονικότητα, ετεροκαταστροφικό ιδεασμό ή συμπεριφορά, προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμούς ή επεισόδια βίας, καθώς και πρόθεση,

σχέδιο, πρόσβαση σε μέσα, χρήση ουσιών, παρορμητικότητα και προστατευτικούς παράγοντες. Εκτιμώ επίσης, όπου είναι σχετικό, αυτοπαραμέληση και ευαλωτότητα. Αν τίθεται ζήτημα συναίνεσης ή άρνησης θεραπείας, εκτιμώ και την ικανότητα λήψης της συγκεκριμένης απόφασης.

Τέλος, συνθέτω τα δεδομένα σε λίστα προβλημάτων, διαφορική διάγνωση και βιοψυχοκοινωνική διατύπωση, με προδιαθεσικούς, εκλυτικούς, διαιωνιστικούς και προστατευτικούς παράγοντες, και από αυτά καταρτίζω το αρχικό σχέδιο αντιμετώπισης.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η διατύπωση με προδιαθεσικούς, εκλυτικούς, διαιωνιστικούς και προστατευτικούς παράγοντες είναι **οργανωτικό εργαλείο, όχι διαγνωστικό κριτήριο**.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς διακρίνετε ψευδαίσθηση από παραίσθηση και πότε υποψιάζεστε οργανικό ή ουσιοεπαγόμενο φαινόμενο;

Ψευδαίσθηση είναι αντιληπτική εμπειρία χωρίς αντίστοιχο εξωτερικό ερέθισμα· **παραίσθηση** είναι παραμορφωμένη ή λανθασμένη αντίληψη πραγματικού ερεθίσματος. Ρωτώ για αισθητηριακή τροπικότητα, σαφήνεια, εντόπιση στον εξωτερικό χώρο, χρόνο εμφάνισης, εκλυτικούς παράγοντες, επίπεδο συνείδησης, εναισθησία και συνοδά συμπτώματα. Οξεία έναρξη, διακύμανση προσοχής ή συνείδησης, αποπροσανατολισμός, διαταραχή ύπνου–εγρήγορσης και ιατρικός εκλυτικός παράγοντας στρέφουν προς ντελίριο. Για ουσίες και φάρμακα χρειάζεται πειστική χρονική σχέση· μια θετική τοξικολογική εξέταση δεν αποδεικνύει αιτιότητα. Ελέγχω επίσης σημαντική απώλεια όρασης ή ακοής.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι εννοείτε με τον όρο διαταραχή της μορφής της σκέψης;

Αφορά την οργάνωση και τη ροή της σκέψης όπως εκφράζεται στον λόγο. Περιγράφω, ανάλογα με την εικόνα, φυγή ιδεών ή επιτάχυνση, χαλάρωση συνειρμών/εκτροχιασμό, εφαπτομενικότητα, περιστασιακότητα, ανακοπή, εμμονική επανάληψη, ασυναρτησία και νεολογισμούς. Τη διακρίνω από το **περιεχόμενο** της σκέψης, όπου ανήκουν οι παραληρητικές ιδέες και οι ιδεοληψίες.

Πώς διακρίνετε μια παραληρητική ιδέα, μια υπερτιμημένη ιδέα και μια ιδεοληψία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διάκριση είναι κυρίως φαινομενολογική. Δεν αρκεί το περιεχόμενο μιας ιδέας· με ενδιαφέρει πώς τη βιώνει ο ασθενής, πόσο βέβαιος είναι, αν μπορεί να αμφιβάλλει, αν η σκέψη εισβάλλει ανεπιθύμητα ή υιοθετείται ως αληθινή και αν υπάρχει προσπάθεια αντίστασης.

Η **παραληρητική ιδέα** είναι μια σταθερή πεποίθηση που ο ασθενής υποστηρίζει με μεγάλη βεβαιότητα και η οποία δεν μεταβάλλεται εύκολα ακόμη και όταν υπάρχουν σαφή αντίθετα στοιχεία, ενώ δεν εξηγείται από το πολιτισμικό ή υποπολιτισμικό πλαίσιο του ατόμου. Το κρίσιμο είναι η μορφή και η ποιότητα της πεποίθησης, όχι αν το περιεχόμενό της είναι απλώς παράξενο ή λανθασμένο. Μια μη παράδοξη πεποίθηση μπορεί να είναι παραληρητική.

Η **υπερτιμημένη ιδέα** είναι μια έντονα υποστηριζόμενη και συναισθηματικά φορτισμένη πεποίθηση που αποκτά δυσανάλογα κεντρική θέση στη σκέψη και στη συμπεριφορά. Συνήθως είναι περισσότερο σύμφωνη με τον τρόπο που ο ασθενής αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον κόσμο, είναι ψυχολογικά κατανοητή σε σχέση με την προσωπικότητα, τις αξίες, το συναίσθημα ή το πλαίσιο ζωής του και είναι λιγότερο άκαμπτη και λιγότερο απρόσβλητη από αντίθετα στοιχεία από ό,τι μια παραληρητική ιδέα.

Η **ιδεοληψία** είναι επαναλαμβανόμενη, παρεισφρητική και ανεπιθύμητη σκέψη, εικόνα ή παρόρμηση που προκαλεί δυσφορία. Ο ασθενής συνήθως την αναγνωρίζει ως προερχόμενη από τον δικό του νου και προσπαθεί να της αντισταθεί, να την αγνοήσει ή να την εξουδετερώσει, συχνά μέσω καταναγκασμού για να μειώσει το άγχος ή να αποτρέψει ένα φοβούμενο αποτέλεσμα.

Η **εναισθησία** χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Μπορεί να είναι καλή, πτωχή ή και απύσχη. Επομένως η πτωχή εναισθησία δεν μετατρέπει αυτόματα μια ιδεοληψία σε παραληρητική ιδέα.

Στην κλινική συνέντευξη ρωτώ, για παράδειγμα, πόσο βέβαιος είναι ο ασθενής, αν θεωρεί πιθανό να κάνει λάθος, τι θα χρειαζόταν για να αλλάξει γνώμη, αν η σκέψη έρχεται παρά τη θέλησή του, αν προσπαθεί να της αντισταθεί και τι πιστεύει ότι θα συμβεί αν δεν ενεργήσει σύμφωνα με αυτήν. Έτσι ξεχωρίζω τη **σταθερά υιοθετημένη παραληρητική πεποίθηση**, την **κυρίαρχη αλλά ψυχολογικά κατανοητή υπερτιμημένη ιδέα** και την **παρεισφρητική ιδεοληψία**.

Όταν εμφανίζονται ψυχιατρικά συμπτώματα για πρώτη φορά, πότε πρέπει να υποψιαστείτε ιατρικό, νευρολογικό, φαρμακευτικό ή σχετιζόμενο με ουσίες αίτιο;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε κάθε πρώτη ψυχιατρική εκδήλωση εξετάζω αν μπορεί να υπάρχει **υποκείμενο ιατρικό ή νευρολογικό αίτιο ή επίδραση φαρμάκου ή ουσίας**. Η υποψία αυξάνεται όταν η έναρξη ή η πορεία είναι οξεία, υποξεία ή ασυνήθιστη, όταν υπάρχει γρήγορη επιδείνωση ή όταν συνοδά ευρήματα δεν ταιριάζουν με μια τυπική πρωτοπαθή ψυχιατρική διαταραχή.

Η **διαταραχή της προσοχής ή του επιπέδου συνείδησης, η γνωστική μεταβολή και η διακύμανση της εικόνας** αυξάνουν ιδιαίτερα την υποψία για ντελίριο, το οποίο αποτελεί ιατρικό επείγον. Αναζητώ επίσης αποπροσανατολισμό, διαταραχή του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης και οξεία μεταβολή από το προηγούμενο επίπεδο λειτουργίας.

Αναζητώ επίσης **εστιακά νευρολογικά ευρήματα ή επιληπτικές κρίσεις, παθολογικά ζωτικά σημεία, υποξία ή αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, πυρετό ή άλλα συστηματικά σημεία, καθώς και ταχεία γνωστική ή συμπεριφορική μεταβολή**. Κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενδοκρινικά ή μεταβολικά συμπτώματα και ασυνήθιστη ηλικία έναρξης επίσης αυξάνουν την υποψία. Η ηλικία από μόνη της, όμως, δεν αποτελεί διαγνωστικό κανόνα για οργανικό αίτιο.

Παίρνω αναλυτικό **ιστορικό φαρμάκων και ουσιών**: συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα, πρόσφατες αλλαγές δόσης ή διακοπές, χρήση ουσιών, τοξίκωση και στέρηση. Η χρονική σχέση είναι σημαντική, αλλά η απλή έκθεση σε ένα φάρμακο ή μια ουσία δεν αρκεί για να αποδώσω αιτιότητα.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει **σωματική και νευρολογική εξέταση** και στοχευμένο παρακλινικό έλεγχο ανάλογα με το ιστορικό και τα ευρήματα. Μπορεί να χρειαστεί έλεγχος για μεταβολική ή ενδοκρινική διαταραχή, λοίμωξη, επιληψία, νευρολογική νόσο, φαρμακευτική τοξικότητα ή χρήση ουσιών. Δεν υπάρχει ένα εξαντλητικό πακέτο εξετάσεων κατάλληλο για όλους.

Για να αποδώσω τα συμπτώματα σε ένα φάρμακο, ουσία ή ιατρική κατάσταση, θέλω **εύλογη χρονική σχέση, συμβατό κλινικό σύνδρομο και απουσία καλύτερης εναλλακτικής εξήγησης**. Ενισχύεται επίσης η αιτιολογική συσχέτιση όταν η εικόνα μεταβάλλεται με την αντιμετώπιση ή την απομάκρυνση του πιθανού αιτίου. Η ψυχιατρική φαινομενολογία από μόνη της συχνά δεν αρκεί για να ξεχωρίσει ένα πρωτοπαθές από ένα δευτεροπαθές σύνδρομο.

Πώς εκτιμάτε την αυτοκτονική πρόθεση και τον άμεσο κίνδυνο αυτοκτονίας;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εκτίμηση του αυτοκτονικού κινδύνου γίνεται με **άμεσες ερωτήσεις για την τρέχουσα αυτοκτονικότητα** και καταλήγει σε συνολική κλινική εκτίμηση του άμεσου κινδύνου και σε συγκεκριμένο πλάνο ασφάλειας. Δεν προσπαθώ να προβλέψω με βεβαιότητα αν ο ασθενής θα αυτοκτονήσει ούτε βασίζω την απόφαση σε μια συνολική βαθμολογία κινδύνου.

Ρωτώ για **σκέψεις θανάτου και αυτοκτονικό ιδεασμό**, πόσο συχνές και επίμονες είναι, πόσο δύσκολο είναι να τις ελέγξει και αν υπάρχει επιθυμία να πεθάνει. Στη συνέχεια διερευνώ χωριστά την **πρόθεση**: αν σκέφτεται πραγματικά να ενεργήσει, πόσο αποφασισμένος είναι και αν η πρόθεση μεταβάλλεται.

Ελέγχω αν υπάρχει **σχέδιο ή προπαρασκευή**: συγκεκριμένη μέθοδος, χρόνος ή τόπος, ενέργειες που έχουν ήδη γίνει, πρόσβαση στα αναγκαία μέσα, μέτρα για να μην γίνει αντιληπτός και πόσο θανατηφόρα θεωρεί ο ίδιος τη μέθοδο. Πρόσφατη πρόβα, απόπειρα ή συμπεριφορά που δείχνει προετοιμασία αυξάνει ιδιαίτερα την ανησυχία.

Παίρνω αναλυτικό ιστορικό **προηγούμενων αποπειρών αυτοκτονίας και μη αυτοκτονικού αυτοτραυματισμού**, διακρίνοντάς τα μεταξύ τους. Με ενδιαφέρουν η πρόθεση, η μέθοδος, οι συνθήκες, η διάσωση, τι συνέβη μετά και αν η σημερινή κρίση μοιάζει με προηγούμενα επεισόδια.

Παράλληλα εκτιμώ την τρέχουσα ψυχική κατάσταση: **απελπισία, κατάθλιψη, ψύχωση, έντονη διέγερση, παρορμητικότητα, αϋπνία, τοξίκωση ή στέρηση και προβληματική χρήση ουσιών**. Αναζητώ πρόσφατες απώλειες ή άλλους οξείς διαπροσωπικούς, οικονομικούς, νομικούς ή υγειονομικούς στρεσογόνους παράγοντες και εξετάζω αν υπάρχει σωματική βλάβη από αυτοτραυματισμό που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Ρωτώ επίσης για **λόγους για να ζει, σχέσεις και ευθύνες, μελλοντικά σχέδια, διαθέσιμη υποστήριξη και δυνατότητα συνεργασίας** με ένα εφαρμόσιμο πλάνο ασφάλειας. Οι προστατευτικοί παράγοντες συνεκτιμώνται, αλλά δεν αναιρούν σαφή πρόθεση, προπαρασκευή ή εύκολη πρόσβαση σε θανατηφόρα μέσα.

Τελικά διατυπώνω γιατί ο κίνδυνος είναι αυξημένος ή μειωμένος **τώρα**: ποιοι είναι οι χρόνιοι παράγοντες ευαλωτότητας, ποιοι δυναμικοί παράγοντες μπορούν να αλλάξουν και τι είναι πιθανό να αυξήσει ή να μειώσει τον κίνδυνο τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Από αυτή την εκτίμηση αποφασίζω το ασφαλές πλαίσιο φροντίδας, την ανάγκη νοσηλείας ή στενότερης παρακολούθησης, περιορίζω όσο είναι εφικτό την πρόσβαση σε φάρμακα, όπλα ή άλλα διαθέσιμα μέσα, αντιμετωπίζω την υποκείμενη διαταραχή, εμπλέκω υποστηρικτικά πρόσωπα όπου ενδείκνυται και οργανώνω σαφές πλάνο επανεκτίμησης και παρακολούθησης.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Κλίμακες και κατηγορίες «χαμηλού/μέτριου/υψηλού» κινδύνου δεν προβλέπουν ατομικά την αυτοκτονία και δεν πρέπει να αποφασίζουν το εξιτήριο.

Ένας ασθενής επέζησε από απόπειρα αυτοκτονίας. Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο επανάληψης;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η περίοδος μετά από απόπειρα αυτοκτονίας είναι περίοδος αυξημένου κινδύνου και χρειάζεται **έγκαιρη ψυχοκοινωνική εκτίμηση και οργανωμένη συνέχεια της φροντίδας**, πέρα από την αντιμετώπιση των άμεσων σωματικών συνεπειών.

Ανασυνθέτω την απόπειρα: τι προηγήθηκε, ποια ήταν η πρόθεση, πόσο σχεδιασμένη ήταν, ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε, αν υπήρχε προπαρασκευή ή προσπάθεια απόκρυψης, τι περίμενε ο ασθενής ότι θα συμβεί και ποια είναι η τρέχουσα αυτοκτονική πρόθεση. Εξετάζω επίσης την ψυχική κατάσταση, τη χρήση ουσιών, τις τρέχουσες πιέσεις, τα διαθέσιμα στηρίγματα, τα προστατευτικά στοιχεία και τις άμεσες ανάγκες ασφάλειας.

Αν υπάρχει **υποκείμενη ψυχιατρική διαταραχή ή διαταραχή χρήσης ουσιών**, την αντιμετωπίζω σύμφωνα με την ένδειξή της. Η φαρμακοθεραπεία στοχεύει την υποκείμενη διαταραχή ή άλλο συγκεκριμένο θεραπευτικό στόχο· δεν αποτελεί από μόνη της γενική παρέμβαση πρόληψης νέου αυτοτραυματισμού.

Καταρτίζω μαζί με τον ασθενή ένα **συνεργατικό πλάνο ασφάλειας**. Περιλαμβάνει προσωπικά προειδοποιητικά σημεία και εκλυτικούς παράγοντες, στρατηγικές που μπορεί να εφαρμόσει ο ίδιος, ανθρώπους ή χώρους που μπορούν να προσφέρουν στήριξη, επαφές για κρίση, συγκεκριμένα βήματα για το τι θα κάνει αν αυξηθεί ξανά η αυτοκτονική παρόρμηση και σχέδιο για περιορισμό της πρόσβασης σε μέσα. Το πλάνο πρέπει να είναι πρακτικό και προσβάσιμο στον ασθενή.

Παράλληλα μειώνω όσο γίνεται την **πρόσβαση στα μέσα** που σχετίζονται με την απόπειρα ή με ένα πιθανό μελλοντικό σχέδιο. Η παρέμβαση πρέπει να είναι συγκεκριμένη για τη μέθοδο, την πραγματική πρόσβαση και το περιβάλλον του ασθενούς.

Πριν από εξιτήριο ή μεταφορά φροντίδας πρέπει να είναι σαφές **ποιος αναλαμβάνει την παρακολούθηση, πότε θα γίνει η επόμενη επαφή και πώς θα επικοινωνήσουν οι υπηρεσίες**. Όταν εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια, οργανώνω πολύ έγκαιρη επαφή μετά το εξιτήριο, συνήθως εντός 48 ωρών.

Προσφέρω επίσης δομημένη, προσωποκεντρική ψυχολογική παρέμβαση προσαρμοσμένη στον αυτοτραυματισμό, συχνά γνωσιακής-συμπεριφορικής κατεύθυνσης.

Επανεκτιμώ συχνά τον κίνδυνο, γιατί η πρόθεση, οι στρεσογόνοι παράγοντες, η χρήση ουσιών, η πρόσβαση σε μέσα και η διαθέσιμη υποστήριξη μπορεί να αλλάξουν γρήγορα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Όταν παραμένουν ανησυχίες για την ασφάλεια, χρήσιμο σημείο αναφοράς είναι επαφή εντός 48 ωρών.
- CBT-ενημερωμένη παρέμβαση προσαρμοσμένη στον αυτοτραυματισμό: συχνά 4–10 συνεδρίες, ανάλογα με τις ανάγκες.

Πώς εκτιμάτε τον κίνδυνο βίας ή επιθετικότητας;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν αρκεί να χαρακτηρίσω έναν ασθενή γενικά ως «επικίνδυνο» ή «υψηλού κινδύνου». Θέλω να καταλάβω τι ακριβώς φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί, προς ποιον, πόσο άμεσα και κάτω από ποιες συνθήκες, και ποιοι παράγοντες μπορούν να αλλάξουν.

Παίρνω πρώτα αναλυτικό ιστορικό προηγούμενης βίας ή επιθετικότητας: τι συνέβη, ποια ήταν η σοβαρότητα, ποιος ήταν ο στόχος, ποιοι ήταν οι εκλυτικοί παράγοντες, αν υπήρχε χρήση ουσιών και τι βοήθησε να σταματήσει η κλιμάκωση. Η προηγούμενη βία είναι σημαντικό ιστορικό στοιχείο, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς.

Στην τρέχουσα εκτίμηση εξετάζω ψυχωτικά συμπτώματα που συνδέονται με απειλή ή φόβο, μανία, έντονη διέγερση, παρορμητικότητα, γνωστικές ή επικοινωνιακές δυσκολίες, τοξίκωση ή στέρηση, χρήση ουσιών, συνεργασία με τη θεραπεία και οξείς κοινωνικούς ή διαπροσωπικούς στρεσογόνους παράγοντες. Η ψυχιατρική διάγνωση από μόνη της δεν ισοδυναμεί με εκτίμηση βίας.

Ρωτώ άμεσα για απειλές και πρόθεση: αν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα ως στόχος, τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει ο ασθενής, αν υπάρχει σχέδιο ή προπαρασκευή, αν έχει πρόσβαση σε όπλα ή άλλα μέσα και αν υπάρχει χρονική εγγύτητα. Όταν υπάρχει αναγνωρίσιμο πιθανό θύμα, η προστασία του εντάσσεται στο σχέδιο διαχείρισης.

Εξετάζω επίσης το περιβάλλον και τους εκλυτικούς παράγοντες. Συνωστισμός, αντιλαμβανόμενη πρόκληση ή πρόσβαση σε ουσίες μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο. Ρωτώ επίσης τι έχει βοηθήσει στο παρελθόν, όπως ήρεμη επικοινωνία, περισσότερος προσωπικός χώρος, απομάκρυνση ενός ερεθίσματος ή έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση.

Διαχωρίζω τους στατικούς ή ιστορικούς από τους δυναμικούς και τροποποιήσιμους παράγοντες. Στο τέλος συνοψίζω τι αυξάνει τον κίνδυνο τώρα, τι μπορεί να τον μειώσει και τι πρέπει να γίνει άμεσα.

Η εκτίμηση πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένο σχέδιο: προειδοποιητικά σημεία, τρόποι αποκλιμάκωσης, επίπεδο παρακολούθησης, αντιμετώπιση ουσιών και οξέων συμπτωμάτων, προστασία πιθανών θυμάτων και σαφείς ενέργειες αν ο κίνδυνος αυξηθεί. Τεκμηριώνω το σκεπτικό και διαβιβάζω τις απαραίτητες πληροφορίες στην ομάδα που αναλαμβάνει τη φροντίδα.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- BVC και DASA-IV μπορούν να υποστηρίξουν βραχυπρόθεσμη ενδονοσοκομειακή εκτίμηση· δεν αντικαθιστούν την κλινική διατύπωση.

Πώς αντιμετωπίζετε τη σοβαρή διέγερση στα επείγοντα;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η σοβαρή διέγερση είναι **σύμπτωμα και επείγον πρόβλημα ασφάλειας, όχι διάγνωση**. Εκτιμώ ταυτόχρονα τον άμεσο κίνδυνο, τη σωματική κατάσταση και την πιθανή αιτία, ενώ οργανώνω το περιβάλλον ώστε να μειώσω την πιθανότητα κλιμάκωσης.

Ελέγχω αν ο ασθενής κινδυνεύει να τραυματίσει τον εαυτό του ή άλλους, αν υπάρχει επαρκές προσωπικό και ασφαλής χώρος και αν υπάρχουν σημεία **ιατρικής αστάθειας**. Αποκλείω ιδιαίτερα ντελίριο, τοξίκωση ή στέρηση και άλλα οξέα ιατρικά ή νευρολογικά αίτια, παράλληλα με μανία, ψύχωση και άλλες ψυχιατρικές αιτίες.

Όταν είναι ασφαλές, χρησιμοποιώ πρώτα **λεκτική και περιβαλλοντική αποκλιμάκωση**: ήρεμη, σαφή επικοινωνία, αποφυγή αντιπαράθεσης και πρόκλησης, μείωση των ερεθισμάτων, επαρκή προσωπικό χώρο και πιο ήσυχο περιβάλλον. Προσπαθώ να διατηρήσω όσο γίνεται την αξιοπρέπεια και την αίσθηση ελέγχου του ασθενούς.

Αν χρειαστεί περιοριστική παρέμβαση, χρησιμοποιώ το **λιγότερο περιοριστικό μέτρο που επαρκεί για την ασφάλεια και για τον συντομότερο αναγκαίο χρόνο**. Η παρέμβαση δεν χρησιμοποιείται ως τιμωρία ή ως υποκατάστατο της θεραπείας.

Αν ο ασθενής συνεργάζεται, προτιμώ **από του στόματος αγωγή**. Παρεντερική αγωγή χρησιμοποιώ όταν η διέγερση παραμένει επικίνδυνη και η από του στόματος αντιμετώπιση δεν είναι εφικτή ή επαρκής. Το ενδομυϊκό σχήμα επιλέγεται με βάση την πιθανή αιτία, τα φάρμακα που έχει ήδη λάβει, τις σωματικές συννοσηρότητες και το ισχύον τοπικό πρωτόκολλο.

Χορηγώ αρχικά **μία δόση** και δεν την επαναλαμβάνω πριν εκτιμήσω το αποτέλεσμά της. Μετά την παρεντερική αγωγή παρακολουθώ στενά το επίπεδο συνείδησης, την αναπνοή, τα ζωτικά σημεία και τις ανεπιθύμητες ενέργειες μέχρι ο ασθενής να είναι κλινικά σταθερός.

Όταν υποχωρήσει η κρίση, επανεκτιμώ την αιτία, τυχόν τραυματισμούς ή ανεπιθύμητες ενέργειες και τι προηγήθηκε της κλιμάκωσης. Καταγράφω τι βοήθησε στην αποκλιμάκωση και το ενσωματώνω στο επόμενο πλάνο διαχείρισης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ταχεία καταστολή ενηλίκων: **IM λοραζεπάμη ή IM αλοπεριδόλη + IM προμεθαζίνη**.
- Αν οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, δεν υπάρχει προηγούμενη έκθεση σε αντιψυχωσικά, υπάρχει QT/καρδιαγγειακή ανησυχία ή δεν υπάρχει ΗΚΓ, προτιμάται λοραζεπάμη.
- Μετά την ταχεία καταστολή: **τουλάχιστον ωριαία παρακολούθηση, και ανά 15 λεπτά** όταν ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

Πώς εκτιμάτε αν ένας ασθενής μπορεί να δώσει έγκυρη ενημερωμένη συναίνεση;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για να είναι έγκυρη η συναίνεση, ο ασθενής πρέπει να έχει λάβει **επαρκή και κατανοητή ενημέρωση**, να μπορεί να πάρει τη **συγκεκριμένη απόφαση** και να **συναινεί ελεύθερα και ειδικά** στη συγκεκριμένη πράξη.

Η ενημέρωση πρέπει να είναι σαφής και προσαρμοσμένη στον συγκεκριμένο ασθενή. Περιλαμβάνει την κατάσταση της υγείας του, τι ακριβώς προτείνεται, τα αναμενόμενα οφέλη, τους ουσιώδεις κινδύνους, τις εναλλακτικές επιλογές και τι μπορεί να συμβεί αν δεν γίνει η προτεινόμενη παρέμβαση.

Η **ικανότητα λήψης της απόφασης** εκτιμάται λειτουργικά, για τη συγκεκριμένη απόφαση και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ελέγχω αν ο ασθενής κατανοεί τι πρόβλημα υπάρχει και τι προτείνεται, αν αντιλαμβάνεται τι σημαίνουν οι πιθανές συνέπειες για τον ίδιο, αν μπορεί να συγκρίνει και να σταθμίσει τις διαθέσιμες επιλογές και αν μπορεί να εκφράσει μια ουσιαστική επιλογή. Η ύπαρξη ψυχιατρικής διάγνωσης, ψύχωσης, ακούσιας νοσηλείας ή διαφωνίας με τον γιατρό **δεν σημαίνει από μόνη της ανικανότητα**.

Η απόφαση πρέπει επίσης να είναι **ελεύθερη, χωρίς εξαναγκασμό ή παραπλάνηση**, και η συναίνεση πρέπει να αφορά τη συγκεκριμένη πράξη. Ο ασθενής μπορεί να την ανακαλέσει.

Αν ο ασθενής δεν μπορεί να δώσει έγκυρη συναίνεση, αναζητώ το πρόσωπο που έχει τη **νόμιμη αρμοδιότητα** να συναινέσει. Ακόμη και τότε, ενημερώνω τον ίδιο τον ασθενή όσο είναι εφικτό και τον εμπλέκω στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στη λήψη της απόφασης.

Για τους ανηλίκους, η συναίνεση παρέχεται από όσους ασκούν γονική μέριμνα ή επιμέλεια, ενώ η γνώμη του ανηλίκου λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με την ηλικία, την ωριμότητα και την κατανόησή του.

Σε πραγματικό **επείγον**, όταν η κατάλληλη συναίνεση δεν μπορεί να ληφθεί και η θεραπεία δεν μπορεί να αναβληθεί, μπορεί να γίνει η αναγκαία επείγουσα παρέμβαση. Η εξαίρεση αυτή δεν επιτρέπει γενικά την παράκαμψη μιας έγκυρης μη επείγουσας άρνησης.

Η **ακούσια νοσηλεία και η συναίνεση σε συγκεκριμένη θεραπεία είναι διαφορετικά νομικά ζητήματα**. Το γεγονός ότι ένας ασθενής νοσηλεύεται ακούσια δεν σημαίνει ότι έχει χάσει συνολικά την αυτονομία ή το δικαίωμα συμμετοχής στις θεραπευτικές αποφάσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ν. 3418/2005, άρθρα 11–12: ενημέρωση και συναίνεση.
- Το `understand–retain–use/weigh–communicate` είναι χρήσιμη κλινική γλώσσα, όχι θεσπισμένο ελληνικό νομικό τεστ.

- Υποκατάστατη συναίνεση: δικαστικός συμπαραστάτης αν υπάρχει· διαφορετικά ο Κώδικας αναφέρεται στους **οικείους** χωρίς ειδική ιεράρχηση.
- Η επείγουσα εξαίρεση καλύπτει ρητά και την **απόπειρα αυτοκτονίας**.

Πότε μπορεί ένας ασθενής να νοσηλευτεί ακούσια στην Ελλάδα και ποια είναι η διαδικασία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην Ελλάδα η ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία προβλέπεται κυρίως από τον Ν. 2071/1992, όπως έχει τροποποιηθεί. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές νόμιμες βάσεις, άρα η επικινδυνότητα δεν είναι το μοναδικό κριτήριο.

Στην **πρώτη οδό** πρέπει να συνυπάρχουν τρία στοιχεία: ο ασθενής έχει ψυχική διαταραχή, εξαιτίας της δεν είναι σε θέση να κρίνει το συμφέρον της υγείας του και, χωρίς νοσηλεία, είτε θα αποκλειόταν η θεραπεία είτε θα επιδεινωνόταν η κατάσταση της υγείας του.

Η **δεύτερη οδός** είναι εναλλακτική: υπάρχει ψυχική διαταραχή και η νοσηλεία είναι αναγκαία για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του ίδιου ή άλλων. Η κοινωνική, ηθική ή πολιτική μη συμμόρφωση από μόνη της δεν θεωρείται ψυχική διαταραχή.

Η διαδικασία κινείται από τα πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος και, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο πρόσωπο και υπάρχει επείγον, μπορεί να κινηθεί αυτεπαγγέλτως από τον **Εισαγγελέα Πρωτοδικών**. Κατά κανόνα απαιτούνται **δύο αιτιολογημένες γραπτές ιατρικές γνωματεύσεις** που να απαντούν στα νόμιμα κριτήρια.

Αν δεν είναι δυνατή η προηγούμενη εξέταση, για παράδειγμα επειδή ο ασθενής αρνείται να εξεταστεί, ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει μεταφορά σε δημόσια ψυχιατρική κλινική για εξέταση. Η παραμονή για τον σκοπό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις **48 ώρες**. Το 48ωρο αφορά τη διαδικαστική εξέταση και όχι τη συνολική διάρκεια της νοσηλείας.

Ακολουθεί **δικαστικός έλεγχος μέσα στις νόμιμες προθεσμίες**, με δικαίωμα του ασθενούς να ενημερωθεί, να παραπεμφθεί και να εκπροσωπηθεί. Η σημερινή πρωτοβάθμια δικαστική αρμοδιότητα είναι στο **Μονομελές Πρωτοδικείο**, παρά την παλαιότερη διατύπωση του νόμου που αναφέρεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Η ακούσια νοσηλεία διαρκεί μόνο όσο εξακολουθούν να πληρούνται τα νόμιμα κριτήρια και υπόκειται σε επανεξέταση. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με **υγειονομική ευθύνη και σεβασμό της αξιοπρέπειας**, με αστυνομική εμπλοκή μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Τέλος, η ακούσια νοσηλεία **δεν εξουσιοδοτεί αυτομάτως κάθε θεραπεία**. Η νόμιμη βάση της εισαγωγής και η συναίνεση σε συγκεκριμένη ιατρική πράξη εξετάζονται χωριστά.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 | 2 οδοί → 2 γνωματεύσεις → 48ωρο εξέτασης → εισαγγελέας → δικαστικές προθεσμίες → δικαιώματα/επανεξέταση/μεταφορά

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Γνωματεύσεις: συνήθως 2 ψυχίατροι ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, 1 ψυχίατρος + 1 ιατρός συναφούς ειδικότητας.
- Προθεσμίες: εξέταση έως 48 ώρες· εισαγγελίας προς δικαστήριο 3 ημέρες· δικαστήριο 10 ημέρες· κλήτευση ασθενούς ≥ 48 ώρες πριν.
- Σημερινό πρωτοβάθμιο δικαστήριο: **Μονομελές Πρωτοδικείο**.
- Συνήθης ανώτατη διάρκεια: 6 μήνες, με επανεξέταση μετά τους πρώτους 3 μήνες.
- Η μεταφορά είναι υγειονομικά καθοδηγούμενη· η αστυνομική εμπλοκή δεν είναι η προεπιλογή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΈΝΑΝΤΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η παλαιότερη διατύπωση αναφέρει **Πολυμελές Πρωτοδικείο**· σήμερα αρμόδιο είναι το **Μονομελές Πρωτοδικείο**. Το σχέδιο μεταρρύθμισης του 2019 δεν είναι ισχύον δίκαιο.

Πώς αναγνωρίζετε την κατατονία και πώς την αντιμετωπίζετε;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κατατονία είναι ψυχοκινητικό σύνδρομο που μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές ψυχιατρικές, νευρολογικές και άλλες ιατρικές καταστάσεις· δεν περιορίζεται στη σχιζοφρένεια.

Την υποψιάζομαι από χαρακτηριστικό συνδυασμό κινητικών, συμπεριφορικών και γλωσσικών σημείων. Διαγνωστικά απαιτούνται **τουλάχιστον 3 χαρακτηριστικά κατατονικά σημεία**. Η εικόνα μπορεί να είναι υποκινητική ή διεγερμένη, επομένως δεν περιμένω πάντοτε έναν ακίνητο και άλαλο ασθενή.

Χαρακτηριστικά φαινόμενα είναι, μεταξύ άλλων, **εμβροντησία, αλαλία, αρνητισμός, διατήρηση στάσης ή καταληψία, κηρώδης ευκαμψία, στερεοτυπίες, διέγερση, ηχολαλία και ηχοπραξία**. Η **Bush–Francis Catatonia Rating Scale (BFCRS)** μπορεί να βοηθήσει στη συστηματική εξέταση και την παρακολούθηση, αλλά δεν υποκαθιστά την κλινική διάγνωση και την αναζήτηση αιτίου.

Παράλληλα διερευνώ την **υποκείμενη αιτία**. Παίρνω πληροφορίες από το περιβάλλον όταν χρειάζεται, κάνω σωματική και νευρολογική εξέταση και οργανώνω στοχευμένο έλεγχο για ψυχιατρικές, νευρολογικές, μεταβολικές, λοιμώδεις, αυτοάνοσες, φαρμακευτικές και τοξικολογικές αιτίες ανάλογα με την εικόνα.

Η σωματική φροντίδα είναι μέρος της θεραπείας από την αρχή. Ελέγχω και αντιμετωπίζω **αφυδάτωση ή ανεπαρκή θρέψη, εισρόφηση, κατακλίσεις, επιπλοκές ακινησίας και θρομβοεμβολικό κίνδυνο**, καθώς και κάθε άλλη ιατρική επιπλοκή.

Οι βασικές θεραπείες είναι οι **βενζοδιαζεπίνες και η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT)**. Η λοραζεπάμη χρησιμοποιείται συχνά και μπορώ να κάνω **δοκιμασία λοραζεπάμης, συνήθως 1–2 mg ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκά**, με σύντομη κλινική επανεκτίμηση. Σαφής βελτίωση υποστηρίζει τη διάγνωση και την ανταπόκριση στη θεραπεία, αλλά η μη ανταπόκριση δεν αποκλείει την κατατονία.

Αν η κατατονία είναι σοβαρή, υπάρχει σημαντικός ιατρικός κίνδυνος ή δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στη λοραζεπάμη, προχωρώ έγκαιρα σε ECT.

Πυρετός, έντονη δυσκαμψία, αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος και συστηματική επιδείνωση θέτουν **κακοήθη κατατονία και κακοήθες νευροληπτικό σύνδρομο (NMS)** στη διαφορική. Πρόκειται για ιατρικό επείγον: παρέχω άμεση υποστηρικτική θεραπεία, διακόπτω ανταγωνιστές ντοπαμίνης όταν υπάρχει σχετική έκθεση και υποψία, χρησιμοποιώ λοραζεπάμη και, όταν πρόκειται για κακοήθη κατατονία με ανεπαρκή ανταπόκριση, δεν καθυστερώ την ECT.

Χρειάζεται επίσης ιδιαίτερη προσοχή με τα αντιψυχωσικά στην ενεργό κατατονία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πιθανότητα κακοήθους κατατονίας ή NMS.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

1 ≥ 3 σημεία → αίτιο/επιπλοκές → λοραζεπάμη → ECT → κακοήθης κατατονία/NMS

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Δοκιμασία λοραζεπάμης: 1–2 mg IV/IM ή 2 mg από του στόματος.
- Η BFCRS βοηθά στην εξέταση και παρακολούθηση· δεν αποτελεί τη διάγνωση.
- Κακοήθης κατατονία με ανεπαρκή ανταπόκριση στη λοραζεπάμη: ταχεία κλιμάκωση σε ECT, με 48–72 ώρες ως χρήσιμο σημείο αναφοράς.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι αλλάζει αν ο ασθενής έχει πυρετό, δυσκαμψία και αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος;

Πρόκειται για ιατρικό επείγον με διαφορεική μεταξύ κακοήθους κατατονίας και NMS. Αναζητώ πρόσφατη έκθεση σε ανταγωνιστές ντοπαμίνης ή διακοπή ντοπαμινεργικής αγωγής, ελέγχω άμεσα τις ιατρικές επιπλοκές και παρέχω υποστηρικτική θεραπεία. Αν υποψιάζομαι κακοήθη κατατονία, αποφεύγω ή διακόπτω ανταγωνιστές ντοπαμίνης, ξεκινώ λοραζεπάμη και δεν καθυστερώ την ECT αν η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής.

Ένας 23χρονος παρουσιάζει παρανοειδείς ιδέες, ακουστικές ψευδαισθήσεις και κοινωνική απόσυρση. Πώς θα προσεγγίζατε την περίπτωση;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα τον αντιμετωπίζα αρχικά ως πρώτο επεισόδιο ψύχωσης, χωρίς να θεωρήσω από την πρώτη συνέντευξη ότι έχει σχιζοφρένεια.

Ελέγχω πρώτα την **ασφάλεια και την ανάγκη επείγουσας παρέμβασης**: αυτοκτονικότητα ή κίνδυνο βίας, σοβαρή διέγερση ή αυτοπαραμέληση, κατατονία, ντελίριο, ουσίες και οποιαδήποτε ιατρική αστάθεια. Η ανάγκη νοσηλείας ή άλλου εντατικού πλαισίου κρίνεται από την κλινική κατάσταση και τον κίνδυνο, όχι μόνο από την παρουσία ψύχωσης.

Στη συνέχεια περιγράφω το **ψυχωτικό σύνδρομο και τη χρονική του πορεία**. Ρωτώ για έναρξη και εξέλιξη, παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, αποδιοργάνωση, αρνητικά συμπτώματα, κατατονικά φαινόμενα και συμπτώματα κατάθλιψης ή μανίας. Εκτιμώ την εναισθησία και τη λειτουργικότητα πριν και μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Πληροφορίες από την οικογένεια ή άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν τον ασθενή είναι συχνά πολύτιμες, ιδιαίτερα για την αλλαγή της συμπεριφοράς, τη λειτουργικότητα και την πραγματική διάρκεια των συμπτωμάτων.

Παίρνω αναλυτικό ιστορικό **ουσιών και φαρμάκων**, με ιδιαίτερη προσοχή σε χρονική σχέση της ψύχωσης με τοξίκωση, στέρηση ή έκθεση σε φάρμακο. Ένα θετικό τοξικολογικό αποτέλεσμα δεν αρκεί από μόνο του για να αποδείξει ότι η ψύχωση είναι ουσιοεπαγόμενη.

Κάνω σωματική και νευρολογική εξέταση και οργανώνω **στοχευμένο έλεγχο για δευτεροπαθή αίτια** ανάλογα με το ιστορικό και τα ευρήματα. Η νευροαπεικόνιση δεν γίνεται υποχρεωτικά σε κάθε ανεπίπλεκτο πρώτο επεισόδιο· την ζητώ όταν υπάρχουν νευρολογικά, άτυπα ή άλλα ανησυχητικά ευρήματα.

Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνω **σχιζοφρένεια και άλλες πρωτοπαθείς ψυχωτικές διαταραχές, διαταραχή διάθεσης με ψυχωτικά συμπτώματα ή σχιζοσυναισθηματική εικόνα, ουσιο- ή φαρμακοεπαγόμενη ψύχωση και ιατρικά ή νευρολογικά αίτια**. Η σχέση των ψυχωτικών συμπτωμάτων με επεισόδια διάθεσης και με ουσίες χρειάζεται διαχρονική παρακολούθηση.

Όπου υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία πρώιμης παρέμβασης στην ψύχωση, επιδιώκω **έγκαιρη σύνδεση χωρίς καθυστέρηση** και πολυεπιστημονική αξιολόγηση. Σε εγκατεστημένο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, η θεραπεία συνδυάζει συνήθως **από του στόματος αντιψυχωσικό** με ψυχολογική παρέμβαση και οικογενειακή παρέμβαση. Η επιλογή αντιψυχωσικού γίνεται από κοινού με τον ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη έκθεση, προτιμήσεις και προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών, ξεκινώντας συνήθως με χαμηλή δόση και τιτλοποιώντας ανάλογα με την ανταπόκριση και την ανοχή.

Η τελική διάγνωση παραμένει **διαχρονική**. Η εξέλιξη των συμπτωμάτων, η

λειτουργικότητα, η σχέση με τη διάθεση και τις ουσίες και η πορεία με τον χρόνο μπορεί να αλλάξουν τη διαγνωστική κατηγορία.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Αν κάνει βαριά χρήση κάνναβης, πότε θα σκεφτείτε ουσιοεπαγόμενη ψύχωση;

Χρειάζεται εύλογη χρονική σχέση με τη χρήση ή τη στέρηση και τα συμπτώματα να μην εξηγούνται απλώς από την οξεία τοξίκωση. Πρωτοπαθής ψυχωτική διαταραχή γίνεται πιθανότερη αν η ψύχωση προϋπήρχε της σχετικής έκθεσης, επιμένει για σημαντικό διάστημα μετά τη διακοπή ή υπήρχαν προηγούμενα ανεξάρτητα ψυχωτικά επεισόδια. Δεν χρησιμοποιώ ένα αυθαίρετο ενιαίο διάστημα αποχής ως απόλυτο κανόνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι αλλάζει αν η ψύχωση έχει άτυπη ή όψιμη έναρξη;

Χαμηλώνει το κατώφλι για δευτεροπαθές αίτιο. Αναζητώ ιδιαίτερα γνωστική ή συνειδησιακή μεταβολή, νευρολογικά σημεία ή κρίσεις, κινητικές/αυτόνομες διαταραχές, συστηματικά ή ενδοκρινικά συμπτώματα, φάρμακα/ουσίες και σημαντική αισθητηριακή έκπτωση. Κάνω σωματική και νευρολογική εξέταση και στοχευμένες εξετάσεις ή απεικόνιση ανάλογα με τα ευρήματα. Η ηλικία από μόνη της δεν αποδεικνύει οργανική αιτιολογία.

Περιγράψτε την κλινική εικόνα και τη διάγνωση της σχιζοφρένειας.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η **σχιζοφρένεια** είναι πρωτοπαθής ψυχωτική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχές της σκέψης, της αντίληψης και της συμπεριφοράς, με ποικίλους συνδυασμούς θετικών και αρνητικών συμπτωμάτων, αποδιοργάνωσης και γνωστικής δυσλειτουργίας. Η αιτιολογία της είναι **πολυπαραγοντική**, με αλληλεπίδραση γενετικών, νευροβιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η διάγνωση είναι κλινική και διαχρονική και βασίζεται στη συνολική κλινική εικόνα, στη διάρκεια και την πορεία της διαταραχής και στον αποκλεισμό άλλων αιτιών ψύχωσης.

Κλινικά, η εικόνα περιλαμβάνει **θετικά συμπτώματα**, **αρνητικά συμπτώματα**, **αποδιοργάνωση** και **γνωστική δυσλειτουργία**.

Στα **θετικά συμπτώματα** περιλαμβάνονται κυρίως οι παραληρητικές ιδέες και οι ψευδαισθήσεις. Οι ψευδαισθήσεις είναι συχνότερα ακουστικές, αλλά μπορούν να αφορούν και άλλες αισθητηριακές οδούς. Μπορεί επίσης να υπάρχουν διαταραχές της αίσθησης ελέγχου των σκέψεων ή των πράξεων του ασθενούς, όπως παρεμβολή, απόσυρση ή εκπομπή της σκέψης και εμπειρίες παθητικότητας ή εξωτερικού ελέγχου.

Η **αποδιοργάνωση** εκδηλώνεται κυρίως ως διαταραχή της μορφής και της ροής της σκέψης, η οποία γίνεται αντιληπτή στον λόγο, για παράδειγμα με χαλάρωση των συνειρμών, εκτροχιασμό ή ασυναρτησία. Μπορεί επίσης να υπάρχει έντονα αποδιοργανωμένη ή απρόσφορη συμπεριφορά.

Τα **αρνητικά συμπτώματα** περιλαμβάνουν τη μειωμένη συναισθηματική έκφραση, την αλογία, την αβουλία, την ανηδονία και τη μειωμένη κοινωνικότητα. Πριν τα θεωρήσω πρωτοπαθή αρνητικά συμπτώματα, πρέπει να αποκλείσω δευτεροπαθή αίτια, όπως κατάθλιψη, ενεργό ψύχωση, εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες, καταστολή, χρήση ουσιών ή περιβαλλοντική αποστέρηση.

Η **γνωστική δυσλειτουργία** είναι επίσης συχνή και μπορεί να αφορά την προσοχή, την εργαζόμενη μνήμη, τη μάθηση και τη μνήμη, τις εκτελεστικές λειτουργίες και την κοινωνική γνωσία. Επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργικότητα του ασθενούς, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της διαγνωστικό κριτήριο.

Μπορούν ακόμη να υπάρχουν **καταθλιπτικά ή μανιακά συμπτώματα**, καθώς και **ψυχοκινητικές ή κατατονικές εκδηλώσεις**. Στην οξεία φάση μπορεί να κυριαρχούν τα θετικά συμπτώματα και η αποδιοργάνωση, ενώ στη μακροχρόνια πορεία τα αρνητικά και γνωστικά συμπτώματα μπορεί να συμβάλλουν περισσότερο στη λειτουργική έκπτωση.

Για τη διάγνωση εξετάζω τη **διάρκεια**, την **πορεία** και τη **λειτουργικότητα** και δεν θεωρώ ότι ένα πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο ισοδυναμεί αυτόματα με σχιζοφρένεια.

Στο **DSM-5-TR** απαιτούνται τουλάχιστον δύο από πέντε βασικά συμπτώματα της ενεργού φάσης — παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, αποδιοργανωμένος λόγος,

έντονα αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά και αρνητικά συμπτώματα — και τουλάχιστον ένα από τα τρία πρώτα πρέπει να είναι παρόν. Απαιτούνται επίσης συνεχή σημεία της διαταραχής για συνολικά τουλάχιστον **έξι μήνες**, με ενεργό φάση περίπου ενός μήνα, καθώς και λειτουργική έκπτωση.

Στο **ICD-11** απαιτούνται τουλάχιστον δύο από επτά συμπτωματικά πεδία, με τουλάχιστον ένα από τα βασικά ψυχωτικά συμπτώματα, για τις περισσότερες ημέρες επί τουλάχιστον **έναν μήνα**. Το ICD-11 δεν απαιτεί το επιπλέον εξάμηνο συνολικής διάρκειας του DSM-5-TR.

Στη **διαφορική διάγνωση** πρέπει να αποκλείσω κυρίως διαταραχές διάθεσης με ψυχωτικά συμπτώματα, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, ουσιο- ή φαρμακοεπαγόμενη ψύχωση και ψύχωση οφειλόμενη σε ιατρική ή νευρολογική κατάσταση. Η χρονική σχέση των συναισθηματικών συμπτωμάτων με την ψύχωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάκριση.

Στα κλασικά **συμπτώματα πρώτης τάξης του Schneider** περιλαμβάνονται κυρίως φωνές που σχολιάζουν ή συζητούν μεταξύ τους, παρεμβολή, απόσυρση ή εκπομπή της σκέψης, φαινόμενα παθητικότητας ή εξωτερικού ελέγχου και παραληρητική αντίληψη. Αποτελούν χρήσιμη περιγραφή της ψυχοπαθολογίας, αλλά δεν είναι παθογνωμονικά και δεν αρκούν για τη διάγνωση της **σχιζοφρένειας**.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR:** 2/5 στην ενεργό φάση, με ≥ 1 από παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις ή αποδιοργανωμένο λόγο· συνολική διαταραχή ≥ 6 μήνες.
- **ICD-11:** 2/7 πεδία, με ≥ 1 βασικό ψυχωτικό πεδίο, τις περισσότερες ημέρες για ≥ 1 μήνα· χωρίς το επιπλέον DSM εξάμηνο.

Πώς διακρίνετε τη σχιζοφρένεια από τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και από μια διαταραχή διάθεσης με ψυχωτικά συμπτώματα;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διάκριση γίνεται κυρίως από τη **διαχρονική σχέση ανάμεσα στα ψυχωτικά συμπτώματα και στα επεισόδια διάθεσης**, όχι από το περιεχόμενο μιας παραληρητικής ιδέας ή μιας ψευδαίσθησης σε μία μόνο εξέταση.

Στη **σχιζοφρένεια** μπορεί να υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα διάθεσης, αλλά η ψυχωτική διαταραχή δεν περιορίζεται στα επεισόδια διάθεσης και η συνολική πορεία πληροί τα κριτήρια σχιζοφρένειας.

Σε **διαταραχή διάθεσης με ψυχωτικά συμπτώματα**, η ψύχωση εμφανίζεται στο πλαίσιο του επεισοδίου διάθεσης. Αν τα ψυχωτικά συμπτώματα εμφανίζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια καταθλιπτικού ή μανιακού επεισοδίου, αυτό ευνοεί διαταραχή διάθεσης με ψυχωτικά συμπτώματα και όχι σχιζοσυναισθηματική διαταραχή.

Στη **σχιζοσυναισθηματική διαταραχή** πρέπει να προσέξω ποιο διαγνωστικό σύστημα χρησιμοποιώ, γιατί DSM-5-TR και ICD-11 δεν θέτουν τα ίδια χρονικά κριτήρια.

Στο **DSM-5-TR**, χρειάζεται κάποια στιγμή στην πορεία να υπάρχουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες παραληρητικών ιδεών ή ψευδαισθήσεων χωρίς μείζον επεισόδιο διάθεσης, ενώ τα μείζονα επεισόδια διάθεσης πρέπει να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής διάρκειας της ενεργού και υπολειμματικής νόσου. Άρα το κλασικό «δύο εβδομάδες ψύχωσης χωρίς διάθεση» είναι DSM-specific στοιχείο.

Στο **ICD-11**, η λογική είναι περισσότερο επεισοδιακή: πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα οι πλήρεις απαιτήσεις για σχιζοφρένεια και για μέτριο ή σοβαρό καταθλιπτικό, μανιακό ή μικτό επεισόδιο, με τα ψυχωτικά και συναισθηματικά σύνδρομα να συνυπάρχουν στο ίδιο επεισόδιο, και η σύγχρονη εικόνα να διαρκεί τουλάχιστον **1 μήνα**. Δεν απαιτείται περίοδος ψύχωσης χωρίς συμπτώματα διάθεσης.

Χρειάζομαι λοιπόν λεπτομερές χρονολόγιο των ψυχωτικών και συναισθηματικών συμπτωμάτων, ιδανικά και πληροφορίες από το περιβάλλον, γιατί η διάγνωση συχνά ξεκαθαρίζει μόνο με την πορεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR:** ≥2 εβδομάδες ψύχωσης χωρίς μείζον επεισόδιο διάθεσης κάποια στιγμή + επεισόδια διάθεσης για την πλειονότητα της συνολικής νόσου.
- **ICD-11:** πλήρες σύνδρομο σχιζοφρένειας + μέτριο/σοβαρό επεισόδιο διάθεσης ταυτόχρονα για ≥1 μήνα· δεν απαιτείται ψύχωση χωρίς διάθεση.

Τι γνωρίζουμε για τη νευροβιολογία της σχιζοφρένειας;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η σχιζοφρένεια είναι **πολυγονιδιακή και βιολογικά ετερογενής**· δεν υπάρχει ένας μοναδικός μηχανισμός που να την εξηγεί. Γενετική ευαλωτότητα, νευροαναπτυξιακές διεργασίες και περιβαλλοντικές επιδράσεις αλληλεπιδρούν σε διαφορετικό βαθμό μεταξύ των ασθενών.

Η γενετική συμβολή είναι ισχυρή, αλλά δεν υπάρχει ένα «γονίδιο της σχιζοφρένειας». Τα σύγχρονα γενετικά δεδομένα δείχνουν πολύ μεγάλο αριθμό κοινών παραλλαγών μικρής επίδρασης μαζί με σπανιότερες παραλλαγές μεγαλύτερης επίδρασης. Η γενετική επιβάρυνση αυξάνει την πιθανότητα νόσησης χωρίς να είναι ούτε αναγκαία ούτε επαρκής από μόνη της.

Το **νευροαναπτυξιακό μοντέλο** αποτελεί χρήσιμο οργανωτικό πλαίσιο. Διαταραχές σε αναπτυξιακές και συναπτικές διεργασίες μπορεί να συμβάλλουν σε γνωστικές, κοινωνικές ή κινητικές δυσκολίες που σε ορισμένους ασθενείς προηγούνται της πρώτης ψύχωσης.

Επιδημιολογικά, αυξημένος κίνδυνος έχει συσχετιστεί με παράγοντες όπως η χρήση κάνναβης, η παιδική αντιξοότητα, ορισμένες μαιευτικές ή αναπτυξιακές εκθέσεις και κοινωνικοπεριβαλλοντικούς παράγοντες όπως η αστικοποίηση, η μετανάστευση ή η μειονοτική θέση. Πρόκειται για συσχετίσεις κινδύνου και όχι για ντετερμινιστικά αίτια σε έναν συγκεκριμένο ασθενή.

Ένα από τα πιο σταθερά βιολογικά ευρήματα είναι η **αυξημένη προσυναπτική ντοπαμινεργική λειτουργία στο ραβδωτό σώμα**, ιδιαίτερα σε σχέση με την ψύχωση και τα θετικά συμπτώματα. Αυτό στηρίζει τη σημασία της ντοπαμινεργικής σηματοδότησης, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια ανωμαλία ούτε ότι υπάρχει κλινικό τεστ ντοπαμίνης που διαγιγνώσκει σχιζοφρένεια.

Παράλληλα, οι υποθέσεις **δυσλειτουργίας του γλουταμινεργικού συστήματος και υπολειτουργίας των NMDA υποδοχέων** αποτελούν σημαντικά ερευνητικά μοντέλα, ιδίως επειδή μπορούν να συνδεθούν με ευρύτερα γνωστικά και αρνητικά συμπτώματα. Δεν είναι όμως σωστό να παρουσιάζονται ως ένα αποδεδειγμένο μοναδικό πρωτογενές αίτιο από το οποίο προκύπτει απλώς η ντοπαμίνη.

Απεικονιστικές μελέτες δείχνουν **ομαδικές διαφορές στη δομή, λειτουργία και συνδεσιμότητα εγκεφαλικών δικτύων**, αλλά με μεγάλη επικάλυψη μεταξύ ασθενών, υγιών ατόμων και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών. Ευρήματα που αφορούν GABAεργικούς ενδονευρώνες, σεροτονίνη και ανοσολογικές ή φλεγμονώδεις διεργασίες είναι επίσης ενδιαφέροντα, αλλά δεν αποτελούν ενιαία αποδεδειγμένη εξήγηση.

Κλινικά, το σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι **δεν διαθέτουμε σήμερα MRI, PET, γενετικό ή εργαστηριακό τεστ που να διαγιγνώσκει τη σχιζοφρένεια σε ένα άτομο**. Η διάγνωση παραμένει κλινική.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η αυξημένη προσυναπτική ντοπαμινεργική λειτουργία στο ραβδωτό σώμα είναι από τα πιο σταθερά ομαδικά ευρήματα.
- Δεν υπάρχει σήμερα ατομικός διαγνωστικός βιοδείκτης για τη σχιζοφρένεια.

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την πρόγνωση στη σχιζοφρένεια;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δυσμενέστερη πρόγνωση συνδέεται με κακή προνοσηρή και αρχική λειτουργικότητα, μεγαλύτερη διάρκεια αθεράπευτης ψύχωσης, επίμονα αρνητικά συμπτώματα και γνωστική δυσλειτουργία, κακή συμμόρφωση με τη θεραπεία, συχνές υποτροπές, προβληματική χρήση ουσιών και φτωχό ή συγκρουσιακό κοινωνικό περιβάλλον. Αντίστροφα, καλύτερη λειτουργικότητα, μικρότερη DUP, καλή συμμόρφωση και λιγότερες υποτροπές συνδέονται με ευνοϊκότερη πορεία.

Η κακή προνοσηρή λειτουργικότητα — κοινωνικά, επαγγελματικά και ως προς την αυτονομία — είναι δυσμενές στοιχείο. Το ίδιο ισχύει για μεγαλύτερη συνολική βαρύτητα της νόσου και ιστορικό επανειλημμένων υποτροπών ή νοσηλείων.

Η μεγάλη διάρκεια αθεράπευτης ψύχωσης, η DUP, συνδέεται με χειρότερη συμπτωματική και λειτουργική έκβαση. Είναι σημαντικός προγνωστικός δείκτης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελεί από μόνη της αποδεδειγμένη αιτία της κακής έκβασης.

Τα επίμονα αρνητικά συμπτώματα και η γνωστική δυσλειτουργία συνδέονται ιδιαίτερα με κακή λειτουργική έκβαση. Μπορεί δηλαδή να υποχωρήσουν οι παραληρητικές ιδέες και οι ψευδαισθήσεις, αλλά ο ασθενής να εξακολουθεί να δυσκολεύεται σημαντικά στην εργασία, στις σχέσεις και στην αυτονομία.

Επίσης δυσμενείς παράγοντες είναι η **κακή συμμόρφωση με τη θεραπεία, η διακοπή της αγωγής, οι επαναλαμβανόμενες υποτροπές και η προβληματική χρήση ουσιών**. Αντίθετα, η σταθερή θεραπευτική παρακολούθηση και η πρόληψη των υποτροπών βελτιώνουν την πιθανότητα καλής έκβασης.

Στο οικογενειακό περιβάλλον, το **υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα** συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής. Η κοινωνική απομόνωση και η περιβαλλοντική στέρηση μπορούν επίσης να επιβαρύνουν τη λειτουργικότητα.

Τέλος, η υποχώρηση της ψύχωσης **δεν σημαίνει απαραίτητα λειτουργική ανάρρωση**. Η πορεία είναι πολύ διαφορετική από ασθενή σε ασθενή και κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν προβλέπει μόνος του την ατομική πορεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα** συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής.
- **Η σχιζοφρένεια** συνδέεται πληθυσμιακά με περίπου **15–20 χρόνια πρόωρης θνησιμότητας**· δεν είναι ατομική πρόβλεψη.

Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε τα αρνητικά συμπτώματα και τη γνωστική δυσλειτουργία στη σχιζοφρένεια;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα αρνητικά συμπτώματα αναζητώ κυρίως **άμβλυνση του συναισθήματος, αλογία, αβουλία, ανηδονία και κοινωνική απόσυρση**. Το κρίσιμο είναι να μην τα θεωρήσω εξαρχής πρωτοπαθή συμπτώματα της σχιζοφρένειας.

Πριν τα χαρακτηρίσω πρωτοπαθή ή επίμονα, ελέγχω αν εξηγούνται από **υπολειμματική ή ενεργό ψύχωση, κατάθλιψη, εξωπυραμιδικά συμπτώματα ή παρκινσονισμό, καταστολή ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες της αγωγής, χρήση ουσιών, γνωστική δυσλειτουργία ή περιβαλλοντική στέρηση**. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική γιατί πολλά από αυτά είναι τροποποιήσιμα.

Πρωτό ποτε άρχισαν τα συμπτώματα, πώς εξελίχθηκαν σε σχέση με την ψύχωση και τη θεραπεία και πόσο επηρεάζουν **εργασία ή σπουδές, κοινωνικές σχέσεις, αυτοφροντίδα και αυτονομία**. Πληροφορίες από την οικογένεια ή άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τον ασθενή βοηθούν ιδιαίτερα όταν η πρωτοβουλία, η δραστηριότητα ή η κοινωνική λειτουργικότητα έχουν αλλάξει σταδιακά.

Παράλληλα εκτιμώ τη **γνωστική λειτουργία**, γιατί η γνωστική δυσλειτουργία είναι συχνή και μπορεί να επηρεάζει έντονα τη λειτουργικότητα ακόμη και όταν τα θετικά συμπτώματα έχουν υποχωρήσει. Με ενδιαφέρουν κυρίως η ταχύτητα επεξεργασίας, η προσοχή, η εργαζόμενη μνήμη, η μάθηση και μνήμη, η επίλυση προβλημάτων και η κοινωνική νόηση. Δεν χρησιμοποιώ όμως τη γνωστική δυσλειτουργία ως διαγνωστικό κριτήριο για τη σχιζοφρένεια.

Αν τα αρνητικά συμπτώματα είναι **δευτεροπαθή**, αντιμετωπίζω το αντίστοιχο αίτιο: ελέγχω καλύτερα την υπολειμματική ψύχωση, θεραπεύω την κατάθλιψη όταν υπάρχει, μειώνω εξωπυραμιδικές ή κατασταλτικές ανεπιθύμητες ενέργειες όπου είναι δυνατόν, αντιμετωπίζω τη χρήση ουσιών και προσπαθώ να μειώσω την κοινωνική απομόνωση και την περιβαλλοντική στέρηση.

Αν παραμένουν **πρωτοπαθή αρνητικά συμπτώματα ή γνωστική δυσλειτουργία**, δεν αυξάνω απλώς τη δόση του αντιψυχωσικού. Η επίδραση των αντιψυχωσικών σε αυτά τα πεδία είναι περιορισμένη και ετερογενής. Δίνω έμφαση στην ψυχοκοινωνική και λειτουργική αποκατάσταση, σε δομημένη δραστηριότητα, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και, ειδικά για τη γνωστική δυσλειτουργία, σε **γνωστική αποκατάσταση**. Δεν υπάρχει καθιερωμένη φαρμακευτική θεραπεία ρουτίνας που να διορθώνει ειδικά τη γνωστική δυσλειτουργία της σχιζοφρένειας.

Η επιμονή αρνητικών ή γνωστικών συμπτωμάτων **δεν σημαίνει από μόνη της θεραπευτικά ανθεκτική σχιζοφρένεια**. Πρέπει πρώτα να είμαι βέβαιος τι ακριβώς παραμένει, ποια είναι η αιτία του και ποιο λειτουργικό πρόβλημα χρειάζεται παρέμβαση.

Πώς αντιμετωπίζετε τη σχιζοφρένεια μακροχρόνια;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μακροχρόνια αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας στοχεύει ταυτόχρονα στην πρόληψη υποτροπών, στη λειτουργική ανάρρωση, στη σωματική υγεία και στους προσωπικούς στόχους του ασθενούς. Χρειάζεται κοινό σχέδιο που να περιλαμβάνει αναγνώριση πρώιμων σημείων υποτροπής, συμμόρφωση, χρήση ουσιών, αυτοκτονικότητα, λειτουργικότητα, ανάγκες οικογένειας ή φροντιστών και στόχους κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.

Μετά από καλή ανταπόκριση συνεχίζω το αποτελεσματικό αντιψυχωσικό ως **θεραπεία συντήρησης**, στη χαμηλότερη αποτελεσματική και ανεκτή δόση. Δεν χρησιμοποιώ ρουτίνα διαλείπουσα θεραπεία μόνο όταν εμφανίζονται συμπτώματα, γιατί αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής.

Η διάρκεια της θεραπείας δεν είναι ίδια για όλους. Μετά από πρώτο επεισόδιο, ο WHO δίνει ως ελάχιστο σύγχρονο σημείο αναφοράς **7–12 μήνες θεραπείας μετά την ύφεση**, ενώ το NICE τονίζει ότι ο κίνδυνος υποτροπής είναι υψηλός αν η αγωγή διακοπεί μέσα στα πρώτα **1–2 χρόνια**. Αυτά τα δεδομένα συζητούνται με τον ασθενή και δεν μετατρέπονται σε ένα άκαμπτο καθολικό χρονικό όριο. Σε υποτροπιάζουσα νόσο συνήθως χρειάζεται πιο μακρόχρονη θεραπεία, ανάλογα με τον αριθμό και τη βαρύτητα των επεισοδίων, τις συνέπειες των υποτροπών, τα υπολειμματικά συμπτώματα, τη συμμόρφωση, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την προτίμηση του ασθενούς.

Αν αποφασιστεί διακοπή, γίνεται **σταδιακά και με στενή παρακολούθηση**. Το NICE προτείνει παρακολούθηση για τουλάχιστον **2 χρόνια μετά τη διακοπή**, λόγω του κινδύνου υποτροπής.

Τα **μακράς δράσης ενέσιμα αντιψυχωσικά (long-acting injectable antipsychotics, LAIs)** συζητούνται τόσο όταν ο ασθενής τα προτιμά όσο και όταν η αβέβαιη ή πτωχή συμμόρφωση αποτελεί σημαντικό κλινικό ζήτημα. Δεν τα παρουσιάζω μόνο ως μέσο «επιβολής» θεραπείας. Οι κανόνες έναρξης και η ανάγκη από του στόματος επικάλυψης εξαρτώνται από το συγκεκριμένο προϊόν.

Η μακροχρόνια φροντίδα περιλαμβάνει συστηματική **σωματική και μεταβολική παρακολούθηση**: βάρος, περίμετρο μέσης, αρτηριακή πίεση και σφυγμό, γλυκόζη ή HbA1c, λιπίδια, προλακτίνη και κινητικές ανεπιθύμητες ενέργειες, μαζί με τη γενικότερη σωματική υγεία. ΗΚΓ γίνεται όταν υπάρχει κλινική ή φαρμακευτική ένδειξη.

Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις είναι βασικό μέρος της θεραπείας: **CBT για ψύχωση, οικογενειακή παρέμβαση και ψυχοεκπαίδευση, συντονισμένη φροντίδα, επαγγελματική αποκατάσταση και υποστηριζόμενη εργασία** όπου είναι διαθέσιμες. Στόχος δεν είναι μόνο η μείωση συμπτωμάτων αλλά η κοινωνική και λειτουργική επανένταξη.

Σε επίμονη απόσυρση ή αδράνεια δεν θεωρώ αυτόματα ότι πρόκειται για

«ανθεκτικά αρνητικά συμπτώματα». Αποκλείω υπολειμματική ψύχωση, κατάθλιψη, εξωπυραμιδισμό ή παρκινσονισμό, καταστολή και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, χρήση ουσιών, γνωστική δυσλειτουργία και περιβαλλοντική στέρηση. Η γνωστική έκπτωση είναι κλινικά σημαντική, αλλά δεν υπάρχει καθιερωμένη ρουτίνα φαρμακευτικής θεραπείας που να τη διορθώνει ειδικά· η αποκατάσταση και η λειτουργική υποστήριξη έχουν ουσιαστικό ρόλο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- WHO μετά από πρώτο επεισόδιο: 7–12 μήνες μετά την ύφεση ως ελάχιστο σημείο αναφοράς.
- NICE: υψηλός κίνδυνος υποτροπής αν διακοπεί η αγωγή στα πρώτα 1–2 χρόνια.
- Μετά τη διακοπή: παρακολούθηση για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Πότε χαρακτηρίζετε τη σχιζοφρένεια ως θεραπευτικά ανθεκτική και τι πρέπει να αποκλείσετε πρώτα;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μιλάμε για θεραπευτικά ανθεκτική σχιζοφρένεια όταν παραμένουν κλινικά σημαντικά συμπτώματα παρά τουλάχιστον δύο επαρκείς δοκιμές αντιψυχωσικών, αφού πρώτα αποκλειστεί η ψευδοανθεκτικότητα.

Πριν δεχθώ ότι υπάρχει ανθεκτικότητα, ξεκαθαρίζω ποιο είναι το πραγματικό **σύμπτωμα-στόχος**. Επανεξετάζω τη διάγνωση και διακρίνω επίμονα θετικά ψυχωτικά συμπτώματα από πρωτογενή ή δευτερογενή αρνητικά συμπτώματα, γνωστική δυσλειτουργία, κατάθλιψη ή άλλη συννοσηρότητα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστεί «ανθεκτική ψύχωση» ένα πρόβλημα που δεν αναμένεται να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερη αντιψυχωσική έκθεση.

Οι προηγούμενες δοκιμές πρέπει να ήταν **πραγματικά επαρκείς**. Ως χρήσιμο λειτουργικό σημείο αναφοράς, το **Treatment Response and Resistance in Psychosis (TRRIP)** χρησιμοποιεί τουλάχιστον **6 εβδομάδες σε θεραπευτική δόση για κάθε αντιψυχωσικό**, με επαρκή τεκμηρίωση της έκθεσης. Τα ισοδύναμα χλωροπρομαζίνης είναι χρήσιμο σημείο αναφοράς και όχι καθολικός υποχρεωτικός δοσολογικός στόχος.

Χρειάζεται να ξεχωρίζω το λειτουργικό πλαίσιο TRRIP από τη συγκεκριμένη διαδρομή του NICE προς την κλοζαπίνη. Το TRRIP δεν απαιτεί το ένα από τα δύο φάρμακα να είναι αντιψυχωσικό δεύτερης γενιάς. Το NICE, αντίθετα, αναφέρεται σε αποτυχία δύο διαφορετικών αντιψυχωσικών, από τα οποία τουλάχιστον το ένα είναι **μη κλοζαπινικό αντιψυχωσικό δεύτερης γενιάς**.

Η **συμμόρφωση και η πραγματική έκθεση** στην αγωγή είναι κρίσιμες. Μη λήψη ή ασυνεπής λήψη είναι συχνή αιτία ψευδοανθεκτικότητας. Ελέγχω συνταγογραφικό και κλινικό ιστορικό και, όταν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα και είναι εφικτό, μπορεί να βοηθήσει μέτρηση επιπέδων ή μια περίοδος θεραπείας με μακράς δράσης ενέσιμο ή άμεσα παρατηρούμενη λήψη. Αυτά μειώνουν την αβεβαιότητα, αλλά δεν αποτελούν καθολικές ρυθμιστικές προϋποθέσεις για τη διάγνωση.

Ελέγχω επίσης **δόση, διάρκεια, φαρμακοκινητικούς παράγοντες και αλληλεπιδράσεις**, χρήση ουσιών και σχετική ιατρική νόσο. Παράλληλα αξιολογώ αν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς οι ψυχοκοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες και αν ο ασθενής έχει λάβει κατάλληλη ψυχοκοινωνική θεραπεία.

Όταν τεκμηριωθεί γνήσια θεραπευτικά ανθεκτική σχιζοφρένεια μετά από δύο επαρκείς αποτυχίες, η **κλοζαπίνη πρέπει να προσφερθεί χωρίς άσκοπη καθυστέρηση**. Δεν είναι σωστό να συνεχίζονται διαδοχικά πολλά μη κλοζαπινικά αντιψυχωσικά μόνο για να αναβληθεί η κλοζαπίνη.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 | στόχος → 2 επαρκείς δοκιμές → ≥6 εβδομάδες/έκθεση → ψευδοανθεκτικότητα → κλοζαπίνη

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- TRRIP: **≥6 εβδομάδες** σε θεραπευτική δόση για κάθε δοκιμή.
- TRRIP **δεν απαιτεί SGA**· η NICE διαδρομή προς κλοζαπίνη απαιτεί τουλάχιστον ένα μη κλοζαπινικό SGA.

Μιλήστε μου για την κλοζαπίνη: ενδείξεις, κύριοι κίνδυνοι και παρακολούθηση.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κλοζαπίνη είναι άτυπο αντιψυχωσικό με ιδιαίτερο υποδοχικό προφίλ. Έχει σχετικά ασθενέστερη δράση στους D2 υποδοχείς και δράση σε ντοπαμινεργικούς, σεροτονινεργικούς, μυσκαρινικούς, ισταμινεργικούς και αδρενεργικούς υποδοχείς. Ο ακριβής μηχανισμός που εξηγεί την ιδιαίτερη αποτελεσματικότητά της, ιδίως στην ανθεκτική σχιζοφρένεια, δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος.

Η βασική ένδειξη είναι η ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια, δηλαδή ανεπαρκής ανταπόκριση παρά δύο επαρκείς δοκιμές αντιψυχωσικών, αφού αποκλειστεί ψευδοαντοχή, όπως ανεπαρκής συμμόρφωση, ανεπαρκής δόση ή διάρκεια θεραπείας και χρήση ουσιών. Έχει επίσης ιδιαίτερη θέση σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και επίμονο σημαντικό αυτοκτονικό κίνδυνο και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, σοβαρή επίμονη επιθετικότητα.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι:

- ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιμία,
- μυοκαρδίτιδα και μυοκαρδιοπάθεια,
- γαστρεντερική υποκινητικότητα, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή δυσκοιλιότητα, κοπρόσταση ή ειλεό,
- σπασμοί,
- μεταβολικές ανεπιθύμητες ενέργειες,
- και επίσης καταστολή, υπερσιελόρροια, ταχυκαρδία και ορθοστατική υπόταση.

Πριν από την έναρξη κάνω βασική κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση, με ιδιαίτερη έμφαση στον απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων, ANC, στο βάρος και τις μεταβολικές παραμέτρους, στην αρτηριακή πίεση και τις σφύξεις, στο καρδιακό ιστορικό, στα συγχωρηγούμενα φάρμακα και στο κάπνισμα.

Για την αιματολογική παρακολούθηση, η έναρξη απαιτεί ANC τουλάχιστον $1,5 \times 10^9/L$ στον γενικό πληθυσμό ή $1,0 \times 10^9/L$ σε επιβεβαιωμένη Duffy-null ουδετεροπενία. Στη συνέχεια ο ANC ελέγχεται:

- εβδομαδιαία για τις πρώτες 18 εβδομάδες,
- μηνιαία μέχρι το τέλος του πρώτου έτους,
- ανά 12 εβδομάδες μετά τον πρώτο χρόνο, εφόσον δεν έχει εμφανιστεί ουδετεροπενία,
- και ετησίως μετά τα δύο έτη, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ουδετεροπενία.

ANC κάτω από $1,0 \times 10^9/L$ στον γενικό πληθυσμό αποτελεί όριο διακοπής, ενώ σε επιβεβαιωμένη Duffy-null ουδετεροπενία το αντίστοιχο όριο είναι $0,5 \times 10^9/L$. Πυρετός ή άλλα συμπτώματα λοίμωξης απαιτούν άμεση κλινική εκτίμηση και έλεγχο ANC.

Για τη μυοκαρδίτιδα χρειάζεται ιδιαίτερη επαγρύπνηση στην αρχή της θεραπείας. Επίμονη ανεξήγητη ταχυκαρδία, θωρακικό άλγος, δύσπνοια, γριπώδη συμπτώματα

ή σημεία καρδιακής ανεπάρκειας απαιτούν άμεση διερεύνηση. Σε αρκετά πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται CRP και τροπονίνη κατά τον πρώτο μήνα.

Παρακολουθώ επίσης ενεργά τη λειτουργία του εντέρου, καθώς η γαστρεντερική υποκινητικότητα μπορεί να γίνει σοβαρή ή και απειλητική για τη ζωή. Παράλληλα παρακολουθώ βάρος, γλυκόζη, λιπίδια, αρτηριακή πίεση και τις υπόλοιπες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η φαρμακοκινητική της κλοζαπίνης έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Μεταβολίζεται κυρίως μέσω του CYP1A2. Το κάπνισμα επάγει το CYP1A2, επομένως η απότομη διακοπή του καπνίσματος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα κλοζαπίνης. Αντίστοιχα, σοβαρή λοίμωξη ή φλεγμονή μπορεί να μειώσει τον μεταβολισμό της και να προκαλέσει τοξικότητα.

Η μέτρηση επιπέδων κλοζαπίνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ανεπαρκή ανταπόκριση, υποψία μη συμμόρφωσης ή τοξικότητας, αλλαγή στο κάπνισμα, αλληλεπιδράσεις και σοβαρή λοίμωξη. Προδόση συγκέντρωση περίπου 350 ng/mL ή περισσότερο αποτελεί χρήσιμο σημείο αναφοράς επαρκούς έκθεσης πριν θεωρήσω ότι υπάρχει πραγματική μη ανταπόκριση.

Αν η κλοζαπίνη έχει διακοπεί για πάνω από 48 ώρες, δεν επαναφέρω την προηγούμενη δόση. Ξεκινώ ξανά με 12,5 mg μία ή δύο φορές την πρώτη ημέρα και επανατιτλοποιώ, κυρίως λόγω του κινδύνου σοβαρής υπότασης.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 ένδειξη → ANC → μυοκαρδίτιδα/έντερο → κάπνισμα/λοίμωξη/TDM → >48ωρη διακοπή

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- ANC έναρξης: $\geq 1,5 \times 10^9/L$. Duffy-null $\geq 1,0 \times 10^9/L$. Διακοπή: $<1,0$ και $<0,5 \times 10^9/L$ αντίστοιχα.
- ANC: εβδομαδιαία 18 εβδομάδες → μηνιαία έως 1 έτος → ανά 12 εβδομάδες → ετησίως μετά τα 2 έτη, εφόσον δεν έχει υπάρξει ουδετεροπενία.
- Πριν χαρακτηριστεί μη ανταπόκριση: προδόση συγκέντρωση περίπου ≥ 350 ng/mL ως χρήσιμο σημείο επαρκούς έκθεσης.
- Διακοπή >48 ωρών: επανέναρξη 12,5 mg μία ή δύο φορές την πρώτη ημέρα και επανατιτλοποίηση.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πνευμονία και απότομη διακοπή καπνίσματος: τι αλλάζει;

Και τα δύο μπορούν να αυξήσουν απότομα την έκθεση στην κλοζαπίνη: η φλεγμονή καταστέλλει το CYP1A2 και η διακοπή καπνίσματος αφαιρεί την επαγωγή του. Αναζητώ τοξικότητα, αντιμετωπίζω τη λοίμωξη, ελέγχω ANC και επίπεδο κλοζαπίνης όταν είναι δυνατό, ανασκοπώ αλληλεπιδράσεις και μειώνω ή διακόπτω προσωρινά την κλοζαπίνη ανάλογα με τη βαρύτητα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΉΝΑΝΤΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η αναθεώρηση του 2025 αντικατέστησε το παλαιότερο ευρωπαϊκό σχήμα WBC+ANC και δια βίου μηνιαίας παρακολούθησης με το νεότερο πρόγραμμα ANC.

Ποια είναι η κλινική εικόνα, η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κλινική εικόνα της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής χαρακτηρίζεται κυρίως από επίμονη καταθλιπτική διάθεση και/ή σημαντική απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης, με συνοδά γνωστικά, βιολογικά και ψυχοκινητικά συμπτώματα και έκπτωση της λειτουργικότητας.

Στο **συναίσθημα** κυριαρχούν η καταθλιπτική διάθεση και η ανηδονία. Μπορεί επίσης να υπάρχουν άγχος, ευερεθιστότητα ή μειωμένη συναισθηματική αντιδραστικότητα.

Στη **γνωστική λειτουργία** μπορεί να παρατηρούνται μειωμένη προσοχή και συγκέντρωση, επιβράδυνση της σκέψης και δυσκολία στη λήψη αποφάσεων.

Στο **περιεχόμενο της σκέψης** είναι συχνές η απαισιοδοξία, η απελπισία, τα αισθήματα ενοχής ή αναξιότητας και η μειωμένη αυτοεκτίμηση. Ο ασθενής μπορεί να θεωρεί ότι δεν υπάρχει προοπτική βελτίωσης, ότι έχει αποτύχει ή ότι αποτελεί βάρος για τους άλλους. Η **απελπισία** έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία και αναζητώ πάντοτε σκέψεις θανάτου, αυτοκαταστροφικό ιδεασμό και αυτοκτονικότητα.

Στα **βιολογικά συμπτώματα** περιλαμβάνονται διαταραχές του ύπνου, μεταβολές της όρεξης και του βάρους, μειωμένη ενέργεια, κόπωση και μείωση της libido. Μπορεί επίσης να υπάρχει ημερήσια διακύμανση της συμπτωματολογίας.

Η **ψυχοκινητικότητα** μπορεί να εμφανίζει επιβράδυνση ή διέγερση. Σε πολύ βαριά επεισόδια η ψυχοκινητική επιβράδυνση μπορεί να φθάσει μέχρι εμβροντησία.

Παράλληλα εκτιμώ τη **βαρύτητα και τον κίνδυνο**. Η αυτοκτονικότητα αξιολογείται ως προς ιδεασμό, πρόθεση, σχέδιο, πρόσβαση σε μέσα και προηγούμενη αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Σε σοβαρή κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστούν **ψυχωτικά συμπτώματα**, κυρίως παραληρητικές ιδέες ενοχής, αναξιότητας, καταστροφής ή μηδενισμού και, λιγότερο συχνά, ψευδαισθήσεις. Κλασικό παράδειγμα είναι οι μηδενιστικές παραληρητικές ιδέες του **συνδρόμου Cotard**.

Η **διάγνωση** είναι κλινική και βασίζεται στη συνολική συμπτωματολογία, στη διάρκεια, στη βαρύτητα και στην επίδραση στη λειτουργικότητα. Στο **DSM-5-TR** απαιτούνται τουλάχιστον 5 από 9 συμπτώματα για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, με τουλάχιστον ένα από αυτά να είναι καταθλιπτική διάθεση ή απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης.

Στο **ICD-11** το καταθλιπτικό επεισόδιο απαιτεί τουλάχιστον 5 από 10 συμπτώματα για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, με παρουσία καταθλιπτικής διάθεσης ή σημαντικά μειωμένου ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης. Ανάλογα με τη διαχρονική πορεία, η διαταραχή ταξινομείται ως μονήρες ή υποτροπιάζον καταθλιπτικό επεισόδιο.

Στη **διαφορική διάγνωση**, πρώτα πρέπει να αποκλείσω **διπολική κατάθλιψη**, αναζητώντας προηγούμενα επεισόδια μανίας ή υπομανίας και, όπου χρειάζεται, πληροφορίες από το περιβάλλον. Εξετάζω επίσης **πένθος και διαταραχή προσαρμογής**, ουσιο- ή φαρμακοεπαγόμενη κατάθλιψη και **ιατρικά αίτια**, ιδιαίτερα ενδοκρινικά, μεταβολικά και νευρολογικά. Αν υπάρχουν ψυχωτικά συμπτώματα, εξετάζω τη χρονική τους σχέση με το καταθλιπτικό επεισόδιο και αν υποδηλώνουν άλλη ψυχωτική ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR:** ≥5/9 συμπτώματα για ≥2 εβδομάδες, με καταθλιπτική διάθεση ή ανηδονία.
- **ICD-11:** ≥5/10 συμπτώματα για ≥2 εβδομάδες, με καταθλιπτική διάθεση ή απώλεια ενδιαφέροντος/ευχαρίστησης.
- **Major depressive disorder** είναι όρος DSM· το ICD-11 χρησιμοποιεί μονήρες ή υποτροπιάζον καταθλιπτικό επεισόδιο/διαταραχή ανάλογα με την πορεία.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

PMDD ή προεμμηνορροϊκή επιδείνωση άλλης διαταραχής;

Στην **PMDD** περιμένω σαφές κυκλικό πρότυπο: συμπτώματα προεμμηνορροϊκά, βελτίωση μετά την έναρξη της εμμήνου ρύσεως και ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα στο θυλακικό διάστημα. Στην προεμμηνορροϊκή επιδείνωση υπάρχει υποκείμενη διαταραχή σε όλον τον κύκλο που χειροτερεύει προεμμηνορροϊκά. Όταν χρειάζεται διαγνωστική βεβαιότητα, χρησιμοποιώ προοπτικές καθημερινές καταγραφές για **τουλάχιστον δύο διαδοχικούς συμπτωματικούς κύκλους**.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΉΝΑΝΤΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Το παλαιό ICD-10 σχήμα «2 από 3 βασικά συμπτώματα» είναι ιστορικό· το τρέχον ICD-11 χρησιμοποιεί **5 από 10**.

Πώς αντιμετωπίζετε ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αντιμετώπιση ενός μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου αρχίζει με εκτίμηση της **βαρύτητας και της ασφάλειας**. Ελέγχω αυτοκτονικότητα, ψυχωτικά συμπτώματα, κατατονία ή πολύ βαριά ψυχοκινητική επιβράδυνση, αυτοπαραμέληση, λήψη τροφής και υγρών, χρήση ουσιών, πιθανά ιατρικά αίτια και αν υπάρχει ιστορικό μανίας ή υπομανίας. Από αυτά κρίνω και αν ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπιστεί εξωνοσοκομειακά ή χρειάζεται νοσηλεία ή πιο εντατική φροντίδα.

Η επιλογή θεραπείας γίνεται σε συνεργασία με τον ασθενή, με βάση τη βαρύτητα, προηγούμενη ανταπόκριση, συννοσηρότητα, ανεπιθύμητες ενέργειες, προτίμηση και πραγματική διαθεσιμότητα των παρεμβάσεων. Δεν χρησιμοποιώ έναν άκαμπτο κανόνα ότι «ήπια κατάθλιψη σημαίνει μόνο ψυχοθεραπεία, μέτρια μόνο φάρμακο και σοβαρή πάντα συνδυασμό».

Σε **λιγότερο σοβαρή κατάθλιψη**, μια δομημένη τεκμηριωμένη ψυχολογική ή συμπεριφορική παρέμβαση είναι συχνά κατάλληλη αρχική επιλογή. Το αντικαταθλιπτικό δεν είναι υποχρεωτικά πρώτη επιλογή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το προτιμά ο ασθενής ή υπάρχει άλλος κλινικός λόγος.

Σε **πιο σοβαρή κατάθλιψη**, τόσο η δομημένη ψυχοθεραπεία όσο και η αντικαταθλιπτική αγωγή είναι θεμιτές πρώτες επιλογές. Ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν η βαρύτητα ή η χρονιότητα είναι μεγαλύτερη, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ή έχει υπάρξει ατελής ανταπόκριση σε μία μόνο παρέμβαση. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τεκμηριωμένης ψυχοθεραπείας.

Η επιλογή αντικαταθλιπτικού εξατομικεύεται σύμφωνα με προηγούμενο όφελος, ανεκτικότητα, αλληλεπιδράσεις, σωματικές συννοσηρότητες, κίνδυνο σε υπερδοσολογία και προτίμηση του ασθενούς.

Στην **ψυχωτική κατάθλιψη** χρειάζεται ειδική προσοχή και συνήθως ειδική ψυχιατρική φροντίδα. Η βασική φαρμακολογική επιλογή είναι **αντικαταθλιπτικό μαζί με αντιψυχωσικό**. Αν ο ασθενής δεν δέχεται αντιψυχωσικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντικαταθλιπτικό μόνο, αλλά ο συνδυασμός παραμένει η βασική επιλογή.

Η **ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT)** δεν είναι μόνο μακρινή «τελευταία λύση». Τη σκέφτομαι όταν χρειάζεται γρήγορη ανταπόκριση επειδή η κατάσταση είναι απειλητική για τη ζωή — για παράδειγμα ο ασθενής δεν τρώει ή δεν πίνει — σε σοβαρή ψυχωτική ή κατατονική κατάθλιψη, μετά από αποτυχία άλλων κατάλληλων θεραπειών ή όταν υπήρξε πολύ καλή προηγούμενη ανταπόκριση και αποτελεί αποδεκτή επιλογή για τον ασθενή.

Αν η ανταπόκριση είναι ανύπαρκτη ή περιορισμένη, περίπου στις **4 εβδομάδες σε αναγνωρισμένη θεραπευτική δόση** επανεκτιμώ αν η θεραπεία πράγματι δόθηκε επαρκώς. Ελέγχω συμμόρφωση, ανεκτικότητα, διάγνωση, ψυχοκοινωνικούς και

ιατρικούς παράγοντες και χρήση ουσιών. Η μη ανταπόκριση στις 4 εβδομάδες δεν σημαίνει αυτόματα θεραπευτικά ανθεκτική κατάθλιψη. Αν δεν υπάρχει ουσιαστικό όφελος ή υπάρχει κακή ανεκτικότητα, συνήθως σκέφτομαι αλλαγή θεραπείας· αν υπάρχει σημαντική μερική ανταπόκριση σε καλά ανεκτή αγωγή, μπορεί να είναι πιο λογική η προσθήκη ή ενίσχυση.

Μετά την ύφεση συνεχίζω την αποτελεσματική αντικαταθλιπτική θεραπεία αντί να τη διακόψω απότομα. Για μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη, **τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ύφεση** είναι χρήσιμο σύγχρονο σημείο αναφοράς, με μεγαλύτερη διάρκεια όταν ο κίνδυνος υποτροπής είναι υψηλός. Η μελλοντική διακοπή γίνεται σταδιακά και συνοδεύεται από σχέδιο πρόληψης και έγκαιρης αναγνώρισης υποτροπής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ανεπαρκής ανταπόκριση: επανεκτίμηση περίπου στις **4 εβδομάδες** σε θεραπευτική δόση· αυτό δεν ορίζει TRD.
- Μετά την ύφεση μέτριας/σοβαρής κατάθλιψης: συνέχιση αποτελεσματικής αγωγής για **τουλάχιστον 6 μήνες** ως χρήσιμο σημείο αναφοράς.

Τι κάνετε όταν η κατάθλιψη είναι ανθεκτική στη θεραπεία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ως πρακτικό σημείο αναφοράς, μιλάμε για **θεραπευτικά ανθεκτική κατάθλιψη** όταν παραμένει κλινικά σημαντικό καταθλιπτικό επεισόδιο παρά τουλάχιστον δύο **επαρκείς αντικαταθλιπτικές θεραπείες στο ίδιο επεισόδιο**. Πριν όμως χαρακτηρίσω έναν ασθενή ανθεκτικό, πρέπει να αποκλείσω ψευδοανθεκτικότητα.

Επανεξετάζω πρώτα τη **διάγνωση**, ιδιαίτερα το ενδεχόμενο διπολικής διαταραχής. Ελέγχω αν οι προηγούμενες θεραπείες είχαν επαρκή δόση και διάρκεια, αν πράγματι λαμβάνονταν, αν οι ανεπιθύμητες ενέργειες οδήγησαν σε ουσιαστικά μικρότερη έκθεση, και αν υπήρχε ταυτόχρονη χρήση ουσιών. Εξετάζω επίσης ψυχιατρική συννοσηρότητα, ιατρικές παθήσεις ή φάρμακα που μπορεί να συντηρούν την εικόνα, σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και αν η ψυχοθεραπεία ή άλλη παρέμβαση δόθηκε πραγματικά με επαρκή τρόπο.

Παράλληλα επανεκτιμώ **βαρύτητα, αυτοκτονικότητα, ψυχωτικά συμπτώματα και κατατονία**. Αυτά μπορεί να αλλάξουν άμεσα το θεραπευτικό πλάνο ανεξάρτητα από το πόσες προηγούμενες θεραπείες έχουν αποτύχει.

Η επόμενη στρατηγική εξαρτάται και από το είδος της προηγούμενης ανταπόκρισης. Αν υπήρξε **ελάχιστη ή καθόλου βελτίωση**, ή σημαντική δυσανεξία, είναι λογικό να αλλάξω αντικαταθλιπτικό ή θεραπευτική προσέγγιση. Αν υπήρξε **ουσιαστική μερική ανταπόκριση** σε καλά ανεκτή θεραπεία, συχνά προτιμάται προσθήκη ή ενίσχυση αντί για πλήρη αλλαγή.

Στις καθιερωμένες φαρμακολογικές στρατηγικές ενίσχυσης περιλαμβάνονται **άτυπα αντιψυχωσικά**, με την αριπιπραζόλη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, και το **λίθιο**. Δεν υπάρχει μία μοναδική καθολική ιεράρχηση, γιατί οι οδηγίες διαφέρουν και η επιλογή εξαρτάται από το προφίλ του ασθενούς.

Η **ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT)** παραμένει η σημαντικότερη σωματική θεραπεία όταν η κατάθλιψη είναι σοβαρή, επείγουσα ή πολύ ανθεκτική, ιδιαίτερα με ψύχωση, κατατονία, σοβαρή αυτοκτονικότητα ή απειλητική για τη ζωή άρνηση τροφής και υγρών.

Η **επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)** είναι καθιερωμένη μη επεμβατική θεραπευτική επιλογή για κατάθλιψη που δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς σε συνήθη θεραπεία· δεν τη θεωρώ πειραματική περιθωριακή παρέμβαση.

Η **ενδορρινική εσκεταμίνη** έχει ευρωπαϊκή άδεια, μαζί με SSRI ή SNRI, για ενήλικες με TRD μετά από τουλάχιστον δύο αποτυχίες αντικαταθλιπτικών και χορηγείται υπό επίβλεψη και παρακολούθηση. Δεν είναι όμως καθολικά προτεινόμενη ή διαθέσιμη: το NICE εξακολουθεί να μην τη συστήνει για χρήση στο NHS λόγω αβεβαιότητας ως προς το κλινικό και οικονομικό όφελος, ενώ η ευρωπαϊκή άδεια δεν συνεπάγεται αυτόματα διαθεσιμότητα ή αποζημίωση στην Ελλάδα. Επομένως τη βλέπω ως **ειδική θεραπευτική επιλογή**, όχι ως αυτόματο

επόμενο βήμα.

Σε ασθενείς με επίμονη επιβάρυνση παρά πολλές εύλογες θεραπείες, ο όρος **difficult-to-treat depression (DTD)** μπορεί να είναι πιο χρήσιμος από μια δυαδική ετικέτα «ανθεκτικός/μη ανθεκτικός». Η μακροχρόνια φροντίδα τότε περιλαμβάνει λειτουργική ανάρρωση, συννοσηρότητες, πρόληψη υποτροπής και προσωπικούς στόχους, όχι μόνο διαδοχικές αλλαγές φαρμάκων.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- | | |
|---|--|
| 1 | 2 αποτυχίες → ψευδοανθεκτικότητα → αλλαγή ή ενίσχυση → ECT/rTMS → ειδικές επιλογές |
|---|--|

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Συμβατικό TRD: ≥ 2 επαρκείς αντικαταθλιπτικές θεραπείες στο ίδιο επεισόδιο.
- rTMS είναι καθιερωμένη θεραπεία, όχι πειραματική.
- Εσκεταμίνη: EU-**authorised** για TRD υπό επίβλεψη· η ελληνική πρόσβαση/αποζημίωση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Πώς διαγιγνώσκετε τη διπολική διαταραχή και πώς τη διακρίνετε από σημαντικές εναλλακτικές διαγνώσεις;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διάγνωση της διπολικής διαταραχής είναι **διαχρονική και επεισοδιακή**. Δεν αρκεί ο ασθενής να αναφέρει «μεταπτώσεις της διάθεσης». Αναζητώ διακριτά επεισόδια που αποτελούν σαφή μεταβολή από το συνηθισμένο επίπεδο διάθεσης, ενέργειας, δραστηριότητας και λειτουργικότητας.

Σε **μανιακό ή υπομανιακό** επεισόδιο υπάρχει συνήθως **ανυψωμένη, επεκτατική ή ευερέθιστη διάθεση μαζί με αυξημένη ενέργεια και δραστηριότητα**. Πρωτό για μειωμένη ανάγκη για ύπνο, αυξημένη ομιλία ή πίεση λόγου, φυγή ιδεών ή επιτάχυνση σκέψης, διασπαστικότητα, αυξημένη στοχοκατευθυνόμενη δραστηριότητα, άρση αναστολών ή επικίνδυνες συμπεριφορές και μεγαλοϊδεατισμός. Ψυχωτικά συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στη μανία.

Η διάκριση **μανίας από υπομανία** βασίζεται κυρίως στη βαρύτητα και στη λειτουργική συνέπεια. Η μανία προκαλεί σημαντική έκπτωση, μπορεί να απαιτήσει νοσηλεία και μπορεί να συνοδεύεται από ψύχωση. Η υπομανία είναι σαφώς επεισοδιακή αλλαγή από τη συνήθη λειτουργία, αλλά χωρίς την ίδια σοβαρή λειτουργική αποδιοργάνωση και χωρίς ψύχωση.

Η βασική διαγνωστική διάκριση είναι απλή: **διπολική διαταραχή τύπου I** απαιτεί τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο. **Διπολική διαταραχή τύπου II** απαιτεί τουλάχιστον ένα υπομανιακό και τουλάχιστον ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, χωρίς ιστορικό μανίας.

Στο **DSM-5-TR** η μανία έχει συνήθως διάρκεια τουλάχιστον **1 εβδομάδας**, ή οποιαδήποτε διάρκεια αν απαιτείται νοσηλεία, ενώ η υπομανία τουλάχιστον **4 συνεχόμενες ημέρες**. Αυτά τα ακριβή χρονικά όρια δεν ταυτίζονται με τη διατύπωση του ICD-11, το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετική γλώσσα και για την υπομανία αναφέρεται σε «αρκετές ημέρες».

Τα **μικτά χαρακτηριστικά** είναι επίσης σημαντικά. Μπορεί να υπάρχουν κλινικά ουσιώδη μανιακά συμπτώματα μέσα σε κατάθλιψη ή καταθλιπτικά συμπτώματα κατά τη μανία ή υπομανία, χωρίς να απαιτείται το παλαιό πλήρες «μικτό επεισόδιο». Αυτό αυξάνει τη διαγνωστική πολυπλοκότητα και την προσοχή στη χρήση αντικαταθλιπτικών.

Για να ξεχωρίσω τη διπολική από **μονοπολική κατάθλιψη**, αναζητώ συστηματικά προηγούμενη μανία ή υπομανία, επεισοδιακότητα, μικτά συμπτώματα, πληροφορίες από το περιβάλλον, οικογενειακό ιστορικό και επεισόδια ενεργοποίησης κατά τη θεραπεία. Κανένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό ενός καταθλιπτικού επεισοδίου δεν αποδεικνύει διπολικότητα.

Η **ΔΕΠΥ (ADHD)** είναι συνήθως επίμονο νευροαναπτυξιακό πρότυπο, ενώ η υπομανία ή μανία αποτελεί σαφή επεισοδιακή αλλαγή από τη συνήθη λειτουργία. Μειωμένη ανάγκη για ύπνο, μεγαλοϊδεατισμός, σαφής μεταβολή

διάθεσης/ενέργειας και ψύχωση ευνοούν διπολική διαταραχή. Οι δύο διαταραχές μπορούν να συνυπάρχουν.

Στην **οριακή διαταραχή προσωπικότητας**, η συναισθηματική αστάθεια είναι συνήθως ταχεία και αντιδραστική σε διαπροσωπικά ή περιβαλλοντικά γεγονότα και εντάσσεται σε ευρύτερο επίμονο πρότυπο διαπροσωπικής αστάθειας, ταυτότητας και παρορμητικότητας. Η διπολική διαταραχή απαιτεί περισσότερο διακριτά και παρατεταμένα επεισόδια. Και εδώ μπορεί να υπάρχει συννοσηρότητα.

Ελέγχω τέλος ουσίες, διεγερτικά, κορτικοστεροειδή, αντικαταθλιπτικά και άλλα φάρμακα, καθώς και θυρεοειδικά, νευρολογικά ή άλλα ιατρικά αίτια. Αν υπάρχει επίμονη ψύχωση που δεν οργανώνεται γύρω από επεισόδια διάθεσης, εξετάζω διαταραχή του φάσματος της σχιζοφρένειας.

Αν πλήρες μανιακό ή υπομανιακό σύνδρομο εμφανιστεί κατά τη λήψη αντικαταθλιπτικού και **επιμένει μετά τη διακοπή και αφού υποχωρήσει η άμεση φυσιολογική επίδραση του φαρμάκου**, μπορεί να μετρήσει ως πρωτοπαθές επεισόδιο. Μια σύντομη ενεργοποίηση που περιορίζεται στην άμεση φαρμακευτική επίδραση δεν αρκεί από μόνη της για διάγνωση διπολικής διαταραχής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Διπολική Ι:** ≥ 1 μανιακό επεισόδιο. **Διπολική ΙΙ:** υπομανία + κατάθλιψη, χωρίς μανία.
- DSM-5-TR: μανία ≥ 1 **εβδομάδα** ή οποιαδήποτε διάρκεια αν απαιτείται νοσηλεία· υπομανία ≥ 4 **ημέρες**. Δεν είναι αυτούσια ICD-11 όρια.
- Αντικαταθλιπτικό-εμφανιζόμενο πλήρες σύνδρομο μπορεί να μετρήσει ως πρωτοπαθές επεισόδιο όταν **επιμένει πέρα από την άμεση φαρμακευτική επίδραση**.

ΠΙΘΑΝΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΉ

Πρώτο μανιακό επεισόδιο: τι πρέπει να αποκλείσετε;

Επιβεβαιώνω πρώτα ότι υπάρχει **σαφές επεισοδιακό μανιακό σύνδρομο** και εκτιμώ ασφάλεια, ψύχωση και ανάγκη νοσηλείας. Ελέγχω **διεγερτικά και άλλες ουσίες, αντικαταθλιπτικά, κορτικοστεροειδή και άλλα φάρμακα**, καθώς και θυρεοειδικά, νευρολογικά και άλλα ιατρικά αίτια ανάλογα με την εικόνα. Παίρνω πληροφορίες από το περιβάλλον, κάνω σωματική/νευρολογική εξέταση και στοχευμένο έλεγχο όταν υπάρχουν ενδείξεις δευτεροπαθούς αιτίου.

Πώς αντιμετωπίζετε την οξεία μανία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην οξεία μανία εκτιμώ πρώτα τη **βαρύτητα και την ασφάλεια**: κίνδυνο για τον ίδιο ή άλλους, έντονη διέγερση, ψύχωση, αδυναμία ελέγχου της συμπεριφοράς, σοβαρή στέρηση ύπνου, χρήση ουσιών, ικανότητα λήψης αποφάσεων και δυνατότητα συνεργασίας με τη θεραπεία. Ελέγχω παράλληλα φάρμακα, ουσίες και ιατρικά ή νευρολογικά αίτια. Η σοβαρή μανία συχνά απαιτεί επείγουσα ειδική αξιολόγηση και νοσηλεία.

Αν το επεισόδιο εμφανίστηκε ενώ ο ασθενής λαμβάνει **αντικαταθλιπτικό**, το διακόπτω ή δρομολογώ τη διακοπή του στο πλαίσιο της οξείας αντιμετώπισης. Αν υπάρχει τοξίκωση, στέρηση ή άλλο δευτεροπαθές αίτιο, το αντιμετωπίζω παράλληλα.

Οι βασικές αντιμανιακές επιλογές είναι **αντιψυχωσικά, λίθιο και βαλπροϊκό/διβαλπροϊκό**. Δεν υπάρχει μία ενιαία διεθνής σειρά που να ισχύει σε κάθε ασθενή. Το NICE ξεκινά πρακτικά συχνά με αντιψυχωσικό, ενώ άλλες μεγάλες οδηγίες περιλαμβάνουν λίθιο, διβαλπροϊκό και αρκετά άτυπα αντιψυχωσικά μεταξύ των πρώτων επιλογών.

Σε **λιγότερο σοβαρή μανία**, μια κατάλληλη μονοθεραπεία μπορεί να είναι επαρκής. Σε **σοβαρότερη μανία**, ιδιαίτερα όταν χρειάζεται ταχύτερη και ισχυρότερη ανταπόκριση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νωρίς συνδυασμός **αντιψυχωσικού με λίθιο ή βαλπροϊκό/διβαλπροϊκό**. Η επιλογή λαμβάνει υπόψη προηγούμενη ανταπόκριση, σωματικές συννοσηρότητες, ανεπιθύμητες ενέργειες, δυνατότητα παρακολούθησης και τις προτιμήσεις του ασθενούς.

Οι **βενζοδιαζεπίνες** μπορεί να χρησιμοποιηθούν βραχυχρόνια ως συμπληρωματική θεραπεία για σοβαρή διέγερση ή αϋπνία μέχρι να δράσει η κύρια αντιμανιακή θεραπεία. Δεν αποτελούν τη βασική θεραπεία της μανίας.

Παράλληλα φροντίζω για **ήρεμο, χαμηλής διέγερσης περιβάλλον, αποκατάσταση ύπνου, ενυδάτωση και θρέψη**, και εμπλέκω υποστηρικτικά πρόσωπα όταν αυτό είναι κατάλληλο και ασφαλές.

Η **ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT)** παραμένει επιλογή σε παρατεταμένη, πολύ σοβαρή, ανθεκτική ή απειλητική για τη ζωή μανία και δεν πρέπει να αποκλείεται από την αρχή μόνο επειδή θεωρείται «τελευταία λύση».

Αν εξετάζω **βαλπροϊκό**, η αναπαραγωγική ασφάλεια είναι υποχρεωτικό μέρος της απόφασης. Δεν χρησιμοποιείται για διπολική διαταραχή κατά την εγκυμοσύνη. Σε κορίτσια ή γυναίκες που μπορούν να μείνουν έγκυες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Pregnancy Prevention Programme και οι εναλλακτικές είναι αναποτελεσματικές ή μη ανεκτές. Για άνδρες, οι τρέχουσες ευρωπαϊκές/ελληνικές προφυλάξεις απαιτούν εξειδικευμένη ενημέρωση για πιθανό νευροαναπτυξιακό κίνδυνο από πατρική έκθεση, αποτελεσματική αντισύλληψη για τον άνδρα και τη γυναίκα σύντροφο κατά τη θεραπεία και για τουλάχιστον **3 μήνες μετά τη διακοπή**, καθώς και αποφυγή δωρεάς σπέρματος στο ίδιο διάστημα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Σε σοβαρή μανία μπορεί να χρησιμοποιηθεί νωρίς αντιψυχωσικό + λίθιο ή διβαλπροϊκό.
- Βαλπροϊκό: **όχι στην εγκυμοσύνη**· Pregnancy Prevention Programme όπου εφαρμόζεται στους άνδρες αντισύλληψη και αποφυγή δωρεάς σπέρματος κατά τη θεραπεία και για 3 μήνες μετά.

Πώς αντιμετωπίζετε τη διπολική κατάθλιψη;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διπολική κατάθλιψη δεν αντιμετωπίζεται σαν κοινή μονοπολική κατάθλιψη. Πριν επιλέξω θεραπεία επιβεβαιώνω τη διπολική διάγνωση και τον υπότυπο, αναζητώ μικτά ή μανιακά συμπτώματα, εκτιμώ αυτοκτονικότητα, ψύχωση ή κατατονία, ελέγχω συμμόρφωση, ουσίες, προηγούμενη ανταπόκριση και τι θεραπεία συντήρησης θα χρειαστεί στη συνέχεια.

Βασικές τεκμηριωμένες επιλογές είναι **κουετιαπίνη, λίθιο και λαμοτριγίνη**. Η επιλογή εξαρτάται από τον υπότυπο, την προηγούμενη ανταπόκριση, την κυρίαρχη πολικότητα των επεισοδίων, τη βαρύτητα, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις μακροχρόνιες ανάγκες. Η λαμοτριγίνη έχει ιδιαίτερη θέση στη depressive polarity και στην πρόληψη καταθλιπτικών υποτροπών, αλλά **δεν είναι θεραπεία οξείας μανίας**. Το NICE περιλαμβάνει επίσης τον συνδυασμό ολανζαπίνης-φλουοξετίνης ως επιλογή σε μέτρια ή σοβαρή διπολική κατάθλιψη.

Τα αντικαταθλιπτικά δεν αποτελούν τον **βασικό κορμό της θεραπείας της διπολικής I κατάθλιψης**. Δεν συστήνω αντικαταθλιπτικό ως μονοθεραπεία στη διπολική I. Αν χρησιμοποιηθεί αντικαταθλιπτικό σε επιλεγμένο ασθενή, χορηγείται επικουρικά σε ήδη καθιερωμένη θεραπεία σταθεροποίησης της διάθεσης και με προσεκτική παρακολούθηση για μεταστροφή ή μικτά συμπτώματα. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν υπάρχει προηγούμενη αντικαταθλιπτικό-επαγόμενη μανία, μικτή εικόνα ή πρόσφατη ταχεία εναλλαγή επεισοδίων. Αν εμφανιστεί μανία, το αντικαταθλιπτικό διακόπτεται.

Η ECT είναι σημαντική επιλογή σε ανθεκτική διπολική κατάθλιψη και πρέπει να εξετάζεται νωρίτερα όταν απαιτείται ταχεία ανταπόκριση λόγω σοβαρής αυτοκτονικότητας, ψύχωσης, κατατονίας ή ιατρικής επιβάρυνσης από ανεπαρκή λήψη τροφής και υγρών.

Παράλληλα χρησιμοποιώ ψυχολογικές παρεμβάσεις, ρύθμιση ύπνου και κερκαδικού ρυθμού, αντιμετώπιση ουσιών και σχέδιο πρόληψης υποτροπής, χωρίς αυτά να υποκαθιστούν την κατάλληλη θεραπεία του οξέος επεισοδίου.

Χρειάζεται επίσης να ξεχωρίζω την **τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας από τη ρυθμιστική άδεια**. Διεθνείς οδηγίες όπως CANMAT/ISBD περιλαμβάνουν στρατηγικές με καριπραζίνη και λουρασιδόνη για διπολική I κατάθλιψη. Ωστόσο οι τρέχουσες ευρωπαϊκές άδειες των Reagila και Latuda παραμένουν για σχιζοφρένεια. Επομένως δεν τις παρουσιάζω ως συνήθεις ευρωπαϊκά αδειοδοτημένες θεραπείες διπολικής κατάθλιψης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Όχι αντικαταθλιπτικό ως μονοθεραπεία στη διπολική I.
- Καριπραζίνη/λουρασιδόνη έχουν διεθνή τεκμηρίωση για bipolar depression αλλά δεν είναι EU-licensed για αυτή την ένδειξη.

Πώς αντιμετωπίζετε τη διπολική διαταραχή μακροχρόνια;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μακροχρόνια αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής είναι **πρόληψη νέων επεισοδίων και λειτουργική ανάρρωση**, όχι απλώς συνέχιση του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε στην οξεία φάση. Μαζί με τον ασθενή καταγράφω το ατομικό πρότυπο υποτροπής, την κυρίαρχη πολικότητα των επεισοδίων, εκλυτικούς παράγοντες, ύπνο και κιρκαδικό ρυθμό, συμμόρφωση, χρήση ουσιών, αυτοκτονικότητα, λειτουργικούς στόχους και ανάγκες οικογένειας ή φροντιστών.

Το **λίθιο** παραμένει κεντρική θεραπεία πρώτης γραμμής για τη συντήρηση και το NICE το περιγράφει ως την πιο αποτελεσματική μακροχρόνια φαρμακολογική θεραπεία της διπολικής διαταραχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η σωστή επιλογή για όλους: λαμβάνω υπόψη προηγούμενη ανταπόκριση, ανεκτικότητα, αντενδείξεις, δυνατότητα παρακολούθησης, πολικότητα και προτίμηση του ασθενούς.

Άλλες καθιερωμένες επιλογές συντήρησης περιλαμβάνουν **κουετιαπίνη, λαμοτριγίνη, βαλπροϊκό/διβαλπροϊκό και επιλεγμένα αντιψυχωσικά**, ανάλογα με το ιστορικό ανταπόκρισης και το είδος των υποτροπών που θέλουμε περισσότερο να προλάβουμε. Η φάση έχει σημασία: η **λαμοτριγίνη** είναι χρήσιμη κυρίως για την πρόληψη καταθλιπτικών υποτροπών και δεν είναι φάρμακο οξείας μανίας.

Η φαρμακευτική αγωγή συνοδεύεται από **ψυχοεκπαίδευση, ενίσχυση της συμμόρφωσης, αναγνώριση πρώιμων προειδοποιητικών σημείων, σταθερό ύπνο και καθημερινό ρυθμό, αντιμετώπιση ουσιών και οικογενειακές ή CBT-ενημερωμένες παρεμβάσεις** όπου είναι κατάλληλες. Η κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα αποτελεί ξεχωριστό θεραπευτικό στόχο.

Παρακολουθώ συστηματικά τη **σωματική υγεία και τις φαρμακοειδικές ανεπιθύμητες ενέργειες**, όπως βάρος και μεταβολικό/καρδιαγγειακό κίνδυνο, με ειδικότερη παρακολούθηση ανάλογα με το φάρμακο.

Το **λίθιο** έχει επιπλέον δεδομένα που υποστηρίζουν **μείωση του κινδύνου αυτοκτονικής συμπεριφοράς** σε κατάλληλους ασθενείς. Αυτό είναι χρήσιμο στην επιλογή θεραπείας, αλλά δεν σημαίνει πλήρη προστασία ούτε χρειάζεται να εκφράζεται με ένα σταθερό ποσοστό.

Η διπολική διαταραχή είναι συνήθως υποτροπιάζουσα και η θεραπεία συντήρησης είναι συχνά **μακροχρόνια, ακόμη και επ' αόριστον** μετά από επαναλαμβανόμενα ή σοβαρά επεισόδια. Δεν υπάρχει μία καθολική ημερομηνία διακοπής. Αν εξετάζεται διακοπή, συνεκτιμώ αριθμό και βαρύτητα επεισοδίων, ψύχωση, συνέπειες προηγούμενων υποτροπών, υπολειμματικά συμπτώματα, ανεπιθύμητες ενέργειες, προτίμηση και το ιστορικό υποτροπής. Η απόσυρση γίνεται σταδιακά.

Αν χρησιμοποιείται **βαλπροϊκό**, εφαρμόζονται οι ίδιες τρέχουσες ευρωπαϊκές αναπαραγωγικές προφυλάξεις όπως στην οξεία μανία. Δεν χρησιμοποιείται για

διπολική διαταραχή στην εγκυμοσύνη. Σε κορίτσια ή γυναίκες που μπορούν να μείνουν έγκυες απαιτούνται οι προϋποθέσεις του Pregnancy Prevention Programme όταν οι εναλλακτικές είναι ανεπαρκείς ή μη ανεκτές. Για άνδρες απαιτείται ειδική ενημέρωση και αποτελεσματική αντισύλληψη για τον άνδρα και τη γυναίκα σύντροφο κατά τη θεραπεία και για τουλάχιστον **3 μήνες μετά τη διακοπή**, καθώς και αποφυγή δωρεάς σπέρματος σε αυτό το διάστημα.

Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε την επιλόχεια ψύχωση;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιλόχεια ψύχωση είναι ψυχιατρικό επείγον. Συνήθως αρχίζει απότομα στην άμεση λοχεία, πολύ συχνά μέσα στις πρώτες 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό, και μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα.

Η εικόνα συχνά είναι **κυμαινόμενη και μεικτή**: μπορεί να υπάρχουν μανιακά ή μικτά συμπτώματα, σοβαρή κατάθλιψη, έντονη αϋπνία, ψυχοκινητική διέγερση, παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις, αποδιοργάνωση και σύγχυση. Δεν τη σκέφτομαι απλώς ως «σχιζοφρένεια που εμφανίστηκε μετά τον τοκετό». Η σχέση της με το **διπολικό φάσμα** είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Η άμεση εκτίμηση αφορά δύο πρόσωπα: **τη μητέρα και το βρέφος**. Ελέγχω αυτοκτονικότητα, σκέψεις ή συμπεριφορά που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το βρέφος, ικανότητα ασφαλούς φροντίδας, σοβαρή διέγερση, ψύχωση, κατατονία και βαθμό αποδιοργάνωσης ή σύγχυσης. Παράλληλα αποκλείω ντελίριο και σχετιζόμενα μαιευτικά, ιατρικά, νευρολογικά ή ουσιοεπαγόμενα αίτια. Παίρνω επείγοντως πληροφορίες από το περιβάλλον και συνεργάζομαι με μαιευτικές και περιγεννητικές υπηρεσίες.

Γενικά χρειάζεται **επείγουσα ειδική αξιολόγηση και νοσηλεία**. Όπου υπάρχει διαθέσιμη εξειδικευμένη **μονάδα μητέρας-βρέφους (mother-and-baby unit, MBU)**, είναι το προτιμώμενο πλαίσιο, επειδή επιτρέπει ταυτόχρονα θεραπεία της μητέρας, προστασία του βρέφους και υποστήριξη της σχέσης τους.

Στην οξεία θεραπεία συνήθως απαιτείται **αντιψυχωσικό**. Το **λίθιο** έχει σημαντική θέση όταν είναι κλινικά κατάλληλο, ιδιαίτερα λόγω της στενής σχέσης με το διπολικό φάσμα και του ρόλου του στην πρόληψη υποτροπής. Βενζοδιαζεπίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν βραχυχρόνια όταν χρειάζονται για σοβαρή διέγερση ή αϋπνία.

Η **ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT)** πρέπει να εξετάζεται νωρίς όταν χρειάζεται γρήγορη ανταπόκριση, ιδίως σε πολύ σοβαρή ή ανθεκτική νόσο, κατατονία, έντονη διέγερση ή σημαντικό αυτοκτονικό ή βρεφοκτονικό κίνδυνο. Δεν τη θεωρώ θεραπεία μόνο μετά την εξάντληση κάθε άλλης επιλογής.

Οι αποφάσεις για **θηλασμό** είναι φαρμακοειδικές και βασίζονται στον κίνδυνο υποτροπής της μητέρας, στην έκθεση του βρέφους και στη δική του ιατρική ευαλωτότητα. Δεν χρησιμοποιώ γενικούς χαρακτηρισμούς «ασφαλές/μη ασφαλές για τον θηλασμό» για ολόκληρες κατηγορίες. Στο σχετικό πλαίσιο NICE δεν συστήνεται θηλασμός κατά τη λήψη λιθίου, κλοζαπίνης ή καρβαμαζεπίνης.

Μετά την οξεία φάση χρειάζεται σαφής **πρόληψη υποτροπής**. Το **λίθιο** έχει την ισχυρότερη τεκμηρίωση για πρόληψη μετά από προηγούμενη επιλόχεια ψύχωση και αποτελεί σημαντική προφυλακτική επιλογή. Κάθε μελλοντική κύηση χρειάζεται εξειδικευμένο προγεννητικό σχεδιασμό και συγκεκριμένο σχέδιο για την κύηση και την άμεση λοχεία· σε γυναίκες υψηλού κινδύνου μπορεί να είναι

κατάλληλη η έναρξη προφύλαξης αμέσως μετά τον τοκετό.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Συνήθης απότομη έναρξη μέσα στις πρώτες 2 εβδομάδες και ισχυρή σχέση με το διπολικό φάσμα.
- Όπου υπάρχει, προτιμάται νοσηλεία σε **mother-and-baby unit**.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς διαφέρει η επιλόχεια κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζεται;

Η επιλόχεια κατάθλιψη είναι καταθλιπτικό σύνδρομο χωρίς τη χαρακτηριστική ψυχωτική, μανιακή ή βαριά αποδιοργανωμένη εικόνα της επιλόχειας ψύχωσης. Εκτιμώ βαρύτητα, αυτοκτονικότητα, ασφάλεια του βρέφους, λειτουργικότητα, διπολικό ιστορικό και ψύχωση. Η θεραπεία ακολουθεί τις αρχές της κατάθλιψης, προσαρμοσμένες σε περιγεννητικό πλαίσιο και θηλασμό: ψυχοθεραπεία, αντικαταθλιπτικό ή συνδυασμός ανάλογα με βαρύτητα, ιστορικό και προτίμηση· πολύ σοβαρή/ψυχωτική/κατατονική εικόνα μπορεί να απαιτεί νοσηλεία και ECT.

Η ζουρανολόνη έχει ευρωπαϊκή άδεια από τον Σεπτέμβριο 2025 ως 14ήμερη από του στόματος θεραπεία για επιλόχεια κατάθλιψη, μόνη ή μαζί με άλλο αντικαταθλιπτικό. Η ελληνική εμπορική διαθεσιμότητα/αποζημίωση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΈΝΑΝΤΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ζουρανολόνη είναι πλέον **EU-authorised**, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ελληνική πρόσβαση ή αποζημίωση.

Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή πανικού και την αγοραφοβία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια **κρίση πανικού** είναι απότομη έξαρση έντονου φόβου ή δυσφορίας που κορυφώνεται γρήγορα και συνοδεύεται από σωματικά και γνωστικά συμπτώματα, όπως αίσθημα παλμών, θωρακική δυσφορία, δύσπνοια, ζάλη, τρόμο, εφίδρωση, παραισθησίες και φόβο απώλειας ελέγχου ή θανάτου. Η κρίση πανικού είναι διαγνωστικά μη ειδικό φαινόμενο και μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές ψυχιατρικές ή ιατρικές καταστάσεις.

Για **διαταραχή πανικού** χρειάζομαι επαναλαμβανόμενες **απρόσμενες** κρίσεις και, μετά από αυτές, επίμονη ανησυχία για νέες κρίσεις ή τις συνέπειές τους και/ή σημαντική δυσπροσαρμοστική αλλαγή της συμπεριφοράς, όπως αποφυγές. Εκτιμώ επίσης προληπτικό άγχος, λειτουργική έκπτωση και το αν οι κρίσεις συμβαίνουν μόνο μέσα σε άλλη φοβική κατάσταση.

Παράλληλα αποκλείω δευτεροπαθείς αιτίες σύμφωνα με την κλινική εικόνα: καρδιολογικά, αναπνευστικά, ενδοκρινικά και νευρολογικά προβλήματα, καθώς και φάρμακα, διεγερτικές ουσίες, τοξίκωση ή στέρηση. Δεν αποδίδω αυτόματα ένα πρώτο επεισόδιο έντονης ταχυκαρδίας και δύσπνοιας σε πανικό χωρίς βασική ιατρική εκτίμηση.

Η **αγοραφοβία** είναι ξεχωριστή σύγχρονη διάγνωση. Χαρακτηρίζεται από έντονο και επίμονο φόβο ή αποφυγή καταστάσεων όπου ο ασθενής πιστεύει ότι η διαφυγή θα είναι δύσκολη ή ότι δεν θα υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια αν εμφανιστούν έντονα ή ανικανωτικά συμπτώματα. Οι κρίσεις πανικού είναι συχνές αλλά δεν είναι απαραίτητες. Διαταραχή πανικού και αγοραφοβία μπορούν να συνυπάρχουν όταν πληρούνται ανεξάρτητα και τα δύο σύνδρομα.

Η βασική ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση είναι **γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT)**. Περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση και γνωσιακή επεξεργασία των καταστροφικών ερμηνειών, **έκθεση σε φοβούμενες σωματικές αισθήσεις (interoceptive exposure)** και βαθμιαία έκθεση στις καταστάσεις που αποφεύγονται, ιδιαίτερα στην αγοραφοβία.

Αν χρειάζεται φαρμακοθεραπεία, οι **SSRIs** αποτελούν βασική μακροχρόνια επιλογή και οι **SNRIs** είναι επίσης τεκμηριωμένες επιλογές. Οι βενζοδιαζεπίνες δεν πρέπει να αποτελούν τον κεντρικό μακροχρόνιο θεραπευτικό άξονα λόγω εξάρτησης και προβλημάτων στη μακροχρόνια διαχείριση.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Στο **ICD-11**, διαταραχή πανικού και αγοραφοβία είναι **ανεξάρτητες διαγνώσεις**: το παλαιό «panic disorder with/without agoraphobia» είναι ιστορικό.

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή χαρακτηρίζεται από επίμονη, υπερβολική και δύσκολα ελεγχόμενη ανησυχία για πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής. Η ανησυχία υπάρχει τις περισσότερες ημέρες και συνοδεύεται από σημαντική δυσφορία ή λειτουργική επιβάρυνση.

Συχνά συνυπάρχουν ανησυχία ή εσωτερική ένταση, μυϊκή τάση, συμπτώματα αυτόνομου άγχους, κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα και διαταραχές ύπνου. Η εικόνα είναι πιο διάχυτη και επίμονη από τις διακριτές κρίσεις πανικού και δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη φοβική κατάσταση.

Η χρονικότητα χρειάζεται προσοχή. Στο **ICD-11** τα συμπτώματα πρέπει να είναι επίμονα για τουλάχιστον **αρκετούς μήνες**, ενώ το **DSM-5-TR** διατηρεί όριο **6 μηνών**. Το εξάμηνο επομένως είναι DSM-5-TR κριτήριο και όχι καθολικό χρονικό όριο και των δύο συστημάτων.

Στη διαφορική διάγνωση εξετάζω **καταθλιπτική μηρυκαστική σκέψη, διαταραχή πανικού, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, άγχος υγείας**, καθώς και φάρμακα, ουσίες και σχετικά ιατρικά αίτια. Με ενδιαφέρει αν η σκέψη είναι διάχυτη ανησυχία για πραγματικές πιθανότητες ή παρεισφρητική ιδεοληπτική σκέψη, αν υπάρχουν σαφείς πανικοί ή αν το άγχος οργανώνεται κυρίως γύρω από μια άλλη ψυχιατρική διαταραχή.

Η **γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT)** είναι βασική θεραπεία. Ανάλογα με τη βαρύτητα και το πλαίσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης CBT-based παρεμβάσεις χαμηλότερης έντασης και εφαρμοσμένη χαλάρωση.

Αν επιλεγεί φαρμακοθεραπεία, οι **SSRIs** αποτελούν πρώτη επιλογή. Αν δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα ή ανεκτικότητα, συνηθισμένη επόμενη στρατηγική είναι άλλο SSRI ή **SNRI**. Η **pregabalin** έχει θέση κυρίως όταν SSRIs/SNRIs δεν είναι ανεκτά και δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ισότιμη ρουτίνα πρώτη επιλογή.

Οι **βενζοδιαζεπίνες** περιορίζονται σε βραχυχρόνια χρήση σε κρίση και δεν αποτελούν κανονική μακροχρόνια θεραπεία της GAD.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR:** 6 μήνες. **ICD-11:** τουλάχιστον αρκετοί μήνες.

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή κοινωνικού άγχους;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή κοινωνικού άγχους χαρακτηρίζεται από έντονο φόβο ή άγχος σε μία ή περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις επειδή το άτομο αναμένει ότι θα εκτεθεί σε παρατήρηση, θα ντροπιαστεί ή θα αξιολογηθεί αρνητικά. Οι καταστάσεις αποφεύγονται ή υπομένονται με έντονο άγχος και υπάρχει ουσιαστική λειτουργική επιβάρυνση. Έτσι τη διακρίνω από τη φυσιολογική συστολή ή ντροπαλότητα.

Στην αξιολόγηση με ενδιαφέρει τι ακριβώς φοβάται ότι θα παρατηρήσουν οι άλλοι και ποια συνέπεια αναμένει. Αναζητώ συμπεριφορές ασφάλειας, όπως υπερβολική προετοιμασία, αποφυγή βλεμματικής επαφής ή περιορισμό της ομιλίας, και έντονη αυτοεστιασμένη προσοχή, επειδή συχνά συντηρούν το πρόβλημα.

Στη διαφορική, η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας αφορά ευρύτερο και επίμονο πρότυπο κοινωνικής αναστολής, αισθήματος ανεπάρκειας και υπερευαίσθησίας στην αρνητική αξιολόγηση σε πολλαπλά πλαίσια. Η κοινωνική αγχώδης διαταραχή οργανώνεται περισσότερο γύρω από συγκεκριμένο φόβο κοινωνικής αξιολόγησης. Οι δύο μπορούν να συνυπάρχουν.

Ο αυτισμός είναι νευροαναπτυξιακή κατάσταση με επίμονες διαφορές στην κοινωνική επικοινωνία και περιορισμένα/επαναληπτικά ή αισθητηριακά χαρακτηριστικά. Η κοινωνική αποφυγή μπορεί να οφείλεται στις επικοινωνιακές ή αισθητηριακές απαιτήσεις και όχι κυρίως σε φόβο αρνητικής αξιολόγησης. Και εδώ συννοσηρότητα με κοινωνικό άγχος είναι δυνατή.

Η θεραπεία πρώτης επιλογής είναι συνήθως ατομική, ειδική για τη διαταραχή γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία. Περιλαμβάνει έκθεση και συμπεριφορικά πειράματα, μείωση συμπεριφορών ασφάλειας και αυτοεστιασμένης προσοχής και γνωσιακή επεξεργασία των προβλέψεων για αρνητική αξιολόγηση.

Αν προτιμάται ή χρειάζεται φαρμακοθεραπεία, οι SSRIs είναι η βασική φαρμακολογική επιλογή, με εναλλακτικές στρατηγικές άλλου SSRI ή SNRI σε μη ανταπόκριση ή δυσανεξία.

Οι β-αναστολείς, όπως η προπρανολόλη, δεν αποτελούν καθιερωμένη θεραπεία της διαταραχής κοινωνικού άγχους. Μπορεί να χρησιμοποιούνται περιστασιακά off-label για περιορισμένα performance-related αυτόνομα συμπτώματα, αλλά δεν αποτελούν θεραπευτικό πυλώνα του συνδρόμου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Β-αναστολείς δεν αποτελούν standard θεραπεία της διαταραχής.
- DSM-5-TR: **performance-only specifier**: ο παλαιός επίσημος «generalized subtype» είναι ξεπερασμένος.

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η **ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD)** χαρακτηρίζεται από ιδεοληψίες, καταναγκασμούς ή και τα δύο, με σημαντική δυσφορία ή λειτουργική επιβάρυνση.

Οι **ιδεοληψίες** είναι επαναλαμβανόμενες, παρειασθητικές και ανεπιθύμητες σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις/ορμές που προκαλούν άγχος ή δυσφορία. Το άτομο συνήθως προσπαθεί να τις αγνοήσει, να αντισταθεί ή να τις εξουδετερώσει. Οι **καταναγκασμοί** είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή νοητικές πράξεις που γίνονται ως απάντηση στην ιδεοληψία ή σε άκαμπτους κανόνες για να μειωθεί η δυσφορία ή να προληφθεί ένα φοβούμενο γεγονός, παρότι είναι υπερβολικοί ή δεν συνδέονται ρεαλιστικά με αυτό το αποτέλεσμα.

Συχνά περιεχόμενα είναι μόλυνση/καθαρισμός, αμφιβολία/έλεγχος, συμμετρία/τακτοποίηση, απαγορευμένες ή αποτροπιαστικές σκέψεις και νοητικές τελετουργίες. Το περιεχόμενο όμως δεν είναι αυτό που ορίζει τη διαταραχή· μεγαλύτερη σημασία έχει η ιδεοληπτική και καταναγκαστική μορφή.

Η **εναισθησία ποικίλλει**. Μπορεί να είναι καλή, πτωχή ή και απύσχα. Επομένως πολύ ισχυρή πεποίθηση δεν σημαίνει αυτόματα παραληρητική διαταραχή όταν η πεποίθηση εντάσσεται καθαρά στη φαινομενολογία OCD και δεν υπάρχει ευρύτερο ψυχωτικό σύνδρομο.

Στη διαφορική εξετάζω ψύχωση, καταθλιπτικό μνηρυσμό, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή (GAD), ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, αυτιστικές επαναληπτικές συμπεριφορές και φαινόμενα που σχετίζονται με τικ. Η OCD ανήκει πλέον στις ιδεοψυχαναγκαστικές και συναφείς διαταραχές (OCD) και όχι στις αγχώδεις διαταραχές.

Η βασική ψυχολογική θεραπεία είναι γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία με έκθεση και παρεμπόδιση αντίδρασης (exposure and response prevention, ERP). Ο ασθενής εκτίθεται βαθμιαία στα ερεθίσματα ή στις σκέψεις που προκαλούν άγχος και εξασκείται στο να μην εκτελεί τον καταναγκασμό ή άλλη εξουδετέρωση.

Οι **SSRIs** είναι η βασική φαρμακοθεραπεία. Η ανταπόκριση στην OCD μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ό,τι στην κατάθλιψη και μια πλήρης θεραπευτική δοκιμή μπορεί να χρειαστεί έως **12 εβδομάδες**. Αν μετά από περίπου 4-6 εβδομάδες σε συνήθη δόση δεν υπάρχει επαρκές αποτέλεσμα αλλά η αγωγή είναι ανεκτή, μπορεί να γίνει σταδιακή βελτιστοποίηση προς το ανώτερο **εγκεκριμένο δοσολογικό εύρος**. Δεν χρησιμοποιώ ως ρουτίνα δόσεις SSRI πάνω από το εγκεκριμένο εύρος.

Η **κλινική παραμένει** τεκμηριωμένη μεταγενέστερη επιλογή μετά από αποτυχία ή δυσανεξία SSRI ή όταν υπήρξε προηγούμενο όφελος, αλλά έχει μεγαλύτερο αντιχολινεργικό, καρδιαγγειακό και κίνδυνο σε υπερδοσολογία. Σε ουσιαστικά ανθεκτική OCD, μετά από επαρκή SSRI και θεραπεία βασισμένη σε ERP, μπορεί εξειδικευμένα να χρησιμοποιηθεί **αντιψυχωσική ενίσχυση**. Αντιψυχωσικό

μόνο του δεν είναι καθιερωμένη θεραπεία OCD.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η OCD ανήκει στις **OCRD**, όχι στις αγχώδεις διαταραχές.
- Πλήρης δοκιμή SSRI μπορεί να χρειαστεί έως **12 εβδομάδες**.

ΠΙΘΑΝΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΉ

Πώς διακρίνετε τη διαταραχή αποθησαύρισης από την OCD;

Η διαταραχή αποθησαύρισης είναι ξεχωριστή σύγχρονη OCRD διάγνωση. Υπάρχει επίμονη δυσκολία απόρριψης αντικειμένων ανεξάρτητα από την αντικειμενική τους αξία, με συσσώρευση και ακαταστασία που περιορίζει τη χρήση των χώρων και προκαλεί δυσφορία ή έκπτωση. Η υπερβολική απόκτηση αντικειμένων είναι συχνή αλλά όχι απαραίτητη. Οι πεποιθήσεις για τη διατήρηση μπορεί να είναι περισσότερο εγωσυντονικές και η εναισθησία περιορισμένη. Διακρίνεται από φυσιολογική συλλογή, πραγματική υλική στέρηση και ακαταστασία λόγω άλλης διαταραχής. Αν χρειάζεται θεραπεία, χρησιμοποιείται ειδικά προσαρμοσμένη γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία με στόχο απόρριψη, απόκτηση, λήψη αποφάσεων και αποφυγή· δεν θεωρώ ότι η φαρμακοθεραπεία της κλασικής OCD έχει αυτόματα ισοδύναμη τεκμηρίωση.

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή μετατραυματικού στρες;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) εμφανίζεται μετά από έκθεση σε εξαιρετικά απειλητικό ή φρικτό γεγονός ή σειρά γεγονότων. Η διάγνωση απαιτεί ένα ειδικό σύνδρομο που σχετίζεται με το τραύμα και λειτουργική επιβάρυνση· δεν αρκεί το άτομο να είναι απλώς δυσφορικό μετά από μια δύσκολη εμπειρία.

Στο ICD-11 η PTSD οργανώνεται σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, **επαναβίωση του γεγονότος στο παρόν**, με αίσθηση ότι το τραύμα ξανασυμβαίνει, όπως σε έντονες παρεισφρητικές αναβιώσεις, flashbacks ή εφιάλτες. Δεν αρκεί η απλή ανάμνηση του γεγονότος. Δεύτερον, **αποφυγή σκέψεων, συναισθημάτων, προσώπων, τόπων ή καταστάσεων** που συνδέονται με το τραύμα. Τρίτον, **επίμονη αίσθηση τρέχουσας απειλής**, που μπορεί να εκφράζεται με υπερεπαγρύπνηση ή υπερβολική αντίδραση αιφνιδιασμού.

Στη διαφορική εξετάζω οξείες αντιδράσεις στο στρες, διαταραχή προσαρμογής, κατάθλιψη, άλλες αγχώδεις διαταραχές, διασχιστικά φαινόμενα, χρήση ουσιών και, όπου σχετίζεται, ιατρικές ή νευρολογικές καταστάσεις. Η χρονικότητα, η σχέση με το τραύμα και η ειδική ποιότητα της επαναβίωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες.

Το ICD-11 **Complex PTSD (CPTSD)** απαιτεί πλήρες PTSD και επιπλέον επίμονες διαταραχές στην οργάνωση του εαυτού: δυσκολίες στη ρύθμιση του συναισθήματος, σταθερά αρνητική εικόνα για τον εαυτό και δυσκολίες στις σχέσεις. Δεν είναι απλώς «πολύ σοβαρό PTSD» και δεν ταυτίζεται με οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

Η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι **τραυματοεστιασμένη ψυχοθεραπεία**. Η ατομική trauma-focused CBT αποτελεί βασική επιλογή και το **Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)** είναι επίσης καθιερωμένη θεραπεία πρώτης γραμμής στους ενήλικες. Η θεραπεία περιλαμβάνει επεξεργασία των τραυματικών αναμνήσεων και των σχετικών νοημάτων, καθώς και μείωση της αποφυγής.

Όταν η ψυχοθεραπεία είναι αποδεκτή και διαθέσιμη, δεν προτιμώ ρουτίνα το φάρμακο αντί της τραυματοεστιασμένης θεραπείας. Αν ο ασθενής προτιμά φαρμακοθεραπεία ή υπάρχει σχετική κλινική ανάγκη, **SSRI ή βενλαφαξίνη** είναι εύλογες επιλογές.

Δεν προσφέρω ρουτίνα εφάπαξ ψυχολογικό **debriefing** ως πρόληψη ή θεραπεία της PTSD, καθώς δεν αποτελεί συνιστώμενη παρέμβαση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- ICD-11 PTSD: επαναβίωση στο παρόν + αποφυγή + τρέχουσα απειλή.
- ICD-11 CPTSD: PTSD + συναισθηματική απορρύθμιση + αρνητική αυτοεικόνα + δυσκολίες σχέσεων.
- Το DSM-5-TR δεν έχει ξεχωριστή διάγνωση CPTSD.

Πώς διακρίνετε την οξεία διαταραχή στρες από τη διαταραχή προσαρμογής;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εδώ χρειάζεται πρώτα να ξεχωρίσω **DSM-5-TR** από **ICD-11**, γιατί δεν χρησιμοποιούν την ίδια αρχιτεκτονική για τις οξείες αντιδράσεις μετά από τραύμα.

Στο **DSM-5-TR**, η **οξεία διαταραχή στρες (Acute Stress Disorder, ASD)** είναι ψυχική διαταραχή μετά από έκθεση σε qualifying τραύμα. Απαιτούνται τουλάχιστον **9 συμπτώματα** από τις κατηγορίες παρεισφρητικών συμπτωμάτων, αρνητικής διάθεσης, διάσχισης, αποφυγής και υπερδιέγερσης, με κλινικά σημαντική δυσφορία ή λειτουργική έκπτωση και κατάλληλους αποκλεισμούς. Η διάρκεια είναι **από 3 ημέρες έως 1 μήνα μετά το τραύμα**.

Στο **ICD-11** δεν υπάρχει αντίστοιχη ψυχιατρική διάγνωση «acute stress disorder». Η **Acute Stress Reaction** περιγράφεται ως παροδική αντίδραση μέσα στο φυσιολογικό εύρος μετά από εξαιρετικό στρες και **δεν ταξινομείται ως ψυχική διαταραχή**. Συνήθως εμφανίζεται γρήγορα και υποχωρεί μέσα σε ημέρες ή περίπου μία εβδομάδα καθώς μειώνεται η απειλή.

Η **διαταραχή προσαρμογής** είναι διαφορετική. Μπορεί να ακολουθήσει πολύ ευρύτερο αναγνωρίσιμο ψυχοκοινωνικό στρεσογόνο παράγοντα και δεν απαιτεί qualifying trauma. Στο **ICD-11** χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από **έντονη ενασχόληση με τον στρεσογόνο παράγοντα ή τις συνέπειές του και αποτυχία προσαρμογής**, με λειτουργική έκπτωση.

Η **διαταραχή προσαρμογής** συνήθως εμφανίζεται μέσα σε περίπου **1 μήνα** από τον στρεσογόνο παράγοντα και τείνει να υποχωρεί μέσα σε **6 μήνες μετά το τέλος του στρεσογόνου παράγοντα ή των συνεπειών του**, εκτός αν ο παράγοντας συνεχίζεται.

Το **DSM ASD** είναι **τραυματοειδικό σύνδρομο στο παράθυρο 3 ημερών–1 μήνα**, ενώ η **διαταραχή προσαρμογής** μπορεί να προκύψει από ευρύτερους στρεσογόνους παράγοντες και οργανώνεται γύρω από δυσανάλογη ενασχόληση και δυσκολία προσαρμογής, όχι από το ειδικό μετατραυματικό σύμπλεγμα του ASD.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR ASD: ≥9 συμπτώματα, 3 ημέρες–1 μήνας.**
- **ICD-11 Acute Stress Reaction: όχι ψυχική διαταραχή.**
- **Adjustment disorder: συνήθως έναρξη εντός ~1 μήνα και υποχώρηση εντός 6 μηνών μετά τη λήξη του στρεσογόνου παράγοντα/συνεπειών, αν δεν επιμένει.**

Ποιες είναι οι κύριες διασχιστικές διαταραχές και πώς τις αξιολογείτε;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι διασχιστικές διαταραχές αφορούν διαταραχές στη φυσιολογική ολοκλήρωση της συνείδησης, της μνήμης, της ταυτότητας, της αίσθησης εαυτού και της εκούσιας λειτουργίας. Στην αξιολόγηση ξεκινώ από την ακριβή φαινομενολογία και όχι από την υπόθεση ότι κάθε ασυνήθιστη εμπειρία μετά από τραύμα είναι διασχιστική.

Στην **αποπροσωποποίηση**, ο ασθενής βιώνει αίσθημα απομάκρυνσης ή μη πραγματικότητας σχετικά με τον εαυτό του, το σώμα, τις σκέψεις ή τα συναισθήματά του. Στην **αποπραγματοποίηση**, η αίσθηση μη πραγματικότητας αφορά το περιβάλλον. Ο έλεγχος πραγματικότητας συνήθως διατηρείται· ο ασθενής αναγνωρίζει ότι πρόκειται για αλλοίωση της εμπειρίας και όχι κατ' ανάγκη για κυριολεκτική αλλαγή της πραγματικότητας.

Η **διασχιστική αμνησία** είναι αδυναμία ανάκλησης σημαντικών αυτοβιογραφικών πληροφοριών που δεν εξηγείται από συνηθισμένη λήθη και τίθεται αφού αποκλειστούν άλλες αιτίες. Στο ICD-11 η **διασχιστική φυγή (fugue)** δεν είναι ξεχωριστή διαταραχή αλλά προσδιοριστής της διασχιστικής αμνησίας.

Η **διασχιστική διαταραχή ταυτότητας** περιλαμβάνει κλινικά σημαντική ασυνέχεια ή διαταραχή της ταυτότητας με σχετικά φαινόμενα μνήμης, αίσθησης αυτενέργειας και εμπειρίας του εαυτού.

Στο ICD-11 η διασχιστική νευρολογική συμπτωματολογία εντάσσεται επίσης στην ομάδα των διασχιστικών διαταραχών. Αυτό διαφέρει από το DSM-5-TR, όπου η λειτουργική νευρολογική διαταραχή βρίσκεται στις Somatic Symptom and Related Disorders.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των επεισοδίων, έναρξη, διάρκεια, εκλυτικούς παράγοντες, επίπεδο συνείδησης, μνήμη πριν, κατά και μετά το επεισόδιο, αίσθηση αυτενέργειας και λειτουργικές συνέπειες. Πρωτό για τραύμα ή άλλο πλαίσιο όταν είναι σχετικό, χωρίς να θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί τραύμα για να είναι δυνατή η διάγνωση. Παίρνω πληροφορίες από το περιβάλλον όπου βοηθούν, κάνω εξέταση ψυχικής κατάστασης και οργανώνω νευρολογική εκτίμηση και φαρμακευτικό/ουσιολογικό ιστορικό.

Η διαφορική περιλαμβάνει επιληψία, συγκοπή, ντελίριο, διαταραχές ύπνου, PTSD, άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, ουσίες και νευρολογικά νοσήματα ανάλογα με το φαινόμενο. Λαμβάνω επίσης υπόψη το **πολιτισμικό πλαίσιο**, ιδιαίτερα σε εμπειρίες κατοχής, έκστασης ή άλλων αλλοιωμένων καταστάσεων συνείδησης, ώστε να μην παθολογικοποιώ πολιτισμικά αποδεκτές εμπειρίες. Η διάγνωση δεν τίθεται απλώς επειδή MRI, EEG ή άλλες εξετάσεις είναι φυσιολογικές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Αποπροσωποποίηση/αποπραγματοποίηση: ο έλεγχος πραγματικότητας συνήθως διατηρείται.
- ICD-11: dissociative fugue = **qualifier** της διασχιστικής αμνησίας, όχι ξεχωριστή διάγνωση.
- ICD-11 εντάσσει τη λειτουργική νευρολογική συμπτωματολογία στις διασχιστικές διαταραχές· το DSM-5-TR όχι.

Πώς διακρίνετε τη διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων από τη διαταραχή άγχους ασθένειας;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο DSM-5-TR, η βασική διάκριση είναι αν το κέντρο του προβλήματος είναι το ίδιο το σωματικό σύμπτωμα και η υπερβολική ανταπόκριση σε αυτό ή κυρίως ο φόβος ότι υπάρχει σοβαρή νόσος ενώ τα σωματικά συμπτώματα είναι απόντα ή ήπια.

Στη διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων (Somatic Symptom Disorder, SSD) υπάρχει ένα ή περισσότερα σωματικά συμπτώματα που προκαλούν ουσιαστική δυσφορία ή διαταράσσουν τη ζωή και συνοδεύονται από δυσανάλογες ή υπερβολικές σκέψεις, άγχος ή συμπεριφορές γύρω από τα συμπτώματα και την υγεία.

Τα συμπτώματα δεν χρειάζεται να είναι ιατρικά ανεξήγητα. Ένας ασθενής μπορεί να έχει πραγματική σωματική νόσο και ταυτόχρονα SSD, αν η γνωσιακή, συναισθηματική και συμπεριφορική απάντηση στα συμπτώματα είναι υπερβολική και δυσλειτουργική.

Στη διαταραχή άγχους ασθένειας (Illness Anxiety Disorder, IAD) κυριαρχεί η επίμονη ενασχόληση με την πιθανότητα να έχει ή να αποκτήσει σοβαρή νόσο, ενώ τα σωματικά συμπτώματα είναι απόντα ή σχετικά ήπια. Υπάρχει υψηλό άγχος υγείας και συχνά επαναλαμβανόμενος αυτοέλεγχος, αναζήτηση ιατρικών διαβεβαιώσεων ή, αντίθετα, αποφυγή ιατρικής φροντίδας λόγω φόβου.

Άρα όταν η ουσιαστική επιβάρυνση από σωματικά συμπτώματα είναι το κεντρικό πρόβλημα, SSD ταιριάζει περισσότερο. Όταν κυριαρχεί ο φόβος της νόσου με ελάχιστη σωματική συμπτωματολογία, IAD είναι πιο χαρακτηριστική.

Το ICD-11 δεν αντιστοιχεί άμεσα σε αυτές τις DSM κατηγορίες. Η **bodily distress disorder** περιλαμβάνει ενοχλητικά σωματικά συμπτώματα μαζί με υπερβολική προσοχή/ενασχόληση και impairment, επίσης χωρίς να απαιτεί απουσία ιατρικής εξήγησης. Η υποχονδρία/health anxiety στο ICD-11 τοποθετείται κυρίως στις ιδεοψυχαναγκαστικές και συναφείς διαταραχές, με cross-listing στις anxiety/fear-related disorders.

Στη διαχείριση επικυρώνω ότι τα συμπτώματα είναι πραγματικά και δυσφορικά χωρίς να επιβεβαιώνω καταστροφικές ερμηνείες. Προτιμώ **συνέχεια με σταθερό γιατρό ή ομάδα, προγραμματισμένες επανεκτιμήσεις και αναλογικό αντί επαναλαμβανόμενου ανεξέλεγκτου ελέγχου**. Αντιμετωπίζω συνυπάρχουσα κατάθλιψη, άγχος ή σωματική νόσο και δημιουργώ συνεργατική βιοψυχοκοινωνική διατύπωση.

Η διάγνωση δεν πρέπει να οδηγεί σε διαγνωστική αδιαφορία. **Νέα, μεταβαλλόμενα ή ανησυχητικά σωματικά ευρήματα** χρειάζονται κανονική ιατρική επανεκτίμηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- SSD δεν απαιτεί ιατρικά ανεξήγητα συμπτώματα και μπορεί να συνυπάρχει με πραγματική σωματική νόσο.
- IAD: κυρίαρχος φόβος σοβαρής νόσου με απόντα ή ήπια σωματικά συμπτώματα.
- DSM SSD/IAD και ICD-11 bodily distress disorder/hypochondriasis δεν είναι άμεσα ισοδύναμες κατηγορίες.

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη λειτουργική νευρολογική διαταραχή;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η λειτουργική νευρολογική διαταραχή (Functional Neurological Disorder, FND) είναι σύγχρονα **θετική διάγνωση**. Δεν τη θέτω απλώς επειδή MRI, EEG ή άλλες εξετάσεις είναι φυσιολογικές και δεν τη θεωρώ εξ ορισμού ψυχογενή.

Η κλινική εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει **λειτουργική αδυναμία ή διαταραχή βάδισης, κινητικές διαταραχές, αισθητικά συμπτώματα, διαταραχές ομιλίας/επικοινωνίας και λειτουργικές κρίσεις**. Η διάγνωση στηρίζεται σε θετικά κλινικά σημεία εσωτερικής ασυνέπειας ή ασυμβατότητας με αναγνωρισμένη νευρολογική νόσο, όταν αυτά χρησιμοποιούνται στο σωστό φαινοτυπικό πλαίσιο.

Για παράδειγμα, στη λειτουργική αδυναμία μπορούν να βοηθήσουν το **Hoover sign** ή το **hip-abductor sign**. Σε λειτουργικό τρόπο μπορεί να παρατηρούνται **μεταβλητότητα, distractibility και entrainment**. Δεν χρησιμοποιώ όμως ένα μεμονωμένο σημείο μηχανικά έξω από το κατάλληλο κλινικό πλαίσιο.

Στις **λειτουργικές κρίσεις**, η προσεκτική σημειολογία είναι ουσιαστική. Όταν υπάρχει διαγνωστική αβεβαιότητα, video-EEG τυπικού επεισοδίου είναι χρήσιμο όπου είναι εφικτό. Ταυτόχρονα θυμάμαι ότι λειτουργικές κρίσεις και επιληψία μπορούν να συνυπάρχουν.

Δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί **ψυχολογικό τραύμα ή οξύς στρεσογόνος παράγοντας**. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να έχουν ρόλο στη διατύπωση ορισμένων ασθενών, αλλά δεν αποτελούν διαγνωστική προϋπόθεση και δεν πρέπει να επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση.

Η θεραπεία αρχίζει ήδη με τον τρόπο που εξηγείται η διάγνωση. Λέω καθαρά ότι τα συμπτώματα είναι **πραγματικά, ακούσια και δυνητικά σημαντικά**, και εξηγώ ποια θετικά ευρήματα έδειξαν διαταραχή του τρόπου λειτουργίας ή ελέγχου του νευρικού συστήματος. Όπου είναι δυνατό, τα θετικά σημεία μπορούν να δείξουν ότι υπάρχει διατηρημένη δυνατότητα φυσιολογικής κίνησης και άρα περιθώριο επανεκπαίδευσης.

Σε κινητικούς φαινοτύπους, η **εξειδικευμένη φυσικοθεραπεία/αποκατάσταση για FND** στοχεύει στην επανεκπαίδευση πιο αυτόματης κίνησης, στη μετατόπιση της υπερβολικής αυτοεστιασμένης προσοχής, στην ανάδειξη διατηρημένης φυσιολογικής λειτουργίας και στη μείωση δυσλειτουργικών προτύπων κίνησης και αποφυγής. Ανάλογα με τον φαινότυπο μπορεί να χρειάζονται εργοθεραπεία ή λογοθεραπεία. Ψυχολογική θεραπεία χρησιμοποιείται όταν ενδείκνυται για τα λειτουργικά συμπτώματα ή για σχετική συννοσηρότητα.

Η φροντίδα είναι καλύτερα **κοινή** μεταξύ νευρολογίας και ψυχιατρικής/ψυχολογίας αντί ο ασθενής να μεταφέρεται από τη μία ειδικότητα στην άλλη επειδή «δεν ανήκει» σε καμία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- FND = **θετική, rule-in διάγνωση**· φυσιολογικές εξετάσεις και ψυχολογικό στρες δεν αποτελούν διαγνωστικές προϋποθέσεις.
- Λειτουργικές κρίσεις και επιληψία μπορούν να **συνυπάρχουν**· video-EEG τυπικού επεισοδίου βοηθά όταν υπάρχει αβεβαιότητα.
- ICD-11: dissociative neurological symptom disorder· DSM-5-TR: FND στις Somatic Symptom and Related Disorders.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς εξηγείτε τη διάγνωση στον ασθενή;

Ονομάζω τη διάγνωση καθαρά και λέω ότι τα συμπτώματα είναι πραγματικά και ακούσια. Εξηγώ γιατί την έθεσα από **θετικά κλινικά σημεία**, όχι λέγοντας «δεν βρήκαμε τίποτα». Περιγράφω πρόβλημα λειτουργίας και ελέγχου του νευρικού συστήματος, όχι αναγκαστικά δομική βλάβη, και συνδέω αμέσως την εξήγηση με τη δυνατότητα επανεκπαίδευσης και θεραπειάς. Αποφεύγω φράσεις όπως «είναι όλα ψυχολογικά» ή «το προκάλεσε το τραύμα» αν αυτό δεν προκύπτει από τη συγκεκριμένη διατύπωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς διακρίνετε FND, πλασματική διαταραχή και προσποίηση;

Στην FND τα συμπτώματα δεν παράγονται εκούσια. Στην **πλασματική διαταραχή** υπάρχει σκόπιμη παραποίηση ή πρόκληση συμπτωμάτων με εξαπάτηση και παρουσίαση του εαυτού ή άλλου ως ασθενούς, χωρίς εμφανές εξωτερικό όφελος. Στην **προσποίηση (malingering)** υπάρχει σκόπιμη παραγωγή ή υπερβολή συμπτωμάτων για αναγνωρίσιμο εξωτερικό κίνητρο και δεν αποτελεί από μόνη της ψυχιατρική διαταραχή. Δεν συμπεραίνω πρόθεση ή κίνητρο μόνο από ασυνέπεια, ασυνήθιστη συμπτωματολογία, πιθανό δευτερογενές όφελος ή κλινική καχυποψία· χρειάζεται τεκμηρίωση σκόπιμης εξαπάτησης.

Πώς αξιολογείτε και διατυπώνετε μια διαταραχή χρήσης ουσιών;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αξιολόγηση μιας διαταραχής χρήσης ουσιών δεν περιορίζεται στο «πόσο πίνει ή πόσο χρησιμοποιεί». Θέλω να καταλάβω **ποιο είναι το πρότυπο χρήσης, αν υπάρχει εξάρτηση ή άλλο σύνδρομο σχετιζόμενο με τη χρήση ουσιών, ποιες βλάβες έχουν ήδη εμφανιστεί, ποιοι είναι οι άμεσοι κίνδυνοι και τι στόχο έχει ο ίδιος ο ασθενής.**

Καταγράφω όλες τις ουσίες που χρησιμοποιεί: αλκοόλ, κάνναβη, διεγερτικά, οπιοειδή, κατασταλτικά, νικοτίνη, νέες ψυχοδραστικές ουσίες, αλλά και **συνταγογραφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα φάρμακα**. Ρωτώ ποσότητα, συχνότητα, οδό χορήγησης, διάρκεια, πλαίσιο, μεταβολές με τον χρόνο και πολυχρήση, επειδή ο κίνδυνος συχνά προκύπτει από τον συνδυασμό ουσιών και όχι από μία ουσία μόνη της.

Εξετάζω **τοξίκωση και στερητικά συμπτώματα**, έντονη επιθυμία για χρήση (craving), απώλεια ελέγχου, προτεραιοποίηση της ουσίας έναντι άλλων δραστηριοτήτων, ανοχή, επιμονή της χρήσης παρά τις βλάβες και προηγούμενες προσπάθειες μείωσης ή αποχής. Αυτά με βοηθούν να χαρακτηρίσω τη βαρύτητα και τη φύση του συνδρόμου χωρίς να περιορίζομαι στον παλιό ICD-10 κατάλογο 3 από 6 κριτηρίων.

Αξιολογώ τις **συνέπειες** σε πολλούς τομείς: ψυχιατρικά συμπτώματα ή επιδείνωση υπάρχουσας νόσου, ηπατική ή άλλη σωματική νοσηρότητα, λοιμώξεις, τραυματισμούς, σχέσεις, εργασία, οικονομικά και νομικά προβλήματα. Αν υπάρχει **ενέσιμη χρήση**, εξετάζω ειδικά λοιμώξεις και πρακτικές μείωσης βλάβης.

Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει **υπερδοσολογία, προηγούμενους στερητικούς σπασμούς ή παραλήρημα, αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικότητα, βία, παραμέληση, ζητήματα προστασίας ευάλωτων προσώπων, οδήγηση και επαγγελματικό κίνδυνο**. Η πρόσφατη μείωση ανοχής μετά από αποχή ή αποτοξίνωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κίνδυνο υπερδοσολογίας.

Όπου χρειάζεται, παίρνω πληροφορίες από το περιβάλλον και χρησιμοποιώ στοχευμένες εξετάσεις ή τοξικολογικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την κλινική εικόνα αλλά δεν αντικαθιστούν το ιστορικό ούτε αποδεικνύουν από μόνα τους αιτιότητα.

Ρωτώ τι έχει συμβεί σε προηγούμενες προσπάθειες θεραπείας ή αποχής, τι λειτούργησε, τι οδήγησε σε υποτροπή και ποιος είναι ο σημερινός στόχος: αποχή, μείωση, σταθεροποίηση ή άμεση μείωση βλάβης. Η **κινητοποίηση δεν είναι σταθερό χαρακτηριστικό προσωπικότητας**· μπορεί να μεταβάλλεται και να αποτελεί θεραπευτικό στόχο.

Η τελική διατύπωση ενσωματώνει το σύνδρομο χρήσης ουσιών, ψυχιατρική και σωματική συννοσηρότητα, παράγοντες που διατηρούν τη χρήση, κινδύνους,

προστατευτικούς παράγοντες και συγκεκριμένες ανάγκες μείωσης βλάβης και θεραπείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Το ICD-11 χρησιμοποιεί ευρύτερη ταξινομική αρχιτεκτονική, ειδική ανά ουσία, από το παλιό ICD-10 «3 από 6» για το σύνδρομο εξάρτησης.
- Η επικίνδυνη χρήση (**hazardous use**) είναι κατηγορία κινδύνου, όχι ψυχική διαταραχή.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι προσέχετε στη διακοπή καπνίσματος σε ασθενή με σχιζοφρένεια;

Προσφέρω ενεργά θεραπεία διακοπής. Η επαγωγή του **CYP1A2** προκαλείται από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες του καπνού και όχι από τη νικοτίνη. Η απότομη μείωση ή διακοπή καπνίσματος μπορεί μέσα σε λίγες ημέρες — συχνά περίπου **3–5 ημέρες** — να αυξήσει σημαντικά την έκθεση στην κλοζαπίνη και επίσης να επηρεάσει την ολανζαπίνη. Η νικοτινική υποκατάσταση ή το άτμισμα νικοτίνης δεν διατηρούν αυτή την επαγωγή. Χρειάζονται κλινική παρακολούθηση, εξειδικευμένη επανεκτίμηση και, όπου είναι χρήσιμη, μέτρηση επιπέδων φαρμάκου (therapeutic drug monitoring, TDM), όχι μία καθολική ποσοστιαία μείωση δόσης. Αν ο ασθενής ξαναρχίσει να καπνίζει, τα επίπεδα μπορεί να πέσουν και να μειωθεί η αποτελεσματικότητα. Η **βαρενικλίνη** και η **θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης (NRT)** είναι νόμιμες θεραπευτικές επιλογές· η **βουπροπιόνη** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μετά από εξατομικευμένο έλεγχο αντενδείξεων.

Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε το στερητικό σύνδρομο από αλκοόλ;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το **στερητικό σύνδρομο από αλκοόλ** εμφανίζεται μετά από σημαντική μείωση ή διακοπή της κατανάλωσης, συνήθως σε άτομα με **παρατεταμένη και βαριά χρήση αλκοόλ, συχνά στο πλαίσιο εξάρτησης**. Η συνήθης εικόνα περιλαμβάνει **τρόμο, εφίδρωση, ταχυκαρδία, άγχος, αϋπνία, ναυτία και παροδικές αντιληπτικές διαταραχές**. Οι σοβαρότερες επιπλοκές είναι οι **στερητικοί σπασμοί** και το **delirium tremens**.

Από την αρχή εκτιμώ τόσο τη **βαρύτητα των συμπτωμάτων στέρησης** όσο και τον **κίνδυνο επιπλεγμένης στέρησης**. Η ένταση των συμπτωμάτων, η υπερδραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, η σύγχυση, οι αντιληπτικές διαταραχές και οι σπασμοί καθορίζουν την τρέχουσα βαρύτητα. Παράλληλα αναζητώ παράγοντες κινδύνου για σοβαρή πορεία, κυρίως προηγούμενο **delirium tremens** ή **στερητικούς σπασμούς**, επανειλημμένα σοβαρά επεισόδια στέρησης, σημαντική σωματική ή ψυχιατρική συννοσηρότητα, ευπάθεια, ανεπαρκή υποστήριξη και ταυτόχρονη στέρηση άλλων κατασταλτικών ουσιών. Από τη συνολική εκτίμηση κρίνω αν απαιτείται νοσηλεία και στενή παρακολούθηση.

Η βασική φαρμακευτική θεραπεία είναι οι **βενζοδιαζεπίνες**. Το θεραπευτικό σχήμα προσαρμόζεται στη βαρύτητα των συμπτωμάτων, στον κίνδυνο επιπλοκών και στη δυνατότητα παρακολούθησης του ασθενούς. Σε κατάλληλα επιλεγμένη εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί **σταθερό μειούμενο σχήμα**, ενώ σε επιτηρούμενο περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί **σχήμα προσαρμοζόμενο στα συμπτώματα**, με συχνή επανεκτίμηση. Σε σημαντική ηπατική δυσλειτουργία προτιμώνται συχνά **λοραζεπάμη ή οξαζεπάμη**.

Η **CIWA-Ar** (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, Revised) μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά για την εκτίμηση και την παρακολούθηση των συμπτωμάτων. Δεν αντικαθιστά την κλινική κρίση και δεν είναι αξιόπιστη όταν υπάρχει παραλήρημα, σοβαρή γνωστική διαταραχή ή αδυναμία επαρκούς συνεργασίας.

Παράλληλα γίνεται **ιατρική εκτίμηση και υποστηρικτική αντιμετώπιση**, με έλεγχο της ενυδάτωσης, των ηλεκτρολυτών και της θρέψης, αναζήτηση τραυματισμών ή άλλων οξέων ιατρικών προβλημάτων και χορήγηση **θειαμίνης** ανάλογα με τον κίνδυνο.

Το **delirium tremens** είναι η σοβαρότερη μορφή στερητικού συνδρόμου από αλκοόλ. Χαρακτηρίζεται από **παραλήρημα, έντονη υπερδραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, ψυχοκινητική διέγερση και συχνά έντονες αντιληπτικές διαταραχές** και αποτελεί ιατρικό επείγον.

Αντιμετωπίζεται **νοσοκομειακά, με στενή παρακολούθηση και βενζοδιαζεπίνες**, παράλληλα με υποστηρικτική αγωγή και διόρθωση των συνοδών ιατρικών διαταραχών.

Η εγκεφαλοπάθεια Wernicke πρέπει να αναγνωρίζεται έγκαιρα, ιδίως σε ασθενείς με χρόνια βαριά χρήση αλκοόλ ή υποθρεψία. Η κλασική τριάδα είναι μεταβολή της νοητικής κατάστασης, οφθαλμοκινητικές διαταραχές και αταξία, αλλά η πλήρης τριάδα συχνά απουσιάζει και δεν απαιτείται για να ξεκινήσει θεραπεία.

Σε κλινική υποψία Wernicke χορηγώ άμεσα θειαμίνη 300–500 mg ενδοφλεβίως τρεις φορές ημερησίως για 3–5 ημέρες. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συνεχίζεται 300–500 mg ενδοφλεβίως ημερησίως για επιπλέον 3–5 ημέρες ή όσο συνεχίζεται η βελτίωση, και στη συνέχεια από του στόματος θειαμίνη. Η θειαμίνη χορηγείται πριν ή μαζί με υδατάνθρακες όταν είναι εφικτό, αλλά η αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας δεν καθυστερεί. Ελέγχω επίσης και διορθώνω υπομαγνησισαίμια.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 **Βαρύτητα/κίνδυνος** → κατάλληλο πλαίσιο → βενζοδιαζεπίνες → CIWA-Ar ως βοήθημα → θειαμίνη → DT/Wernicke

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η CIWA-Ar είναι βοήθημα παρακολούθησης· δεν αντικαθιστά την κλινική κρίση και δεν είναι αξιόπιστη σε παραλήρημα ή ανεπαρκή συνεργασία.
- Υποπτη Wernicke: IV θειαμίνη 300–500 mg ×3/ημέρα για 3–5 ημέρες, χωρίς αναμονή για πλήρη τριάδα ή απεικόνιση.
- Η θεραπεία υπογλυκαιμίας δεν καθυστερεί για να προηγηθεί η θειαμίνη.

Πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης αλκοόλ μετά την αποτοξίνωση;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αποτοξίνωση δεν αποτελεί ολοκληρωμένη θεραπεία της διαταραχής χρήσης αλκοόλ. Μετά τη στέρηση χρειάζεται σχέδιο πρόληψης υποτροπής που να συνδέει τον προσωπικό στόχο του ασθενούς με ψυχοκοινωνική θεραπεία, φαρμακοθεραπεία όπου ενδείκνυται και αντιμετώπιση των ιατρικών και κοινωνικών συνεπειών της χρήσης.

Συμφωνώ πρώτα τον θεραπευτικό στόχο: **αποχή ή μείωση της κατανάλωσης**, ανάλογα με τη βαρύτητα, τις βλάβες, την ιατρική κατάσταση, προηγούμενες προσπάθειες και τις προτιμήσεις του ασθενούς. Σε ορισμένους ασθενείς η αποχή είναι ο σαφέστερος και ασφαλέστερος στόχος, ενώ σε άλλους μπορεί να είναι ρεαλιστικός ένας οργανωμένος στόχος μείωσης.

Η ψυχοκοινωνική θεραπεία είναι βασικός άξονας. Μπορεί να περιλαμβάνει **κινητοποιητική συνέντευξη, CBT ή άλλες συμπεριφορικές παρεμβάσεις, εργασία με το κοινωνικό δίκτυο ή την οικογένεια και αλληλοβοήθεια** όταν ταιριάζει στον ασθενή. Παράλληλα δουλεύω εκλυτικούς παράγοντες, craving, σχέδιο για υψηλού κινδύνου καταστάσεις και λειτουργική αποκατάσταση.

Οι κύριες φαρμακευτικές επιλογές για πρόληψη υποτροπής μετά την αποτοξίνωση είναι η **ακαμπροσάτη** και η **από του στόματος ναλτρεξόνη**. Δεν τις επιλέγω μηχανικά: συνεκτιμώ ηπατική και νεφρική λειτουργία, τρέχουσα ή πιθανή ανάγκη για οπιοειδή, συμμόρφωση, προηγούμενη ανταπόκριση, αντενδείξεις και τον συμφωνημένο στόχο.

Η **δισουλφιράμη** είναι πιο επιλεγμένη θεραπεία, κυρίως όταν ο στόχος είναι αποχή, οι συνήθειες πρώτες επιλογές δεν είναι κατάλληλες ή ο ασθενής την προτιμά και μπορεί να υπάρχει ασφαλής επίβλεψη. Χρειάζεται σαφής ενημέρωση για την αντίδραση με το αλκοόλ και για τις σχετικές προφυλάξεις.

Η **ναλμεφένη** παραμένει reduction-oriented επιλογή για συγκεκριμένο υποσύνολο ασθενών που δεν χρειάζονται άμεση αποτοξίνωση. Δεν τη μεταφέρω μηχανικά σε κάθε ασθενή μετά από σύνδρομο στέρησης.

Για ακαμπροσάτη ή ναλτρεξόνη, περίπου **6 μήνες** είναι χρήσιμο θεραπευτικό σημείο αναφοράς, όχι υποχρεωτική ημερομηνία διακοπής. Η διάρκεια εξατομικεύεται ανάλογα με ανταπόκριση, υποτροπές, συνεχιζόμενο κίνδυνο και συνολικό θεραπευτικό πλάνο.

Παρακολουθώ παράλληλα ηπατική και άλλη σωματική υγεία, διατροφή, ψυχιατρική συννοσηρότητα, αυτοκτονικότητα, σχέσεις, εργασία και κοινωνικές βλάβες. Η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε ημέρες αποχής αλλά και σε μείωση βλάβης και αποκατάσταση της λειτουργικότητας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Αποτοξίνωση ≠ ολοκληρωμένη θεραπεία της διαταραχής χρήσης αλκοόλ.

- Ακαμπροσάτη ή από του στόματος ναλτρεξόνη είναι κύριες επιλογές πρόληψης υποτροπής· δισουλφιράμη χρησιμοποιείται επιλεγμένα.
- Περίπου 6 μήνες είναι χρήσιμο σημείο αναφοράς για ακαμπροσάτη/ναλτρεξόνη, όχι υποχρεωτική ημερομηνία διακοπής.

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης οπιοειδών;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στη διαταραχή χρήσης οπιοειδών πρέπει να ξεχωρίσω την **οξεία υπερδοσολογία**, το στερητικό σύνδρομο και τη μακροχρόνια θεραπεία της εξάρτησης. Η αποτοξίνωση μόνη της δεν είναι η προτιμώμενη μακροχρόνια στρατηγική για πολλούς ασθενείς, επειδή μετά την απώλεια ανοχής αυξάνεται ο κίνδυνος θανατηφόρας υπερδοσολογίας σε υποτροπή.

Σε πιθανή υπερδοσολογία αναζητώ **μειωμένο επίπεδο συνείδησης και αναπνευστική καταστολή**, συχνά μαζί με μύση. Προτεραιότητα είναι η υποστήριξη αεραγωγού και αερισμού και η χορήγηση **ναλοξόνης**. Μπορεί να χρειαστούν επαναληπτικές δόσεις και παρακολούθηση, επειδή η δράση της ναλοξόνης μπορεί να τελειώσει πριν από τη δράση του οπιοειδούς.

Το στερητικό σύνδρομο αναγνωρίζεται κλινικά από συμπτώματα όπως μυδρίαση, δακρύρροια/ρινόρροια, μυαλγίες, κοιλιακά συμπτώματα, διάρροια, ανησυχία και ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Είναι έντονα δυσφορικό, αλλά το κεντρικό μακροχρόνιο ζήτημα είναι να μη θεωρήσουμε ότι η επιτυχής αποτοξίνωση ολοκληρώνει τη θεραπεία.

Η **θεραπεία αγωνιστών οπιοειδών (opioid agonist treatment, OAT)** με **μεθαδόνη** ή **βουπρενορφίνη** αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπεία συντήρησης. Η μεθαδόνη απαιτεί προσεκτική έναρξη και σταδιακή αύξηση λόγω κινδύνου συσσώρευσης και αναπνευστικής καταστολής, με προσοχή σε αλληλεπιδράσεις και QT όπου σχετίζεται.

Η βουπρενορφίνη μπορεί να προκαλέσει **προκλητή στέρηση** αν δοθεί ενώ υπάρχει ακόμη σημαντική δράση πλήρους αγωνιστή. Επομένως την ξεκινώ όταν υπάρχει κλινικά σημαντικό στερητικό σύνδρομο και όχι με ένα μηχανικό ενιαίο αριθμό ωρών ή μία καθολική βαθμολογία στην **Clinical Opiate Withdrawal Scale (COWS)** για κάθε οπιοειδές.

Κάθε ασθενής υψηλού κινδύνου πρέπει να λαμβάνει **εκπαίδευση για υπερδοσολογία και πρόσβαση σε ναλοξόνη για χρήση στην κοινότητα** όπου είναι δυνατό. Στην Ελλάδα, από τον **Ιούλιο 2025**, ενδορρινική και προγεμισμένη ενέσιμη ναλοξόνη μπορούν να συνταγογραφούνται από ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας, να διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία και να χορηγούνται από οποιονδήποτε σε επείγουσα υπερδοσολογία.

Στην Ελλάδα η OAT παρέχεται μέσα από οργανωμένα προγράμματα θεραπείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Οι κανόνες επιτήρησης και διάθεσης καθορίζονται από το ισχύον ελληνικό πλαίσιο και δεν πρέπει να θεωρούνται ταυτόσημοι με εκείνους άλλων συστημάτων υγείας.

Παράλληλα ελέγχω τον κίνδυνο από ενέσιμη χρήση: **HBV, HCV και HIV**, **εμβολιασμό και έλεγχο** όπου ενδείκνυνται, **λοιμώξεις δέρματος**, **ενδοκαρδίτιδα** και **ασφαφέστερο εξοπλισμό ένεσης**. Η θεραπεία περιλαμβάνει επίσης ψυχιατρική

συννοσηρότητα, στέγαση, κοινωνική υποστήριξη και άλλες ανάγκες μείωσης βλάβης.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Υπερδοσολογία/ναλοξόνη → ΟΑΤ → ασφαλής έναρξη μεθαδόνης/βουπρενορφίνης → ναλοξόνη στην κοινότητα → λοιμώξεις/μείωση βλάβης

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- ΟΑΤ με μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη είναι θεραπεία συντήρησης· η αποτοξίνωση μόνη της δεν είναι η προεπιλεγμένη μακροχρόνια στρατηγική.
- Απώλεια ανοχής μετά από αποτοξίνωση αυξάνει τον κίνδυνο υπερδοσολογίας σε υποτροπή.
- Ελλάδα, Ιούλιος 2025: ναλοξόνη μπορεί να συνταγογραφείται από κάθε ιατρική ειδικότητα, να διατίθεται σε ιδιωτικά φαρμακεία και να χορηγείται από οποιονδήποτε σε επείγουσα υπερδοσολογία.

Ποια ψυχιατρικά σύνδρομα που σχετίζονται με την κάνναβη πρέπει να αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης κάνναβης;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την κάνναβη πρέπει να αναγνωρίζω χωριστά τοξίκωση, στερητικό σύνδρομο, διαταραχή χρήσης και ουσιοεπαγόμενα ψυχιατρικά σύνδρομα, ιδιαίτερα ψύχωση.

Η οξεία τοξίκωση μπορεί να προκαλέσει ευφορία ή χαλάρωση, αλλά και άγχος, κρίσεις πανικού, αντιληπτικές διαταραχές, παράνοια και ψυχωτικά συμπτώματα. Η διαχείριση εξαρτάται από τη βαρύτητα, τον κίνδυνο, πιθανή πολυχρήση και τυχόν ιατρική τοξικότητα.

Η **στέρηση κάνναβης** είναι αναγνωρισμένο σύνδρομο στο ICD-11. Μπορεί να περιλαμβάνει ευερεθιστότητα, άγχος, διαταραχή ύπνου, μειωμένη όρεξη και craving. Η αναγνώρισή της είναι σημαντική γιατί μπορεί να συμβάλλει σε υποτροπή και να συγχέεται με πρωτοπαθή αγχώδη ή συναισθηματική συμπτωματολογία.

Για **ψύχωση που αποδίδεται στην κάνναβη**, χρειάζεται εύλογη χρονική σχέση με τοξίκωση ή στέρηση και η ψυχωτική εικόνα να υπερβαίνει τις συνήθεις παροδικές επιδράσεις της τοξίκωσης. Πρωτοπαθής ψυχωτική διαταραχή γίνεται πιθανότερη όταν η ψύχωση προϋπήρχε της σχετικής χρήσης, όταν επιμένει πολύ πέρα από το αναμενόμενο substance-related διάστημα ή όταν υπήρχαν προηγούμενα ανεξάρτητα επεισόδια. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό χρονικό cutoff αποχής που να αποδεικνύει από μόνο του αιτιότητα.

Η συχνή χρήση και ιδιαίτερα η χρήση **υψηλής δραστηριότητας** συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ψύχωσης και, σε εγκατεστημένη ψυχωτική διαταραχή, με δυσμενέστερη πορεία και υποτροπές. Πρόκειται για σημαντική **συσχέτιση και τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου**, όχι για ντετερμινιστική σχέση όπου η κάνναβη προκαλεί σχιζοφρένεια σε κάθε χρήστη.

Η κύρια θεραπεία της διαταραχής χρήσης κάνναβης είναι **ψυχοκοινωνική**: brief intervention, κινητοποιητική θεραπεία/MI, CBT και οικογενειακή δουλειά όπου ταιριάζει. Δεν υπάρχει μία ρουτίνα εγκεκριμένη φαρμακοθεραπεία που να αποτελεί standard treatment.

Τα **συνθετικά κανναβινοειδή** χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, επειδή μπορούν να προκαλέσουν πιο σοβαρή και απρόβλεπτη διέγερση, ψύχωση και ιατρική τοξικότητα. Στο ICD-11 ταξινομούνται χωριστά από την κάνναβη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Cannabis-induced psychosis απαιτεί **εύλογη χρονική σχέση**: δεν υπάρχει ένα fixed abstinence cutoff που αποδεικνύει αιτιότητα.
- Συχνή/high-potency χρήση σχετίζεται με αυξημένο ψυχωτικό κίνδυνο και δυσμενέστερη πορεία, **όχι ντετερμινιστικά**.

- Κύρια θεραπεία cannabis-use disorder = ψυχοκοινωνική· δεν υπάρχει standard routinely licensed pharmacotherapy.

Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε διαταραχές που σχετίζονται με διεγερτικές ουσίες;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην οξεία χρήση κοκαΐνης ή αμφεταμινών αναζητώ ένα **συμπαθητικομιμητικό σύνδρομο**: έντονη διέγερση, ταχυκαρδία και υπέρταση, εφίδρωση, μυδρίαση, παράνοια ή ψύχωση και, σε βαρύτερες περιπτώσεις, υπερθερμία, επιληπτικές κρίσεις και καρδιαγγειακές ή αγγειακές επιπλοκές.

Η προτεραιότητα είναι να μη θεωρήσω την εικόνα «μόνο ψυχιατρική». Red flags είναι **θωρακικός πόνος ή ισχαιμία, σοβαρή υπέρταση, αρρυθμία, υπερθερμία, κρίση, εστιακή νευρολογική σημειολογία, διαταραχή συνείδησης, ραβδομύωση/νεφρική βλάβη και σοβαρή ψύχωση ή αυτοκτονικότητα**.

Οι **βενζοδιαζεπίνες** αποτελούν βασική οξεία θεραπεία για έντονη διέγερση και υπεραδρενεργική κατάσταση, μαζί με ψύξη, υγρά και άλλη υποστηρικτική αγωγή ανάλογα με τις επιπλοκές. Η ακριβής αντιμετώπιση καρδιακής ισχαιμίας, σοβαρής υπέρτασης ή άλλων ιατρικών επιπλοκών γίνεται σε κατάλληλο επείγον πλαίσιο.

Η παλιά απόλυτη οδηγία «ποτέ β-αναστολέας μετά από κοκαΐνη» είναι υπερβολική. Στην οξεία τοξίκωση προτιμώνται βενζοδιαζεπίνες και αγγειοδιασταλτικές στρατηγικές, αλλά αν υπάρχει κλινική ανάγκη για β-αποκλεισμό, προτιμώνται συνδυασμένοι **α/β αναστολείς όπως labetalol ή carvedilol** αντί καθαρού β-αποκλεισμού.

Αν υπάρχει ψύχωση, αντιμετωπίζω ταυτόχρονα την **ιατρική τοξικότητα και τον ψυχιατρικό κίνδυνο**. Δεν αρκεί να χορηγήσω αντιψυχωσικό σε έναν υπερθερμικό, υπερτασικό ασθενή και να θεωρήσω ότι το πρόβλημα λύθηκε.

Μετά τη διακοπή μπορεί να εμφανιστεί **withdrawal/crash** με κόπωση, αλλαγές ύπνου, δυσφορία ή κατάθλιψη, ανηδονία και craving. Ελέγχω ιδιαίτερα αυτοκτονικότητα, επειδή η έντονη δυσφορία μετά τη χρήση μπορεί να είναι κλινικά σοβαρή.

Για τη μακροχρόνια διαταραχή χρήσης διεγερτικών, η ισχυρότερη ψυχοκοινωνική τεκμηρίωση είναι για **contingency management**, συχνά μαζί με CBT ή άλλες συμπεριφορικές παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό, καθολικά εγκεκριμένο φάρμακο που να αποτελεί standard pharmacotherapy για stimulant-use disorder.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Συμπαθητικομιμητικό toxidrome → ιατρικά red flags → βενζοδιαζεπίνες/υποστήριξη → crash/αυτοκτονικότητα → contingency management

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Το παλιό «ποτέ β-blocker μετά από κοκαΐνη» είναι υπερβολικό· αν χρειάζεται β-αποκλεισμός, προτιμώνται **συνδυασμένοι α/β παράγοντες**.

- To **contingency management** έχει την ισχυρότερη σύγχρονη τεκμηρίωση για stimulant-use disorder.

Πώς αντιμετωπίζετε την εξάρτηση και τη στέρηση από βενζοδιαζεπίνες;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η βασική αρχή είναι ότι σε ασθενή με σωματική εξάρτηση από βενζοδιαζεπίνες **δεν κάνω απότομη διακοπή**, γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρή στέρηση, συμπεριλαμβανομένων επιληπτικών κρίσεων και παραληρήματος.

Πριν αρχίσω taper εκτιμώ τη διάρκεια και τη δόση χρήσης, το συγκεκριμένο φάρμακο και τον χρόνο ημίσειας ζωής, προηγούμενες προσπάθειες μείωσης, ιστορικό σοβαρής στέρησης ή κρίσεων, ταυτόχρονη χρήση αλκοόλ ή άλλων κατασταλτικών, ιατρική και ψυχιατρική συννοσηρότητα, αυτοκτονικότητα και το διαθέσιμο υποστηρικτικό πλαίσιο. Περίπλοκη στέρηση ή σημαντικός ιατρικός/ψυχιατρικός κίνδυνος μπορεί να απαιτεί νοσοκομειακή ή residential αντιμετώπιση.

Η διακοπή γίνεται **συνεργατικά, αργά και εξατομικευμένα**. Ένα χρήσιμο αρχικό πλαίσιο είναι μείωση περίπου 5–10% της δόσης κάθε 2–4 εβδομάδες, και συνήθως να μην υπερβαίνει το 25% κάθε 2 εβδομάδες. Αυτοί δεν είναι υποχρεωτικοί ρυθμοί. Σε μακροχρόνια χρήση, υψηλές δόσεις ή ιδιαίτερα ευαίσθητους ασθενείς μπορεί να χρειάζεται πολύ πιο αργό taper, ακόμη και περίπου 5–10% κάθε 6–8 εβδομάδες ή βραδύτερα.

Αν εμφανιστούν σημαντικά στερητικά συμπτώματα, **επιβραδύνω ή παγώνω προσωρινά** την επόμενη μείωση. Δεν συνεχίζω ένα προγραμματισμένο taper μόνο και μόνο για να τηρήσω το ημερολόγιο.

Η μετάβαση σε διαζεπάμη ή άλλη βενζοδιαζεπίνη μεγαλύτερης διάρκειας δράσης μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο σε ορισμένους ασθενείς, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Σε σημαντική ηπατική δυσλειτουργία μπορεί να είναι προτιμότερη λοραζεπάμη ή οξαζεπάμη ή η διατήρηση διαφορετικής στρατηγικής αντί αυτόματης μετατροπής σε διαζεπάμη. Οι πίνακες ισοδυναμιών είναι προσεγγίσεις και όχι ακριβείς βιολογικές ισοδυναμίες.

Παράλληλα αντιμετωπίζω το πρόβλημα για το οποίο ξεκίνησε ή συνεχίζεται η βενζοδιαζεπίνη. Χρησιμοποιώ κατάλληλη θεραπεία για **άγχος, πανικό ή αϋπνία**, και όπου είναι κατάλληλο CBT ή CBT-I. Αυτό μειώνει την πιθανότητα το taper να αποτύχει επειδή το αρχικό πρόβλημα παραμένει αθεράπευτο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Χρήσιμο αρχικό taper: περίπου 5–10% κάθε 2–4 εβδομάδες, συνήθως όχι >25% κάθε 2 εβδομάδες· επιβραδύνω ή παγώνω αν εμφανίζονται σημαντικά συμπτώματα.
- Σε μακροχρόνια/ευαίσθητη περίπτωση μπορεί να χρειαστεί 5–10% κάθε 6–8 εβδομάδες ή βραδύτερα.
- Μετάβαση σε διαζεπάμη είναι **προαιρετικό εργαλείο**, όχι υποχρεωτικός κανόνας.

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη διαταραχή τζόγου;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή τζόγου στο ICD-11 ανήκει στις διαταραχές λόγω εθιστικών συμπεριφορών. Χαρακτηρίζεται από επίμονο ή επαναλαμβανόμενο πρότυπο με μειωμένο έλεγχο του τζόγου, αυξανόμενη προτεραιότητα σε σχέση με άλλες δραστηριότητες και συνέχιση ή κλιμάκωση παρά τις αρνητικές συνέπειες, με σημαντική λειτουργική επιβάρυνση.

Στο ιστορικό αναζητώ πόσο χρόνο και χρήμα καταναλώνεται, αποτυχημένες προσπάθειες περιορισμού, «κυνήγι» των απωλειών (*chasing losses*), γνωστικές στρεβλώσεις για πιθανότητες ή «σύστημα», απόκρυψη της έκτασης της συμπεριφοράς και επιδείνωση με τον χρόνο.

Η αξιολόγηση κινδύνου είναι ουσιαστική. Ελέγχω **χρέη, οικονομική κρίση, απώλεια εργασίας, διαπροσωπικές και νομικές συνέπειες, κίνδυνο για εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας και αυτοκτονικότητα**. Η ντροπή και η οικονομική καταστροφή μπορούν να συνοδεύονται από σημαντικό αυτοκτονικό κίνδυνο, άρα αυτό δεν είναι δευτερεύον μέρος της αξιολόγησης.

Στη διαφορική εξέταζω ιδιαίτερα **μανία ή υπομανία**. Τζόγος που εμφανίζεται μόνο μέσα σε μανιακά επεισόδια δεν αρκεί για ανεξάρτητη διαταραχή τζόγου. Αν όμως υπάρχει επίμονο εθιστικό πρότυπο και εκτός επεισοδίων, η διαταραχή τζόγου μπορεί να συνυπάρχει με διπολική διαταραχή.

Η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι **ειδικά προσαρμοσμένη γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT)**. Ομαδική CBT αποτελεί καθιερωμένη επιλογή όταν είναι αποδεκτή, ενώ ατομική CBT είναι κατάλληλη όταν η ομάδα δεν είναι επιθυμητή ή εφικτή. Μπορούν να προστεθούν κινητοποιητική δουλειά και πρόληψη υποτροπής.

Παράλληλα χρειάζονται **πρακτικά μέτρα μείωσης της οικονομικής βλάβης**: αυτοαποκλεισμός από πλατφόρμες ή χώρους τζόγου, όρια σε λογαριασμούς ή πλατφόρμες, περιορισμός άμεσης πρόσβασης σε χρήματα όπου αυτό συμφωνείται και είναι ασφαλές, και οικονομική, κοινωνική ή νομική υποστήριξη. Η θεραπεία δεν πρέπει να μένει μόνο στη γνωσιακή κατανόηση ενώ η οικονομική ζημιά συνεχίζεται.

Η φαρμακοθεραπεία δεν είναι **πρώτη γραμμή**. Σε εξειδικευμένη φροντίδα, η **ναλτρεξόνη εκτός εγκεκριμένης ένδειξης (off-label)** μπορεί να εξεταστεί όταν έχει αποτύχει επαρκής ψυχολογική θεραπεία ή υπάρχουν επαναλαμβανόμενες υποτροπές. Δεν τη χρησιμοποιώ ως ρουτίνα αρχική θεραπεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- ICD-11: η διαταραχή τζόγου ανήκει στις διαταραχές λόγω εθιστικών συμπεριφορών.
- Πάντα εκτιμώ **οικονομική κρίση/χρέος και αυτοκτονικότητα**.

- Ειδικά προσαρμοσμένη CBT είναι πρώτη γραμμή· **ναλτρεξόνη** μόνο επιλεγμένα, εκτός εγκεκριμένης ένδειξης, μετά αποτυχία ψυχολογικής θεραπείας ή επαναλαμβανόμενες υποτροπές.

Πώς αναγνωρίζετε, αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε το ντελίριο;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ντελίριο είναι οξεία ή υποξεία, κυμαινόμενη διαταραχή της προσοχής και της επίγνωσης, που συνήθως συνοδεύεται από διαταραχές άλλων γνωστικών λειτουργιών και οφείλεται σε υποκείμενο ιατρικό αίτιο, φάρμακο, ουσία ή στέρηση.

Το αναγνωρίζω από την οξεία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο λειτουργίας, τη διακύμανση μέσα στην ημέρα και κυρίως τη διαταραχή της προσοχής και της επίγνωσης. Μπορεί επίσης να υπάρχουν αποπροσανατολισμός, διαταραχές μνήμης και σκέψης, διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, αντιληπτικές διαταραχές και μεταβολές της ψυχοκινητικότητας.

Διακρίνουμε υπερκινητικό, υποκινητικό και μικτό ντελίριο. Το υποκινητικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μπορεί εύκολα να διαφύγει της διάγνωσης, καθώς ο ασθενής μπορεί να είναι ήσυχος, υπνηλικός ή αποσυρμένος.

Το 4AT (4 'A's Test) είναι ένα σύντομο εργαλείο ανίχνευσης που εξετάζει εγρήγορση, προσανατολισμό με τέσσερις ερωτήσεις, προσοχή με τους μήνες ανάποδα και οξεία μεταβολή ή κυμαινόμενη πορεία. Η συνολική βαθμολογία είναι 0–12 και βαθμολογία ≥ 4 υποδηλώνει πιθανό ντελίριο, χωρίς να υποκαθιστά την κλινική διάγνωση. Στην εντατική θεραπεία ή στη μετεγχειρητική ανάνηψη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως η **Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU)** και η **Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC)**.

Στην αξιολόγηση προσπαθώ πρώτα να τεκμηριώσω τι έχει αλλάξει και πότε. Παίρνω πληροφορίες από τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και από το περιβάλλον του, όπως συγγενείς ή φροντιστές, και όταν νοσηλεύεται από το νοσηλευτικό προσωπικό, τον ιατρικό φάκελο και τις προηγούμενες καταγραφές.

Ελέγχω προσεκτικά τη φαρμακευτική αγωγή και πρόσφατες αλλαγές, χρήση ή στέρηση αλκοόλ και άλλων ουσιών, ζωτικά σημεία και οξυγόνωση, και κάνω πλήρη σωματική και νευρολογική εξέταση. Ο εργαστηριακός και λοιπός παρακλινικός έλεγχος κατευθύνεται από την κλινική εικόνα.

Συχνά αίτια που αναζητώ είναι λοιμώξεις, υποξία, αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές ή μεταβολικές διαταραχές, φάρμακα — ιδιαίτερα αντιχολινεργικά ή κατασταλτικά — πόνος, δυσκοιλιότητα ή κατακράτηση ούρων, μέθη ή στέρηση, καθώς και μετεγχειρητικές ή άλλες οξείες ιατρικές καταστάσεις.

Παράλληλα εκτιμώ τη βαρύτητα: επίπεδο συνείδησης και προσοχής, βαθμό αποδιοργάνωσης, ψυχοκινητική διέγερση ή υποκινητικότητα, δυνατότητα λήψης υγρών και τροφής, κίνδυνο πτώσεων ή τραυματισμού και γενικότερη ιατρική αστάθεια.

Η αντιμετώπιση του ντελیریου βασίζεται πρωτίστως στην αναγνώριση και θεραπεία του υποκείμενου αιτίου ή των αιτίων.

Παράλληλα εφαρμόζονται μη φαρμακευτικά μέτρα: ήρεμο και σταθερό περιβάλλον, συχνός επαναπροσανατολισμός, σαφής κύκλος ημέρας-νύχτας, επαρκής ενυδάτωση και θρέψη, κινητοποίηση, χρήση γυαλιών ή ακουστικών όταν χρειάζονται, παρουσία οικείων προσώπων και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και περιοριστικών μέτρων.

Ως ψυχίατρος μπορεί να χρειαστεί να παρέμβω συμπτωματικά όταν υπάρχει σοβαρή δυσφορία, έντονη ψυχοκινητική διέγερση, σοβαρή αποδιοργάνωση ή κίνδυνος για τον ίδιο τον ασθενή ή για άλλους, και τα μη φαρμακευτικά μέτρα και η αποκλιμάκωση δεν επαρκούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί βραχυχρόνια αντιψυχωσική αγωγή, συνήθως αλοπεριδόλη στη χαμηλότερη κατάλληλη δόση και για το συντομότερο δυνατό διάστημα. Αποφεύγεται ιδιαίτερα στη νόσο Parkinson και στην άνοια με σωμάτια Lewy.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- 4AT ≥ 4 υποδηλώνει πιθανό ντελίριο· είναι εργαλείο ανίχνευσης, όχι διάγνωση. Σε ΜΕΘ/άνανηψη χρησιμοποιούνται CAM-ICU ή ICDSC.
- Το υποκινητικό ντελίριο διαφεύγει εύκολα της διάγνωσης.
- Αντιψυχωσικό μόνο για σοβαρή δυσφορία ή κίνδυνο όταν τα μη φαρμακευτικά μέτρα δεν επαρκούν· ιδιαίτερη αποφυγή αλοπεριδόλης σε Parkinson/DLB.

Πώς αξιολογείτε έναν ασθενή με πιθανή άνοια;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αξιολόγηση πιθανής άνοιας βασίζεται στην τεκμηρίωση επίκτητης γνωστικής έκπτωσης, στη διαχρονική της πορεία και κυρίως στην επίδρασή της στην ανεξαρτησία. Δεν θέτω τη διάγνωση από έναν χαμηλό βαθμό σε γνωστικό τεστ.

Παίρνω ιστορικό από τον ασθενή και πληροφορίες από το περιβάλλον, επειδή η επίγνωση των ελλειμμάτων μπορεί να είναι περιορισμένη. Πρωτό τότε άρχισε η αλλαγή, αν η πορεία είναι ύπουλη, κλιμακωτή, κυμαινόμενη ή ταχεία και ποιο γνωστικό πεδίο επηρεάστηκε πρώτο.

Οργανώνω τη γνωστική εκτίμηση σε προσοχή, εκτελεστικές λειτουργίες, μάθηση και μνήμη, γλώσσα, οπτικοχωρική και αντιληπτικοκινητική λειτουργία και κοινωνική νόηση. Παράλληλα αναζητώ συμπεριφορικά και ψυχιατρικά συμπτώματα, όπως απάθεια, κατάθλιψη, ψύχωση, ευερεθιστότητα ή αλλαγή προσωπικότητας, επειδή μπορεί να κατευθύνουν προς συγκεκριμένο υπότυπο.

Η λειτουργικότητα είναι καθοριστική. Εξετάζω τις βασικές δραστηριότητες καθημερινής ζωής και ιδιαίτερα τις σύνθετες δραστηριότητες, όπως διαχείριση χρημάτων και φαρμάκων, μαγείρεμα, μετακινήσεις, ψώνια και οργάνωση υποχρεώσεων. Η απώλεια ανεξαρτησίας διαχωρίζει πρακτικά την άνοια ή μείζονα νευρογνωστική διαταραχή από ηπιότερη γνωστική έκπτωση.

Πριν αποδώσω την εικόνα σε νευροεκφυλιστική νόσο, αποκλείω ντελίριο, σημαντική κατάθλιψη όπου σχετίζεται, φαρμακευτικές επιδράσεις και αντιχολινεργικό φορτίο, αλκοόλ ή άλλες ουσίες και πιθανά ιατρικά ή νευρολογικά αίτια. Κάνω πλήρη σωματική και νευρολογική εξέταση.

Χρησιμοποιώ ένα επικυρωμένο σύντομο γνωστικό εργαλείο ως μέρος της αξιολόγησης. Φυσιολογική επίδοση δεν αποκλείει άνοια, ιδιαίτερα σε άτομα με υψηλή προνοσηρή γνωστική ικανότητα ή σε μη αμνηστικά σύνδρομα. Αν η διάγνωση ή ο υπότυπος παραμένει ασαφής, μπορεί να χρειαστεί νευροψυχολογική αξιολόγηση.

Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι στοχευμένος σε αναστρέψιμα ή επιβαρυντικά αίτια που προκύπτουν από το ιστορικό και την εξέταση. Δομική απεικόνιση εγκεφάλου προσφέρεται γενικά εκτός αν η διάγνωση και ο υπότυπος είναι ήδη σαφείς. Η μαγνητική τομογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρειάζεται καλύτερη εκτίμηση αγγειακής νόσου ή υποτύπου, ενώ η αξονική τομογραφία αποτελεί κατάλληλη εναλλακτική όταν η μαγνητική δεν είναι εφικτή.

Σε εξειδικευμένο πλαίσιο, βιοδείκτες αμυλοειδούς και tau στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ή επικυρωμένοι βιοδείκτες πλάσματος μπορούν να αυξήσουν την αιτιολογική βεβαιότητα σε ασαφείς περιπτώσεις και πλέον έχουν ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάζεται ανταμυλοειδική θεραπεία. Δεν αντικαθιστούν όμως το ιστορικό, τη λειτουργική εκτίμηση ή τη δομική απεικόνιση.

Εκτιμώ επίσης οδήγηση, διαχείριση φαρμάκων και οικονομικών, ικανότητα λήψης αποφάσεων, κίνδυνο εκμετάλλευσης ή παραμέλησης και ανάγκες των

φροντιστών, ανάλογα με τον πραγματικό κίνδυνο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η **απώλεια ανεξαρτησίας** διαχωρίζει πρακτικά την άνοια/μείζονα νευρογνωστική διαταραχή από ηπιότερη γνωστική έκπτωση· φυσιολογικό σύντομο τεστ δεν την αποκλείει.
- Δομική απεικόνιση προσφέρεται γενικά εκτός αν διάγνωση και υπότυπος είναι ήδη σαφείς.
- Βιοδείκτες ΕΝΥ/πλάσματος είναι **εξειδικευμένα συμπληρωματικά εργαλεία**, όχι υποκατάστατο της κλινικής και λειτουργικής εκτίμησης.

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη νόσο Alzheimer;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η νόσος Alzheimer συνήθως εμφανίζεται με ύπουλη και προοδευτική γνωστική **έκπτωση**, συχνά αρχικά με δυσκολία στη νέα μάθηση και στην επεισοδιακή μνήμη. Με την εξέλιξη μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές γλώσσας, πράξης, αναγνώρισης, οπτικοχωρικής και εκτελεστικής λειτουργίας, μαζί με προοδευτική απώλεια λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Η διάγνωση στηρίζεται στο **κλινικό σύνδρομο, στη διαχρονική πορεία και στην αιτιολογική διερεύνηση**. Παίρνω πληροφορίες από το περιβάλλον και αξιολογώ τη λειτουργικότητα. Στη διαφορική περιλαμβάνω άνοια με σωματίδια Lewy, μετωποκροταφική άνοια, αγγειακή γνωστική διαταραχή, κατάθλιψη και ντελίριο.

Τα κλασικά παθολογικά χαρακτηριστικά είναι οι **εναποθέσεις β-αμυλοειδούς και η παθολογία tau**. Βιοδείκτες στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ή στο αίμα μπορούν σε εξειδικευμένο πλαίσιο να αυξήσουν τη διαγνωστική βεβαιότητα όταν η εικόνα είναι άτυπη ή ασαφής. Είναι επίσης απαραίτητη η επιβεβαίωση αμυλοειδικής παθολογίας όταν εξετάζεται ειδική αντιαμυλοειδική θεραπεία. Ο βιοδείκτης όμως δεν αντικαθιστά τη συνολική κλινική διάγνωση.

Για τη συμπτωματική θεραπεία χρησιμοποιούνται **donepezil, rivastigmine ή galantamine** σε ήπια έως μέτρια νόσο Alzheimer. Η **μεμαντίνη** χρησιμοποιείται στη μέτρια νόσο όταν οι αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης αντενδείκνυνται ή δεν είναι ανεκτοί και στη σοβαρή νόσο. Σε μέτρια ή σοβαρή νόσο μπορεί να συνδυαστεί με αναστολέα ακετυλοχολινεστεράσης σύμφωνα με τη σύγχρονη θεραπευτική καθοδήγηση.

Παράλληλα οργανώνω **σταθερή καθημερινότητα, διατήρηση λειτουργικότητας, αντιμετώπιση σωματικής και ψυχιατρικής συννοσηρότητας, αξιολόγηση ασφάλειας, υποστήριξη φροντιστών και σχεδιασμό των μελλοντικών αναγκών**. Η φαρμακοθεραπεία δεν υποκαθιστά αυτά τα στοιχεία.

Τα **lecanemab και donanemab** έχουν ευρωπαϊκή άδεια για προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς με **πρώιμη συμπτωματική νόσο Alzheimer — ήπια γνωστική διαταραχή ή ήπια άνοια λόγω Alzheimer — και επιβεβαιωμένη αμυλοειδική παθολογία**. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ένδειξη περιορίζεται σε μη φορείς ή ετεροζυγώτες του **ΑΡΟΕ ε4**, όχι σε ομοζυγώτες.

Οι θεραπείες αυτές **επιβραδύνουν σε μέτριο βαθμό τη γνωστική και λειτουργική έκπτωση· δεν αναστρέφουν την εγκατεστημένη άνοια ούτε επαναφέρουν χαμένη λειτουργία**. Κεντρικό ζήτημα ασφάλειας είναι οι **ανωμαλίες απεικόνισης που σχετίζονται με αμυλοειδές, ARIA-E και ARIA-H**, γι' αυτό απαιτείται προσεκτική επιλογή ασθενών και παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία. Η ευρωπαϊκή αδειοδότηση δεν σημαίνει αυτόματα συνήθη διαθεσιμότητα ή αποζημίωση στην Ελλάδα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Donepezil/rivastigmine/galantamine: ήπια–μέτρια Alzheimer· μεμαντίνη σε επιλεγμένη μέτρια και σε σοβαρή νόσο.
- Lecanemab/donanemab: μόνο επιλεγμένη πρόωμη, αμυλοειδικά επιβεβαιωμένη νόσος· η ευρωπαϊκή ένδειξη αποκλείει APOE ε4 ομοζυγώτες.
- **ARIA και MRI monitoring** είναι κεντρικά ζητήματα ασφάλειας· ευρωπαϊκή άδεια ≠ βέβαιη ελληνική πρόσβαση/αποζημίωση.

Πώς διακρίνετε την άνοια με σωμάτια Lewy από την άνοια στη νόσο Parkinson;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η άνοια με σωμάτια Lewy (DLB) και η άνοια στη νόσο Parkinson (PDD) ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα της νόσου με σωμάτια Lewy. Η πρακτική διάκριση βασίζεται κυρίως στη χρονική σχέση της άνοιας με τον παρκινσονισμό, όχι σε κάποιο αποδεδειγμένο βιολογικό όριο.

Στην DLB η πρώιμη γνωστική εικόνα μπορεί να χαρακτηρίζεται περισσότερο από διαταραχές προσοχής, εκτελεστικής και οπτικοαντιληπτικής/οπτικοχωρικής λειτουργίας παρά από καθαρά αμνηστικό σύνδρομο. Τα τέσσερα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά είναι **διακυμάνσεις της γνωστικής λειτουργίας, επαναλαμβανόμενες καλά σχηματισμένες οπτικές ψευδαισθήσεις, αυτόματος παρκινσονισμός και διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM (RBD).**

Η RBD μπορεί να προηγείται της γνωστικής έκπτωσης για χρόνια και σήμερα θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό, όχι απλώς υποστηρικτικό εύρημα. Πτώσεις, συγκοπτικά επεισόδια, ορθοστατική υπόταση και άλλη αυτόνομη δυσλειτουργία μπορούν επίσης να ενισχύσουν την κλινική υποψία.

Η **σοβαρή ευαισθησία στα αντιψυχωσικά** είναι κρίσιμο στοιχείο ασφάλειας. Αποφεύγω, όπου είναι δυνατόν, φάρμακα με ισχυρό αποκλεισμό D2 και δεν αντιμετωπίζω μηχανικά κάθε οπτική ψευδαίσθηση με αντιψυχωσικό.

Ο **κανόνας του ενός έτους** χρησιμοποιείται λειτουργικά. Αν η άνοια εμφανιστεί πριν, ταυτόχρονα ή μέσα σε ένα έτος από την έναρξη του παρκινσονισμού, χρησιμοποιείται η διάγνωση DLB. Αν εμφανιστεί μετά από ήδη εγκατεστημένη νόσο Parkinson και πέρα από αυτό το διάστημα, μιλάμε για PDD. Πρόκειται για **ταξινομική σύμβαση**, όχι για αποδεδειγμένη βιολογική διαχωριστική γραμμή.

Σε ασαφή περίπτωση, ενδεικτικοί βιοδείκτες, όπως η μειωμένη πρόσληψη του μεταφορέα ντοπαμίνης, μπορούν να υποστηρίξουν τη διάγνωση χωρίς να αντικαθιστούν την κλινική εικόνα.

Για ήπια έως μέτρια DLB, **donepezil ή rivastigmine** είναι καθιερωμένες επιλογές. Η μεμαντίνη μπορεί να εξεταστεί όταν οι αναστολείς χολινεστεράσης δεν είναι ανεκτοί ή αντενδείκνυνται. Στην PDD υπάρχει επίσης τεκμηρίωση για αναστολή χολινεστεράσης, ιδιαίτερα με rivastigmine.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- DLB: διακυμάνσεις + οπτικές ψευδαισθήσεις + παρκινσονισμός + RBD.
- Κανόνας του ενός έτους: λειτουργική ταξινομική σύμβαση, όχι βιολογικό όριο.
- Η σοβαρή ευαισθησία στα αντιψυχωσικά είναι κρίσιμο σημείο ασφάλειας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς προσεγγίζετε τις οπτικές ψευδαισθήσεις στη νόσο Parkinson;

Πρώτα αποκλείω ντελίριο, λοίμωξη, μεταβολική διαταραχή, φαρμακευτική τοξικότητα και οπτική ή άλλη αισθητηριακή επιβάρυνση. Αν οι ψευδαισθήσεις είναι καλά ανεκτές και δεν προκαλούν κίνδυνο, δεν χρειάζεται αυτομάτως φαρμακευτική θεραπεία. Σε συνεργασία με ειδικό στη νόσο Parkinson επανεξετάζω τη ντοπαμινεργική αγωγή, εξισορροπώντας τον κίνδυνο κινητικής επιδείνωσης. Η **quetiapine** μπορεί να εξεταστεί σε επιλεγμένους ασθενείς χωρίς γνωστική διαταραχή, ενώ η **clozapine** είναι τεκμηριωμένη εξειδικευμένη επιλογή όταν η συνήθης αντιμετώπιση αποτυγχάνει και μπορεί να γίνει η απαιτούμενη αιματολογική παρακολούθηση. Αποφεύγω **olanzapine** και σημαντικό αποκλεισμό D2 λόγω κινητικής επιδείνωσης. Η **rimavanserin** δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως συνήθης ευρωπαϊκή ή ελληνική θεραπεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι γνωρίζετε για τις διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων από αγωνιστές ντοπαμίνης;

Πρωτό ενεργά για τυχερά παιχνίδια, υπερσεξουαλικότητα, καταναγκαστικές αγορές/δαπάνες και επεισόδια υπερφαγίας, επειδή συχνά αποκρύπτονται. Οι αγωνιστές ντοπαμίνης είναι σημαντικός φαρμακευτικός παράγοντας κινδύνου. Η βασική παρέμβαση είναι, όπου είναι εφικτό, **σταδιακή μείωση του αγωνιστή ντοπαμίνης υπό ειδική παρακολούθηση**. Δεν τον διακόπτω απότομα λόγω κινδύνου συνδρόμου στέρησης αγωνιστών ντοπαμίνης. Αν η τροποποίηση της αγωγής δεν επαρκεί, μπορεί να εξεταστεί ειδικά προσαρμοσμένη γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία.

Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε τη μετωποκροταφική άνοια;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μετωποκροταφική άνοια, ιδιαίτερα η **συμπεριφορική παραλλαγή (bvFTD)**, συχνά εμφανίζεται πρώτα με **μεταβολή συμπεριφοράς, προσωπικότητας και εκτελεστικών λειτουργιών** και όχι με το τυπικό πρώιμο αμνηστικό σύνδρομο της νόσου Alzheimer.

Χαρακτηριστικά πρώιμα φαινόμενα είναι η **κοινωνική αποδέσμευση, η απάθεια ή αδράνεια, η απώλεια ενσυναίσθησης, οι στερεότυπες, επαναληπτικές ή καταναγκαστικές συμπεριφορές, η υπερστοματικότητα και οι αλλαγές στις διατροφικές προτιμήσεις, μαζί με εκτελεστική δυσλειτουργία**. Μπορούν επίσης να εμφανιστούν γλωσσικές παραλλαγές της μετωποκροταφικής εκφύλισης, όταν η διαταραχή της γλώσσας αποτελεί το κυρίαρχο αρχικό πρόβλημα.

Η σχετική διατήρηση της επεισοδιακής μνήμης και της οπτικοχωρικής λειτουργίας είναι συχνό πρώιμο πρότυπο, αλλά **δεν αποτελεί απαραίτητο κριτήριο**. Επομένως, σημαντική διαταραχή μνήμης δεν αποκλείει από μόνη της τη bvFTD, ιδίως όσο εξελίσσεται η νόσος.

Η διαφορική είναι συχνά απαιτητική επειδή η αρχική εικόνα μπορεί να μοιάζει ψυχιατρική. Εξετάζω **διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με απάθεια, πρωτοπαθή μεταβολή προσωπικότητας, ψύχωση και νόσο Alzheimer**. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προοδευτική αλλαγή από το προηγούμενο επίπεδο λειτουργίας, η απώλεια κοινωνικών δεξιοτήτων και ενσυναίσθησης, το συνολικό νευρογνωστικό προφίλ και οι πληροφορίες από το περιβάλλον.

Η **μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου** μπορεί να δείξει μετωπιαία και/ή πρόσθια κροταφική ατροφία. Σε ασαφή περίπτωση, FDG-PET ή SPECT μπορούν να υποστηρίξουν τη διάγνωση. Φυσιολογική ή μη εντυπωσιακή απεικόνιση, ιδιαίτερα νωρίς, δεν αρκεί από μόνη της για να αποκλείσει τη νόσο.

Δεν υπάρχει καθιερωμένη θεραπεία που να τροποποιεί την πορεία της νόσου ή ειδική γνωστικοενισχυτική φαρμακοθεραπεία. **Οι αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης και η μεμαντίνη δεν χρησιμοποιούνται ως θεραπεία ρουτίνας στη μετωποκροταφική άνοια** όπως στη νόσο Alzheimer.

Η αντιμετώπιση είναι κυρίως **συμπτωματική και υποστηρικτική**. SSRI ή trazodone μπορούν σε επιλεγμένους ασθενείς να χρησιμοποιηθούν για αποδέσμευση, καταναγκαστικές ή επαναληπτικές συμπεριφορές, ευερεθιστότητα ή υπερστοματικότητα, με περιορισμένη τεκμηρίωση και σαφή συμπτωματικό στόχο. Εξίσου σημαντικά είναι η εκπαίδευση των φροντιστών, οι περιβαλλοντικές και συμπεριφορικές στρατηγικές, η αξιολόγηση ασφάλειας και η πολυεπιστημονική υποστήριξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η σχετική πρώιμη διατήρηση μνήμης είναι **συχνή αλλά όχι απαραίτητη**.

- Αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης και μεμαντίνη δεν χρησιμοποιούνται ως θεραπεία ρουτίνας στην FTD.

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε την αγγειακή γνωστική διαταραχή / αγγειακή άνοια;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αγγειακή γνωστική διαταραχή είναι ευρύτερο φάσμα γνωστικής έκπτωσης που οφείλεται σε αγγειακή εγκεφαλική νόσο· η αγγειακή άνοια είναι το άκρο του φάσματος όπου η έκπτωση επηρεάζει ουσιαστικά την ανεξαρτησία. Για τη διάγνωση δεν αρκεί ούτε το ιστορικό αγγειακών παραγόντων κινδύνου ούτε η παρουσία λευκοεγκεφαλοπάθειας στην απεικόνιση. Χρειάζεται πειστική σχέση ανάμεσα στο αγγειακό φορτίο και στο γνωστικό σύνδρομο.

Η πορεία μπορεί να είναι μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κλιμακωτή ή σταδιακά προοδευτική. Η κλασική «stepwise» επιδείνωση είναι χρήσιμη όταν υπάρχει, αλλά δεν είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερα στη νόσο μικρών αγγείων μπορεί να κυριαρχούν βραδύτητα επεξεργασίας, εκτελεστική δυσλειτουργία και διαταραχή προσοχής, περισσότερο από ένα καθαρά αμνηστικό σύνδρομο.

Στο ιστορικό αναζητώ προηγούμενα αγγειακά επεισόδια και τη χρονική τους σχέση με τη γνωστική μεταβολή, καθώς και υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα και άλλους σχετικούς παράγοντες. Στην εξέταση, εστιακά νευρολογικά σημεία, διαταραχή βάδισης ή άλλα στοιχεία αγγειακής προσβολής ενισχύουν την υπόθεση όταν ταιριάζουν με το ιστορικό και την απεικόνιση.

Η νευροαπεικόνιση πρέπει να δείχνει εγκεφαλοαγγειακή βλάβη συμβατή σε κατανομή και βαρύτητα με την κλινική εικόνα. Η απλή ύπαρξη λευκής ουσίας βλαβών σε ηλικιωμένο ασθενή δεν αρκεί. Αντίστροφα, μια σταδιακή πορεία δεν αποκλείει αγγειακή γνωστική διαταραχή.

Δεν επιβάλλω ψευδή διάκριση «Alzheimer ή αγγειακή». Μικτή Alzheimer και αγγειακή παθολογία είναι συχνή, και η κλινική εικόνα μπορεί να αντανακλά και τις δύο διεργασίες. Η διαφορική περιλαμβάνει επίσης άλλες νευροεκφυλιστικές άνοιες, ντελίριο και κατάθλιψη ανάλογα με την παρουσίαση.

Η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως στην πρόληψη νέας αγγειακής βλάβης και στη διατήρηση της λειτουργικότητας. Βελτιστοποιώ τους αγγειακούς παράγοντες κινδύνου και εφαρμόζω τη δευτερογενή πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου όπου ενδείκνυται. Παράλληλα οργανώνω αποκατάσταση, υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας, ασφάλεια, θεραπεία συννοσηροτήτων και υποστήριξη φροντιστών.

Οι αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης και η μεμαντίνη δεν αποτελούν θεραπεία ρουτίνας για καθαρή αγγειακή άνοια. Μπορούν να έχουν θέση όταν συνυπάρχει νευροεκφυλιστική ένδειξη, όπως μικτή νόσος με Alzheimer, σύμφωνα με το αντίστοιχο θεραπευτικό πλαίσιο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Stepwise** πορεία είναι κλασική, όχι υποχρεωτική· σταδιακή πορεία δεν αποκλείει αγγειακή γνωστική διαταραχή.

- Η απεικόνιση πρέπει να είναι **συμβατή με το κλινικό σύνδρομο**· αλλοιώσεις λευκής ουσίας μόνες τους δεν αρκούν.
- Μικτή **Alzheimer/αγγειακή παθολογία** είναι συχνή.

Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα της άνοιας;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα της άνοιας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διέγερση ή επιθετικότητα, ψυχωσικά συμπτώματα, κατάθλιψη ή άγχος, απάθεια, διαταραχές ύπνου, περιπλάνηση και άρση αναστολών. Δεν τα αντιμετωπίζω ως ένα ενιαίο σύνδρομο που χρειάζεται καταστολή. Πρώτα ορίζω τι ακριβώς έχει αλλάξει, τότε εμφανίζεται και τι μπορεί να το προκαλεί ή να το συντηρεί.

Πριν αποδώσω τη συμπεριφορά στην άνοια, αναζητώ **αναστρέψιμους εκλυτικούς παράγοντες**: ντελίριο, πόνο, λοίμωξη, δυσκοιλιότητα, επίσχεση ούρων, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, αισθητηριακή στέρηση, διαταραχή ύπνου, υπερδιέγερση ή αλλαγές στο περιβάλλον και ανεκπλήρωτες ανάγκες. Η νέα ή απότομη συμπεριφορική μεταβολή ιδιαίτερα απαιτεί ενεργή αναζήτηση σωματικού αιτίου.

Εκτιμώ επίσης **κίνδυνο** για τον ίδιο τον ασθενή, τους φροντιστές και άλλους, καθώς και το φορτίο και την εξάντληση των φροντιστών. Η κατανόηση του πλαισίου είναι συχνά πιο χρήσιμη από την ονομασία του συμπτώματος: τότε εμφανίζεται, με ποιον, σε ποιο περιβάλλον, τι προηγείται και τι φαίνεται να το μειώνει.

Η πρώτη θεραπευτική γραμμή είναι **μη φαρμακευτική και προσωποκεντρική**. Προσαρμόζω το περιβάλλον και τη ρουτίνα, μειώνω περιττά ερεθίσματα, διορθώνω προβλήματα όρασης ή ακοής, βελτιώνω άνεση και ύπνο, χρησιμοποιώ κατάλληλη επικοινωνία και ουσιαστικές δραστηριότητες και υποστηρίζω τους φροντιστές. Η παρέμβαση πρέπει να ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο πρόβλημα και όχι να είναι γενική «διαχείριση συμπεριφοράς».

Αν υπάρχει διακριτό **καταθλιπτικό, αγχώδες, ψυχωσικό ή άλλο σύνδρομο**, το θεραπεύω σύμφωνα με την κλινική ένδειξη, χωρίς να χρησιμοποιώ κατασταλτική αγωγή ως υποκατάστατο αιτιολογικής εκτίμησης.

Τα **αντιψυχωσικά** έχουν περιορισμένο ρόλο. Τα εξετάζω μόνο όταν υπάρχει **σοβαρή δυσφορία ή κίνδυνος βλάβης** και οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν ή δεν είναι εφικτές. Συζητώ τον αυξημένο κίνδυνο αγγειακών εγκεφαλικών συμβαμάτων και θνησιμότητας, χρησιμοποιώ τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για το μικρότερο δυνατό διάστημα και επανεκτιμώ τακτικά την ανάγκη συνέχισης, με προσπάθεια μείωσης ή διακοπής όταν είναι κλινικά κατάλληλο.

Η **ριςπεριδόνη** έχει ειδική αδειοδοτημένη χρήση βραχυχρόνια, έως **6 εβδομάδες**, για επίμονη επιθετικότητα σε μέτρια έως σοβαρή νόσο Alzheimer όταν έχουν αποτύχει οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Οι 6 εβδομάδες δεν αποτελούν γενικό κανόνα διάρκειας για κάθε αντιψυχωσικό ή κάθε συμπεριφορικό σύμπτωμα στην άνοια.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Πριν από BPSD ελέγχω ντελίριο, πόνο, λοίμωξη, δυσκοιλιότητα, επίσχεση ούρων και φάρμακα.
- Αντιψυχωσικά μόνο για **σοβαρή δυσφορία ή κίνδυνο**, στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση και για το συντομότερο δυνατό διάστημα.
- Ρισπεριδόνη: ειδική ένδειξη έως **6 εβδομάδες** για επίμονη επιθετικότητα σε μέτρια–σοβαρή Alzheimer μετά αποτυχία μη φαρμακευτικών μέτρων· όχι γενικός χρονικός κανόνας.

Πώς προσεγγίζετε σοβαρή αυτοπαραμέληση ή διαβίωση σε ακραία ακαταστασία όταν ο ασθενής αρνείται βοήθεια;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε σοβαρή αυτοπαραμέληση δεν ξεκινώ από το αν ο τρόπος ζωής μου φαίνεται «απαράδεκτος», αλλά από τον **πραγματικό κίνδυνο, την αιτία της κατάστασης και το αν η άρνηση βοήθειας αποτελεί έγκυρη απόφαση**. Η ακραία ακαταστασία ή η αυτοπαραμέληση από μόνη της δεν αποτελεί διάγνωση ούτε αυτόματη ένδειξη ακούσιας ψυχιατρικής νοσηλείας.

Ελέγχω άμεσα **θρέψη και ενυδάτωση, λοιμώξεις ή άλλη αθεράπευτη σωματική νόσο, πτώσεις, παραμέληση φαρμάκων και περιβαλλοντικούς κινδύνους** όπως πυρκαγιά, αέριο, παράσιτα ή δομική επικινδυνότητα της κατοικίας. Εξετάζω επίσης αν υπάρχουν εξαρτώμενα πρόσωπα ή άλλοι άνθρωποι που κινδυνεύουν.

Στη συνέχεια προσπαθώ να καταλάβω **γιατί** έχει προκύψει η κατάσταση. Αναζητώ άνοια ή άλλη νευρογνωστική διαταραχή, ντελίριο, βαριά κατάθλιψη, ψύχωση, χρήση ουσιών, διαταραχή αποθησαύρισης και μετωπιαία/εκτελεστική δυσλειτουργία. Ο όρος «σύνδρομο Διογένη» μπορεί να περιγράφει την εικόνα, αλλά δεν εξηγεί την αιτία.

Οι **πληροφορίες από το περιβάλλον** είναι συχνά καθοριστικές για την προηγούμενη λειτουργικότητα, την ταχύτητα της επιδείνωσης και τους κινδύνους. Όπου είναι εφικτό, η άμεση εκτίμηση του σπιτιού με κοινωνικές ή κοινοτικές υπηρεσίες δίνει πληροφορίες που δεν φαίνονται στο ιατρείο.

Αν ο ασθενής αρνείται παρέμβαση, εκτιμώ αν μπορεί να λάβει τη **συγκεκριμένη απόφαση** με επαρκή κατανόηση του προβλήματος, των κινδύνων και των διαθέσιμων επιλογών. Ψυχιατρική διάγνωση, εκκεντρικός τρόπος ζωής ή μια απόφαση που θεωρώ κακή δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ανικανότητα. Το βρετανικό τετραμερές τεστ του Mental Capacity Act μπορεί να προσφέρει χρήσιμη κλινική γλώσσα, αλλά **δεν αποτελεί ελληνικό νομοθετικό κριτήριο**.

Αν ο ασθενής μπορεί να δώσει έγκυρη άρνηση, η φαινομενικά «άσοφη» επιλογή του **δεν επιτρέπει από μόνη της εξαναγκασμό**. Συνεχίζω την εμπλοκή, μειώνω τη βλάβη, προσφέρω πρακτική βοήθεια και επανεκτιμώ, ιδίως αν αλλάξουν οι συνθήκες ή ο κίνδυνος.

Αν η ικανότητα για τη συγκεκριμένη απόφαση είναι ουσιαστικά επηρεασμένη, εφαρμόζω το αντίστοιχο ελληνικό πλαίσιο συναίνεσης και τις διαθέσιμες οικογενειακές, κοινωνικές ή νομικές διαδικασίες. Η επείγουσα θεραπεία χωρίς συναίνεση είναι ξεχωριστή και στενή εξαίρεση όταν υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη.

Για **ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία** πρέπει να συντρέχει ψυχική διαταραχή και μία από τις νόμιμες οδούς του Ν. 2071/1992. Η σοβαρή αυτοπαραμέληση από μόνη της δεν αρκεί. Στην πράξη χρειάζεται πολυεπιστημονικό σχέδιο με ψυχιατρικές, ιατρικές, κοινωνικές και κοινοτικές υπηρεσίες και το λιγότερο περιοριστικό μέτρο

που μπορεί να μειώσει τον πραγματικό κίνδυνο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Αυτοπαραμέληση** ≠ **αυτόματη ακούσια νοσηλεία**· πρέπει να πληρούνται τα ελληνικά νόμιμα κριτήρια.
- Η ικανότητα/άρνηση είναι **απόφαση-ειδική**· κακή ή εκκεντρική επιλογή δεν ισοδυναμεί με ανικανότητα.

Ποια σημεία σας κάνουν να υποψιαστείτε αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα σε ψυχιατρική παρουσίαση;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υποψιάζομαι αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα όταν μια νέα ψυχιατρική εικόνα εξελίσσεται γρήγορα, μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες, και αρχίζουν να εμφανίζονται νευρολογικά ή γνωστικά σημεία που δεν ταιριάζουν με μια συνήθη πρωτοπαθή ψυχιατρική πορεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν αρκεί να ονομάσω την εικόνα ψύχωση ή μανία· χρειάζεται επείγουσα νευρολογική διερεύνηση.

Νέες επιληπτικές κρίσεις, κατατονία, ταχέως εξελισσόμενη γνωστική έκπτωση, μειωμένο ή κυμαινόμενο επίπεδο συνείδησης, δυσκινησίες — συχνά και στοματοπροσωπικές —, διαταραχή της γλώσσας, αυτόνομη αστάθεια και εστιακά νευρολογικά σημεία αυξάνουν ιδιαίτερα την υποψία. Με ανησυχεί επίσης έντονη και ταχέως μεταβαλλόμενη συμπεριφορική αποδιοργάνωση που είναι δυσανάλογη προς την αναμενόμενη πορεία μιας πρωτοπαθούς ψυχιατρικής διαταραχής.

Η εγκεφαλίτιδα από αντισώματα έναντι του υποδοχέα NMDA είναι το κλασικό παράδειγμα που μπορεί να αρχίσει με έντονα ψυχιατρικά συμπτώματα. Άλλα αντισώματα, όπως LGI1 ή CASPR2, μπορεί να είναι σχετικά ανάλογα με τον φαινότυπο. Η κλινική εικόνα και ο φαινότυπος καθοδηγούν τον στοχευμένο αντισωματικό έλεγχο· ένας εξαντλητικός κατάλογος αντισωμάτων δεν υποκαθιστά τη σύνδρομική αναγνώριση.

Η διερεύνηση περιλαμβάνει πλήρη νευρολογική εξέταση, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού, με φλεγμονώδεις δείκτες και έλεγχο νευρωνικών αντισωμάτων. Ελέγχω επίσης αντισώματα στον ορό, αλλά **δεν βασίζομαι μόνο στον ορό όταν είναι εφικτή η εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού**, γιατί μεμονωμένα ορολογικά αποτελέσματα μπορεί να είναι παραπλανητικά, ιδιαίτερα στα αντισώματα έναντι NMDAR.

Ανάλογα με το σύνδρομο και το αντισωματικό προφίλ αναζητώ **σχετιζόμενο νεόπλασμα**. Η διαφορική πρέπει παράλληλα να περιλαμβάνει λοιμώδη εγκεφαλίτιδα και άλλες ιατρικές, νευρολογικές ή τοξικολογικές αιτίες της εικόνας.

Όταν η λοίμωξη έχει αποκλειστεί επαρκώς και η υποψία είναι ισχυρή, η θεραπεία δεν πρέπει να καθυστερεί περιμένοντας να ολοκληρωθεί κάθε επιβεβαιωτική εξέταση. Η θεραπεία πρώτης γραμμής περιλαμβάνει **υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη και/ή πλασμαφαίρεση**, με αντιμετώπιση ή αφαίρεση σχετιζόμενου όγκου όπου υπάρχει. Περαιτέρω ανοσοθεραπεία ανήκει σε εξειδικευμένη νευρολογική διαχείριση.

Αντιψυχωσικά μπορεί να χρειαστούν προσωρινά για επικίνδυνη διέγερση, αλλά **δεν θεραπεύουν την εγκεφαλίτιδα** και δεν πρέπει να καθυστερούν τη νευρολογική διερεύνηση και την αιτιολογική θεραπεία.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Υποξεία ψυχιατρική εικόνα + νευρολογικά red flags → EEG/MRI/ENY → αντισώματα ENY/ορού → ανοσοθεραπεία ± αντιμετώπιση όγκου

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ισχυρά red flags: νέες κρίσεις, κατατονία, ταχεία γνωστική έκπτωση, δυσκινησίες, αυτόνομη αστάθεια ή μεταβολή συνείδησης.
- Πρώτη γραμμή μετά από επαρκή αποκλεισμό λοίμωξης: κορτικοστεροειδή, IVIG και/ή πλασμαφαίρεση.

Ποιες είναι οι βασικές ψυχιατρικές εκδηλώσεις της επιληψίας και πώς τις προσεγγίζετε;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι ψυχιατρικές εκδηλώσεις της επιληψίας γίνονται πιο κατανοητές αν τις συσχετίσω χρονικά με τις κρίσεις: **ικτικές, περιϊκτικές ή μετακριτικές και μεσοκριτικές**. Παράλληλα πρέπει να αναγνωρίζω την πολύ συχνή ψυχιατρική συννοσηρότητα, τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιεπιληπτικών και τις αλληλεπιδράσεις με τα ψυχοτρόπα.

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης μπορεί να εμφανιστούν **αιφνίδιος φόβος, βιωματικά φαινόμενα, αυτόνομα συμπτώματα ή αντιληπτικές εμπειρίες που μοιάζουν με ψευδαισθήσεις**, ιδιαίτερα σε κρίσεις κροταφικού λοβού. Το στερεότυπο, η αιφνίδια έναρξη, η βραχεία διάρκεια και η σχέση με άλλα επιληπτικά φαινόμενα βοηθούν στη διάκριση από πρωτοπαθή ψυχιατρική συμπτωματολογία.

Μετά από κρίσεις μπορεί να υπάρχει σύγχυση ή διέγερση. Η **μετακριτική ψύχωση** είναι ιδιαίτερα σημαντική: συχνά εμφανίζεται μετά από συρροή κρίσεων και χαρακτηρίζεται από **διαυγές μεσοδιάστημα** ανάμεσα στην αποκατάσταση από την άμεση μετακριτική σύγχυση και την έναρξη της ψύχωσης. Το παλαιότερο σταθερό 24–48ωρο δεν αποτελεί άκαμπτο κανόνα· το διάστημα μπορεί να είναι από ώρες έως αρκετές ημέρες, με την ψύχωση συνήθως να εμφανίζεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Μεσοκριτικά, οι σημαντικότερες ψυχιατρικές διαταραχές είναι **κατάθλιψη και άγχος**, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί χρόνια ψύχωση. Ελέγχω ενεργά αυτοκτονικό ιδεασμό και κίνδυνο αντί να θεωρώ ότι όλα τα συμπτώματα εξηγούνται από την επιληψία.

Επανεξετάζω πάντα την **αντιεπιληπτική αγωγή**. Η levetiracetam μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, κατάθλιψη, διέγερση και ψυχωσικά συμπτώματα. Κλινικά έχει μεγαλύτερη αξία η χρονική συσχέτιση της μεταβολής της ψυχικής κατάστασης με την έναρξη ή αλλαγή της αγωγής παρά ένας εξαντλητικός κατάλογος όλων των αντιεπιληπτικών.

Στην επιλογή ψυχοτρόπων λαμβάνω υπόψη τον **ουδό σπασμών και τις φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις**. Η clozapine μειώνει τον ουδό σπασμών με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Η bupropion αντενδείκνυται σε άτομα με τρέχουσα ή προηγούμενη επιληπτική διαταραχή. Οι SSRI γενικά συγκαταλέγονται στις προτιμώμενες αντικαταθλιπτικές επιλογές στην επιληψία. Αντιεπιληπτικά που επάγουν ηπατικά ένζυμα μπορούν να μειώσουν την έκθεση σε ψυχοτρόπα και απαιτούν έλεγχο αλληλεπιδράσεων.

Σημαντική διαφορική είναι οι **λειτουργικές/διασχιστικές κρίσεις**. Δεν είναι εκούσια παραγόμενες. Η διάγνωση βασίζεται στη σημειολογία και στο συνολικό κλινικό πλαίσιο και, όταν χρειάζεται, υποστηρίζεται από βιντεο-ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή τυπικού επεισοδίου. Λειτουργικές κρίσεις και επιληψία μπορούν να συνυπάρχουν.

Η αντιμετώπιση επομένως χρειάζεται συνεργασία νευρολογίας και ψυχιατρικής: βελτιστοποίηση ελέγχου κρίσεων, θεραπεία ψυχιατρικής συννοσηρότητας, επανεκτίμηση αντιεπιληπτικών και ψυχοτρόπων και αντιμετώπιση των λειτουργικών και κοινωνικών συνεπειών της νόσου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Μετακριτική ψύχωση: **διαυγές μεσοδιάστημα**, όχι άκαμπτα 24–48 ώρες.
- **Levetiracetam** μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
- **Clozapine** μειώνει δοσοεξαρτώμενα τον ουδό σπασμών· **bupropion** αντενδείκνυται σε τρέχουσα ή προηγούμενη επιληπτική διαταραχή.
- Λειτουργικές/διασχιστικές κρίσεις **δεν είναι εκούσιες** και μπορεί να συνυπάρχουν με επιληψία.

Ποιες είναι οι ψυχιατρικές συνέπειες της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης και πώς τις αντιμετωπίζετε;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση διαχωρίζω την **οξεία μετατραυματική σύγχυση και τη μετατραυματική αμνησία** από τις πιο επίμονες γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές συνέπειες. Η ψυχιατρική εικόνα πρέπει πάντα να ερμηνεύεται μέσα στο πλαίσιο της εγκεφαλικής κάκωσης και της αποκατάστασης, όχι σαν να πρόκειται αυτόματα για πρωτοπαθή ψυχιατρική διαταραχή.

Στην οξεία φάση μπορεί να υπάρχει ντελρίριο, διέγερση και **μετατραυματική αμνησία (PTA)**. Η διάρκεια της PTA παραμένει χρήσιμη για την εκτίμηση βαρύτητας και για τον σχεδιασμό της αποκατάστασης, αλλά δεν χρησιμοποιώ τις παλιές ακριβείς κατηγορίες διάρκειας σαν καθολική σύγχρονη ταξινόμηση.

Μακροχρόνια μπορεί να παραμένουν **διαταραχές προσοχής, ταχύτητας επεξεργασίας, μνήμης και ιδιαίτερα εκτελεστικών λειτουργιών**. Σε επίπεδο διάθεσης και συμπεριφοράς είναι συχνές η κατάθλιψη, η ευερεθιστότητα, η επιθετικότητα, η συναισθηματική αστάθεια, η απάθεια ή αδράνεια, η άρση αναστολών και η επίκτητη αλλαγή προσωπικότητας. Ελέγχω επίσης προβληματική χρήση ουσιών και αυτοκτονικό κίνδυνο.

Η μετωπιαία βλάβη μπορεί να δώσει χρήσιμα νευροσυμπεριφορικά πρότυπα. Βλάβες σε τροχαιομετωπιαία δίκτυα μπορεί να συνδέονται με **αποδέσμευση και παρορμητικότητα**, ενώ βλάβες σε ραχιοπλάγια ή έσω μετωπιαία δίκτυα μπορεί να εκδηλώνονται περισσότερο με **απάθεια, πτωχή πρωτοβουλία και εκτελεστική δυσλειτουργία**. Αυτά είναι χρήσιμα κλινικά πρότυπα και όχι απόλυτοι κανόνες εντόπισης.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει το είδος και τη βαρύτητα της κάκωσης, τη διάρκεια της μετατραυματικής αμνησίας, τη νευρολογική και ιατρική κατάσταση, γνωστική και εκτελεστική λειτουργία, διάθεση, παρορμητικότητα και επιθετικότητα, χρήση ουσιών, αυτοκτονικό κίνδυνο, φάρμακα, λειτουργικότητα και το φορτίο της οικογένειας ή των φροντιστών.

Κατά την περίοδο μετατραυματικής αμνησίας ή έντονης διέγερσης προτιμώ **ήρεμο περιβάλλον με χαμηλή διέγερση, σταθερό προσανατολισμό, ρύθμιση ύπνου και αρχές νευροαποκατάστασης**. Αποφεύγω περιττή πολυφαρμακία και καταστολή που μπορεί να επιβαρύνει τη γνωστική αποκατάσταση.

Μακροχρόνια, η θεραπεία είναι **πολυτροπική**: νευροαποκατάσταση, εργοθεραπευτικές, γνωστικές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις, εκπαίδευση οικογένειας και προσαρμογή του περιβάλλοντος, μαζί με φαρμακοθεραπεία όταν υπάρχει σαφές σύμπτωμα-στόχος. Η τεκμηρίωση για ένα μοναδικό φαρμακευτικό σχήμα στη μετατραυματική διέγερση είναι ετερογενής και δεν υποστηρίζει έναν καθολικό φαρμακευτικό αλγόριθμο.

Χρησιμοποιώ τα ψυχοτρόπα με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί **καταστολή, αντιχολινεργικό φορτίο, γνωστικές ανεπιθύμητες ενέργειες και επίδραση στον ουδό σπασμών** μπορεί να έχουν μεγαλύτερη κλινική σημασία μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η διάρκεια της **ΡΤΑ** παραμένει χρήσιμη, αλλά οι παλιές ακριβείς χρονικές κατηγορίες δεν είναι καθολικός σύγχρονος κανόνας.
- Δεν υπάρχει ένας καθολικός φαρμακευτικός αλγόριθμος για μετατραυματική διέγερση· **περιβάλλον και νευροαποκατάσταση προηγούνται.**

Πώς προσεγγίζετε ψυχιατρική διασύνδεση σε νοσηλευόμενο ασθενή με σωματική νόσο;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην ψυχιατρική διασύνδεση αρχικά αποσαφηνίζω ποιο ακριβώς ερώτημα θέλει να απαντήσει η ιατρική ή χειρουργική ομάδα και ποια απόφαση πρέπει να ληφθεί τώρα. Αυτό καθορίζει τι χρειάζεται να εκτιμήσω επειγόντως και αποτρέπει μια γενική ψυχιατρική εξέταση που δεν απαντά στο πραγματικό κλινικό πρόβλημα.

Συχνά ζητήματα είναι ντελίριο, ικανότητα για συναίνεση ή άρνηση συγκεκριμένης θεραπείας, αυτοκαταστροφικός ή αυτοκτονικός κίνδυνος, στερητικά σύνδρομα, κατάθλιψη, άγχος, προσαρμογή στη σωματική νόσο, φαρμακοεπαγόμενα ψυχιατρικά σύνδρομα και λειτουργικές ή σωματικές παρουσιάσεις.

Πριν αποδώσω ένα σύμπτωμα σε πρωτοπαθή ψυχιατρική διαταραχή, εξετάζω τη σωματική νόσο και την τρέχουσα φυσιολογική κατάσταση: υποξία, λοίμωξη, μεταβολικές διαταραχές, πόνο, ύπνο, πρόσφατες επεμβάσεις ή παραμονή σε ΜΕΘ και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ψυχική κατάσταση. Ελέγχω επίσης όλη τη φαρμακευτική αγωγή για ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις, καθώς και χρήση ή στέρηση αλκοόλ και άλλων ουσιών.

Παίρνω το προηγούμενο ψυχιατρικό και λειτουργικό ιστορικό και, όταν χρειάζεται, πληροφορίες από την οικογένεια, τους φροντιστές ή την ίδια τη νοσηλευτική ομάδα. Συνθέτω την εικόνα βιοψυχοκοινωνικά: τι οφείλεται στη νόσο, τι στη θεραπεία, τι προϋπήρχε, πώς αντιδρά ο ασθενής και ποιοι κοινωνικοί ή οικογενειακοί παράγοντες επηρεάζουν την τρέχουσα διαχείριση.

Όταν το ερώτημα αφορά συναίνεση ή άρνηση θεραπείας, η εκτίμηση αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κλινικά εξετάζω αν ο ασθενής μπορεί να κατανοήσει επαρκώς το πρόβλημα, τη θεραπεία, τις ουσιώδεις συνέπειες και τις εναλλακτικές και να λάβει ουσιαστική απόφαση. Το τετραμερές τεστ του βρετανικού Mental Capacity Act μπορεί να προσφέρει χρήσιμη κλινική γλώσσα, αλλά δεν αποτελεί ελληνικό νομοθετικό κριτήριο· η κλινική ικανότητα λήψης απόφασης πρέπει να διαχωρίζεται από τη νομική εγκυρότητα της συναίνεσης ή άρνησης.

Η εκτίμηση πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένες συστάσεις προς τη **θεράπουσα ομάδα**. Αναφέρω ποιο σύνδρομο θεωρώ πιθανότερο, ποιος είναι ο άμεσος κίνδυνος, ποια ιατρική ή ψυχιατρική διερεύνηση χρειάζεται, ποιες αλλαγές στη φαρμακευτική ή μη φαρμακευτική αντιμετώπιση προτείνω, πώς μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία ή η συμπεριφορική διαχείριση και πότε χρειάζεται επανεκτίμηση.

Η ψυχιατρική διασύνδεση δεν «παίρνει» τον ασθενή από την κύρια ομάδα. Προσθέτει ψυχιατρική σκέψη μέσα στο ιατρικό πλαίσιο, ώστε η συνολική θεραπεία να παραμένει ασφαλής και συνεκτική.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Πρώτο βήμα: ποιο είναι το ερώτημα της παραπομπής και ποια απόφαση πρέπει να ληφθεί τώρα;
- Η ικανότητα είναι απόφαση-ειδική· το UK Mental Capacity Act δεν αποτελεί ελληνικό νομοθετικό τεστ.

Πώς διακρίνετε την απάθεια από την κατάθλιψη;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η **απάθεια** είναι κυρίως μείωση της στοχοκατευθυνόμενης δραστηριότητας, της πρωτοβουλίας και της κινητοποίησης. Η **κατάθλιψη** είναι σύνδρομο διάθεσης που οργανώνεται γύρω από καταθλιπτικό συναίσθημα και αρνητικές γνώσεις. Οι δύο καταστάσεις μπορεί να μοιάζουν συμπεριφορικά και μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Στην απάθεια ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει **μειωμένη έναρξη δραστηριοτήτων, λιγότερη αυθόρμητη συμπεριφορά και σκέψη, συναισθηματική αμβλύτητα και κοινωνική απόσυρση**, χωρίς να αναφέρει επίμονη λύπη, ενοχή, αναξιότητα ή απελπισία. Μπορεί να μη διαμαρτύρεται ιδιαίτερα για την αδράνεια, παρότι αυτή είναι εμφανής στους συγγενείς και έχει σημαντική λειτουργική επίπτωση.

Στην κατάθλιψη αναζητώ **σταθερά χαμηλή διάθεση, απαισιοδοξία, αυτομομφή, ενοχή, απελπισία, καταθλιπτικές σκέψεις, βιολογικά συμπτώματα και αυτοκτονικό ιδεασμό**. Αυτά, ιδίως η ενοχή, η απελπισία και η αυτοκτονικότητα, ευνοούν σαφώς καταθλιπτικό σύνδρομο και όχι απλή απάθεια.

Η **ανηδονία δεν αρκεί για τη διάκριση**, επειδή μπορεί να υπάρχει και στις δύο καταστάσεις. Χρειάζεται να δω αν ο ασθενής δεν κινητοποιείται επειδή έχει μειωμένη πρωτοβουλία ή επειδή βιώνει καταθλιπτική διάθεση, αρνητική πρόβλεψη, ενοχή ή αίσθημα ματαιότητας.

Η απάθεια είναι συχνή σε **μετωποϋποφλοιώδεις διαταραχές**, όπως νόσο Parkinson, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νευροεκφυλιστικές νόσους. Επανεξετάζω επίσης γνωστική διαταραχή, ντελίριο και φάρμακα που μπορεί να προκαλούν καταστολή ή μειωμένη ενεργοποίηση.

Η σύγχρονη περιγραφή της απάθειας δεν περιορίζεται μόνο στη συμπεριφορά. Μπορεί να αφορά **συμπεριφορική/γνωστική κινητοποίηση, συναισθηματική ανταπόκριση και κοινωνική εμπλοκή**. Δεν χρειάζεται όμως να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένη κλίμακα για να κάνω την κλινική διάκριση.

Στην πράξη αξιολογώ και τα δύο σύνδρομα ανεξάρτητα. Αν υπάρχουν καταθλιπτικά χαρακτηριστικά, τα θεραπεύω ως κατάθλιψη. Αν κυριαρχεί η απάθεια, αναζητώ το νευρολογικό, γνωστικό, φαρμακευτικό και περιβαλλοντικό υπόβαθρο και προσαρμόζω την αποκατάσταση και την ενεργοποίηση ανάλογα.

Πώς διακρίνετε το σύνδρομο Charles Bonnet από ψύχωση, ντελίριο και νευροεκφυλιστική νόσο;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το **σύνδρομο Charles Bonnet** είναι η εμφάνιση επαναλαμβανόμενων οπτικών ψευδαισθήσεων σε άτομο με σημαντική διαταραχή της όρασης, χωρίς πρωτοπαθή ψυχωσική διαταραχή ή ντελίριο που να εξηγεί την εικόνα. Το κλειδί είναι να αναγνωρίσω το οπτικό υπόβαθρο και να ελέγξω ότι δεν υπάρχει παράλληλη διαταραχή προσοχής, συνείδησης ή νευρολογική νόσος που αλλάζει τη διάγνωση.

Οι ψευδαισθήσεις είναι συχνά **ζωηρές, σύνθετες και καλά σχηματισμένες**: άνθρωποι, πρόσωπα, ζώα, αντικείμενα ή ολόκληρες σκηνές. Τυπικά είναι αποκλειστικά οπτικές. Ο ασθενής συχνά διατηρεί **εναισθησία**, δηλαδή καταλαβαίνει ότι αυτό που βλέπει δεν είναι πραγματικά παρόν.

Η διατηρημένη εναισθησία είναι χαρακτηριστική αλλά **δεν χρειάζεται να είναι απόλυτη από την πρώτη στιγμή**. Ο ασθενής μπορεί αρχικά να αιφνιδιάζεται ή να μην είναι βέβαιος τι συμβαίνει. Επίμονη και πλήρης πεποίθηση ότι οι εικόνες είναι πραγματικές, ιδιαίτερα μαζί με άλλα ψυχωσικά ή γνωστικά συμπτώματα, πρέπει να με οδηγήσει σε διαφορετική διαφορική.

Από το **ντελίριο** το διακρίνω επειδή στο Charles Bonnet δεν υπάρχει το οξύ, διακυμαινόμενο σύνδρομο διαταραχής προσοχής και επίγνωσης. Από την **άνοια με σωματίδια Lewy ή την άνοια στη νόσο Parkinson** με βοηθούν η απουσία προοδευτικής γνωστικής έκπτωσης, διακυμάνσεων, παρκινσονισμού και διαταραχής συμπεριφοράς ύπνου REM. Αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, οι οπτικές ψευδαισθήσεις δεν πρέπει να αποδοθούν αυτόματα στη μειωμένη όραση.

Εξετάζω επίσης **επιληπτικά φαινόμενα, ημικρανία, φάρμακα ή ουσίες και εστιακή νευρολογική νόσο** όταν το ιστορικό ή η σημειολογία δεν ταιριάζουν με το τυπικό σύνδρομο. Κάνω γνωστική και νευρολογική εκτίμηση όπου χρειάζεται και ελέγχω το ίδιο το οφθαλμολογικό πρόβλημα.

Η αντιμετώπιση είναι κυρίως **εξήγηση και καθησυχασμός**. Εξηγώ ότι οι ψευδαισθήσεις μπορούν να εμφανιστούν ως φαινόμενο οπτικής απελευθέρωσης σε σημαντική απώλεια όρασης και ότι δεν σημαίνουν από μόνες τους ψύχωση ή άνοια. Βελτιστοποιώ την όραση και αντιμετωπίζω οφθαλμολογικά προβλήματα όπου είναι δυνατό, αναζητώ φάρμακα ή άλλους εκλυτικούς παράγοντες και χρησιμοποιώ πρακτικές περιβαλλοντικές ή συμπεριφορικές στρατηγικές.

Αντιψυχωσική θεραπεία ρουτίνας δεν ενδείκνυται σε ανεπίπλεκτο Charles Bonnet. Η φαρμακολογική τεκμηρίωση είναι περιορισμένη και τέτοιες παρεμβάσεις ανήκουν σε εξαιρετικές, εξειδικευμένες περιπτώσεις όταν η δυσφορία παραμένει σημαντική.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η εναισθησία είναι **χαρακτηριστικά διατηρημένη αλλά όχι απόλυτα υποχρεωτική από την πρώτη στιγμή**· επίμονη απουσία της απαιτεί άλλη διαφορική.

- Ρουτίνα αντιψυχωσικής θεραπείας δεν ενδείκνυται σε ανεπίπλεκτο Charles Bonnet.

Πώς διαγιγνώσκετε ΔΕΠΥ σε ενήλικα και ποιες είναι οι συχνές μιμητικές καταστάσεις;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ΔΕΠΥ στον ενήλικα είναι νευροαναπτυξιακή διαταραχή, επομένως δεν αρκεί να υπάρχουν σήμερα δυσκολίες συγκέντρωσης ή οργάνωσης. Πρέπει να τεκμηριώσω ένα συνεκτικό αναπτυξιακό πρότυπο απροσεξίας και/ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας, με συμπτώματα που υπήρχαν ήδη στην παιδική ηλικία, εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα σημαντικά πλαίσια και προκαλούν ουσιαστική λειτουργική έκπτωση τώρα.

Το σύγχρονο ηλικιακό σημείο αναφοράς είναι ότι **ορισμένα συμπτώματα πρέπει να υπήρχαν πριν από τα 12 έτη**. Δεν απαιτείται να είχε τεθεί παιδική διάγνωση ούτε να υπάρχουν υποχρεωτικά σχολικοί έλεγχοι ή γονεϊκή μαρτυρία. Αν αυτά είναι διαθέσιμα, βοηθούν σημαντικά. Αν όχι, ανασυνθέτω προσεκτικά την παιδική και εφηβική λειτουργία και δηλώνω την αβεβαιότητα όπου παραμένει.

Στον ενήλικα εξετάζω όχι μόνο τα συμπτώματα αλλά και **τη λειτουργικότητα**: σπουδές ή εργασία, οργάνωση καθημερινών υποχρεώσεων, οικονομικά και πρακτικά θέματα, σχέσεις, οδήγηση και διαχείριση χρόνου. Πρωτό αν οι δυσκολίες εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα περιβάλλοντα και αν είναι επίμονες ή εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένες περιόδους στρες, αϋπνίας ή διαταραχής διάθεσης.

Η διαφορική είναι κρίσιμη, επειδή δυσκολία συγκέντρωσης μπορεί να εμφανιστεί σε αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, διπολική διαταραχή, διαταραχές ύπνου, χρήση ουσιών, αυτισμό, διαταραχές προσωπικότητας, **κρανιοεγκεφαλική κάκωση και άλλες γνωστικές διαταραχές**. Παράλληλα αυτά μπορεί να συνυπάρχουν πραγματικά με ΔΕΠΥ, άρα δεν χρησιμοποιώ τη διαφορική για να αποκλείσω μηχανικά τη συννοσηρότητα.

Παίρνω ιστορικό ουσιών και φαρμάκων, ύπνου, ιατρικών και ψυχιατρικών προβλημάτων και, όπου είναι δυνατό, **πληροφορίες από την οικογένεια ή άλλους ανθρώπους που γνώριζαν τον ασθενή σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του**. Οι κλίμακες συμπτωμάτων μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση, αλλά δεν θέτουν διάγνωση από μόνες τους.

Αν η διάγνωση τεκμηριωθεί και ενδείκνυται φαρμακοθεραπεία, οι βασικές πρώτες επιλογές στους ενήλικες είναι **lisdexamfetamine ή methylphenidate**, με **atomoxetine** ως κύρια μη διεγερτική επιλογή όταν τα δύο διεγερτικά δεν είναι ανεκτά ή δεν έχουν αποδώσει επαρκώς. Πριν από την έναρξη ελέγχω καρδιαγγειακό ιστορικό, σφυγμό και αρτηριακή πίεση, βάρος, συννοσηρότητα, αλληλεπιδράσεις και κίνδυνο κατάχρησης ή εκτροπής. Ηλεκτροκαρδιογράφημα δεν απαιτείται ως εξέταση ρουτίνας σε κάθε ασθενή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Χρειάζονται **ορισμένα συμπτώματα πριν από τα 12 έτη**, παρουσία σε περισσότερα από ένα σημαντικά πλαίσια και λειτουργική έκπτωση.

- Παιδική διάγνωση ή σχολικά έγγραφα δεν είναι υποχρεωτικά· οι κλίμακες δεν θέτουν μόνες τους διάγνωση.
- Πραγματική de novo «ενήλικης έναρξης» ΔΕΠΥ δεν αποτελεί καθιερωμένη DSM-5-TR/ICD-11 διάγνωση.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι κάνετε όταν δεν τεκμηριώνεται σαφής παιδική έκπτωση;

Διαχωρίζω την απουσία τεκμηρίωσης από την πραγματική απουσία παιδικών συμπτωμάτων. Υψηλή γνωστική ικανότητα, αυστηρή εξωτερική δομή ή ισχυρή οικογενειακή υποστήριξη μπορεί να έχουν περιορίσει την εμφανή έκπτωση. Πραγματική de novo «ενήλικης έναρξης» ΔΕΠΥ δεν αποτελεί καθιερωμένη διάγνωση στο DSM-5-TR ή ICD-11· αν δεν βρίσκω αναπτυξιακή συνέχεια, επανεξετάζω τόσο την πιθανότητα μη αναγνωρισμένης παιδικής ΔΕΠΥ όσο και άλλες αιτίες των σημερινών συμπτωμάτων.

Πώς αξιολογείτε πιθανό αυτισμό σε ενήλικα;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο αυτισμός είναι **δια βίου νευροαναπτυξιακή κατάσταση**, επομένως η αξιολόγηση ενός ενήλικα πρέπει να δείξει ένα συνεκτικό αναπτυξιακό πρότυπο και όχι ένα νέο σύνδρομο που εμφανίστηκε στην ενήλικη ζωή. Αναζητώ τόσο επίμονες διαφορές στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση όσο και περιορισμένα, επαναληπτικά, άκαμπτα ή αισθητηριακά χαρακτηριστικά, με πραγματική επίδραση στη λειτουργικότητα.

Στην κοινωνική επικοινωνία εξετάζω την αμοιβαιότητα, την κατανόηση κοινωνικών σημάτων, τη μη λεκτική επικοινωνία, τον τρόπο δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων και το αν ο ασθενής χρειάζεται ασυνήθιστα συνειδητή προσπάθεια για κοινωνικές καταστάσεις που άλλοι χειρίζονται πιο αυτόματα.

Παράλληλα αναζητώ **περιορισμένα ή έντονα ενδιαφέροντα, επαναληπτικές συμπεριφορές, ανάγκη για προβλεψιμότητα ή σταθερές ρουτίνες και αισθητηριακές υπερευαισθησίες ή υποευαισθησίες**. Δεν αρκεί ένα μόνο χαρακτηριστικό· χρειάζεται να φαίνεται το ευρύτερο νευροαναπτυξιακό μοτίβο.

Ανασυνθέτω όσο γίνεται την παιδική και εφηβική ανάπτυξη: κοινωνικές σχέσεις, παιχνίδι, ενδιαφέροντα, σχολική προσαρμογή, αισθητηριακές ιδιαιτερότητες, δυσκολίες στις αλλαγές και μετέπειτα μετάβαση σε σπουδές, εργασία και ανεξάρτητη ζωή. **Πληροφορίες από γονείς, συγγενείς ή παλαιά αρχεία** είναι χρήσιμες όταν υπάρχουν, αλλά η απουσία τους δεν ακυρώνει αυτομάτως την αξιολόγηση.

Εξετάζω τη σημερινή λειτουργικότητα σε εκπαίδευση και εργασία, σχέσεις, καθημερινή ζωή και περιβάλλοντα με υψηλές κοινωνικές ή αισθητηριακές απαιτήσεις. Παράλληλα ελέγχω συχνές συννοσηρότητες, όπως άγχος, κατάθλιψη και ΔΕΠΥ.

Η διαφορική περιλαμβάνει **κοινωνική αγχώδη διαταραχή, ΔΕΠΥ, OCD, σχιζοειδή ή σχιζότυπα χαρακτηριστικά, ψύχωση και νοητική αναπηρία**. Για παράδειγμα, στην κοινωνική αγχώδη διαταραχή το κέντρο είναι ο φόβος αρνητικής αξιολόγησης, ενώ στον αυτισμό οι κοινωνικές δυσκολίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου αναπτυξιακού προτύπου και συνυπάρχουν με τα δεύτερα χαρακτηριστικά της διαταραχής.

Δομημένα εργαλεία και ερωτηματολόγια μπορούν να βοηθήσουν, αλλά **κανένα AQ, ADOS, CAT-Q ή άλλο εργαλείο δεν αποδεικνύει ούτε αποκλείει από μόνο του τον αυτισμό**. Η διάγνωση προκύπτει από τη συνολική αναπτυξιακή και κλινική αξιολόγηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Απαιτείται **αναπτυξιακή συνέχεια** και τόσο κοινωνικοεπικοινωνιακά όσο και περιορισμένα/επαναληπτικά/αισθητηριακά χαρακτηριστικά.
- Κανένα ερωτηματολόγιο ή δομημένο εργαλείο **δεν θέτει μόνο του τη διάγνωση**.

- Το masking/camouflaging μπορεί να αποκρύπτει χαρακτηριστικά αλλά δεν αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι είναι το masking ή camouflaging;

Είναι η συνειδητή ή ημι-συνειδητή απόκρυψη, καταστολή ή αντιστάθμιση εμφανών αυτιστικών χαρακτηριστικών. Παραδείγματα είναι η χρήση προετοιμασμένων κοινωνικών «σεναρίων», η μίμηση άλλων, η συστηματική εκμάθηση κοινωνικών κανόνων, η επιτηδευμένη οπτική επαφή ή η καταστολή επαναληπτικών κινήσεων. Μπορεί να μειώσει τα ορατά σημεία σε μια σύντομη δομημένη συνέντευξη και να συμβάλει σε καθυστερημένη αναγνώριση. Δεν είναι όμως διάγνωση ούτε διαγνωστικό κριτήριο και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε στερεότυπο, π.χ. ότι «ο γυναικείος αυτισμός είναι masking».

Πώς προσεγγίζετε νέα ψυχιατρικά ή συμπεριφορικά συμπτώματα σε ενήλικα με νοητική αναπηρία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε ενήλικα με νοητική αναπηρία και νέα συμπεριφορική ή ψυχιατρική μεταβολή, το βασικό είναι να μην αποδώσω αυτόματα το σύμπτωμα στη νοητική αναπηρία. Πρέπει πρώτα να τεκμηριώσω τι έχει αλλάξει από το συνηθισμένο επίπεδο λειτουργίας και να αναζητήσω ενεργά σωματικά, φαρμακευτικά, ψυχιατρικά και περιβαλλοντικά αίτια.

Η νοητική αναπηρία ορίζεται σήμερα από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στη νοητική λειτουργία όσο και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, με έναρξη στην αναπτυξιακή περίοδο. Η βαρύτητα δεν πρέπει να περιγράφεται μόνο με παλαιές κατηγορίες IQ· με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πραγματικό επίπεδο υποστήριξης και προσαρμοστικής λειτουργίας.

Καταγράφω το **βασικό επίπεδο** επικοινωνίας, συμπεριφοράς, αυτοεξυπηρέτησης, ύπνου, δραστηριότητας και κοινωνικής λειτουργίας. Οι πληροφορίες από οικογένεια ή φροντιστές που γνωρίζουν καλά τον ασθενή είναι συχνά απαραίτητες για να καταλάβω αν πρόκειται πράγματι για αλλαγή και τότε άρχισε.

Πριν θεωρήσω ότι η μεταβολή είναι «ψυχιατρική», αναζητώ πόνο, λοίμωξη, **οδοντιατρικό πρόβλημα, δυσκοιλιότητα, επίσχεση ούρων, επιληπτικές κρίσεις, διαταραχή ύπνου, τραυματισμό, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και άλλες ιατρικές αιτίες**. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ο ασθενής δυσκολεύεται να περιγράψει λεκτικά πόνο ή δυσφορία.

Στη συνέχεια εξετάζω κατάθλιψη, άγχος, ψύχωση, κατατονία και άλλες ψυχιατρικές καταστάσεις, αλλά και **περιβαλλοντικές ή επικοινωνιακές αλλαγές**: αλλαγή φροντιστή, απαιτήσεων ή ρουτίνας, υπερφόρτωση, απώλεια, σύγκρουση ή πιθανή κακοποίηση. Η συμπεριφορά πρέπει να ερμηνεύεται μέσα στο πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται.

Επανεξετάζω όλη τη φαρμακευτική αγωγή και πρόσφατες αλλαγές. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα **καταστολή, αντιχολινεργικό φορτίο, ακαθυσία ή άλλα εξωπυραμιδικά συμπτώματα, τοξικότητα ή στέρηση και συμπεριφορικές ανεπιθύμητες ενέργειες αντιεπιληπτικών**.

Η αντιμετώπιση στοχεύει στην αιτία και χρησιμοποιεί όσο γίνεται **περιβαλλοντικές, επικοινωνιακές, συμπεριφορικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις**. Αντιψυχωσικά δεν χρησιμοποιούνται ως θεραπεία ρουτίνας για «δύσκολη συμπεριφορά». Τα εξετάζω μόνο όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ή όταν οι κατάλληλες σωματικές, ψυχιατρικές, ψυχολογικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις έχουν αποτύχει ή δεν επαρκούν. Τότε ορίζω σαφές σύμπτωμα-στόχο, χρησιμοποιώ την ελάχιστη αποτελεσματική δόση και επανεκτιμώ νωρίς την ανάγκη συνέχισης.

Παράλληλα εκτιμώ κίνδυνο για τον ασθενή και τους άλλους, αυτοπαραμέληση,

πιθανή κακοποίηση ή εκμετάλλευση και τις ανάγκες της οικογένειας ή των φροντιστών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η σύγχρονη εκτίμηση βαρύτητας δίνει κεντρικό βάρος στην **προσαρμοστική λειτουργικότητα**, όχι μόνο στο IQ.
- **Diagnostic overshadowing**: νέα συμπεριφορά δεν αποδίδεται αυτόματα στη νοητική αναπηρία· ειδικά με περιορισμένη επικοινωνία ελέγχω πρώτα σωματικό αίτιο.
- Αντιψυχωσικό δεν είναι **θεραπεία ρουτίνας** της συμπεριφοράς που προκαλεί πρόβλημα.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ελάχιστα λεκτικός ενήλικας εμφανίζει ξαφνικά επιθετικότητα και αϋπνία. Τι σκέφτεστε;

Αντιμετωπίζω πρώτα την εικόνα σαν πιθανή έκφραση πόνου ή σωματικής νόσου. Ελέγχω οδοντιατρικό πόνο, δυσκοιλιότητα, ουρολογικό πρόβλημα ή ουρολοίμωξη, λοίμωξη, τραυματισμό, σπασμούς, φάρμακα ή στέρηση, διαταραχή ύπνου και πιθανές περιβαλλοντικές ή προστατευτικές ανησυχίες. Χρησιμοποιώ τις γνώσεις των φροντιστών για το συνηθισμένο συμπεριφορικό πρότυπο και **δεν ξεκινώ κατευθείαν καταστολή ή αντιψυχωσικό.**

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη νευρική ανορεξία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η νευρική ανορεξία δεν διαγιγνώσκεται από ένα συγκεκριμένο BMI ούτε απαιτεί αμηνόρροια. Το σύνδρομο βασίζεται σε **σημαντικά χαμηλό βάρος για το συγκεκριμένο άτομο και το πλαίσιο, επίμονο περιορισμό ή άλλες συμπεριφορές που εμποδίζουν την αποκατάσταση του βάρους και χαρακτηριστική ψυχοπαθολογία γύρω από βάρος και σχήμα σώματος.**

Στο ιστορικό εξετάζω τον τρόπο και τον ρυθμό απώλειας βάρους, τη διατροφική πρόσληψη, νηστεία ή περιορισμούς, υπερβολική άσκηση και τυχόν επεισόδια υπερφαγίας ή καθαρτικές συμπεριφορές. Αναζητώ **φόβο αύξησης βάρους, υπερεκτίμηση της σημασίας του βάρους/σχήματος ή διαταραγμένη εμπειρία του σώματος**, καθώς και συμπεριφορές που επιμένουν παρά το χαμηλό βάρος.

Η βαρύτητα δεν κρίνεται μόνο από το βάρος. Εκτιμώ **ταχύτητα απώλειας, βαθμό περιορισμού, ζωτικά σημεία, ενυδάτωση, καρδιακά συμπτώματα, ηλεκτρολύτες και ECG όπου ενδείκνυται**, καθώς και άλλες σωματικές επιπλοκές. Παράλληλα ελέγχω κατάθλιψη, άγχος, OCD, αυτοτραυματισμό, αυτοκτονικό κίνδυνο και άλλες συννοσηρότητες.

Η θεραπεία έχει τρεις κεντρικούς άξονες: **διατροφική αποκατάσταση και αποκατάσταση βάρους, εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία διατροφικής διαταραχής και στενή σωματική παρακολούθηση.** Η διατροφική αποκατάσταση δεν είναι απλώς «να πάρει βάρος»· χρειάζεται οργανωμένο σχέδιο που αντιμετωπίζει τον φόβο και τις συμπεριφορές που συντηρούν τον περιορισμό.

Σε ενήλικες, τεκμηριωμένες ψυχοθεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν **CBT-ED, MANTRA και SSCM.** Η επιλογή προσαρμόζεται στην κλινική εικόνα, την προτίμηση, τη δυνατότητα εμπλοκής και το επίπεδο κινδύνου.

Η φαρμακοθεραπεία δεν αποτελεί **αυτόνομη θεραπεία του πυρήνα της νευρικής ανορεξίας.** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σαφή ψυχιατρική συννοσηρότητα όπου ενδείκνυται, αλλά δεν αντικαθιστά τη διατροφική αποκατάσταση και την ειδική ψυχοθεραπεία.

Η ανάγκη εξωνοσοκομειακής, ημερήσιας ή ενδονοσοκομειακής φροντίδας καθορίζεται από τον συνολικό ιατρικό και ψυχιατρικό κίνδυνο, τη δυνατότητα ασφαλούς σίτισης και παρακολούθησης και τη λειτουργικότητα — όχι από ένα μεμονωμένο BMI.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Δεν υπάρχει καθολικό διαγνωστικό όριο BMI 17,5 και η **αμηνόρροια δεν απαιτείται.**
- Η βαρύτητα και το επίπεδο φροντίδας δεν κρίνονται από BMI μόνο.
- Η φαρμακοθεραπεία δεν αποτελεί αυτόνομη θεραπεία του πυρήνα της νόσου.

ΠΙΘΑΝΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΉ

Πώς διακρίνετε ARFID από νευρική ανορεξία;

Στην **ARFID** η αποφυγή ή ο περιορισμός μπορεί να οφείλεται σε **αισθητηριακή ευαισθησία, φόβο δυσάρεστων συνεπειών της σίτισης ή χαμηλό ενδιαφέρον/όρεξη για φαγητό**. Μπορεί να προκαλεί απώλεια βάρους, διατροφικές ελλείψεις, εξάρτηση από συμπληρώματα ή εντερική σίτιση και σημαντική ψυχοκοινωνική επιβάρυνση. Το βασικό διαχωριστικό είναι ότι **δεν καθοδηγείται από υπεραξιολόγηση βάρους/σχήματος ή φόβο πάχυνσης**. Η θεραπεία είναι πολυεπιστημονική, με διόρθωση ιατρικών και διατροφικών συνεπειών και συμπεριφορική/γνωσιακή παρέμβαση προσαρμοσμένη στον μηχανισμό της αποφυγής.

Πώς αντιμετωπίζετε ιατρικά επιβαρυμένη νευρική ανορεξία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ιατρικά επιβαρυμένη νευρική ανορεξία μπορεί να είναι **ιατρικό επείγον**. Όταν υπάρχει φυσιολογική αστάθεια ή οργανική δυσλειτουργία, η προτεραιότητα είναι η σωματική σταθεροποίηση και η ασφαλής επανασίτιση σε συνεργασία ψυχιατρικής και ιατρικής ομάδας. Δεν κρίνω την ασφάλεια από το BMI μόνο.

Η σύγχρονη εκτίμηση ακολουθεί πολυπαραγοντική λογική τύπου **MEED**, η οποία έχει αντικαταστήσει το παλαιότερο MARSIPAN ως βασικό σύγχρονο πλαίσιο. Εξετάζω ζωτικά σημεία, ορθοστατική μεταβολή, ενυδάτωση, ρυθμό απώλειας βάρους, βαθμό περιορισμού πρόσληψης, μυϊκή αδυναμία, συγκοπές, λοίμωξη και ενδείξεις οργανικής δυσλειτουργίας.

Με ανησυχούν ιδιαίτερα **σημαντική βραδυκαρδία, υπόταση ή ορθοστατική αστάθεια, υποθερμία, αφυδάτωση, ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες, ηλεκτρολυτικές διαταραχές και υπογλυκαιμία**. Χρήσιμα παραδείγματα «κόκκινου» ενήλικου κινδύνου είναι **BMI <13 kg/m², σφυγμός εγγήγορης <40/min, θερμοκρασία <35,5°C και γλυκόζη <3,0 mmol/L**. Αυτά είναι σημεία σοβαρού κινδύνου μέσα σε συνολική εκτίμηση και όχι αυτόνομα κριτήρια εισαγωγής.

Ζητώ ECG και κατάλληλο βιοχημικό έλεγχο, με ιδιαίτερη προσοχή σε **κάλιο, φωσφορικά, μαγνήσιο και γλυκόζη**, καθώς και σε άλλες διαταραχές ανάλογα με την κλινική εικόνα. Αν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά ασταθής, σοβαρά βιοχημικά ή ηλεκτροκαρδιογραφικά επιβαρυσμένος, δεν μπορεί να διατηρήσει ασφαλή ενυδάτωση/σίτιση ή έχει σοβαρό κίνδυνο επανασίτισης, **χρειάζεται επείγουσα ιατρική εισαγωγή ή υψηλότερο επίπεδο σωματικής παρακολούθησης**.

Κατά την επανασίτιση σκέφτομαι ενεργά το **σύνδρομο επανασίτισης**. Μπορεί να εμφανιστούν πτώση φωσφορικών, καλίου και μαγνησίου, διαταραχές υγρών, ανεπάρκεια θειαμίνης, αρρυθμίες, νευρολογική επιδείνωση και οργανική ανεπάρκεια.

Σε ασθενή υψηλού κινδύνου χορηγώ **θειαμίνη και πολυβιταμινούχα πριν ή μαζί με την έναρξη της σίτισης**, παρακολουθώ στενά και διορθώνω φωσφορικά, κάλιο, μαγνήσιο, γλυκόζη και ισοζύγιο υγρών. Η συχνότητα των ελέγχων και ο ρυθμός αύξησης της πρόσληψης καθορίζονται από τη βαρύτητα και την ανταπόκριση.

Η επανασίτιση **δεν πρέπει να είναι αδικαιολόγητα αργή με την υπόθεση ότι αυτό είναι πάντα ασφαλέστερο**. Χρειάζεται ενεργή, εξατομικευμένη και στενά παρακολουθούμενη επανασίτιση, με πιο προσεκτική έναρξη στους πολύ υψηλού κινδύνου ασθενείς. Παρατεταμένη ανεπαρκής σίτιση μπορεί και η ίδια να παρατείνει τον ιατρικό κίνδυνο.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 **Ιατρική αστάθεια → ιατρικό επίπεδο φροντίδας → κίνδυνος επανασίτισης → θειαμίνη/ηλεκτρολύτες → ενεργή στενά παρακολουθούμενη επανασίτιση**

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Το **MEED** έχει αντικαταστήσει το MARSIPAN ως σύγχρονο πολυπαραγοντικό πλαίσιο.
- Παραδείγματα σοβαρού ενήλικου κινδύνου: **BMI <13, σφυγμός <40/min, θερμοκρασία <35,5°C, γλυκόζη <3,0 mmol/L** — όχι ως αυτόματα μεμονωμένα κριτήρια εισαγωγής.
- Σύνδρομο επανασίτισης: **φωσφορικά, κάλιο, μαγνήσιο, υγρά και θειαμίνη.**

Πώς διαγιγνώσκετε και αντιμετωπίζετε τη νευρογενή βουλιμία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η νευρογενής βουλιμία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας με αίσθημα απώλειας ελέγχου, ακολουθούμενα από επαναλαμβανόμενες αντισταθμιστικές συμπεριφορές, μέσα σε ψυχοπαθολογία όπου το βάρος και το σχήμα σώματος επηρεάζουν υπερβολικά την αυτοαξιολόγηση. Η διάγνωση δεν εξαρτάται από το αν ο ασθενής έχει «φυσιολογικό» βάρος.

Στο ιστορικό διευκρινίζω τι θεωρεί ο ασθενής υπερφαγικό επεισόδιο, αν υπάρχει πραγματική απώλεια ελέγχου, πόσο συχνά εμφανίζονται τα επεισόδια και ποιες αντισταθμιστικές συμπεριφορές ακολουθούν. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν προκλητό έμετο, κατάχρηση καθαρτικών ή διουρητικών, νηστεία ή υπερβολική άσκηση.

Εξετάζω το κεντρικό γνωσιακό στοιχείο: κατά πόσο **βάρος και σχήμα σώματος υπερκαθορίζουν την αυτοεκτίμηση** και αν υπάρχει έντονος φόβος αύξησης βάρους. Παράλληλα ελέγχω διάθεση, αυτοτραυματισμό, αυτοκτονικό κίνδυνο, χρήση ουσιών και άλλες συννοσηρότητες.

Σημαντική διαφορική είναι η **νευρική ανορεξία με επεισόδια υπερφαγίας/κάθαρσης**. Αν ο ασθενής είναι σημαντικά λιποβαρής και πληροί την κεντρική αρχιτεκτονική της νευρικής ανορεξίας, η διάγνωση παραμένει νευρική ανορεξία και όχι βουλιμία. Δεν χρησιμοποιώ το παλιό BMI 17,5 ως μηχανικό διαχωριστικό όριο.

Η σωματική εκτίμηση πρέπει να αναζητά τις συνέπειες της κάθαρσης. Πρωτό για εμέτους, καθαρτικά και διουρητικά και ελέγχω, όπου ενδείκνυται, **ενυδάτωση, ηλεκτρολύτες και ηλεκτροκαρδιογράφημα**. Η υποκαλιαιμία και άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικό καρδιακό κίνδυνο. Ελέγχω επίσης οδοντικές και γαστρεντερικές επιπλοκές και άλλες σωματικές συνέπειες ανάλογα με την παρουσίαση.

Η βασική θεραπεία είναι **γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία προσαρμοσμένη στη διατροφική διαταραχή**. Σε ορισμένα συστήματα φροντίδας μπορεί να προηγείται ειδικά προσανατολισμένη καθοδηγούμενη αυτοβοήθεια και, όταν αυτή δεν επαρκεί ή δεν είναι κατάλληλη, ατομική CBT-ED. Ο στόχος είναι να διακοπεί ο κύκλος περιορισμού, υπερφαγίας, κάθαρσης και υπεραξιολόγησης του βάρους/σχήματος.

Η **fluoxetine 60 mg ημερησίως** αποτελεί τεκμηριωμένη **επικουρική θεραπεία** στους ενήλικες και μπορεί να μειώσει τα επεισόδια υπερφαγίας και κάθαρσης. Δεν αποτελεί μόνη της ολοκληρωμένη θεραπεία και δεν αντικαθιστά την ψυχοθεραπεία και τη διατροφική αποκατάσταση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Αν υπάρχει σημαντικά χαμηλό βάρος με την αρχιτεκτονική της νευρικής ανορεξίας, η διάγνωση είναι **AN** και όχι **BN**.
- Σημαντική κάθαρση απαιτεί έλεγχο ηλεκτρολυτών και καρδιακού κινδύνου.
- **Fluoxetine 60 mg/ημέρα** είναι επικουρική θεραπεία στους ενήλικες, όχι υποκατάστατο της CBT-ED.

Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε τη χρόνια αϋπνία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η χρόνια αϋπνία χαρακτηρίζεται από **δυσκολία έναρξης ή διατήρησης του ύπνου ή πρόωρη αφύπνιση, παρά επαρκή ευκαιρία για ύπνο, με ουσιαστικές συνέπειες την ημέρα**. Πριν τη θεραπεύσω ως πρωτοπαθή αϋπνία, χρειάζεται να καταλάβω το πραγματικό πρόγραμμα ύπνου και να αποκλείσω άλλες αιτίες που διατηρούν το πρόβλημα.

Πρωτό για ώρα κατάκλισης και αφύπνισης, χρόνο μέχρι να αποκοιμηθεί, νυχτερινές αφυπνίσεις, υπνάκους, μεταβλητότητα μεταξύ εργασιμων και ελεύθερων ημερών και αν υπάρχει πράγματι επαρκής ευκαιρία για ύπνο. Ένα **ημερολόγιο ύπνου** είναι συχνά χρήσιμο για να ξεκαθαρίσει το πρότυπο.

Ελέγχω **καφεΐνη, αλκοόλ και άλλες ουσίες, φάρμακα, άγχος, κατάθλιψη ή μανία, πόνο και άλλες σωματικές καταστάσεις**. Στη διαφορική εξετάζω αποφρακτική άπνοια ύπνου, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, άλλες διαταραχές ύπνου και κιρκάδιες διαταραχές. Ξεχωρίζω ιδιαίτερα την αϋπνία από την καθυστερημένη φάση ύπνου, όπου το άτομο μπορεί να κοιμάται καλά όταν επιτρέπεται να ακολουθήσει το φυσικό του καθυστερημένο ωράριο.

Η προτιμώμενη μακροχρόνια θεραπεία είναι η **γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία (CBT-I)**. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως έλεγχο ερεθισμάτων, περιορισμό ή συμπίεση του χρόνου στο κρεβάτι, γνωσιακή εργασία γύρω από τον ύπνο και πρόληψη υποτροπής. Η απλή «υγιεινή ύπνου» είναι υποστηρικτική αλλά **δεν αποτελεί επαρκή αυτόνομη θεραπεία της χρόνιας αϋπνίας**.

Φαρμακοθεραπεία χρησιμοποιείται επιλεκτικά όταν η CBT-I δεν είναι διαθέσιμη, δεν είναι κατάλληλη, δεν γίνεται αποδεκτή ή δεν επαρκεί. Βενζοδιαζεπίνες και Z-drugs δεν αποτελούν προεπιλεγμένη χρόνια θεραπεία· όταν χρησιμοποιούνται, χρειάζεται σαφής στόχος και επανεκτίμηση λόγω ανοχής, εξάρτησης και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η **daridorexant** είναι σύγχρονη ευρωπαϊκά αδειοδοτημένη επιλογή για χρόνια αϋπνία με ημερήσια επιβάρυνση. Η NICE την τοποθετεί όταν η CBT-I έχει αποτύχει ή δεν είναι διαθέσιμη/κατάλληλη. Η επιλογή υπνωτικού πρέπει να παραμένει εξατομικευμένη και να έπεται της αιτιολογικής αξιολόγησης. Σημαντική αντένδειξη της daridorexant είναι η **ναρκοληψία**.

Η θεραπεία ολοκληρώνεται με επανεκτίμηση της ημερήσιας λειτουργικότητας και της αιτίας που συντηρεί την αϋπνία, όχι μόνο με το αν ο ασθενής αναφέρει περισσότερες ώρες ύπνου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **CBT-I** είναι η προτιμώμενη μακροχρόνια θεραπεία· η υγιεινή ύπνου μόνη της δεν αρκεί.
- Χρόνια βενζοδιαζεπίνη/Z-drug δεν είναι η συνήθης προεπιλογή.

- **Daridorexant** είναι ευρωπαϊκή επιλογή σε κατάλληλους ασθενείς και αντενδείκνυται στη ναρκοληψία.

ΠΙΘΑΝΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΉ

Πώς διακρίνετε τη διαταραχή καθυστερημένης φάσης ύπνου–εγρήγορσης;

Στην καθυστερημένη φάση υπάρχει **κιρκάδια μετατόπιση**: το άτομο δυσκολεύεται να κοιμηθεί και να ξυπνήσει στις συμβατικές ώρες, αλλά όταν του επιτρέπεται να ακολουθήσει το προτιμώμενο αργότερο ωράριο, η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου μπορεί να είναι φυσιολογικές. Στην αϋπνία, αντίθετα, ο ύπνος παραμένει δύσκολος παρά κατάλληλη ευκαιρία και χρόνο. Η αντιμετώπιση της καθυστερημένης φάσης χρησιμοποιεί σταθεροποίηση ωραρίου και κατάλληλα χρονισμένες κιρκάδιες παρεμβάσεις, όπως φως ή μελατονίνη, χωρίς ένα καθολικό σχήμα για όλους.

Πώς αξιολογείτε υπερβολική ημερήσια υπνηλία και πιθανή ναρκοληψία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην υπερβολική ημερήσια υπνηλία πρώτα επιβεβαιώνω ότι πρόκειται για **πραγματική τάση για ύπνο και όχι απλώς κόπωση, έλλειψη ενέργειας ή απάθεια**. Η ναρκοληψία είναι μία σημαντική αιτία, αλλά πριν από αυτή πρέπει να αποκλείσω πολύ συχνότερα αίτια όπως ανεπαρκή ύπνο, αποφρακτική άπνοια ύπνου, κατασταλτικά φάρμακα, κιρκάδια διαταραχή, κατάθλιψη ή άλλη ιατρική νόσο.

Παίρνω λεπτομερές ιστορικό ωραρίου και διάρκειας ύπνου, υπνάκων, εργασίας σε βάρδιες, ροχαλητού ή επεισοδίων άπνοιας, ουσιών και φαρμάκων. Με ενδιαφέρει αν υπάρχουν **ακατανίκητα επεισόδια υπνηλίας ή αιφνίδιες προσβολές ύπνου** που προκαλούν πρόβλημα στην καθημερινότητα ή κίνδυνο, για παράδειγμα στην οδήγηση.

Στη ναρκοληψία αναζητώ ιδιαίτερα την **καταπληξία**, δηλαδή παροδική απώλεια μυϊκού τόνου με διατήρηση της συνείδησης, συχνά εκλυόμενη από έντονο συναίσθημα. Η καταπληξία είναι πολύ ισχυρό στοιχείο για ναρκοληψία τύπου 1. Ρωτώ επίσης για υπνική παράλυση και υπναγωγικές ή υπνοπομπικές ψευδαισθήσεις, αλλά αυτά είναι υποστηρικτικά και **δεν απαιτούνται** για τη διάγνωση.

Η **ναρκοληψία τύπου 1** συνδέεται με καταπληξία και/ή ανεπάρκεια υποκρετίνης/ορεξίνης μέσα στο κατάλληλο διαγνωστικό πλαίσιο. Η **ναρκοληψία τύπου 2** δεν έχει καταπληξία ούτε τεκμηριωμένη ανεπάρκεια υποκρετίνης. Η επιβεβαίωση ανεπάρκειας υποκρετίνης ανήκει στην εξειδικευμένη διαγνωστική διερεύνηση.

Η αντικειμενική διερεύνηση, όταν η κλινική υποψία το δικαιολογεί, γίνεται με **νυχτερινή πολυυπνογραφία και στη συνέχεια Multiple Sleep Latency Test (MSLT)**. Η πολυυπνογραφία βοηθά επίσης να αποκλειστούν άλλες διαταραχές ύπνου και να εξασφαλιστεί ότι η ερμηνεία του MSLT γίνεται στο σωστό πλαίσιο.

Η θεραπεία είναι εξειδικευμένη. Περιλαμβάνει **σταθερό πρόγραμμα ύπνου, προγραμματισμένους υπνάκους και μέτρα ασφάλειας**, μαζί με φάρμακα που προάγουν την εγρήγορση ή στοχεύουν την καταπληξία και άλλα REM φαινόμενα ανάλογα με τον φαινότυπο. Η ακριβής φαρμακολογική επιλογή εξαρτάται ανάλογα με το κυρίαρχο σύμπτωμα, τις συννοσηρότητες και την ασφάλεια.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Πριν από ναρκοληψία αποκλείω **ανεπαρκή ύπνο, OSA, φάρμακα και κιρκάδια αίτια**.
- **Καταπληξία** είναι ισχυρή ένδειξη τύπου 1· τύπος 2 δεν έχει καταπληξία ούτε τεκμηριωμένη ανεπάρκεια υποκρετίνης.
- Βασική αντικειμενική διαδρομή: **νυχτερινή πολυυπνογραφία → MSLT**.

ΠΙΘΑΝΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΉ

Τι γνωρίζετε για τη διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM;

Η διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM (RBD) χαρακτηρίζεται από εκδήλωση του περιεχομένου των ονείρων με κινήσεις ή συμπεριφορές επειδή χάνεται η φυσιολογική μυϊκή ατονία του REM. Η διάγνωση υποστηρίζεται ή επιβεβαιώνεται με πολυπνογραφική καταγραφή REM ύπνου χωρίς ατονία. Πρώτα εξασφαλίζω την ασφάλεια του ασθενούς και του συντρόφου, ελέγχω φάρμακα και άλλες διαταραχές ύπνου και, όταν χρειάζεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί **άμεσης αποδέσμευσης μελατονίνη ή clonazepam** σε κατάλληλους ασθενείς. Η RBD έχει ισχυρή σχέση με τρέχουσες ή μελλοντικές **α-συνουκλεϊνοπάθειες**, όπως νόσο Parkinson και DLB, γεγονός με σημαντική προγνωστική αξία. Δεν υπάρχει καθιερωμένη νευροπροστατευτική θεραπεία.

Ποια είναι τα στάδια του ύπνου και τα βασικά ηλεκτροεγκεφαλογραφικά χαρακτηριστικά τους;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ύπνος χωρίζεται σε NREM στάδια N1, N2, N3 και ύπνο REM.

- Το N1 είναι το ελαφρύ μεταβατικό στάδιο από την εγρήγορση στον ύπνο και στο EEG κυριαρχεί κυρίως θήτα δραστηριότητα.
- Το N2 χαρακτηρίζεται ηλεκτροεγκεφαλογραφικά από ατράκτους ύπνου και συμπλέγματα K.
- Το N3 είναι ο ύπνος βραδέων κυμάτων, με υψηλού δυναμικού βραδεία/δέλτα δραστηριότητα.
- Στον REM το EEG είναι χαμηλού δυναμικού και μικτής συχνότητας, υπάρχουν ταχείες οφθαλμικές κινήσεις και φυσιολογικά ατονία των σκελετικών μυών, με τις αναμενόμενες εξαιρέσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εναλλάσσονται επανειλημμένα κύκλοι NREM και REM.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- N1: θήτα · N2: άτρακτοι + K-complexes · N3: δέλτα · REM: χαμηλού δυναμικού μικτή συχνότητα + REMs + ατονία.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ποιες κλασικές μεταβολές της αρχιτεκτονικής ύπνου έχουν περιγραφεί στην κατάθλιψη;

Κλασικά έχουν συσχετισθεί βραχύτερος λανθάνων χρόνος REM, αυξημένη πυκνότητα REM και μειωμένος ύπνος βραδέων κυμάτων. Πρόκειται για κλασικά ερευνητικά ευρήματα· δεν αποτελούν διαγνωστικό τεστ για κατάθλιψη και δεν χρησιμοποιώ ένα σταθερό όριο λανθάνοντος REM ως καθολικό κριτήριο.

Πώς ταξινομείτε και διατυπώνετε τις διαταραχές προσωπικότητας;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή προσωπικότητας αφορά ένα **επίμονο και διάχυτο δυσπροσαρμοστικό πρότυπο λειτουργίας του εαυτού και των σχέσεων**, που έχει τις ρίζες του στην εφηβεία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή και προκαλεί ουσιαστική δυσλειτουργία. Στο ICD-11 η βασική σύγχρονη λογική είναι κυρίως **διαστασιακή**: πρώτα κρίνω αν υπάρχει διαταραχή προσωπικότητας και πόσο σοβαρή είναι και στη συνέχεια περιγράφω τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά.

Η βαρύτητα στο ICD-11 χαρακτηρίζεται ως **ήπια, μέτρια ή σοβαρή**. Με ενδιαφέρει πόσο εκτεταμένα επηρεάζονται η ταυτότητα και η αυτοκατεύθυνση, η ικανότητα για σταθερές σχέσεις, η ρύθμιση συναισθήματος και συμπεριφοράς, η κοινωνική και επαγγελματική λειτουργία και ο κίνδυνος για τον ίδιο ή τους άλλους.

Στη συνέχεια περιγράφω τους πέντε τομείς χαρακτηριστικών του ICD-11:

- αρνητική συναισθηματικότητα (Negative Affectivity),
- απόσυρση/αποστασιοποίηση (Detachment),
- αντικοινωνικότητα ή δυσκοινωνικότητα (Dissociality),
- αποαναστολή (Disinhibition),
- αναγκαστικότητα/αναγκαστικό πρότυπο (Anankastia).

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ο προαιρετικός **προσδιοριστής μεταιχμιακού προτύπου** όταν η κλινική εικόνα το δικαιολογεί.

Δεν συγχέω αυτή την αρχιτεκτονική με το DSM-5-TR. Το DSM-5-TR Section II εξακολουθεί να διατηρεί τις παραδοσιακές ονομαστικές κατηγορίες και τις ομάδες **A, B και C**. Αυτές είναι χρήσιμες όταν μιλάω με όρους DSM, αλλά δεν τις παρουσιάζω ως τη σημερινή δομή του ICD-11.

Η ταξινόμηση από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται **διατύπωση περίπτωσης**: αναπτυξιακό ιστορικό, σημαντικές σχέσεις και προσκόλληση, ιδιοσυγκρασία, τραυματικές ή άλλες δυσμενείς εμπειρίες όπου σχετίζονται, σχήματα και τρόποι αντιμετώπισης, επαναλαμβανόμενα διαπροσωπικά μοτίβα, δυνατότητες και προστατευτικοί παράγοντες. Παράλληλα αξιολογώ κατάθλιψη, άγχος, χρήση ουσιών, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άλλες συννοσηρότητες, καθώς και αυτοτραυματισμό, αυτοκτονικότητα ή βία όπου σχετίζονται.

Στόχος είναι να περιγράψω τι είδους **δυσλειτουργία υπάρχει, πόσο σοβαρή είναι και ποια χαρακτηριστικά την οργανώνουν**, χωρίς να μετατρέπω έναν άνθρωπο σε μία κατηγορική ετικέτα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- ICD-11: διαταραχή προσωπικότητας → βαρύτητα → τομείς χαρακτηριστικών.
- Βαρύτητα: **ήπια, μέτρια, σοβαρή**· τομείς: Negative Affectivity, Detachment, Dissociality, Disinhibition, Anankastia.

- Ο **borderline pattern qualifier** είναι προαιρετικός· τα clusters A/B/C ανήκουν στη DSM αρχιτεκτονική, όχι στο ICD-11.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας ή κοινωνικό άγχος;

Το αποφευκτικό προσωπικό πρότυπο είναι ευρύτερο και διαχρονικά διάχυτο, επηρεάζοντας αυτοαντίληψη, σχέσεις και συνολική διαπροσωπική λειτουργία. Η κοινωνική αγχώδης διαταραχή οργανώνεται κυρίως γύρω από φόβο έκθεσης και αρνητικής αξιολόγησης. Μπορούν να συνυπάρχουν. Στο ICD-11 το αντίστοιχο αποφευκτικό φαινότυπο περιγράφεται διαστασιακά, συχνά με αρνητική συναισθηματικότητα και απόσυρση, αντί ως ξεχωριστή κατηγορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς διακρίνετε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας από OCD;

Το αναγκαστικό/ιδεοψυχαναγκαστικό προσωπικό πρότυπο χαρακτηρίζεται από διάχυτη τελειοθηρία, ακαμψία, ανάγκη τάξης και ελέγχου και υπερβολική ευσυνειδησία. Η OCD απαιτεί ιδεοληψίες και/ή καταναγκασμούς. Η διάκριση «εγωσυντονικό έναντι εγωδυστονικού» είναι χρήσιμη ως τάση αλλά όχι απόλυτος κανόνας. Στο ICD-11 δεν υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία OCPD/αναγκαστικής προσωπικότητας· η **Anankastia** είναι τομέας χαρακτηριστικών, ενώ η OCD παραμένει ξεχωριστή ιδεοψυχαναγκαστική και συναφής διαταραχή.

Πώς αντιμετωπίζετε τη μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αντιμετώπιση της μεταιχμιακής διαταραχής προσωπικότητας βασίζεται κυρίως σε **σταθερό θεραπευτικό πλαίσιο, συνεργατική διατύπωση και δομημένη εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία**. Η φαρμακοθεραπεία δεν αποτελεί θεραπεία της ίδιας της διαταραχής ούτε του βασικού προτύπου συναισθηματικής αστάθειας και αυτοτραυματισμού.

Η κλινική εικόνα συνήθως περιλαμβάνει **αστάθεια στις σχέσεις, στην αυτοεικόνα και στο συναίσθημα, παρορμητικότητα, ευαισθησία στην εγκατάλειψη, έντονο θυμό, επαναλαμβανόμενο αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονική συμπεριφορά και, σε έντονο στρες, παροδική παρανοειδή ιδεασμό ή διασχιστικά συμπτώματα**.

Στην αρχή εκτιμώ **αυτοκτονικότητα, αυτοτραυματισμό, χρήση ουσιών, βία ή άλλον άμεσο κίνδυνο**. Δεν χρησιμοποιώ όμως τον κίνδυνο μόνο ως λόγο για αποσπασματικές εισαγωγές ή συνεχείς αλλαγές θεραπείας. Με τον ασθενή διαμορφώνω ένα σαφές σχέδιο για το τι πυροδοτεί τις κρίσεις, ποια είναι τα πρώιμα σημεία, ποιες δεξιότητες ή επαφές βοηθούν και τότε χρειάζεται επείγουσα βοήθεια.

Το **θεραπευτικό πλαίσιο** πρέπει να είναι προβλέψιμο: σαφείς ρόλοι, όρια, τρόπος επικοινωνίας, σχέδιο για κρίσεις και συνέπεια μεταξύ των επαγγελματιών. Αυτό δεν είναι τιμωρητική «οριοθέτηση», αλλά τρόπος να μειωθεί η αποδιοργάνωση και να διατηρηθεί μια σταθερή θεραπευτική σχέση.

Η κύρια θεραπεία είναι **δομημένη εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία**. Η διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία (DBT), η θεραπεία βασισμένη στη νοηματοδότηση/mentalization (MBT) και άλλα συνεκτικά τεκμηριωμένα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν υπάρχει ένα μόνο υποχρεωτικό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο για όλους· μεγαλύτερη σημασία έχει η συστηματική, καλά οργανωμένη θεραπεία με σαφή στόχο.

Επανεξετάζω τα φάρμακα που ήδη λαμβάνει ο ασθενής. **Δεν χρησιμοποιώ χρόνια αντιψυχωσικά ή μακροχρόνια πολυφαρμακία για τη μεταιχμιακή διαταραχή καθαυτή**, ούτε συνταγογραφώ για κάθε συναισθηματική μεταβολή. Αν υπάρχει σαφώς διαγνωσμένη συννοσηρή κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή, ΔΕΠΥ ή άλλη κατάσταση, τη θεραπεύω σύμφωνα με τη δική της ένδειξη.

Σε οξεία κρίση μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιηθεί **πολύ βραχυχρόνια φαρμακευτική παρέμβαση** για συγκεκριμένο στόχο, με ιδιαίτερη προσοχή στην τοξικότητα σε υπερδοσολογία, τον κίνδυνο κατάχρησης, ένα φάρμακο όπου είναι δυνατό και σαφές σχέδιο διακοπής ή επανεξέτασης. Δεν την αφήνω να γίνει ο βασικός τρόπος διαχείρισης των κρίσεων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Κύρια θεραπεία = **δομημένη εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία**· DBT, MBT και άλλα συνεκτικά τεκμηριωμένα προγράμματα είναι έγκυρες επιλογές.

- Φάρμακα δεν θεραπεύουν τον πυρήνα της BPD· αποφεύγω χρόνια αντιψυχωσικά και πολυφαρμακία χωρίς άλλη σαφή ένδειξη.
- Η οξεία κρίση χρειάζεται **σχέδιο, συνέχεια και συγκεκριμένο στόχο**, όχι αυτόματη προσθήκη φαρμάκου.

ΠΙΘΑΝΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΉ

Πώς διακρίνετε τη συναισθηματική αστάθεια της μεταιχμιακής διαταραχής από τη διπολική διαταραχή;

Στη μεταιχμιακή διαταραχή οι μεταβολές είναι συχνά **ταχείες και αντιδραστικές σε διαπροσωπικά ή περιβαλλοντικά γεγονότα**, μέσα σε χρόνιο πρότυπο αστάθειας ταυτότητας και σχέσεων. Η διπολική διαταραχή απαιτεί **διακριτά, παρατεταμένα επεισόδια** που αποτελούν σαφή μεταβολή από το βασικό επίπεδο λειτουργίας. Αναζητώ μειωμένη ανάγκη για ύπνο, μεγαλοϊδεατισμό, αυξημένη στοχοκατευθυνόμενη δραστηριότητα, επεισοδιακότητα και το επίπεδο λειτουργίας μεταξύ επεισοδίων. Η διάρκεια βοηθά αλλά δεν αρκεί μόνη της, και οι δύο διαγνώσεις μπορούν να συνυπάρχουν.

Πώς διακρίνετε αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας από ψυχοπάθεια;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η βασική διάκριση είναι ότι η **αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας (ASPD)** είναι επίσημη διάγνωση του DSM, ενώ η **ψυχοπάθεια** δεν αποτελεί ανεξάρτητη διάγνωση ούτε στο DSM-5-TR ούτε στο ICD-11. Η ψυχοπάθεια είναι κυρίως προσωπολογική και εγκληματολογική έννοια που δίνει μεγαλύτερο βάρος σε συγκεκριμένα διαπροσωπικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά.

Η ASPD είναι περισσότερο **συμπεριφορικά σταθμισμένη**. Περιλαμβάνει επίμονο πρότυπο παραβίασης δικαιωμάτων και κοινωνικών κανόνων, εξαπάτηση, παρορμητικότητα, επιθετικότητα, ανευθυνότητα και σχετικό αναπτυξιακό αντικοινωνικό ιστορικό όπου απαιτείται από το σύστημα ταξινόμησης.

Η ψυχοπάθεια περιγράφει ευρύτερο φαινότυπο με χαρακτηριστικά όπως **επιφανειακή γοητεία, χειριστικότητα, σκληρότητα, ρηχό συναίσθημα, έλλειψη ενσυναίσθησης ή τύψεων**, μαζί με αντικοινωνικό τρόπο ζωής και συμπεριφορά. Επομένως δύο άνθρωποι με παρόμοιο ιστορικό παραβατικότητας δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο ψυχοπαθητικό προφίλ.

Στο ICD-11 δεν υπάρχει ξεχωριστή διάγνωση «ψυχοπάθειας». Αντικοινωνικά ή δυσκοινωνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται **διαστασιακά μέσα στη διαταραχή προσωπικότητας**, κυρίως μέσω του τομέα της δυσκοινωνικότητας και της συνολικής βαρύτητας.

Η αξιολόγηση χρειάζεται **αναπτυξιακό ιστορικό, ιστορικό παραβατικότητας και βίας, σχέσεις, εργασία, χρήση ουσιών, παρορμητικότητα, προηγούμενες συνέπειες, πιθανές ψυχιατρικές διαταραχές και προστατευτικούς παράγοντες**. Δεν αρκεί να γνωρίζω ότι κάποιος έχει καταδικαστεί ή ότι είναι χειριστικός.

Η **Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)** μπορεί να αναφερθεί ως εξειδικευμένο εργαλείο εγκληματολογικής αξιολόγησης όταν χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία. Δεν είναι εργαλείο ρουτίνας της γενικής ψυχιατρικής και δεν χρησιμοποιείται για να μετατρέψει ένα άθροισμα βαθμών σε αυτόματη διάγνωση.

Και στις δύο περιπτώσεις η κλινική σημασία είναι να γίνει **προσεκτική εκτίμηση κινδύνου, χρήσης ουσιών, δυναμικών παραγόντων και διαχειριστικών αναγκών**, χωρίς να εξισώνεται η εγκληματικότητα με την ψυχοπάθεια ούτε η ψυχοπάθεια με αναπόφευκτη βία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- ASPD = επίσημη DSM διάγνωση · ψυχοπάθεια ≠ επίσημη DSM-5-TR/ICD-11 διάγνωση.
- Η ASPD είναι περισσότερο συμπεριφορικά σταθμισμένη· η ψυχοπάθεια δίνει μεγαλύτερο βάρος σε διαπροσωπικά/συναισθηματικά χαρακτηριστικά.

- **PCL-R** = εξειδικευμένο εγκληματολογικό εργαλείο, όχι screening ή αυτόματο διαγνωστικό τεστ γενικής ψυχιατρικής.

Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε σεξουαλική δυσλειτουργία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στη σεξουαλική δυσλειτουργία πρώτα διευκρινίζω **ποιο ακριβώς πεδίο έχει διαταραχθεί**: επιθυμία, διέγερση, οργασμός ή πόνος/δυσκολία διείσδυσης. Η αξιολόγηση είναι βιοψυχοκοινωνική, επειδή η σεξουαλική λειτουργία επηρεάζεται ταυτόχρονα από σωματική υγεία, φάρμακα, ψυχική κατάσταση, σχέση και πλαίσιο.

Πρωτό ποτέ άρχισε το πρόβλημα και αν είναι **δια βίου ή επίκτητο, γενικευμένο ή καταστασιακό**, αν προκαλεί δυσφορία και πώς μεταβάλλεται ανάλογα με τον σύντροφο ή το πλαίσιο. Εξετάζω τη σχέση, την επικοινωνία, τυχόν φόβο επίδοσης, άγχος, κατάθλιψη, τραυματικές εμπειρίες όπου σχετίζονται και τη συνολική σεξουαλική επιθυμία και ικανοποίηση.

Παράλληλα αναζητώ **ιατρικά, ενδοκρινικά και νευρολογικά αίτια**, καθώς και αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Η φαρμακευτική αγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ψυχιατρική: οι **SSRI** συχνά προκαλούν μείωση επιθυμίας, καθυστέρηση ή αδυναμία οργασμού, ενώ αντιψυχωσικά που αυξάνουν την προλακτίνη μπορούν να προκαλέσουν σεξουαλική δυσλειτουργία μέσω υπερπρολακτιναιμίας και άλλων μηχανισμών.

Η σωματική εξέταση και οι εξετάσεις καθορίζονται από την παρουσίαση. Όταν υπάρχουν ενδείξεις, εξετάζω **προλακτίνη και άλλες ορμονικές παραμέτρους**, αγγειακούς ή νευρολογικούς παράγοντες και άλλες πιθανές σωματικές αιτίες. Δεν χρειάζεται ένα ίδιο εργαστηριακό πακέτο για όλους.

Η θεραπεία ξεκινά από την **αναστρέψιμη αιτία**. Αν το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά από φάρμακο, επανεξετάζω την ένδειξη, τη δόση ή πιθανή αλλαγή αγωγής με βάση τον κίνδυνο υποτροπής της ψυχιατρικής νόσου. Αν υπάρχει κατάθλιψη, άγχος, ενδοκρινική ή άλλη ιατρική κατάσταση, τη θεραπεύω αντίστοιχα.

Όπου το πρόβλημα συνδέεται με άγχος επίδοσης, επικοινωνία, προσδοκίες, τραύμα ή δυναμική σχέσης, μπορούν να βοηθήσουν **ψυχοσεξουαλικές και σχεσιακές παρεμβάσεις**. Αν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη, χρησιμοποιούνται και ειδικές θεραπείες, για παράδειγμα **αναστολείς PDE5** στη στυτική δυσλειτουργία όταν είναι κατάλληλοι.

Ταξινομικά, το ICD-11 έχει μετακινήσει τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες στις **καταστάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία**, αντί να τις οργανώνει απλώς ως «μη οργανικές» ψυχικές διαταραχές. Αυτό ταιριάζει καλύτερα στη σημερινή βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Οργανώνω την αξιολόγηση σε **επιθυμία, διέγερση, οργασμό και πόνο/διείσδυση**, με δια βίου/επίκτητο και γενικευμένο/καταστασιακό πρότυπο.
- **SSRI** και αντιψυχωσικά που αυξάνουν την προλακτίνη είναι συχνά φαρμακευτικά αίτια.

- ICD-11: οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες ανήκουν στις **καταστάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία**, όχι στη παλιά απλή διάκριση «οργανική/μη οργανική».

Πότε ένα παραφιλικό ενδιαφέρον αποτελεί διαταραχή και πώς αξιολογείτε τον κίνδυνο;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ένα άτυπο ή παραφιλικό σεξουαλικό ενδιαφέρον δεν αποτελεί από μόνο του ψυχική διαταραχή. Για να μιλήσω για παραφιλική διαταραχή, με ενδιαφέρει αν το πρότυπο αφορά μη συναινούντα άτομα, αν προκαλεί κλινικά σημαντική δυσφορία που δεν οφείλεται απλώς σε κοινωνικό στίγμα ή απόρριψη, και, ανάλογα με την κατάσταση, αν δημιουργεί ουσιαστικό άμεσο κίνδυνο βλάβης.

Παίρνω προσεκτικό και μη επικριτικό σεξουαλικό ιστορικό. Ρωτώ για φαντασιώσεις, παρορμήσεις και πραγματικές συμπεριφορές, τη συχνότητα και έντασή τους, το κατά πόσο υπάρχει έλεγχος, αν το ενδιαφέρον έχει κλιμακωθεί και αν έχει μετατραπεί σε πράξεις. Η διάκριση ανάμεσα σε φαντασίωση και συμπεριφορά είναι κρίσιμη.

Κεντρικό στοιχείο είναι η **συναίνεση**. Αν οι πράξεις αφορούν ή ενδέχεται να αφορούν μη συναινούντα άτομα, εκτιμώ συγκεκριμένα ποια είναι τα πιθανά θύματα, πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση σε αυτά, αν υπάρχει προπαρασκευή, προηγούμενη σεξουαλική ή άλλη παραβατικότητα και ποιοι παράγοντες αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο.

Ελέγχω επίσης αλκοόλ ή άλλες ουσίες που μειώνουν τον έλεγχο, ψυχιατρικές διαταραχές, παρορμητικότητα, γνωστική δυσλειτουργία, επίπεδο εναισθησίας, κίνητρο για θεραπεία και προστατευτικούς παράγοντες. Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να οδηγεί σε εφαρμόσιμο σχέδιο, όχι σε γενική ετικέτα «επικίνδυνος».

Όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για άλλους, οι υποχρεώσεις προστασίας και οι νομικές/δικαστικές ενέργειες εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη κατάσταση και τη δικαιοδοσία. Στην ελληνική πρακτική οι ενέργειες αυτές πρέπει να στηρίζονται στο εφαρμοστέο ελληνικό νομικό πλαίσιο και όχι σε αυτόματη μεταφορά ξένων κανόνων.

Η θεραπεία είναι εξειδικευμένη και περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτική εργασία γύρω από αυτοέλεγχο, αναγνώριση εκλυτικών παραγόντων, πρόληψη υποτροπής, γνωσιακές στρεβλώσεις και διαχείριση κινδύνου. Σε επιλεγμένες χαμηλότερου ή μέτριου κινδύνου περιπτώσεις με έντονο καταναγκαστικό/παρείσακτο στοιχείο ή σχετική συννοσηρότητα μπορεί να εξεταστεί SSRI.

Σε επιλεγμένες **σοβαρές ή υψηλού κινδύνου** περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανδρογονική θεραπεία ή **ανάλογο GnRH**, αλλά αυτό είναι εξειδικευμένη παρέμβαση. Απαιτεί σαφές θεραπευτικό και νομικό πλαίσιο, συναίνεση όπου εφαρμόζεται και παρακολούθηση ενδοκρινικών, μεταβολικών, οστικών και καρδιαγγειακών επιπτώσεων. Η **ορμονική καταστολή δεν αποτελεί θεραπεία ρουτίνας για συναινετική άτυπη σεξουαλικότητα**.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Παραφιλικό ενδιαφέρον ≠ παραφιλική διαταραχή· συναίνεση, βλάβη/κίνδυνος και κλινικά σημαντική δυσφορία είναι κεντρικά.
- Εκτίμηση κινδύνου = πιθανά θύματα, πρόσβαση, κλιμάκωση, προηγούμενες πράξεις, ουσίες και προστατευτικοί παράγοντες.
- Αντιανδρογόνα/GnRH ανάλογα είναι εξειδικευμένες επιλογές για επιλεγμένες σοβαρές/υψηλού κινδύνου περιπτώσεις, όχι ρουτίνα για συναινετική άτυπη σεξουαλικότητα.

Πώς προσεγγίζετε ενήλικα με δυσφορία φύλου ή ασυμφωνία φύλου;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ποικιλομορφία της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου δεν αποτελεί από μόνη της ψυχική διαταραχή. Στην αξιολόγηση ενήλικα με δυσφορία ή ασυμφωνία φύλου, ο ρόλος μου είναι να κατανοήσω την εμπειρία του ατόμου, τους στόχους του, τυχόν ψυχιατρική δυσφορία ή κίνδυνο και την ικανότητά του να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις — όχι να «αποδείξω» ή να ακυρώσω την ταυτότητά του.

Ρωτώ με σεβασμό πώς βιώνει το άτομο το φύλο του, ποια στοιχεία του σώματος ή της κοινωνικής ζωής προκαλούν δυσφορία, ποιοι είναι οι στόχοι του και τι είδους υποστήριξη αναζητά. Εξετάζω το **κοινωνικό πλαίσιο**, τις σχέσεις, την οικογενειακή ή κοινοτική υποστήριξη, πιθανές διακρίσεις, απόρριψη ή στρες μειονότητας και πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία.

Παράλληλα εκτιμώ **κατάθλιψη, άγχος, νευροαναπτυξιακές καταστάσεις, τραυματικές εμπειρίες, χρήση ουσιών, αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικό κίνδυνο** όταν υπάρχουν ενδείξεις. Αυτές οι καταστάσεις αξιολογούνται και θεραπεύονται με τα δικά τους κριτήρια. Δεν υποθέτω ότι «εξηγούν» ή ακυρώνουν την ταυτότητα φύλου.

Αν το άτομο εξετάζει ιατρικές παρεμβάσεις, αξιολογώ με τον συνήθη κλινικό τρόπο την **ικανότητα λήψης της συγκεκριμένης απόφασης**, την κατανόηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των κινδύνων, των περιορισμών και των εναλλακτικών και υποστηρίζω ενημερωμένα και αυτόνομη λήψη απόφασης. Η ύπαρξη μιας ψυχιατρικής διάγνωσης δεν συνεπάγεται από μόνη της ανικανότητα.

Όπου είναι σχετικό, προσφέρω ή διευκολύνω **κατάλληλη εξειδικευμένη υποστήριξη υγείας φύλου** και συντονισμό με άλλες ειδικότητες. Η συγκεκριμένη ελληνική διαδρομή υπηρεσιών και οι διοικητικοί κανόνες πρέπει να στηρίζονται στο ισχύον επαληθευμένο πλαίσιο.

Ταξινομικά, το ICD-11 έχει μετακινήσει την **ασυμφωνία φύλου εφηβείας και ενηλικίωσης** έξω από τις ψυχικές διαταραχές και στις **καταστάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία**. Αυτή η αλλαγή είναι ουσιώδης: διατηρεί την πρόσβαση σε φροντίδα χωρίς να παθολογικοποιεί την ίδια την ταυτότητα.

Συνολικά, η ψυχιατρική συμβολή είναι να αξιολογήσει **δυσφορία, ασφάλεια, συννοσηρότητα, ικανότητα λήψης απόφασης και ανάγκες υποστήριξης** με τον ίδιο σεβασμό και κλινική ακρίβεια που θα χρησιμοποιούσαμε σε κάθε άλλο ασθενή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η ποικιλομορφία φύλου δεν είναι ψυχική διαταραχή.
- ICD-11: Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood → **Conditions related to sexual health**, όχι ψυχικές διαταραχές.

- Ψυχιατρική συννοσηρότητα αξιολογείται ανεξάρτητα και δεν ακυρώνει την ταυτότητα ή αυτομάτως την ικανότητα λήψης απόφασης.

Ποιες βασικές αρχές φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής πρέπει να γνωρίζει ο ψυχίατρος;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η **φαρμακοκινητική** περιγράφει τι κάνει ο οργανισμός στο φάρμακο — απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμό και αποβολή — ενώ η **φαρμακοδυναμική** τι κάνει το φάρμακο στον οργανισμό, κυρίως μέσω της δράσης του στους υποδοχείς και της σχέσης δόσης-απόκρισης. Στην ψυχιατρική αυτές οι αρχές έχουν πρακτική σημασία για την επιλογή δόσης, τις αλληλεπιδράσεις, την έναρξη και διακοπή θεραπείας και την τοξικότητα.

Μετά τη χορήγηση εξετάζω την **απορρόφηση και τη βιοδιαθεσιμότητα**, δηλαδή ποιο ποσοστό της χορηγούμενης δόσης φθάνει στη συστηματική κυκλοφορία. Η οδός χορήγησης και ο μεταβολισμός πρώτης διόδου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την έκθεση.

Στην **κατανομή**, σημαντικά είναι η λιποδιαλυτότητα, η πρωτεϊνική σύνδεση και ο όγκος κατανομής. Μεταβολές της λευκωματίνης ή αλληλεπιδράσεις σε πολύ ισχυρά δεσμευμένα φάρμακα μπορεί να αλλάξουν το ελεύθερο κλάσμα, αλλά η κλινική σημασία εξαρτάται από το συγκεκριμένο φάρμακο και την κάθαρσή του.

Ο μεταβολισμός γίνεται κυρίως στο ήπαρ. Οι αντιδράσεις **φάσης I** περιλαμβάνουν συχνά οξείδωση μέσω του συστήματος κυτοχρώματος P450, ενώ οι αντιδράσεις **φάσης II** συνήθως περιλαμβάνουν σύζευξη. Η αναστολή ενός ενζύμου μπορεί να αυξήσει γρήγορα την έκθεση σε υπόστρωμα του ενζύμου, ενώ η επαγωγή και η αποδρομή της συνήθως εξελίσσονται πιο αργά επειδή απαιτούν αλλαγή στην ποσότητα του ενζύμου.

Κλασικά ψυχιατρικά παραδείγματα είναι ότι οι **πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες του καπνού — όχι η νικοτίνη — επάγουν το CYP1A2** και μπορούν να μειώσουν την έκθεση σε clozapine ή olanzapine. Fluoxetine και paroxetine είναι κλινικά σημαντικοί αναστολείς του **CYP2D6**, ενώ carbamazepine είναι κλασικός επαγωγέας ενζύμων.

Η **νεφρική λειτουργία** είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για φάρμακα που αποβάλλονται κυρίως από τους νεφρούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το λίθιο. Ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, ηλικία και αλληλεπιδράσεις μπορεί να απαιτούν εξατομίκευση, αλλά δεν υπάρχει ένας καθολικός κανόνας ποσοστιαίας μείωσης για όλα τα ψυχοτρόπα.

Ο **χρόνος ημίσειας ζωής** καθορίζει σε μεγάλο βαθμό πόσο γρήγορα συσσωρεύεται ή απομακρύνεται ένα φάρμακο. Η σταθερή συγκέντρωση επιτυγχάνεται μετά από αρκετούς χρόνους ημίσειας ζωής, συχνά περίπου 4–5. Αυτό εξηγεί γιατί ορισμένες αλλαγές δόσης χρειάζονται χρόνο πριν αξιολογηθούν αξιόπιστα.

Στη φαρμακοδυναμική διακρίνω **αγωνιστές, ανταγωνιστές και μερικούς αγωνιστές**. Η σχέση δόσης-απόκρισης και το θεραπευτικό εύρος/θεραπευτικός δείκτης καθορίζουν πόσο κοντά βρίσκεται η αποτελεσματική έκθεση στην τοξική

και πόσο στενή παρακολούθηση χρειάζεται.

Η φαρμακογενωμική μπορεί να βοηθήσει σε επιλεγμένες περιπτώσεις, αλλά τα εμπορικά πολυγονιδιακά panels δεν αποτελούν καθολική προϋπόθεση πριν τη συνταγογράφηση ψυχοτρόπου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Σταθερή κατάσταση: συνήθως μετά από περίπου 4–5 χρόνους ημίσειας ζωής.
- Ο καπνός — όχι η νικοτίνη — επάγει CYP1A2.
- Δεν απαιτείται γενικά φαρμακογενωμικό panel πριν από τη συνταγογράφηση.

Ποιες σημαντικές αλληλεπιδράσεις ψυχοτρόπων πρέπει να γνωρίζετε;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τις αλληλεπιδράσεις ψυχοτρόπων τις οργανώνω καλύτερα με βάση τον **μηχανισμό και την κλινική συνέπεια**: μεταβολικές αλληλεπιδράσεις, σεροτονινεργική τοξικότητα, παράταση QT, αθροιστική καταστολή, μεταβολές στα επίπεδα λιθίου, ειδικές αντιεπιληπτικές αλληλεπιδράσεις και αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο.

Στις μεταβολικές αλληλεπιδράσεις, σημαντικό παράδειγμα είναι το **κάπνισμα**. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες του καπνού επάγουν CYP1A2 και μειώνουν την έκθεση σε clozapine και olanzapine. Αν ο ασθενής μειώσει ή διακόψει απότομα το κάπνισμα, η έκθεση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Η **θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης δεν διατηρεί αυτή την επαγωγή**, επειδή η νικοτίνη δεν είναι ο επαγωγέας.

Η **σεροτονινεργική τοξικότητα** προκύπτει όταν συνδυάζονται φάρμακα που αυξάνουν υπερβολικά τη σεροτονινεργική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα επικίνδυνοι είναι οι συνδυασμοί **μη αναστρέψιμου ΜΑΟΙ με σεροτονινεργικά αντικαταθλιπτικά**, γι' αυτό χρειάζονται οι κατάλληλες περίοδοι έκπλυσης και δεν γίνεται τυφλό cross-taper.

Στον καρδιαγγειακό κίνδυνο σκέφτομαι την **αθροιστική παράταση QT**. Δεν αρκεί να γνωρίζω αν ένα φάρμακο μόνο του παρατείνει το QT· συνυπολογίζω άλλα QT-prolonging φάρμακα, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καρδιοπάθεια και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά.

Η συνδυασμένη **καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος** είναι κλασικό ζήτημα με βενζοδιαζεπίνες, οπιοειδή και αλκοόλ. Ο συνδυασμός μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο αναπνευστικής καταστολής, πτώσεων και διαταραχής συνείδησης.

Με το **λίθιο**, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με **NSAIDs, αναστολείς ACE, ARBs και κυρίως θειαζιδικά διουρητικά**, επειδή μπορούν να αυξήσουν την έκθεση και τον κίνδυνο τοξικότητας. Αφυδάτωση και οξεία νόσος μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω τον κίνδυνο.

Το **valproate** αυξάνει την έκθεση στη **lamotrigine** αναστέλλοντας τον μεταβολισμό της, άρα απαιτείται πολύ προσεκτικότερη τιτλοποίηση. Αντίστροφα, ενζυμικοί επαγωγείς μεταξύ των αντιεπιληπτικών μπορούν να μειώσουν την έκθεση σε ευαίσθητα ψυχοτρόπα.

Οι **SSRI και SNRI** μπορούν να αυξήσουν τον αιμορραγικό κίνδυνο, ο οποίος γίνεται σημαντικότερος όταν συνδυάζονται με **NSAIDs, αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά**. Αυτό απαιτεί εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου· δεν σημαίνει ότι χρειάζεται καθολικά PPI σε κάθε τέτοιο συνδυασμό.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Μη αναστρέψιμος MAOI + σεροτονινεργικό φάρμακο: υψηλού κινδύνου συνδυασμός.
- Βενζοδιαζεπίνες + οπιοειδή/αλκοόλ: αυξημένος κίνδυνος αναπνευστικής καταστολής.
- NSAIDs, ACEi/ARBs και θειαζίδες μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα λιθίου.
- Valproate αυξάνει την έκθεση στη lamotrigine.
- SSRI/SNRI με NSAID, αντιαιμοπεταλιακό ή αντιπηκτικό αυξάνουν τον αιμορραγικό κίνδυνο.

Πώς επιλέγετε αντιψυχωσικό;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχει ένα «καλύτερο» αντιψυχωσικό για όλους. Η επιλογή γίνεται εξατομικευμένα με βάση την προηγούμενη ανταπόκριση, το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τον συγκεκριμένο ασθενή, τη σωματική συννοσηρότητα, τις αλληλεπιδράσεις, την πιθανότητα συνέπειας στη λήψη και την προτίμησή του.

Αν έχει προηγηθεί αποτελεσματική και καλά ανεκτή θεραπεία, αυτό είναι ισχυρό πρακτικό στοιχείο υπέρ της επαναχρησιμοποίησης. Αν όχι, συζητώ με τον ασθενή ποιοι κίνδυνοι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα: αύξηση βάρους και μεταβολικές επιπλοκές, εξωπυραμидικά συμπτώματα, υπερπρολακτιναιμία και σεξουαλικές/ενδοκρινικές συνέπειες, παράταση QT, καταστολή και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ως χρήσιμα παραδείγματα, **clozapine** και **olanzapine** έχουν υψηλή μεταβολική επιβάρυνση. **Risperidone**, **paliperidone** και **amisulpride** είναι χαρακτηριστικά φάρμακα που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την προλακτίνη, ενώ **aripiprazole** είναι σχετικά προλακτινο-φειδωλή επιλογή. Αυτά δεν είναι άκαμπτη κατάταξη αποτελεσματικότητας, αλλά στοιχεία που βοηθούν να ταιριάξει το φάρμακο στον ασθενή.

Ελέγχω καρδιαγγειακό, μεταβολικό και νευρολογικό ιστορικό, άλλες θεραπείες και πιθανές αλληλεπιδράσεις. Κάπνισμα ή απότομη διακοπή του καπνίσματος έχει ιδιαίτερη σημασία για clozapine και olanzapine λόγω CYP1A2.

Αν η καθημερινή από του στόματος αγωγή είναι δύσκολη ή ο ασθενής προτιμά **ενέσιμο μακράς δράσης**, ένα LAI είναι απολύτως θεμιτή θεραπευτική επιλογή. Δεν το παρουσιάζω ως «φάρμακο για μη συνεργάσιμους» ή ως μέσο εξαναγκασμού. Οι κανόνες έναρξης, φόρτισης ή από του στόματος επικάλυψης είναι σκεύασμα-ειδικοί.

Η επιλογή επανεκτιμάται αφού γίνει πραγματική θεραπευτική δοκιμή με επαρκή δόση, διάρκεια και έκθεση. Αν δύο διαφορετικά αντιψυχωσικά έχουν αποτύχει παρά επαρκείς δοκιμές και έχει αποκλειστεί ψευδοανθεκτικότητα, η θεραπευτική λογική αλλάζει: η **clozapine** είναι η **θεραπεία εκλογής για πραγματικά ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια** και δεν πρέπει να αναβάλλεται με ατέρμονες πρόσθετες μη-κλοζαπινικές δοκιμές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Clozapine/olanzapine: υψηλή μεταβολική επιβάρυνση.
Risperidone/paliperidone/amisulpride: υπερπρολακτιναιμία.
- LAI: θεμιτή επιλογή λόγω προτίμησης ή όταν η συνέπεια στη λήψη είναι σημαντικό ζήτημα.
- Γνήσια TRS μετά δύο επαρκείς αποτυχίες → clozapine.

Ποιες είναι οι εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιψυχωσικών και πώς αντιμετωπίζονται;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι βασικές εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιψυχωσικών είναι **οξεία δυστονία, φαρμακευτικός παρκινσονισμός, ακαθησία και όψιμη δυσκινησία**. Η αντιμετώπιση διαφέρει ουσιαστικά μεταξύ τους, γι' αυτό πρώτα πρέπει να αναγνωρίσω σωστά το σύνδρομο και τη χρονική σχέση με την αντιψυχωσική έκθεση.

Η **οξεία δυστονία** εμφανίζεται συνήθως νωρίς μετά από έναρξη ή αύξηση δόσης και προκαλεί επώδυνες, παρατεταμένες μυϊκές συσπάσεις, όπως ραιβόκρανο, οφθαλμογυρική κρίση ή σπασμό γνάθου. Αν υπάρχει **λαρυγγική δυστονία**, πρόκειται για επείγον αεραγωγού. Η θεραπεία είναι άμεση χορήγηση κατάλληλου **αντιμουσκαρινικού**, μαζί με επανεκτίμηση της αντιψυχωσικής αγωγής.

Ο **φαρμακευτικός παρκινσονισμός** χαρακτηρίζεται από βραδυκινησία, δυσκαμψία και συχνά τρόμο. Επανεξετάζω αν η δόση είναι υψηλότερη από την αναγκαία και, όπου είναι δυνατό, τη μειώνω ή αλλάζω σε φάρμακο με χαμηλότερο κίνδυνο. Αν χρειάζεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί βραχυχρόνια αντιχολινεργική θεραπεία. Δεν χορηγώ όμως αυτόματα χρόνια αντιχολινεργική προφύλαξη σε όλους, λόγω γνωστικών και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η **ακαθησία** είναι συχνά πιο δύσκολη στη διάκριση από ψυχιατρική διέγερση. Ο ασθενής περιγράφει **εσωτερική ανησυχία και έντονη ανάγκη να κινείται**, ενώ παρατηρώ κινητική ανησυχία, βηματισμό ή αδυναμία να παραμείνει καθιστός. Συνήθως υπάρχει χρονική σχέση με έναρξη ή αύξηση φαρμάκου. Αν είναι εφικτό μειώνω τη δόση ή αλλάζω αντιψυχωσικό. Η **propranolol** είναι σημαντική φαρμακολογική επιλογή όταν δεν αντενδείκνυται. Η καθαρή ακαθησία δεν αντιμετωπίζεται κατά κανόνα με αντιχολινεργικό.

Η **όψιμη δυσκινησία** εμφανίζεται μετά από μακροχρόνια ή αθροιστική έκθεση σε αναστολείς ντοπαμίνης και χαρακτηρίζεται από ακούσιες, συχνά στοματοπροσωπικές, χορειοαθετωσικές ή στερεότυπες κινήσεις. Επανεξετάζω όλη την αναγκαία ντοπαμινεργική αναστολή, διακόπτω περιττά αντιχολινεργικά και, όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιώ στρατηγική χαμηλότερου κινδύνου.

Σε κατάλληλους ασθενείς χρησιμοποιούνται **αναστολείς VMAT2**. Η **deutetrabenazine** απέκτησε ευρωπαϊκή άδεια τον Ιανουάριο του 2026 για μέτρια έως σοβαρή όψιμη δυσκινησία σε ενήλικες. Η συνήθης διαθεσιμότητα ή αποζημίωσή της στην Ελλάδα δεν έχει επαληθευτεί και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Λαρυγγική δυστονία** = επείγον αεραγωγού.
- **Ακαθησία**: εσωτερική + κινητική ανησυχία· propranolol σημαντική επιλογή.
- Δεν χρησιμοποιώ χρόνια αντιχολινεργικά ως ρουτίνα για όλα τα EPS.

- Deutetrabenazine: ευρωπαϊκή άδεια από **Ιανουάριο 2026** για μέτρια–σοβαρή όψιμη δυσκινησία ενηλίκων· ελληνική πρόσβαση μη επιβεβαιωμένη.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ακαθησία ή ψυχωσική/μανιακή διέγερση;

Στην ακαθησία χρειάζομαι υποκειμενική εσωτερική ανησυχία/ανάγκη για κίνηση μαζί με παρατηρήσιμη κινητική ανησυχία, συνήθως μετά από έναρξη ή αύξηση φαρμάκου. Στην ψυχωσική ή μανιακή διέγερση η κινητικότητα εξηγείται περισσότερο από το υποκείμενο σύνδρομο και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ψυχιατρικά στοιχεία. Η χρονικότητα και η περιγραφή του ίδιου του ασθενούς είναι πολύ χρήσιμες.

Ποιες μεταβολικές, ενδοκρινικές και καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιψυχωσικών παρακολουθείτε;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παρακολούθηση αντιψυχωσικής θεραπείας πρέπει να είναι **προληπτική και εξατομικευμένη**, όχι να αρχίζει μόνο όταν εμφανιστεί σύμπτωμα. Ελέγχω μεταβολικό κίνδυνο, υπεργλυκαιμία/διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, υπερπρολακτιναιμία και καρδιαγγειακό/QT κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο φάρμακο και τους παράγοντες κινδύνου του ασθενούς.

Πριν από την έναρξη καταγράψω **βάρος, περίμετρο μέσης, αρτηριακή πίεση και σφυγμό, γλυκόζη ή HbA1c, λιπίδια και προλακτίνη**. Αυτά επανελέγχονται κατά τη θεραπεία, με τη συχνότητα να εξαρτάται από το φάρμακο, το στάδιο θεραπείας, την οδηγία που ακολουθείται και τον ατομικό κίνδυνο. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα που να αντικαθιστά τις ειδικές οδηγίες κάθε φαρμάκου και κλινικού πλαισίου.

Η **αύξηση βάρους, η αντίσταση στην ινσουλίνη, ο σακχαρώδης διαβήτης και η δυσλιπιδαιμία** έχουν ιδιαίτερη σημασία με ορισμένα αντιψυχωσικά, με clozapine και olanzapine να έχουν υψηλή μεταβολική επιβάρυνση. Η παρακολούθηση πρέπει να συνοδεύεται από παρέμβαση στη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα και άλλους τροποποιήσιμους καρδιαγγειακούς παράγοντες.

Η **υπερπρολακτιναιμία** μπορεί να προκαλέσει μειωμένη libido, σεξουαλική δυσλειτουργία, αμηνόρροια ή γαλακτόρροια και μακροχρόνια ενδοκρινικά/οστικά προβλήματα. Risperidone, paliperidone και amisulpride είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυξημένου κινδύνου, ενώ aripiprazole είναι σχετικά προλακτινο-φειδωλό. Αν η προλακτίνη είναι αυξημένη ή υπάρχουν σχετικά συμπτώματα, επανεξετάζω φάρμακο, δόση και άλλες πιθανές αιτίες.

Το **ηλεκτροκαρδιογράφημα** δεν είναι υποχρεωτική εξέταση ρουτίνας πριν από κάθε αντιψυχωσικό σε κάθε εξωνοσοκομειακό ασθενή. Το ζητώ όταν το απαιτεί το προϊόν ή το πλαίσιο φροντίδας ή όταν υπάρχουν καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, άλλα φάρμακα που παρατείνουν QT ή σχετικό ιστορικό. **QTc >500 ms** αποτελεί σημαντικό όριο υψηλού κινδύνου και απαιτεί άμεση επανεκτίμηση των QT-prolonging φαρμάκων, των ηλεκτρολυτών και του καρδιακού κινδύνου.

Με την **κλοζαπίνη** θυμάμαι επιπλέον τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας, κυρίως νωρίς στη θεραπεία. Η εμφάνιση συμπτωμάτων ή εργαστηριακών ενδείξεων που εγείρουν υποψία χρειάζεται άμεση αξιολόγηση. Πρωτόκολλα παρακολούθησης με troponin και CRP χρησιμοποιούνται σε εξειδικευμένα πλαίσια, αλλά δεν αποτελούν καθολικά νομοθετημένο υποχρεωτικό πρόγραμμα για όλους.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Baseline: **βάρος, μέση, BP/σφυγμός, γλυκόζη/HbA1c, λιπίδια, προλακτίνη.**
- ΗΚΓ: **ανάλογα με κίνδυνο, προϊόν και πλαίσιο, όχι υποχρεωτικά σε κάθε εξωνοσοκομειακό.**

- QTc >500 ms: σημαντικό όριο υψηλού κινδύνου.
- Clozapine myocarditis: σημαντικός πρώιμος κίνδυνος· troponin/CRP protocols δεν είναι καθολικά υποχρεωτικά.

Πώς επιλέγετε αντικαταθλιπτικό;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιλογή αντικαταθλιπτικού ξεκινά από το αν έχω **σωστή διάγνωση και σαφή ένδειξη**. Πριν συνταγογραφήσω, εξετάζω βαρύτητα, αυτοκτονικό κίνδυνο, ψυχωσικά ή κατατονικά χαρακτηριστικά, ιστορικό μανίας/υπομανίας και προηγούμενη ανταπόκριση. Δεν υπάρχει ένα αντικαταθλιπτικό που είναι καλύτερο για όλους.

Οι **SSRI** αποτελούν βασική πρώτη φαρμακολογική κατηγορία λόγω συνδυασμού αποτελεσματικότητας, ανεκτικότητας και σχετικής ασφάλειας σε υπερδοσολογία. **SNRI** και **mirtazapine** είναι επίσης καθιερωμένες επιλογές όταν το κλινικό προφίλ τις ευνοεί. Τα τρικυκλικά έχουν περιορισμό λόγω αντιχολινεργικών, καρδιακών και τοξικών σε υπερδοσολογία επιδράσεων, ενώ οι **MAOI** ανήκουν κυρίως σε εξειδικευμένη θεραπεία.

Αν ένα φάρμακο είχε σαφή προηγούμενη αποτελεσματικότητα και ήταν καλά ανεκτό, αυτό έχει μεγάλη πρακτική αξία. Στη συνέχεια ταιριάζω την επιλογή με τη **συννοσηρότητα και το προφίλ συμπτωμάτων**. Με ενδιαφέρουν, για παράδειγμα, διαταραχές ύπνου, όρεξης ή χρόνιος πόνος, αλλά δεν επιλέγω μηχανικά ένα φάρμακο μόνο από ένα σύμπτωμα.

Εξετάζω τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον συγκεκριμένο ασθενή: **σεξουαλική δυσλειτουργία, καταστολή, αύξηση βάρους, αρτηριακή πίεση, καρδιαγγειακό/QT κίνδυνο, γαστρεντερικά προβλήματα και κίνδυνο διακοπής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών**. Σε ασθενή με σημαντικό κίνδυνο υπερδοσολογίας αποφεύγω επιλογές με δυσμενέστερη τοξικότητα.

Παίρνω πλήρες φαρμακευτικό και ουσιολογικό ιστορικό για **αλληλεπιδράσεις**, ιδίως όταν υπάρχουν άλλα σεροτονινεργικά φάρμακα, αντιπηκτικά, φάρμακα που επηρεάζουν CYP ή καρδιακό κίνδυνο. Η ηλικία, η ηπατική και νεφρική λειτουργία και η σωματική νόσος επηρεάζουν επίσης την επιλογή.

Σε εγκυμοσύνη ή προγραμματισμό εγκυμοσύνης η απόφαση είναι **εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου-οφέλους**, όχι αυτόματη διακοπή ή απόλυτη απαγόρευση όλης της κατηγορίας. Αντίστοιχα, στον θηλασμό οι αποφάσεις είναι φάρμακο-ειδικές.

Συζητώ με τον ασθενή τις πιθανές επιλογές, την αναμενόμενη καθυστέρηση μέχρι το θεραπευτικό αποτέλεσμα, τις βασικές ανεπιθύμητες ενέργειες και το σχέδιο επανεκτίμησης. Η **προτίμηση του ασθενούς** είναι πραγματικό μέρος της επιλογής, γιατί επηρεάζει τόσο την αποδοχή όσο και τη συνέπεια στη θεραπεία.

Δεν απαιτείται ως ρουτίνα εμπορικός **φαρμακογενωμικός έλεγχος** πριν από την επιλογή αντικαταθλιπτικού.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Οι **SSRI** είναι βασική πρώτη κατηγορία· **SNRI** και **mirtazapine** καθιερωμένες εναλλακτικές.
- Τα **TCA** έχουν μεγαλύτερο καρδιακό και overdose burden.

Ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, αλληλεπιδράσεις και αρχές switching/διακοπής αντικαταθλιπτικών πρέπει να γνωρίζετε;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι αλληλεπιδράσεις των αντικαταθλιπτικών διαφέρουν ανά κατηγορία, αλλά κλινικά δίνω ιδιαίτερη σημασία σε **σεροτονινεργική τοξικότητα, υπονατριαιμία, σεξουαλική δυσλειτουργία, αιμορραγικό κίνδυνο, μεταβολές αρτηριακής πίεσης ή QT όπου σχετίζονται και στο σύνδρομο διακοπής**. Η αλλαγή αντικαταθλιπτικού δεν γίνεται με έναν ενιαίο αλγόριθμο· εξαρτάται από τα δύο συγκεκριμένα φάρμακα.

Η **σεροτονινεργική τοξικότητα** είναι σημαντική όταν συνδυάζονται πολλαπλά σεροτονινεργικά φάρμακα, ιδιαίτερα με μη αναστρέψιμο MAOI. Αντίστοιχα, οι SSRI/SNRI μπορούν να αυξήσουν τον **αιμορραγικό κίνδυνο**, ειδικά μαζί με NSAIDs, αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά.

Η **υπονατριαιμία**, συχνά μέσω SIADH, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε μεγαλύτερους ή άλλους ευάλωτους ασθενείς όταν εμφανίζονται σύγχυση, αδυναμία, σπασμοί ή άλλα συμβατά συμπτώματα. Η σεξουαλική δυσλειτουργία είναι επίσης συχνή και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συνέπεια στη θεραπεία, άρα πρέπει να ερωτάται ενεργά.

Σε ορισμένα φάρμακα με ενδιαφέρει περισσότερο η αρτηριακή πίεση ή ο καρδιακός κίνδυνος. Η επιλογή και η παρακολούθηση καθορίζονται από το προφίλ κινδύνου του συγκεκριμένου ασθενούς και του συγκεκριμένου φαρμάκου, όχι από έναν εξαντλητικό κατάλογο κάθε πιθανής ανεπιθύμητης ενέργειας.

Το **σύνδρομο διακοπής** μπορεί να εμφανιστεί μετά από απότομη διακοπή ή γρήγορη μείωση. Μπορεί να περιλαμβάνει ζάλη, αισθητικά φαινόμενα, γριππώδη συμπτώματα, άγχος, ευερεθιστότητα, αϋπνία και γαστρεντερικά συμπτώματα. Μπορεί να είναι παρατεταμένο. **Paroxetine και venlafaxine** έχουν υψηλότερη τάση για συμπτώματα διακοπής, ενώ **fluoxetine** χαμηλότερη λόγω του μεγάλου χρόνου ημίσειας ζωής.

Η μείωση γίνεται **εξατομικευμένα** και προσαρμόζεται στα συμπτώματα. Δεν υπάρχει καθολικό «τέσσερις εβδομάδες και τέλος» που να ταιριάζει σε κάθε φάρμακο και κάθε διάρκεια θεραπείας.

Όταν αλλάζω αντικαταθλιπτικό, ανάλογα με τον συνδυασμό μπορεί να γίνει **άμεση αλλαγή, διασταυρούμενη σταδιακή μετάβαση ή περίοδος έκπλυσης**. Με MAOI χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και δεν κάνω τυφλό cross-taper λόγω κινδύνου σεροτονινεργικής τοξικότητας.

Με τη **fluoxetine** θυμάμαι δύο ειδικά χρονικά διαστήματα έκπλυσης:

- μετά τη διακοπή **fluoxetine**, περιμένω τουλάχιστον 5 εβδομάδες πριν από έναρξη μη αναστρέψιμου μη εκλεκτικού MAOI,

- μετά τη διακοπή μη αναστρέψιμου MAOI, περιμένω τουλάχιστον **2 εβδομάδες** πριν από έναρξη fluoxetine.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Paroxetine/venlafaxine: μεγαλύτερη τάση για σύνδρομο διακοπής· fluoxetine μικρότερη.
- Switching: **direct switch, cross-taper** ή **washout** ανά ζεύγος φαρμάκων.
- Fluoxetine → irreversible MAOI: **≥5 εβδομάδες**.
- Irreversible MAOI → fluoxetine: **≥2 εβδομάδες**.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το λίθιο;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το λίθιο είναι βασικό φάρμακο για οξεία μανία, μακροχρόνια θεραπεία της διπολικής διαταραχής και ενίσχυση αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Έχει επίσης τεκμηρίωση που υποστηρίζει μείωση αυτοκτονικών συμπεριφορών σε κατάλληλους ασθενείς. Επειδή έχει στενό θεραπευτικό εύρος, η ασφαλής χρήση του απαιτεί σωστή μέτρηση επιπέδων, παρακολούθηση νεφρικής και ενδοκρινικής λειτουργίας και ιδιαίτερη προσοχή σε αλληλεπιδράσεις και αφυδάτωση.

Για συντήρηση διπολικής διαταραχής, όταν ξεκινά θεραπεία, το συνήθες NICE θεραπευτικό εύρος είναι **0,6–0,8 mmol/L**. Επίπεδο **0,8–1,0 mmol/L** μπορεί να εξεταστεί όταν υπάρχει υποτροπή ή επίμονα υποουδικά συμπτώματα. Η μέτρηση γίνεται συμβατικά περίπου **12 ώρες μετά την τελευταία δόση** ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα και ερμηνεύσιμα.

Πριν από την έναρξη ελέγχω νεφρική λειτουργία και ηλεκτρολύτες, θυρεοειδική λειτουργία, ασβέστιο, βάρος/BMI και κύηση όπου σχετίζεται. Ηλεκτροκαρδιογράφημα ζητείται όταν υπάρχει κλινική ένδειξη ή καρδιαγγειακός κίνδυνος, όχι ως καθολική εξέταση σε όλους.

Στη συνέχεια παρακολουθώ συστηματικά. Σύμφωνα με το NICE, το επίπεδο λιθίου ελέγχεται **ανά 3 μήνες κατά το πρώτο έτος**. Μετά γίνεται συνήθως **ανά 6 μήνες**, αλλά παραμένει **ανά 3 μήνες** σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου, για παράδειγμα όταν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, νεφρικός κίνδυνος ή άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μεταβολής του επιπέδου. **Νεφρική λειτουργία/ηλεκτρολύτες μαζί με ασβέστιο και θυρεοειδική λειτουργία** ελέγχονται γενικά **ανά 6 μήνες**.

Συχνές ή σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι **τρόμος, γαστρεντερικά συμπτώματα, αύξηση βάρους, υποθυρεοειδισμός, νεφρογενής άποιος διαβήτης, υπερπαραθυρεοειδισμός/υπερασβεστιασμία και μακροχρόνιος νεφρικός κίνδυνος**. Η παρακολούθηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο επίπεδο λιθίου.

Η **τοξικότητα** μπορεί να εμφανιστεί με επιδείνωση τρόμου, γαστρεντερικά συμπτώματα, αταξία, δυσαρθρία και σύγχυση, ενώ σοβαρή δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει σπασμούς ή κώμα. Σημαντικές αλληλεπιδράσεις που μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο είναι **NSAIDs, ACE inhibitors/ARBs και διουρητικά**, ιδίως θειαζίδες. Αφυδάτωση, έμετοι, διάρροια και οξεία νόσος μπορούν επίσης να προκαλέσουν επικίνδυνη συσσώρευση.

Αν ασθενής που λαμβάνει λίθιο εμφανίσει σημαντική **γαστρεντερίτιδα μαζί με χρήση NSAID**, διακόπτω προσωρινά το λίθιο, ελέγχω επειγόντως **επίπεδο λιθίου, ηλεκτρολύτες/νεφρική λειτουργία και ενυδάτωση** και οργανώνω οξεία ιατρική αξιολόγηση ανάλογα με τα συμπτώματα και τη βαρύτητα.

Σε σοβαρή τοξικότητα η απόφαση για εξωνεφρική κάθαρση **δεν βασίζεται σε ένα μοναδικό επίπεδο λιθίου**. Συνυπολογίζονται κλινικά συμπτώματα, νεφρική λειτουργία, συγκέντρωση και αναμενόμενη αποβολή.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

1 | 12ωρο επίπεδο → baseline → monitoring → τοξικότητα/αλληλεπιδράσεις

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Συνήθης στόχος συντήρησης: 0,6–0,8 mmol/L· 0,8–1,0 mmol/L σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
- Επίπεδο: περίπου 12 ώρες μετά τη δόση.
- Lithium level: 3μηνιαία το πρώτο έτος, μετά συνήθως 6μηνιαία ή 3μηνιαία σε υψηλότερο κίνδυνο.
- Νεφρική λειτουργία/ηλεκτρολύτες, ασβέστιο και θυρεοειδής: γενικά ανά 6 μήνες.
- NSAIDs, ACEi/ARBs, διουρητικά και αφυδάτωση μπορούν να αυξήσουν το λίθιο.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το βαλπροϊκό;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το βαλπροϊκό έχει θέση στη διπολική διαταραχή όταν είναι κλινικά κατάλληλο, αλλά σήμερα η ασφαλής χρήση του απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις μεταβολικές, αιματολογικές, ηπατικές και παγκρεατικές ανεπιθύμητες ενέργειες και κυρίως στους αυστηρούς αναπαραγωγικούς περιορισμούς.

Στις συχνές ή σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται **αύξηση βάρους και μεταβολική επιβάρυνση, τρόμος και αιματολογικές διαταραχές όπως θρομβοπενία**. Σοβαρές, σπανιότερες επιπλοκές είναι η **ηπατοτοξικότητα και η παγκρεατίτιδα**, οι οποίες απαιτούν άμεση κλινική αξιολόγηση όταν υπάρχουν συμβατά συμπτώματα.

Πριν από την έναρξη και κατά τη θεραπεία κάνω τον απαιτούμενο **κλινικό, ηπατικό και αιματολογικό έλεγχο** σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του συγκεκριμένου σκευάσματος και τις ισχύουσες οδηγίες, μαζί με παρακολούθηση βάρους και σχετικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο εργαστηριακό χρονοδιάγραμμα που να ισχύει ανεξάρτητα από την ένδειξη και το συγκεκριμένο σκεύασμα.

Για διπολική διαταραχή, το βαλπροϊκό **αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη**. Σε κορίτσια και γυναίκες που μπορούν να μείνουν έγκυες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις του **Προγράμματος Πρόληψης Κύησης**, υπό ειδική διαχείριση, και οι κατάλληλες εναλλακτικές είναι αναποτελεσματικές, ακατάλληλες ή μη ανεκτές. Η ρυθμιστική διατύπωση είναι πιο συγκεκριμένη από μια απλή γενική φράση «απαγορεύεται σε όλες τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας».

Υπάρχουν πλέον και προφυλάξεις για τους **άνδρες**. Οι τρέχουσες ευρωπαϊκές και ελληνικά κοινοποιημένες οδηγίες απαιτούν ενημέρωση για πιθανό νευροαναπτυξιακό κίνδυνο που σχετίζεται με πατρική έκθεση, συζήτηση αποτελεσματικής αντισύλληψης για τον άνδρα και τη γυναίκα σύντροφο κατά τη θεραπεία και για **3 μήνες μετά τη διακοπή**, και αποφυγή δωρεάς σπέρματος στο ίδιο διάστημα.

Οι αναπαραγωγικοί περιορισμοί αποτελούν **βασικό μέρος της απόφασης** για το αν το βαλπροϊκό είναι κατάλληλο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Διπολική διαταραχή: βαλπροϊκό **αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη**.
- Γυναίκες που μπορούν να μείνουν έγκυες: μόνο υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του **Προγράμματος Πρόληψης Κύησης** όταν οι εναλλακτικές δεν είναι κατάλληλες.
- Άνδρες: αντισύλληψη κατά τη θεραπεία και για **3 μήνες μετά**, και όχι δωρεά σπέρματος στο ίδιο διάστημα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη λαμοτριγίνη;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η λαμοτριγίνη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διπολική κατάθλιψη και στη μακροχρόνια πρόληψη καταθλιπτικών υποτροπών, αλλά δεν αποτελεί θεραπεία οξείας μανίας. Το κεντρικό ζήτημα ασφάλειας είναι το εξάνθημα και ο κίνδυνος σοβαρών δερματικών αντιδράσεων, γι' αυτό απαιτεί αργή και προσεκτική τιτλοποίηση.

Ο σοβαρότερος κίνδυνος είναι το **σύνδρομο Stevens–Johnson και η τοξική επιδερμική νεκρόλυση**. Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει ότι νέο ή ανησυχητικό εξάνθημα χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση. Η ακριβής τιτλοποίηση εξαρτάται από το συγκεκριμένο σκεύασμα και τις συγχορηγήσεις.

Η πιο σημαντική αλληλεπίδραση είναι με το **βαλπροϊκό**, το οποίο αναστέλλει τη γλυκουρονίδωση της λαμοτριγίνης και αυξάνει την έκθεσή της. Όταν συγχορηγούνται, η τιτλοποίηση πρέπει να είναι πιο αργή και σε χαμηλότερη έκθεση σύμφωνα με το ισχύον σχήμα προϊόντος. Αντίστροφα, ενζυμικοί επαγωγείς μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα της λαμοτριγίνης.

Σημαντική είναι και η αλληλεπίδραση με **συνδυασμένα ορμονικά αντισυλληπτικά που περιέχουν οιστρογόνο**. Μπορούν περίπου να **διπλασιάσουν την κάθαρση της λαμοτριγίνης**, με αποτέλεσμα χαμηλότερη έκθεση. Αντίστροφα, η έναρξη ή διακοπή τέτοιας αντισύλληψης μπορεί να μεταβάλει ουσιαστικά τα επίπεδα και να απαιτεί επανεκτίμηση.

Κατά την **εγκυμοσύνη** οι συγκεντρώσεις λαμοτριγίνης μπορεί να πέσουν λόγω αυξημένης κάθαρσης, ενώ **μετά τον τοκετό μπορεί να αυξηθούν γρήγορα** καθώς η κάθαρση επανέρχεται. Αυτό έχει πρακτική σημασία για την παρακολούθηση αποτελεσματικότητας και τοξικότητας και απαιτεί εξατομικευμένη περιγεννητική διαχείριση.

Στην πράξη, όταν χρησιμοποιώ λαμοτριγίνη, θέλω να γνωρίζω το θεραπευτικό πλαίσιο, τις συγχορηγήσεις και οποιαδήποτε αλλαγή σε βαλπροϊκό, ενζυμικούς επαγωγείς, αντισύλληψη ή εγκυμοσύνη. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από μια θεωρητική «τυπική» δόση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Διπολική κατάθλιψη/συντήρηση, όχι οξεία μανία.
- Αργή τιτλοποίηση λόγω SJS/TEN.
- Valproate → αυξημένη έκθεση στη lamotrigine.
- Οιστρογονική συνδυασμένη αντισύλληψη μπορεί περίπου να **διπλασιάσει την κάθαρση**· τα επίπεδα επίσης μεταβάλλονται στην κύηση/λοχεία.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις βενζοδιαζεπίνες και τα υπνωτικά;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι βενζοδιαζεπίνες είναι **θετικοί αλλοστερικοί ρυθμιστές του υποδοχέα GABA-A**. Έχουν χρήσιμη θέση σε επιλεγμένες οξείες καταστάσεις, αλλά η ασφαλής χρήση τους απαιτεί να σκέφτομαι από την αρχή **καταστολή, πτώσεις, γνωστική επιβάρυνση, ανοχή, εξάρτηση, αλληλεπιδράσεις και το ενδεχόμενο δύσκολης στήρησης**.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βραχυχρόνια για έντονο άγχος, αϋπνία ή ορισμένα επείγοντα ψυχιατρικά σύνδρομα, ανάλογα με την ένδειξη. Δεν αποτελούν όμως συνήθη μακροχρόνια θεραπεία των αγχωδών διαταραχών ή της αϋπνίας όταν υπάρχουν καταλληλότερες παρεμβάσεις.

Οι άμεσες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι **υπνηλία, ψυχοκινητική επιβράδυνση, διαταραχή συντονισμού και γνωστική επιβάρυνση**, με ιδιαίτερη σημασία σε ηλικιωμένους λόγω πτώσεων και τραυματισμών. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί **παράδοξη αποαναστολή σε ορισμένους ασθενείς**.

Με παρατεταμένη χρήση μπορεί να αναπτυχθούν **ανοχή και σωματική εξάρτηση**. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής έχει διαταραχή χρήσης, αλλά σημαίνει ότι απότομη διακοπή μετά από σημαντική έκθεση μπορεί να προκαλέσει στερητικό σύνδρομο, ακόμη και **σπασμούς ή ντελίριο**.

Ιδιαίτερα επικίνδυνος είναι ο συνδυασμός με **οπιοειδή ή αλκοόλ**, επειδή η αθροιστική καταστολή μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο **αναπνευστικής καταστολής, διαταραχής συνείδησης και θανάτου**.

Το συχνά αναφερόμενο «**2-4 εβδομάδες**» είναι χρήσιμη συνταγογραφική αρχή για πολλές ενδείξεις και υπενθυμίζει ότι η μακροχρόνια χρήση δεν πρέπει να γίνεται από αδράνεια. Δεν είναι όμως **καθολικό νομικό ή βιολογικό ανώτατο όριο** για κάθε ασθενή και κάθε ένδειξη.

Αν έχει αναπτυχθεί εξάρτηση, δεν διακόπτω απότομα. Η μείωση γίνεται **σταδιακά και εξατομικευμένα**, ανάλογα με τη διάρκεια και τη δόση, το ιστορικό στήρησης, τις συννοσηρότητες και τα συμπτώματα κατά τη μείωση. Τα Z-drugs ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες αρχές ως προς καταστολή, ανοχή, εξάρτηση και ασφάλεια.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Βενζοδιαζεπίνη + **οπιοειδές/αλκοόλ** → σημαντικός αναπνευστικός κίνδυνος.
- Απότομη διακοπή μετά από εξάρτηση μπορεί να προκαλέσει **σπασμούς ή ντελίριο**.
- «**2-4 εβδομάδες**» = χρήσιμη κλινική αρχή, όχι καθολικό νομικό όριο.

Πώς χρησιμοποιείτε φαρμακοθεραπεία στη ΔΕΠΥ ενηλίκων;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Φαρμακοθεραπεία για ΔΕΠΥ ενηλίκων χρησιμοποιώ αφού έχει τεκμηριωθεί η **διάγνωση και η λειτουργική επιβάρυνση** και αφού έχω ελέγξει σωματική και ψυχιατρική συννοσηρότητα, τρέχουσα αγωγή και κίνδυνο κατάχρησης ή εκτροπής του φαρμάκου.

Πριν από την έναρξη παίρνω **καρδιαγγειακό ιστορικό**, μετρώ **σφυγμό, αρτηριακή πίεση και βάρος** και εξετάζω ουσίες, προηγούμενη κατάχρησηση φαρμάκων και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια. **Ηλεκτροκαρδιογράφημα δεν απαιτείται ως ρουτίνα για κάθε ενήλικα**· γίνεται όταν υπάρχει κλινική ένδειξη.

Όταν ενδείκνυται φάρμακο, οι βασικές πρώτες επιλογές του NICE είναι **lisdexamfetamine ή methylphenidate**. Αν μία από τις δύο έχει χορηγηθεί σε επαρκή θεραπευτική δοσική χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση, μπορεί να γίνει αλλαγή στην άλλη. Η επιλογή επηρεάζεται από προηγούμενη ανταπόκριση, διάρκεια κάλυψης που χρειάζεται ο ασθενής, ανεπιθύμητες ενέργειες, προτίμηση και κίνδυνο κατάχρησης.

Η **atomoxetine** είναι η κύρια μη διεγερτική επιλογή όταν ο ασθενής δεν ανέχεται ή δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς τόσο στη lisdexamfetamine όσο και στη methylphenidate. Οι ακριβείς δοσολογίες ακολουθούν την ισχύουσα πληροφορία προϊόντος και την αντίστοιχη κατευθυντήρια οδηγία.

Κατά τη θεραπεία παρακολουθώ **σφυγμό, αρτηριακή πίεση και βάρος**, μαζί με αποτελεσματικότητα, ύπνο, όρεξη, ψυχική κατάσταση και πιθανή κατάχρηση ή εκτροπή. Η θεραπεία πρέπει να έχει σαφείς λειτουργικούς στόχους και να επανεκτιμάται, όχι απλώς να συνεχίζεται επειδή «ο ασθενής νιώθει πιο συγκεντρωμένος».

Αν υπάρχει **ιστορικό ψύχωσης ή διαταραχής χρήσης ουσιών**, αυτό δεν αποτελεί αυτόματα απόλυτη αντένδειξη για κάθε διεγερτικό. **Ενεργή ψύχωση ή μανία** χρειάζεται πρώτα σταθεροποίηση και επανεκτίμηση πριν από θεραπεία ΔΕΠΥ.

Σε διαταραχή χρήσης ουσιών εξετάζω την τρέχουσα σταθερότητα, τον κίνδυνο εκτροπής/κατάχρησης και τη δυνατότητα στενής παρακολούθησης. Όπου είναι κατάλληλο μπορεί να προτιμηθούν **μακράς δράσης ή προφαρμακευτικές μορφές**, ή μη διεγερτική θεραπεία. Η απόφαση είναι εξατομικευμένη και όχι αυτόματο «ναι» ή «όχι» λόγω ιστορικού SUD.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Πρώτες επιλογές ενηλίκων: **lisdexamfetamine ή methylphenidate**.
- **Atomoxetine** μετά από δυσανεξία/μη ανταπόκριση και στα δύο διεγερτικά.
- Baseline: καρδιαγγειακό ιστορικό, **BP/σφυγμός, βάρος**, misuse/diversion risk· routine ECG όχι σε όλους.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ**Τι αλλάζει αν υπάρχει προηγούμενη ψύχωση ή διαταραχή χρήσης ουσιών;**

Δεν τα θεωρώ καθολικές απόλυτες αντενδείξεις. Αν υπάρχει ενεργή ψύχωση ή μανία, σταθεροποιώ πρώτα το οξύ σύνδρομο. Σε SUD εκτιμώ τρέχουσα χρήση, κίνδυνο εκτροπής και δυνατότητα παρακολούθησης και προσαρμόζω μορφή ή κατηγορία φαρμάκου ανάλογα.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές ψυχοφαρμακολογίας στην εγκυμοσύνη και την αναπαραγωγική περίοδο;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ψυχοφαρμακολογία στην εγκυμοσύνη είναι εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου–οφέλους. Δεν συγκρίνω «φάρμακο έναντι μηδενικού κινδύνου», αλλά τον κίνδυνο της φαρμακευτικής έκθεσης με τον κίνδυνο υποτροπής ή μη θεραπευμένης σοβαρής ψυχικής νόσου για τη μητέρα, το έμβρυο και τη μετέπειτα φροντίδα του νεογνού.

Αν μια γυναίκα μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει αποτελεσματική αγωγή, δεν τη διακόπτω ανταντακλαστικά και απότομα μόνο λόγω της εγκυμοσύνης. Επανεκτιμώ διάγνωση, βαρύτητα και ιστορικό υποτροπής, προηγούμενη ανταπόκριση, δόση, συγχρηγήσεις και εναλλακτικές. Στόχος είναι η ελάχιστη αποτελεσματική έκθεση και, όπου είναι δυνατό, ένα όσο γίνεται απλούστερο θεραπευτικό σχήμα, με εξειδικευμένη περιγεννητική συμβολή όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός.

Το **βαλπροϊκό** αποτελεί ειδική περίπτωση. Για διπολική διαταραχή αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη και εφαρμόζονται οι αυστηροί αναπαραγωγικοί περιορισμοί και το Pregnancy Prevention Programme σε γυναίκες που μπορούν να μείνουν έγκυες. Οι σύγχρονες προφυλάξεις για τους άνδρες περιλαμβάνουν επίσης συμβουλευτική και αντισύλληψη κατά τη θεραπεία και για 3 μήνες μετά τη διακοπή, καθώς και αποφυγή δωρεάς σπέρματος στο ίδιο διάστημα.

Το **λίθιο** δεν πρέπει πλέον να περιγράφεται απλώς ως «απαγορευμένο λόγω ανωμαλίας Ebstein». Η σύγχρονη τεκμηρίωση δείχνει **μικρή αύξηση του κινδύνου καρδιακών δυσπλασιών**, μικρότερη από ό,τι υπονοούσε η παλαιότερη διδασκαλία. Σε γυναίκες με υψηλό κίνδυνο σοβαρής διπολικής υποτροπής μπορεί να συνεχιστεί σε επιλεγμένες περιπτώσεις υπό εξειδικευμένη παρακολούθηση.

Οι **SSRI** μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει σαφής κλινική ένδειξη. Ενημερώνω αναλογικά για πιθανές **νεογνικές προσαρμοστικές εκδηλώσεις** και για πιθανή μικρή απόλυτη αύξηση του κινδύνου επίμονης πνευμονικής υπέρτασης του νεογνού, χωρίς να παρουσιάζω αυτούς τους κινδύνους ως λόγο καθολικής αποφυγής όλης της κατηγορίας.

Η **λαμοτριγίνη** χρειάζεται ιδιαίτερη φαρμακοκινητική προσοχή: η κάθαρσή της μπορεί να αυξηθεί στην εγκυμοσύνη και να μειωθεί γρήγορα μετά τον τοκετό, με αντίστοιχη πτώση και μετά άνοδο των συγκεντρώσεων.

Οι αποφάσεις για **αντιψυχωσικά, βενζοδιαζεπίνες και θηλασμό** είναι φάρμακο-ειδικές. Λαμβάνω υπόψη τη μητρική σταθερότητα, τον κίνδυνο νεογνικής έκθεσης, την ωριμότητα και ευαλωτότητα του βρέφους και τη δυνατότητα παρακολούθησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Δεν διακόπτω απότομα αποτελεσματική αγωγή μόνο λόγω κύησης.
- Valproate: αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη για bipolar disorder.
- Lithium: μικρή αύξηση καρδιακών δυσπλασιών, όχι καθολική απαγόρευση.
- Lamotrigine: clearance αυξάνει στην κύηση και μειώνεται γρήγορα μετά τον τοκετό.

Πώς διακρίνετε το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο από το σύνδρομο σεροτονίνης;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο και το σύνδρομο σεροτονίνης μπορούν και τα δύο να προκαλέσουν **υπερθερμία, αυτόνομη αστάθεια και μεταβολή της νοητικής κατάστασης**, αλλά η φαρμακευτική έκθεση, η ταχύτητα έναρξης και κυρίως τα νευρομυϊκά ευρήματα βοηθούν στη διάκριση.

Το **κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο (NMS)** συνδέεται συνήθως με αποκλεισμό ντοπαμίνης ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με απότομη διακοπή ντοπαμινεργικής θεραπείας. Η εικόνα περιλαμβάνει υπερθερμία, διαταραχή επιπέδου συνείδησης, αυτόνομη αστάθεια και χαρακτηριστικά **έντονη γενικευμένη μυϊκή δυσκαμψία**. Η CK είναι συχνά αυξημένη και μπορεί να υπάρχουν ραβδομυόλυση, νεφρική βλάβη και άλλες σοβαρές ιατρικές επιπλοκές.

Το **σύνδρομο σεροτονίνης** ακολουθεί σεροτονινεργική υπερδραστηριότητα, συχνά μετά από προσθήκη, αύξηση ή συνδυασμό σεροτονινεργικών φαρμάκων, και συνήθως εξελίσσεται **ταχύτερα**. Τα πιο χρήσιμα διαχωριστικά νευρομυϊκά σημεία είναι **κλόνος και υπερανταντακλαστικότητα**, συχνά με τρόπο ή μύοκλωνο. Αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερη διαγνωστική αξία από τον πυρετό ή τη σύγχυση μόνα τους.

Και στα δύο σύνδρομα διακόπτω τα ύποπτα φάρμακα και αντιμετωπίζω την κατάσταση ως **ιατρικό επείγον**. Χρειάζονται υγρά, ψύξη, παρακολούθηση ζωτικών και οργανικών επιπλοκών και κλιμάκωση σε εντατική φροντίδα όταν η κατάσταση είναι σοβαρή.

Στο NMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιλεγμένες ή βαριές περιπτώσεις **bromocriptine, amantadine ή dantrolene**, αλλά κανένα από αυτά δεν αποτελεί υποχρεωτικό «αντίδοτο» για κάθε ασθενή. Η επιλογή εξαρτάται από τη βαρύτητα, τις επιπλοκές και την εξειδικευμένη ιατρική εκτίμηση.

Στο σύνδρομο σεροτονίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί **cypheptadine** ως επικουρική θεραπεία σε κατάλληλες περιπτώσεις, αλλά η τεκμηρίωση υψηλής ποιότητας για το κλινικό της αποτέλεσμα είναι περιορισμένη. Η υποστηρικτική αντιμετώπιση και η διακοπή των υπεύθυνων φαρμάκων παραμένουν ο πυρήνας.

Δεν διαγιγνώσκω σύνδρομο σεροτονίνης από «πυρετό + σύγχυση» χωρίς τα χαρακτηριστικά νευρομυϊκά ευρήματα και δεν θεωρώ κάθε δυσκαμψία σε ασθενή με αντιψυχωσικό NMS χωρίς να εξετάσω κατατονία, λοίμωξη και άλλες εναλλακτικές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- NMS: **έντονη γενικευμένη δυσκαμψία**, συχνά αυξημένη CK.
- Serotonin syndrome: συνήθως ταχύτερο, με **κλόνος/υπερανταντακλαστικότητα**.
- Και στα δύο: διακοπή υπεύθυνου φαρμάκου + επιθετική υποστηρικτική φροντίδα· τα ειδικά φάρμακα είναι επικουρικά.

Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε υπερδοσολογία τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η υπερδοσολογία τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών είναι **δυσνητικά θανατηφόρα δηλητηρίαση** λόγω συνδυασμού αντιχολινεργικής, νευρολογικής και κυρίως καρδιοτοξικής δράσης. Η καρδιοτοξικότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον **αποκλεισμό των ταχέων διαύλων νατρίου**, γι' αυτό το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι κεντρικό στην αξιολόγηση.

Η κλινική εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει **μυδρίαση, ξηρότητα, ταχυκαρδία, κατακράτηση ούρων και διαταραχή θερμορύθμισης**, αλλά πιο σημαντικά είναι η διαταραχή συνείδησης, οι **σπασμοί**, η υπόταση και οι διαταραχές καρδιακής αγωγής ή κοιλιακές αρρυθμίες.

Κάνω άμεσα **ΗΚΓ** και παρακολουθώ στενά το QRS και τον ρυθμό. **QRS >100 ms** παραμένει χρήσιμο σημείο σημαντικής τοξικότητας και αυξημένου κινδύνου σπασμών. Δεν περιμένω όμως να εμφανιστεί ένα συγκεκριμένο νούμερο αν ο ασθενής είναι ήδη αιμοδυναμικά ασταθής ή έχει σοβαρή αρρυθμία.

Η αρχική αντιμετώπιση είναι **ABC: αεραγωγός, αναπνοή και κυκλοφορία**, κατάλληλη οξυγόνωση και υποστήριξη, αντιμετώπιση σπασμών και στενή καρδιολογική παρακολούθηση. Η οξέωση μπορεί να επιδεινώσει την καρδιοτοξικότητα και χρειάζεται προσοχή στην οξεοβασική ισορροπία.

Το **ενδοφλέβιο διττανθρακικό νάτριο** είναι θεραπεία πρώτης γραμμής όταν υπάρχει σημαντική διεύρυνση QRS, κοιλιακή δυσρυθμία ή υπόταση λόγω TCA τοξικότητας. Η θεραπεία δεν συνοψίζεται σε μία μοναδική δόση· τιτλοποιείται στο πλαίσιο εξειδικευμένης τοξικολογικής/εντατικής αντιμετώπισης, με παρακολούθηση ΗΚΓ, οξεοβασικής κατάστασης και ηλεκτρολυτών.

Στους σπασμούς χρησιμοποιώ κατάλληλη επείγουσα αντισπασμωδική αντιμετώπιση και αποφεύγω παρεμβάσεις που επιδεινώνουν τη νατριοκαναλική τοξικότητα. **Αντιαρρυθμικά κατηγορίας Ia και Ic** αποφεύγονται στην οξεία καρδιοτοξική δηλητηρίαση με TCA. Επίσης αποφεύγεται η **physostigmine** σε αυτή την εικόνα, παρά το αντιχολινεργικό σύνδρομο.

Ο ασθενής με σημαντική κλινική ή ηλεκτροκαρδιογραφική τοξικότητα χρειάζεται **εντατική παρακολούθηση και τοξικολογική καθοδήγηση**. Η ψυχιατρική εκτίμηση του περιστατικού και του αυτοκτονικού κινδύνου ακολουθεί αφού εξασφαλιστεί η ιατρική σταθερότητα.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

1 | ΗΚΓ/QRS → ABC/σπασμοί → IV διττανθρακικό → εντατική παρακολούθηση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- QRS >100 ms: χρήσιμο major-toxicity/seizure-risk anchor.

- IV sodium bicarbonate: πρώτη γραμμή για σημαντικό QRS widening, ventricular dysrhythmia ή hypotension.
- Αποφεύγονται class Ia/Ic antiarrhythmics και physostigmine.

Ποιες είναι οι ενδείξεις, η διαδικασία και οι βασικές ανεπιθύμητες ενέργειες της ηλεκτροσπασμοθεραπείας;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) είναι από τις πιο αποτελεσματικές βιολογικές θεραπείες για **σοβαρή κατάθλιψη**, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ψυχωσική ή κατατονική εικόνα ή όταν απαιτείται **ταχεία και υψηλής πιθανότητας ανταπόκριση**, για παράδειγμα σε απειλητική για τη ζωή άρνηση τροφής/υγρών ή σοβαρό κίνδυνο. Είναι επίσης βασική θεραπεία της κατατονίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένη σοβαρή ή ανθεκτική μανία.

Η ECT **δεν είναι απλώς «τελευταία λύση μετά από όλα»**. Η θέση της εξαρτάται από τη βαρύτητα, την επείγουσα ανάγκη, προηγούμενη ανταπόκριση, αποτυχία άλλων θεραπειών και την προτίμηση του ασθενούς.

Η ECT χορηγείται υπό **γενική αναισθησία με μυοχάλαση**. Προηγείται ιατρική και αναισθησιολογική αξιολόγηση, επειδή η θεραπεία προκαλεί παροδικές φυσιολογικές μεταβολές και πρέπει να προσαρμόζεται στη σωματική κατάσταση του ασθενούς. Οι ιατρικές παθήσεις είναι συνήθως παράγοντες που απαιτούν εκτίμηση και τροποποίηση του κινδύνου, όχι μια απλουστευμένη λίστα καθολικών απόλυτων αντενδείξεων.

Η επιλογή **μονόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης τοποθέτησης ηλεκτροδίων** και η στρατηγική του ερεθίσματος ισορροπούν αποτελεσματικότητα και γνωστική επιβάρυνση. Ένας ελάχιστος χρόνος σπασμού δεν αποτελεί καθολικό κριτήριο «επιτυχημένης» συνεδρίας χωρίς το συνολικό κλινικό και ηλεκτροφυσιολογικό πλαίσιο.

Συχνές άμεσες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι **κεφαλαλγία, μυαλγίες, ναυτία και παροδική σύγχυση**. Η σημαντικότερη μακροχρόνια ανησυχία είναι η **διαταραχή μνήμης**: μπορεί να υπάρχει παροδική προσθόδρομη δυσκολία και οπισθόδρομη απώλεια μνήμης, συμπεριλαμβανομένων αυτοβιογραφικών αναμνήσεων. Το γνωστικό φορτίο εξαρτάται μεταξύ άλλων από την τοποθέτηση ηλεκτροδίων, τις παραμέτρους του ερεθίσματος και την ατομική ευαλωτότητα.

Μετά από επιτυχή οξεία σειρά χρειάζεται σχέδιο **πρόληψης υποτροπής** με φαρμακοθεραπεία, ψυχοθεραπεία και, σε επιλεγμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου, συνέχιση ή συντήρηση ECT.

Ένας ενήλικας που μπορεί να δώσει έγκυρη συναίνεση **κατά κανόνα πρέπει να συναινέσει προηγουμένως στην ECT** σύμφωνα με το γενικό ελληνικό δίκαιο ιατρικής συναίνεσης. Η **ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία δεν εξουσιοδοτεί από μόνη της ECT** και δεν αποδεικνύει γενική ανικανότητα για συναίνεση.

Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει γενικές διατάξεις για υποκατάστατη συναίνεση και επείγουσα θεραπεία και ειδική ψυχιατρική διάταξη για θεραπεία παρά τη θέληση του ασθενούς σε σοβαρές περιστάσεις. Η ειδική σύγχρονη ελληνική διαδικασία εξουσιοδότησης ECT όταν ο ασθενής στερείται ικανότητας ή

όταν εξετάζεται επείγουσα μη συναινετική ECT δεν είναι σαφώς επαληθευμένη. Δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί χωρίς ειδική νομική επιβεβαίωση ότι απαιτείται δικαστήριο, εισαγγελέας, δικαστικός συμπαραστάτης, ανεξάρτητη δεύτερη γνώμη ή άλλος συγκεκριμένος μηχανισμός, και το βρετανικό Mental Health Act δεν αποτελεί ελληνικό δίκαιο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- ECT: σοβαρή/ψυχωσική κατάθλιψη, κατατονία, ανάγκη ταχείας ανταπόκρισης και επιλεγμένη σοβαρή/ανθεκτική μανία.
- Χορηγείται με γενική αναισθησία και μυοχάλαση.
- Ακούσια νοσηλεία ≠ αυτόματη εξουσιοδότηση ECT. Η ειδική ελληνική διαδικασία σε ανικανότητα/επείγουσα μη συναίνεση παραμένει **μη επαληθευμένη**.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι θέση έχει η rTMS;

Η επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (rTMS) είναι καθιερωμένη μη επεμβατική θεραπεία για κατάθλιψη που δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς σε συνήθη θεραπεία και γενικά δεν απαιτεί γενική αναισθησία. Ο κίνδυνος σπασμού είναι χαμηλός αλλά υπαρκτός. Η rTMS δεν είναι απλώς «ασθενέστερη ECT»: όταν απαιτείται ταχεία και υψηλής πιθανότητας ανταπόκριση σε βαριά, ψυχωσική ή κατατονική νόσο, η ECT παραμένει προτιμητέα.

Τι είναι η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία και πώς χρησιμοποιείται στην ψυχιατρική;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η **γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT)** είναι δομημένη, συνεργατική ψυχοθεραπεία που συνδέει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο **ερμηνεύει μια κατάσταση** με το συναίσθημα, τις σωματικές αντιδράσεις και τη συμπεριφορά του. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι μηχανισμοί που διατηρούν το πρόβλημα και να τροποποιηθούν μέσα από γνωσιακές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις.

Η θεραπεία βασίζεται σε μια **εξατομικευμένη γνωσιακή-συμπεριφορική διατύπωση**. Από τα συγκεκριμένα προβλήματα του ασθενούς προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις καταστάσεις που τα πυροδοτούν, τις αυτόματες σκέψεις ή εκτιμήσεις, τα συναισθήματα και τις σωματικές αντιδράσεις, καθώς και τις συμπεριφορές που μπορεί να ανακουφίζουν βραχυπρόθεσμα αλλά να συντηρούν το πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Η διατύπωση αποτελεί υπόθεση εργασίας και αναθεωρείται στη διάρκεια της θεραπείας.

Η θεραπευτική διαδικασία είναι **συνεργατική**. Θεραπευτής και ασθενής συμφωνούν στους βασικούς στόχους, εξετάζουν μαζί τις υποθέσεις που προκύπτουν από τη διατύπωση και αξιολογούν τι συμβαίνει όταν ο ασθενής δοκιμάζει διαφορετικούς τρόπους σκέψης ή συμπεριφοράς. Αυτό περιγράφεται ως **συνεργατικός εμπειρισμός**.

Οι βασικές τεχνικές εξαρτώνται από τη διαταραχή και από τον μηχανισμό που θέλουμε να αλλάξουμε. Περιλαμβάνουν **συμπεριφορική ενεργοποίηση, έκθεση, γνωσιακή αναδόμηση, συμπεριφορικά πειράματα**, εκπαίδευση σε δεξιότητες και συστηματική αυτοπαρατήρηση.

Στην **κατάθλιψη**, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται συχνά η συμπεριφορική ενεργοποίηση για την αντιμετώπιση της απόσυρσης και της αδράνειας. Στις **αγχώδεις διαταραχές** και στην **ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή**, η έκθεση έχει κεντρικό ρόλο, μαζί με τη μείωση της αποφυγής και των συμπεριφορών ασφάλειας ή των καταναγκασμών. Στην **ψύχωση**, η CBT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της δυσφορίας, την επεξεργασία του νοήματος που αποδίδεται στις ψυχωτικές εμπειρίες και τη βελτίωση των στρατηγικών αντιμετώπισης και της λειτουργικότητας.

Η **εργασία μεταξύ των συνεδριών** αποτελεί βασικό μέρος της θεραπείας και μπορεί να περιλαμβάνει καταγραφές, ασκήσεις, έκθεση ή συμπεριφορικά πειράματα. Προς το τέλος της θεραπείας δίνεται έμφαση στην **αυτοδιαχείριση και την πρόληψη υποτροπής**, με αναγνώριση πρώιμων προειδοποιητικών σημείων και συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπισή τους.

Τι είναι η μεταβίβαση και η αντιμεταβίβαση και γιατί έχουν κλινική σημασία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η **μεταβίβαση** είναι ο τρόπος με τον οποίο προσδοκίες, συναισθήματα και σχεσιακά πρότυπα που έχουν διαμορφωθεί σε προηγούμενες σημαντικές σχέσεις επανεμφανίζονται μέσα στη θεραπευτική σχέση. Η **αντιμεταβίβαση** αφορά τις συναισθηματικές και γνωστικές αντιδράσεις του θεραπευτή απέναντι στον ασθενή και στη μεταξύ τους σχέση.

Και οι δύο έννοιες μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τη διατύπωση της περίπτωσης. Για παράδειγμα, επαναλαμβανόμενη προσδοκία απόρριψης, εγκατάλειψης, ελέγχου ή διάσωσης μπορεί να εμφανιστεί και στη θεραπεία. Αντίστοιχα, έντονη επιθυμία του θεραπευτή να σώσει, να απομακρυνθεί, να αντιπαρατεθεί ή να κάνει εξαιρέσεις μπορεί να αποτελεί κλινικά χρήσιμο σήμα.

Δεν αντιμετωπίζω όμως ούτε τη μεταβίβαση ούτε την αντιμεταβίβαση ως **αντικειμενική απόδειξη** για το τι συμβαίνει στον ασθενή. Είναι υποθέσεις που πρέπει να ελέγχονται μέσα στη συνολική κλινική εικόνα. Η αντιμεταβίβαση μπορεί να σχετίζεται τόσο με τα διαπροσωπικά πρότυπα του ασθενούς όσο και με τις προσωπικές ευαισθησίες, τις εμπειρίες ή την κόπωση του θεραπευτή.

Γι' αυτό χρειάζονται **αναστοχασμός, σαφή θεραπευτικά όρια, εποπτεία και συζήτηση στην ομάδα** όταν είναι απαραίτητο. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιείται η θεραπευτική σχέση ως πηγή πληροφορίας χωρίς να μετατρέπεται η αντίδραση του θεραπευτή σε παρορμητική πράξη ή σε τιμωρητική, απορριπτική ή υπερπροστατευτική στάση.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση είναι πηγές κλινικών υποθέσεων, όχι αντικειμενικά γεγονότα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ιδεατοποίηση, υποτίμηση και πόλωση της θεραπευτικής ομάδας

Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να εμφανιστεί έντονη **ιδεατοποίηση και υποτίμηση** διαφορετικών μελών της ομάδας, με αποτέλεσμα κάποιοι επαγγελματίες να αισθάνονται ότι πρέπει να «σώσουν» τον ασθενή και άλλοι να γίνονται περισσότερο απορριπτικοί ή αυστηροί. Δεν κατηγορώ τον ασθενή ότι «διασπά την ομάδα». Αναγνωρίζω την πόλωση και χρησιμοποιώ **κοινή διατύπωση, τακτική επικοινωνία, συνεπές θεραπευτικό σχέδιο και όρια και εποπτεία** ώστε η ομάδα να απαντά με συνοχή και όχι με αλληλοαναιρούμενες εξαιρέσεις ή αντιδράσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Υποστηρικτική έναντι διερευνητικής ψυχοθεραπείας

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία δίνει μεγαλύτερο βάρος στη σταθεροποίηση, τη συγκράτηση, την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, τον έλεγχο της πραγματικότητας, τις στρατηγικές coping και τη διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικότητας. Ο θεραπευτής είναι συχνά πιο ενεργός.

Η διερευνητική ψυχοθεραπεία δίνει μεγαλύτερο βάρος στην κατανόηση και επεξεργασία υποκείμενων συγκρούσεων και επαναλαμβανόμενων προτύπων μέσω αναστοχασμού και ερμηνείας. Προϋποθέτει επαρκή σταθερότητα, θεραπευτική συμμαχία, ικανότητα αναστοχασμού και αντοχή στο συναίσθημα και την αμφισημία. Στην πράξη υποστηρικτικά και διερευνητικά στοιχεία μπορούν να συνυπάρχουν και να μεταβάλλονται ανάλογα με τη φάση της θεραπείας.

Τι είναι η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία και πότε είναι χρήσιμη;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία (Interpersonal Psychotherapy, IPT) είναι δομημένη, χρονικά περιορισμένη και εγχειριδιακά οργανωμένη ψυχοθεραπεία που συνδέει τα ψυχιατρικά συμπτώματα με το τρέχον διαπροσωπικό πλαίσιο του ασθενούς. Δεν εστιάζει κυρίως στην ανακατασκευή ολόκληρης της προσωπικότητας ή της παιδικής ιστορίας, αλλά σε συγκεκριμένα διαπροσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με την έναρξη ή τη διατήρηση των συμπτωμάτων.

Κλασικά οργανώνεται γύρω από τέσσερις περιοχές: πένθος ή απώλεια, μεταβάσεις ρόλων, διαφωνίες ή συγκρούσεις ρόλων και επίμονες διαπροσωπικές δυσκολίες. Στην αρχική φάση γίνεται σύνδεση των συμπτωμάτων με μία ή περισσότερες από αυτές τις περιοχές και συμφωνείται συγκεκριμένη θεραπευτική εστίαση.

Στη συνέχεια ο θεραπευτής και ο ασθενής εξετάζουν τις σχέσεις και τις επικοινωνιακές δυσκολίες που σχετίζονται με το πρόβλημα, επεξεργάζονται το συναίσθημα, δοκιμάζουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων και ενισχύουν τη διαθέσιμη κοινωνική υποστήριξη. Η τελική φάση περιλαμβάνει ανασκόπηση της προόδου, αναγνώριση μελλοντικών διαπροσωπικών κινδύνων και σχέδιο για πιθανή υποτροπή.

Η κλασική και βασική ένδειξη είναι η κατάθλιψη. Η IPT αποτελεί επίσης αναγνωρισμένη επιλογή στην περιγεννητική κατάθλιψη. Στη διπολική διαταραχή υπάρχει η **Interpersonal and Social Rhythm Therapy (IPSRT)**, η οποία αποτελεί προσαρμογή που ενσωματώνει τη ρύθμιση κοινωνικών και κιρκαδικών ρυθμών και δεν πρέπει να συγχέεται με την απλή IPT.

Η IPT δεν αποτελεί καθολική πρώτη ψυχοθεραπεία για κάθε διάγνωση. Σε διαταραχές όπου υπάρχουν σαφείς ειδικές πρώτης γραμμής παρεμβάσεις, όπως σε αρκετές διατροφικές διαταραχές, η IPT δεν τις εκτοπίζει αυτόματα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Κλασικές περιοχές: πένθος, μεταβάσεις ρόλων, διαφωνίες ρόλων, διαπροσωπικές δυσκολίες.
- Κεντρική ένδειξη: κατάθλιψη. IPSRT είναι διπολική προσαρμογή, όχι συνώνυμο της IPT.

Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση και πώς βελτιώνει την ψυχιατρική θεραπεία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ψυχοεκπαίδευση δεν είναι απλώς να ανακοινώσουμε στον ασθενή τη διάγνωση. Είναι μια οργανωμένη θεραπευτική διαδικασία που βοηθά τον ασθενή να κατανοήσει τη διαταραχή, τη θεραπεία και τους προσωπικούς παράγοντες που αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής, ώστε να συμμετέχει πιο ενεργά στη φροντίδα του.

Συζητώ με τρόπο προσαρμοσμένο στον ασθενή τη φύση της διαταραχής, την αναμενόμενη πορεία, τις διαθέσιμες θεραπείες, τα πιθανά οφέλη και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η πληροφορία πρέπει να οδηγεί σε **συνεργατική λήψη αποφάσεων** και όχι σε μονόδρομη διδασκαλία από τον γιατρό.

Συνδέω τη γενική γνώση με το προσωπικό μοτίβο του ασθενούς. Εντοπίζουμε **πρώιμα προειδοποιητικά σημεία**, συνηθισμένους εκλυτικούς παράγοντες, δυσκολίες στη λήψη της αγωγής και αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης. Στη συνέχεια οργανώνουμε συγκεκριμένο **σχέδιο πρόληψης υποτροπής ή διαχείρισης κρίσης**, με σαφή βήματα για το τι πρέπει να γίνει αν τα συμπτώματα αρχίσουν να επιστρέφουν.

Η ψυχοεκπαίδευση μπορεί επίσης να βελτιώσει τη συνέπεια στη θεραπεία, την αυτοπαρακολούθηση, την επίλυση προβλημάτων και την αίσθηση ελέγχου του ασθενούς πάνω στη νόσο. Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιείται για να αποδίδεται κάθε δυσκολία θεραπείας σε «έλλειψη insight» ή «μη συμμόρφωση» χωρίς να εξετάζονται ανεπιθύμητες ενέργειες, προτιμήσεις, πρακτικά εμπόδια και η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης.

Όπου είναι κατάλληλο και με σεβασμό στη συναίνεση και το απόρρητο, μπορούν να συμμετέχουν **οικογένεια ή φροντιστές**. Η οικογενειακή παρέμβαση έχει τεκμηριωμένη θέση στη σχιζοφρένεια και στη διπολική διαταραχή. Το ότι πρέπει να προσφέρεται όταν σχετίζεται δεν σημαίνει ότι η συμμετοχή της οικογένειας είναι υποχρεωτική σε κάθε ασθενή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Κεντρικά στοιχεία: **προσωπικά πρώιμα προειδοποιητικά σημεία + σχέδιο υποτροπής/κρίσης.**
- Η οικογενειακή παρέμβαση έχει θέση στη σχιζοφρένεια και τη διπολική διαταραχή· **προσφέρεται, δεν επιβάλλεται.**

Ποια μετωποϋποφλοιώδη και μεταιχμιακά κυκλώματα είναι πιο σημαντικά στην ψυχιατρική;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην ψυχιατρική είναι πιο χρήσιμο να σκεφτόμαστε λειτουργικά κυκλώματα και δίκτυα παρά έναν απλοϊκό χάρτη «μία περιοχή = ένα σύμπτωμα».

Ο ραχιοπλάγιος προμετωπιαίος φλοιός και τα μετωποραβδωτά κυκλώματα σχετίζονται με εκτελεστικές λειτουργίες, εργαζόμενη μνήμη, σχεδιασμό, οργάνωση, αλλαγή νοητικού συνόλου και γνωστική ευελιξία. Δυσλειτουργία τους μπορεί να δώσει δυσεκτελεστική εικόνα.

Ο κογχομετωπιαίος και ο κοιλιοέσω προμετωπιαίος φλοιός συμμετέχουν στην κοινωνική κρίση, στην αξιολόγηση ανταμοιβής και τιμωρίας και στον έλεγχο παρορμήσεων. Δυσλειτουργία μπορεί να εκφραστεί με αποαναστολή, κακή κοινωνική κρίση ή παρορμητικότητα.

Ο πρόσθιος προσαγωγίος και ο έσω μετωπιαίος φλοιός έχουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη συμπεριφοράς, την κινητοποίηση, την κατανομή προσπάθειας και την επιλογή δράσης. Δυσλειτουργία μπορεί να συνδέεται με απάθεια ή αβουλία.

Στο μεταιχμιακό σύστημα, η αμυγδαλή συμμετέχει στη συναισθηματική σημασία των ερεθισμάτων, στην επεξεργασία απειλής και στη μάθηση φόβου· δεν είναι απλώς ένα «κέντρο φόβου». Ο ιππόκαμπος είναι κρίσιμος για την επεισοδιακή και δηλωτική μνήμη και για τη σύνδεση των εμπειριών με το πλαίσιο στο οποίο συνέβησαν.

Το κοιλιακό ραβδωτό και ιδιαίτερα ο επικλινής πυρήνας συμμετέχουν στην ανταμοιβή, την προσδοκία ανταμοιβής, την ενισχυτική μάθηση και την κινητοποιητική σημασία των ερεθισμάτων.

Αυτές οι συσχετίσεις είναι χρήσιμες για την κατανόηση νευροψυχιατρικών συνδρόμων, αλλά δεν αποτελούν ντετερμινιστικό σύστημα εντόπισης ούτε διαγνωστική απεικόνιση ενός μεμονωμένου ασθενούς.

Ποιες είναι οι κύριες ντοπαμινεργικές οδοί και η κλινική τους σημασία;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι τέσσερις κύριες ντοπαμινεργικές οδοί που έχουν ιδιαίτερη σημασία στην ψυχιατρική είναι η **μεσομεταιχμιακή**, η **μεσοφλοιώδης**, η **μελανοραβδωτή** και η **φυματοχοανική**.

Η **μεσομεταιχμιακή οδός** συνδέεται με ανταμοιβή, κινητοποιητική σημασία και ενίσχυση. Στην ψύχωση, ιδιαίτερα στη σχιζοφρένεια, η πιο χρήσιμη σύγχρονη διατύπωση δεν είναι ότι υπάρχει «υπερβολική ντοπαμίνη παντού», αλλά ότι **αυξημένη προσυναπτική ντοπαμινεργική σηματοδότηση στο ραβδωτό** σχετίζεται με την παθοφυσιολογία των θετικών ψυχωτικών συμπτωμάτων.

Η **μεσοφλοιώδης οδός** συνδέει το μεσεγκέφαλο με προμετωπιαίες περιοχές και συμμετέχει στη γνωστική λειτουργία και την κινητοποίηση. Το κλασικό μοντέλο σχετικής φλοιώδους υποντοπαμινεργίας για αρνητικά και γνωστικά συμπτώματα είναι χρήσιμο ως απλουστευτικό μοντέλο, αλλά είναι **ανεπαρκές ως πλήρης εξήγηση** της σχιζοφρένειας.

Η **μελανοραβδωτή οδός** είναι κεντρική για την κινητική λειτουργία. Αποκλεισμός υποδοχέων D2 σε αυτή την οδό εξηγεί μεγάλο μέρος των **εξωπυραμιδικών ανεπιθύμητων ενεργειών** των αντιψυχωσικών, όπως παρκινσονισμό, δυστονία και ακαθυσία.

Η **φυματοχοανική οδός** ρυθμίζει την έκκριση προλακτίνης. Η ντοπαμίνη φυσιολογικά αναστέλλει την προλακτίνη, επομένως ο αποκλεισμός D2 μπορεί να προκαλέσει **υπερπρολακτιναιμία** με σεξουαλικές, αναπαραγωγικές και ενδοκρινικές συνέπειες.

Άρα οι ντοπαμινεργικές οδοί είναι χρήσιμες κυρίως γιατί συνδέουν βασική νευροβιολογία με την κατανόηση της ψύχωσης και την πρόβλεψη ανεπιθύμητων ενεργειών των αντιψυχωσικών. Δεν αποτελούν όμως μία πλήρη μονονευροδιαβιβαστική θεωρία της σχιζοφρένειας ούτε ατομικό διαγνωστικό βιοδείκτη.

Τι σημαίνουν η κληρονομικότητα, ο οικογενειακός κίνδυνος και ο πολυγονιδιακός κίνδυνος στην ψυχιατρική;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η **κληρονομικότητα** είναι μέτρο σε επίπεδο πληθυσμού. Περιγράφει ποιο ποσοστό της διακύμανσης ενός χαρακτηριστικού σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό και υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες αποδίδεται σε γενετικές διαφορές. Δεν σημαίνει ότι «ένα συγκεκριμένο ποσοστό της νόσου αυτού του ασθενούς είναι γενετικό».

Ο **οικογενειακός κίνδυνος** δείχνει ότι μία διαταραχή εμφανίζεται συχνότερα σε συγγενείς ατόμων που πάσχουν. Αυτό αντανακλά κοινή γενετική ευαλωτότητα, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάζεται από κοινό ή αναπτυξιακό περιβάλλον. Η οικογενειακή συγκέντρωση από μόνη της δεν αποδεικνύει έναν αποκλειστικά γενετικό μηχανισμό.

Οι περισσότερες μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές έχουν **πολυγονιδιακή αρχιτεκτονική**. Δηλαδή ο κίνδυνος επηρεάζεται από πολύ μεγάλο αριθμό συχνών γενετικών παραλλαγών, καθεμία από τις οποίες έχει πολύ μικρή επίδραση. Δεν υπάρχει συνήθως ένα μεμονωμένο «γονίδιο της σχιζοφρένειας» ή «γονίδιο της κατάθλιψης» που να εξηγεί τη συνηθισμένη ενήλικη νόσο.

Σε ορισμένες παρουσιάσεις μπορεί να υπάρχουν **σπάνιες γενετικές παραλλαγές ή μεταβολές του αριθμού αντιγράφων (copy-number variants, CNVs)** με μεγαλύτερη επίδραση. Είναι σημαντικές βιολογικά και σε επιλεγμένες κλινικές περιπτώσεις, αλλά εξηγούν μόνο μειοψηφία της συνήθους ενήλικης ψυχιατρικής νοσηρότητας.

Υπάρχει επίσης **πλειοτροπία και γενετική επικάλυψη** μεταξύ διαγνωστικών κατηγοριών. Το ίδιο γενετικό υπόβαθρο μπορεί να αυξάνει την ευαλωτότητα για περισσότερους από έναν ψυχιατρικούς φαινοτύπους, κάτι που υπενθυμίζει ότι οι διαγνωστικές κατηγορίες δεν αντιστοιχούν σε απόλυτα ξεχωριστές γενετικές οντότητες.

Οι **πολυγονιδιακές βαθμολογίες κινδύνου (polygenic risk scores, PRS)** συνοψίζουν τη συμβολή πολλών παραλλαγών σε έναν στατιστικό δείκτη κινδύνου. Σήμερα όμως δεν αποτελούν καθιερωμένα αυτόνομα διαγνωστικά ή προγνωστικά τεστ στη συνήθη ψυχιατρική πρακτική και δεν αντικαθιστούν την κλινική αξιολόγηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η κληρονομικότητα είναι ιδιότητα πληθυσμού και περιβάλλοντος, όχι ποσοστό «γενετικότητας» ενός ατόμου.
- Οι PRS δεν είναι εξετάσεις ρουτίνας για αυτόνομη διάγνωση ή πρόγνωση.

Τι σημαίνουν μικτά χαρακτηριστικά και ταχεία εναλλαγή στη διπολική διαταραχή και πώς επηρεάζουν την αντιμετώπιση;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα **μικτά χαρακτηριστικά** σημαίνουν ότι μέσα σε ένα καταθλιπτικό, μανιακό ή υπομανιακό επεισόδιο συνυπάρχουν κλινικά σημαντικά συμπτώματα του αντίθετου πόλου. Δεν είναι απλώς «γρήγορες αλλαγές διάθεσης». Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όταν η κατάθλιψη συνοδεύεται από σαφή μανιακά/υπομανιακά στοιχεία, όπως αυξημένη ενεργητικότητα ή στοχοκατευθυνόμενη δραστηριότητα, μειωμένη ανάγκη για ύπνο, επιτάχυνση της σκέψης ή φυγή ιδεών, αυξημένη ομιλία, μεγαλοϊδεατισμό ή ανυψωμένη/επεκτατική διάθεση, γιατί αυξάνεται η διαγνωστική και θεραπευτική πολυπλοκότητα και χρειάζεται προσεκτική εκτίμηση αυτοκτονικού κινδύνου.

Αν η εικόνα είναι πραγματικά μικτή, πρώτα επιβεβαιώνω ότι πρόκειται για επεισοδιακή διπολική συμπτωματολογία και όχι για άγχος, χρήση ουσιών, ΔΕΠΥ, διαταραχή προσωπικότητας ή φαρμακευτική ενεργοποίηση. Ελέγχω επίσης πρόσφατη έναρξη ή αύξηση αντικαταθλιπτικού και άλλους πιθανούς αποσταθεροποιητικούς παράγοντες.

Όταν συνυπάρχουν σαφή μανιακά και καταθλιπτικά συμπτώματα, η οξεία αντιμετώπιση ακολουθεί κυρίως τη λογική της **μανίας**, με στενή παρακολούθηση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Αν υπάρχει αντικαταθλιπτικό, επανεκτιμώ άμεσα την ανάγκη συνέχισής του· στην εμφάνιση μανίας ή υπομανίας συνήθως διακόπτεται ή εξετάζεται σοβαρά η διακοπή του. Σε διπολική κατάθλιψη με μικτά χαρακτηριστικά αποφεύγω την αντικαταθλιπτική μονοθεραπεία και είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός για ενεργοποίηση ή μεταστροφή σε μανία ή υπομανία.

Η **ταχεία εναλλαγή (rapid cycling)** είναι διαφορετική έννοια. Κλασικά περιγράφει πορεία με **τουλάχιστον τέσσερα συνδρομικά επεισόδια κατάθλιψης, μανίας ή υπομανίας μέσα σε 12 μήνες**. Δεν πρέπει να συγχέεται με ωριαίες μεταβολές συναισθήματος ή αντιδραστικότητα σε διαπροσωπικά γεγονότα.

Όταν υπάρχει ταχεία εναλλαγή, ελέγχω αν συμβάλλουν **αντικαταθλιπτικά ή άλλα ενεργοποιητικά φάρμακα, ουσίες, θυρεοειδική δυσλειτουργία, κακή συμμόρφωση και ασταθής ύπνος/κιρκάδιος ρυθμός**. Δεν υπάρχει ξεχωριστός, αποδεδειγμένα ανώτερος θεραπευτικός αλγόριθμος μόνο και μόνο λόγω της ταχείας εναλλαγής. Αντιμετωπίζω το τρέχον επεισόδιο με τις καθιερωμένες θεραπείες της διπολικής διαταραχής και δίνω ιδιαίτερο βάρος στη μακροχρόνια σταθεροποίηση, στην αποφυγή αποσταθεροποιητικών παραγόντων και στην πρόληψη νέων επεισοδίων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Μικτά χαρακτηριστικά ≠ απλή συναισθηματική αστάθεια.
- Ταχεία εναλλαγή: ≥4 επεισόδια σε 12 μήνες.

Πότε η κατάθλιψη είναι ψυχωτική ή τόσο βαριά ώστε να αλλάζει άμεσα η αντιμετώπιση;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αντιμετώπιση αλλάζει άμεσα όταν η κατάθλιψη συνοδεύεται από **ψυχωτικά συμπτώματα, κατατονία, πολύ υψηλό αυτοκτονικό κίνδυνο, σοβαρή αυτοπαραμέληση ή αδυναμία λήψης τροφής και υγρών**. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται επείγουσα εκτίμηση της ασφάλειας και συχνά εξειδικευμένη ή νοσοκομειακή αντιμετώπιση.

Στην ψυχωτική κατάθλιψη αναζητώ παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθήσεις μέσα στο καταθλιπτικό επεισόδιο. Συχνά το περιεχόμενο είναι συμβατό με το συναίσθημα, όπως έντονη ενοχή, αναξιότητα, καταστροφή, σοβαρή νόσος ή μηδενιστικές ιδέες τύπου **Cotard**, αλλά μπορεί να υπάρχουν και μη συμβατά ψυχωτικά συμπτώματα. Η ψύχωση μπορεί να είναι λεπτή ή να αποκρύπτεται, οπότε χρειάζεται ενεργή διερεύνηση.

Παράλληλα εκτιμώ **αυτοκτονικότητα, πρόσληψη τροφής και υγρών, ψυχοκινητικότητα, κατατονικά σημεία, ικανότητα λήψης αποφάσεων και ιατρική σταθερότητα**. Ελέγχω επίσης για διπολική διαταραχή, ουσίες/φάρμακα και οργανικά αίτια, ιδιαίτερα όταν η εικόνα είναι άτυπη ή οξεία.

Η ψυχωτική κατάθλιψη αντιμετωπίζεται σε εξειδικευμένο πλαίσιο. Η βασική φαρμακολογική επιλογή είναι συνήθως **αντικαταθλιπτικό μαζί με αντιψυχωσικό**. Αν ο ασθενής δεν αποδέχεται αντιψυχωσικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντικαταθλιπτικό μόνο, με στενή παρακολούθηση και επανεκτίμηση.

Η **ECT** πρέπει να εξετάζεται νωρίς όταν χρειάζεται γρήγορη ανταπόκριση, ιδιαίτερα όταν η κατάθλιψη είναι απειλητική για τη ζωή επειδή ο ασθενής δεν τρώει ή δεν πίνει, όταν υπάρχει κατατονία, πολύ σοβαρή ψυχωτική εικόνα ή όταν άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει. Δεν την αντιμετωπίζω ως υποχρεωτικά «τελευταία λύση».

Η διαφορική από σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή είναι κυρίως **διαχρονική**: στην ψυχωτική κατάθλιψη η ψύχωση οργανώνεται μέσα στο καταθλιπτικό επεισόδιο. Αν υπάρχει σαφής ψύχωση εκτός των επεισοδίων διάθεσης, επανεξετάζω τη διάγνωση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ψυχωτική κατάθλιψη: συνήθως **αντικαταθλιπτικό + αντιψυχωσικό**.
- **ECT νωρίς** όταν απαιτείται ταχεία ανταπόκριση ή η κατάσταση είναι απειλητική για τη ζωή.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι είναι το σύνδρομο Cotard;

Είναι **μηδενιστική παραληρητική ιδέα**, συνήθως σε πολύ βαριά ψυχωτική κατάθλιψη, όπου ο ασθενής μπορεί να πιστεύει ότι είναι νεκρός, ότι δεν υπάρχει ή

ότι όργανα ή λειτουργίες του σώματός του έχουν παύσει. Δεν αποτελεί ξεχωριστή διάγνωση και μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα νευροψυχιατρικά σύνδρομα.

Πώς αξιολογείτε και αντιμετωπίζετε υπερπρολακτιναιμία και σεξουαλικές ή ενδοκρινικές ανεπιθύμητες ενέργειες από αντιψυχωσικά;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αντιψυχωσική υπερπρολακτιναιμία μπορεί να προκαλέσει διαταραχές εμμήνου ρύσεως, γαλακτόρροια, σεξουαλική δυσλειτουργία, υπογονιμότητα, γυναικομαστία και μακροχρόνιο υπογοναδισμό με επιβάρυνση της οστικής υγείας. Δεν αρκεί λοιπόν να δω μόνο μια εργαστηριακή τιμή· ρωτώ ενεργά για συμπτώματα και εκτιμώ τη διάρκεια και την κλινική σημασία της αύξησης.

Η προλακτίνη μετράται πριν από την έναρξη αντιψυχωσικού στο πλαίσιο της βασικής παρακολούθησης και επανελέγχεται όταν υπάρχουν συμπτώματα ή όταν το χρησιμοποιούμενο φάρμακο έχει υψηλή προλακτιναιμική δράση. **Ρισπεριδόνη, παλιπεριδόνη και αμισουλπρίδη** είναι χαρακτηριστικά φάρμακα με μεγαλύτερη πιθανότητα αύξησης της προλακτίνης, ενώ η **αριπιπραζόλη** έχει σχετικά μικρή επίδραση στην προλακτίνη.

Αν η προλακτίνη είναι αυξημένη, ελέγχω πρώτα αν το εύρημα είναι συμβατό με τη φαρμακευτική αγωγή και, όταν χρειάζεται, το επιβεβαιώνω με επανάληψη. Αναζητώ άλλες αιτίες όπως **κύηση, υποθυρεοειδισμό, νεφρική δυσλειτουργία και παθολογία της υπόφυσης**. Πολύ υψηλές ή επίμονες τιμές, κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης ή άλλα ενδοκρινολογικά ευρήματα χαμηλώνουν το κατώφλι για ενδοκρινολογική διερεύνηση.

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τα συμπτώματα, τη διάρκεια, τον ενδοκρινικό κίνδυνο και κυρίως από το πόσο απαραίτητο είναι το αντιψυχωσικό που ελέγχει την ψύχωση. Αν είναι κλινικά ασφαλές, μπορώ να **μειώσω τη δόση ή να αλλάξω σε αντιψυχωσικό με μικρότερη επίδραση στην προλακτίνη**. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί **προσθήκη αριπιπραζόλης** για τη μείωση της προλακτίνης, με παρακολούθηση της ψυχικής κατάστασης και αποφυγή άσκοπης μακροχρόνιας πολυφαρμακίας.

Ντοπαμινεργικοί αγωνιστές όπως η καβεργολίνη ή η βρωμοκρυπτίνη δεν αποτελούν συνήθη ψυχιατρική πρώτη επιλογή, επειδή μπορεί να επιβαρύνουν την ψύχωση· όταν χρειάζονται, η απόφαση γίνεται σε συνεργασία με ενδοκρινολόγο.

Η **σεξουαλική δυσλειτουργία δεν σημαίνει πάντα υπερπρολακτιναιμία**. Μπορεί να σχετίζεται με καταστολή, αντιχολινεργική ή αδρενεργική δράση, κατάθλιψη, αρνητικά συμπτώματα, σωματική νόσο ή άλλα φάρμακα. Επομένως φυσιολογική προλακτίνη δεν αρκεί για να ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ρισπεριδόνη/παλιπεριδόνη/αμισουλπρίδη: υψηλότερη προλακτιναιμική δράση· αριπιπραζόλη: σχετικά μικρή επίδραση στην προλακτίνη.

- Επίμονη υπερπρολακτιναιμία μπορεί να προκαλέσει υπογοναδισμό και απώλεια οστικής μάζας.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ο ασθενής έχει σεξουαλική δυσλειτουργία αλλά φυσιολογική προλακτίνη. Τι κάνετε;

Ελέγχω δόση και είδος αντιψυχωσικού, καταστολή, αντιχολινεργική/αδρενεργική επιβάρυνση, κατάθλιψη ή αρνητικά συμπτώματα, άλλες φαρμακευτικές αιτίες, χρήση ουσιών και οργανικά/ενδοκρινικά αίτια. Η αντιμετώπιση στοχεύει στον πιθανότερο μηχανισμό και δεν βασίζεται μόνο στην προλακτίνη.

Πότε θεωρείτε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ανθεκτική και πώς προχωράτε θεραπευτικά;

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πριν χαρακτηρίσω την OCD ανθεκτική, βεβαιώνομαι ότι πρόκειται για **πραγματική αποτυχία επαρκούς θεραπείας**. Επανελέγχω τη διάγνωση, τη βαρύτητα, τη συμμόρφωση, τη συννοσηρότητα και κυρίως αν ο ασθενής έχει λάβει επαρκή CBT με έκθεση και παρεμπόδιση αντίδρασης (ERP) και επαρκή δοκιμή SSRI.

Στην OCD η ανταπόκριση στα SSRI μπορεί να είναι πιο αργή από ό,τι στην κατάθλιψη και μια πλήρης δοκιμή μπορεί να χρειαστεί **έως 12 εβδομάδες**. Αν υπάρχει ανοχή αλλά ανεπαρκής ανταπόκριση, βελτιστοποιώ τη δόση μέσα στο εγκεκριμένο εύρος και ελέγχω αν η ERP εφαρμόζεται πραγματικά με επαρκή ένταση και χωρίς συστηματική αποφυγή ή οικογενειακή διευκόλυνση των καταναγκασμών.

Αν ένα SSRI μόνο του δεν είναι αρκετό, η επόμενη λογική κίνηση είναι συχνά ο **συνδυασμός SSRI με CBT/ERP** ή αλλαγή σε άλλο επαρκές SSRI, ανάλογα με το τι έχει ήδη δοκιμαστεί. Η **κλομιπραμίνη** παραμένει αποτελεσματική επιλογή επόμενης γραμμής, ιδιαίτερα μετά από ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία στα SSRI, αλλά έχει μεγαλύτερο αντιχολινεργικό, καρδιαγγειακό και τοξικό φορτίο σε υπερδοσολογία.

Όταν έχουν αποτύχει επαρκείς δοκιμές SRI και ERP, χρειάζεται **εξειδικευμένη επανεκτίμηση**. Ελέγχω αν τα συμπτώματα που παραμένουν είναι πράγματι ιδεοληψίες και καταναγκασμοί και όχι ψύχωση, καταθλιπτική μηρυκαστικότητα, αυτιστική επαναληπτικότητα ή ιδεοψυχαναγκαστική προσωπικότητα. Εξετάζω επίσης tic-related φαινομενολογία και άλλες συννοσηρότητες που μπορεί να επηρεάζουν την ανταπόκριση.

Σε επιλεγμένη ανθεκτική OCD μπορεί να χρησιμοποιηθεί **προσθήκη αντιψυχωσικού σε SSRI ή κλομιπραμίνη**, συνήθως σε εξειδικευμένο πλαίσιο και αφού έχει προηγηθεί ουσιαστική αποτυχία των βασικών θεραπειών. Το αντιψυχωσικό δεν αποτελεί μονοθεραπεία για την OCD και δεν πρέπει να προστίθεται μηχανικά μετά από μία ανεπαρκή ή βραχεία δοκιμή SSRI.

Σε όλη τη διαδικασία παρακολουθώ λειτουργικότητα, αυτοκτονικό κίνδυνο, ανεπιθύμητες ενέργειες και πραγματική συμμετοχή στην ERP. Ο στόχος δεν είναι απλώς να αλλάζω φάρμακα, αλλά να εξασφαλίσω ότι έχουν εφαρμοστεί σωστά οι θεραπείες με την ισχυρότερη τεκμηρίωση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Πλήρης δοκιμή SSRI στην OCD μπορεί να χρειαστεί **έως 12 εβδομάδες**.
- Αντιψυχωσική ενίσχυση: μόνο σε **επιλεγμένη ανθεκτική OCD**, όχι μονοθεραπεία.

ΠΙΘΑΝΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΉ

Τι γνωρίζουμε για τη νευροβιολογία της OCD;

Το πιο χρήσιμο μοντέλο αφορά δυσλειτουργία στα φλοιοραβδωτοθαλαμοφλοιώδη κυκλώματα, ιδιαίτερα σε τροchioμετωπιαίο φλοιό, πρόσθιο προσαγωγίο και ραβδωτό σώμα. Η σεροτονίνη έχει κλινική σημασία λόγω της αποτελεσματικότητας των SRIs, αλλά η OCD δεν εξηγείται από μία απλή «έλλειψη σεροτονίνης»: γλουταμινεργικοί και ντοπαμινεργικοί μηχανισμοί επίσης μελετώνται. Δεν υπάρχει κλινικά χρησιμοποιούμενος βιοδείκτης ή απεικονιστικό τεστ που να θέτει τη διάγνωση.